Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

KOMPLIKASI NIFAS

Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu

Nurbaety • Gita Kostania • Pipit Indra Lestari • Sri Hennyati Amiruddin
Eva Fauziah • Kusumastuti • Nurul Hidayah

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



BUKU AJAR:
KOMPLIKASI NIFAS: PERDARAHAN, INFEKSI, GANGGUAN LAKTASI, DAN KESEHATAN MENTAL IBU

Penulis:
Nurbaety, S.SiT., M.K.M.
Gita Kostania, S.ST., M.Kes.
Pipit Indra Lestari, S.ST., M.Kes.
Bdn. Sri Hennyati Amiruddin, S.ST., M.Kes., M.Tr.Keb.
Eva Fauziah S.ST., M.Kes.
Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes.
Nurul Hidayah, M.Tr.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar: Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu

Penulis:
Nurbaety, S.SiT., M.K.M.
Gita Kostania, S.ST., M.Kes.
Pipit Indra Lestari, S.ST., M.Kes.
Bdn. Sri Hennyati Amiruddin, S.ST., M.Kes., M.Tr.Keb.
Eva Fauziah S.ST., M.Kes.
Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes.
Nurul Hidayah, M.Tr.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7927-22-4

Cetakan Pertama: September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar berjudul "Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran untuk mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan klinis, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman, komprehensif, dan berpusat pada kebutuhan ibu.

Masa nifas merupakan periode penting sekaligus rentan dalam siklus kehidupan seorang perempuan. Pada masa ini, ibu mengalami proses pemulihan fisik, penyesuaian psikologis, adaptasi terhadap peran baru, serta proses menyusui. Meskipun sebagian besar perubahan berlangsung secara fisiologis, berbagai komplikasi dapat muncul secara tiba-tiba dan berkembang cepat menjadi kondisi yang mengancam keselamatan ibu. Oleh karena itu, kemampuan melakukan pengkajian terfokus, mengenali tanda bahaya, menentukan prioritas masalah, memberikan tindakan awal, serta melakukan kolaborasi dan rujukan tepat waktu merupakan kompetensi yang sangat penting bagi seorang bidan.

Buku ini membahas berbagai komplikasi masa nifas secara sistematis, mulai dari perdarahan postpartum dan penyebabnya, atonia uteri, subinvolusi, retensio atau sisa plasenta, laserasi jalan lahir, serta hematoma. Pembahasan dilanjutkan dengan infeksi masa nifas, endometritis, infeksi luka, dan sepsis puerperalis, termasuk deteksi tanda bahaya, stabilisasi pra-rujukan, serta komunikasi rujukan yang terstruktur. Aspek gangguan laktasi juga dibahas melalui topik bendungan ASI, puting lecet, teknik koreksi menyusui, mastitis, dan abses payudara. Selain itu, buku ini menguraikan tromboemboli dan komplikasi sistemik, gangguan eliminasi pascapersalinan, serta masalah kesehatan mental ibu nifas, seperti *baby blues*, depresi postpartum, psikosis postpartum, dan risiko bunuh diri.

Tidak hanya menekankan aspek penanganan komplikasi, buku ini juga mengintegrasikan edukasi tanda bahaya, dukungan keluarga, dokumentasi asuhan kebidanan, konseling keluarga berencana, kunjungan nifas, dan prinsip *continuity of care*. Dengan demikian, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa pelayanan masa nifas bukan sekadar menangani keluhan yang muncul, melainkan mencakup upaya promotif, preventif, deteksi dini, penatalaksanaan awal, rujukan, serta tindak lanjut yang berkesinambungan.

Penyusunan buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis capaian atau *Outcome-Based Education*. Materi disajikan melalui uraian konsep, kasus klinis, latihan soal, simulasi keterampilan, OSCE, *Direct Observation of Procedural Skills* atau DOPS, refleksi keselamatan pasien, serta penyusunan portofolio. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik menghubungkan pengetahuan teoretis dengan situasi nyata di pelayanan kebidanan, sekaligus melatih kemampuan *clinical reasoning*, komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kerja sama interprofesional.

Buku ini ditujukan terutama bagi mahasiswa Diploma III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan, Sarjana Kebidanan, mahasiswa Profesi Bidan, dosen, pembimbing klinik, bidan praktisi, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan ibu pada masa nifas. Meskipun demikian, materi yang disajikan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola program kesehatan ibu dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan mutu pelayanan maternal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis, editor, penelaah, rekan sejawat, institusi pendidikan, praktisi kesehatan, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga setiap upaya yang telah diberikan menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi tenaga kebidanan serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan ibu pada masa nifas.

Akhir kata, kami berharap buku ajar ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat, aplikatif, dan mudah dipahami. Semoga kehadiran buku ini turut mendukung lahirnya bidan yang profesional, kompeten, empatik, tanggap terhadap kegawatdaruratan, serta mampu memberikan asuhan kebidanan masa nifas yang aman, bermutu, berbasis bukti, dan berkesinambungan.

Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1
SEPSIS PUERPERALIS: TANDA BAHAYA, STABILISASI PRA-RUJUKAN, DAN KOMUNIKASI RUJUKAN

Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai sepsis puerperalis, meliputi tanda bahaya, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan, sebagai salah satu bagian dalam *Buku Ajar Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu Seri 2*.

Buku ajar ini disusun berdasarkan pengalaman penulis dalam praktik klinik dan pendidikan kebidanan, khususnya dalam asuhan masa nifas serta penanganan komplikasi maternal. Sebagai pendidik dan praktisi, penulis memandang bahwa komplikasi pada masa nifas masih menjadi tantangan serius dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang aplikatif, kontekstual, serta berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*) bagi peserta didik dan tenaga kesehatan.

Adapun tujuan penyusunan buku ini adalah:

- Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai identifikasi tanda bahaya sepsis puerperalis serta penilaian derajat kegawatan.
- Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan stabilisasi pra-rujukan dan komunikasi rujukan secara terstruktur ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.

Buku ajar ini ditujukan bagi peserta didik D3 dan D4 Kebidanan/Sarjana Kebidanan, peserta didik profesi bidan, bidan pendidik, bidan praktisi, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan maternal.

Secara umum, buku ini membahas berbagai komplikasi masa nifas, meliputi perdarahan postpartum, sepsis puerperalis, gangguan laktasi, gangguan kesehatan mental ibu, manajemen rujukan maternal, serta peran bidan dalam pencegahan komplikasi. Setiap bab disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar hingga penerapan klinis di lapangan.

Buku ini dirancang dengan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan uraian teori berbasis bukti ilmiah, latihan soal, diskusi kasus klinis, simulasi praktik,

serta refleksi pembelajaran. Metode ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis peserta didik.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan meliputi *Student-Centered Learning*, *Case-Based Learning*, dan *Reflective Learning*, yang mendorong peserta didik untuk aktif, berpikir kritis, serta mampu melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar.
Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, pembaca disarankan untuk:

- Membaca setiap bab secara berurutan.
- Mencermati dan menganalisis kasus klinis yang disajikan.
- Mengerjakan latihan secara mandiri sebagai evaluasi pemahaman.
- Melakukan diskusi kelompok untuk memperdalam analisis kasus.
- Mengkaji kembali rangkuman materi sebagai penguatan konsep.

Tujuan Instruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Instruksional

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep sepsis puerperalis secara menyeluruh, termasuk dalam melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, serta komunikasi rujukan yang efektif pada kasus komplikasi nifas, khususnya yang bersifat sistemik.

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- Mengidentifikasi tanda bahaya sepsis puerperalis serta menilai derajat kegawatan secara tepat.
- Melaksanakan stabilisasi pra-rujukan sesuai standar pelayanan kebidanan.
- Menerapkan komunikasi rujukan yang efektif dan terstruktur kepada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Sepsis Puerperalis

1. Definisi dan Batasan Klinis

   Sepsis puerperalis adalah infeksi pada masa nifas yang disertai respons sistemik tubuh terhadap agen infeksi hingga menimbulkan gangguan fungsi organ. Masa nifas berlangsung sejak plasenta lahir sampai 42 hari postpartum. Dalam periode ini, terjadi proses involusi uterus, regenerasi endometrium, serta penyembuhan luka jalan lahir. Kondisi tersebut secara fisiologis membuka peluang masuknya mikroorganisme ke dalam jaringan reproduksi ibu.

   Definisi klasik infeksi puerperalis merujuk pada kenaikan suhu tubuh ≥38°C yang terjadi pada hari ke-2 sampai hari ke-10 masa nifas (tidak termasuk 24 jam pertama) dan berlangsung minimal dua hari berturut-turut (WHO, 2017). Namun, berdasarkan konsensus Sepsis-3, sepsis dipahami sebagai disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat respons tubuh yang tidak terkontrol terhadap infeksi (Singer et al., 2016). Dengan demikian, sepsis puerperalis merupakan spektrum kondisi yang bermula dari infeksi lokal hingga gangguan sistemik berat.

2. Epidemiologi dan Signifikansi Kesehatan Masyarakat

   Infeksi maternal masih menjadi penyumbang signifikan terhadap angka kematian ibu di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa sekitar 10–15% kematian maternal disebabkan oleh infeksi pada masa kehamilan dan nifas (WHO, 2019). Beban terbesar terjadi di negara berkembang, terutama pada wilayah dengan akses terbatas terhadap pelayanan obstetri emergensi dan sistem rujukan yang belum optimal.

   Di Indonesia, infeksi nifas tetap termasuk dalam kelompok penyebab langsung kematian ibu selain perdarahan dan gangguan hipertensi dalam kehamilan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan, deteksi dini, dan penanganan infeksi postpartum masih menjadi prioritas dalam pelayanan kebidanan.

3. Etiologi dan Agen Penyebab

   Sepsis puerperalis umumnya bersifat polimikroba. Mikroorganisme yang terlibat dapat berasal dari flora normal vagina yang berubah menjadi patogen oportunistik maupun dari lingkungan luar akibat praktik persalinan yang tidak aseptik. Bakteri yang sering ditemukan antara lain *Streptococcus beta-hemolyticus* grup A, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, serta bakteri anaerob seperti *Bacteroides* spp. (Cunningham et al., 2018).

   Infeksi paling sering bermula dari endometrium (endometritis), namun dapat pula berasal dari luka episiotomi, robekan perineum, luka operasi sesar,

atau sisa jaringan plasenta yang tertinggal. Luka implantasi plasenta yang luas dan kaya vaskularisasi menjadi media yang ideal bagi pertumbuhan bakteri bila terjadi kontaminasi.

4. Faktor Risiko

   Terjadinya sepsis puerperalis tidak lepas dari interaksi antara faktor host, agen infeksi, dan lingkungan. Faktor risiko yang sering ditemukan meliputi persalinan lama, ketuban pecah lebih dari 18 jam sebelum persalinan, pemeriksaan vaginal berulang tanpa indikasi jelas, tindakan operatif seperti ekstraksi vakum atau seksio sesarea, retensio plasenta, anemia, serta status gizi yang kurang baik.

   Selain itu, praktik kebersihan yang tidak memadai, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah, dapat meningkatkan risiko kontaminasi bakteri. Kondisi sosial ekonomi dan keterlambatan dalam mencari pertolongan medis juga berperan dalam memperburuk perjalanan penyakit.

5. Patofisiologi Sepsis Puerperalis

   Proses patofisiologi diawali dengan invasi mikroorganisme ke dalam jaringan uterus atau luka jalan lahir. Bakteri yang berkembang biak memicu respons inflamasi lokal berupa pelepasan mediator proinflamasi seperti TNF-α, IL-1, dan IL-6. Pada tahap awal, respons ini bertujuan untuk membatasi dan mengeliminasi infeksi.

   Namun, pada kondisi tertentu, respons inflamasi menjadi berlebihan dan menyebar secara sistemik. Terjadi vasodilatasi luas, peningkatan permeabilitas kapiler, serta gangguan mikrosirkulasi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen jaringan menyebabkan hipoperfusi dan disfungsi organ. Organ yang sering terdampak meliputi ginjal, paru, hati, serta sistem koagulasi. Bila proses ini tidak segera ditangani, pasien dapat mengalami syok septik dengan hipotensi persisten meskipun telah diberikan resusitasi cairan adekuat (Singer et al., 2016; WHO, 2017).

6. Implikasi Klinis dalam Praktik Kebidanan

   Sepsis puerperalis merupakan kondisi yang dapat berkembang cepat dan berakibat fatal. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar sangat penting bagi peserta didik dan praktisi kebidanan. Bidan memiliki peran strategis dalam pencegahan melalui penerapan prinsip pencegahan infeksi, edukasi ibu nifas, serta pemantauan kondisi klinis pada kunjungan masa nifas.

   Selain itu, kewaspadaan terhadap perubahan tanda vital, keluhan nyeri perut bawah, lokia berbau, atau gejala sistemik seperti menggigil dan lemah harus menjadi bagian dari asesmen rutin. Keputusan untuk melakukan stabilisasi awal dan rujukan tidak boleh ditunda ketika terdapat kecurigaan sepsis.

Pendekatan yang cepat, terstruktur, dan empatik terbukti berkontribusi dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal akibat infeksi postpartum (WHO, 2019).

B. Etiologi dan Faktor Risiko

1. Spektrum Etiologi Bakterial

   Sepsis puerperalis pada dasarnya disebabkan oleh infeksi bakteri yang terjadi pada jaringan genitalia setelah persalinan. Infeksi ini umumnya bersifat polimikroba, melibatkan kombinasi bakteri aerob dan anaerob. Agen yang paling sering ditemukan antara lain *Streptococcus* grup A maupun grup B, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, serta bakteri anaerob seperti *Bacteroides* spp. dan *Peptostreptococcus* (Cunningham et al., 2022).

   Mikroorganisme tersebut dapat berasal dari flora normal vagina yang mengalami perubahan keseimbangan, maupun dari sumber eksternal akibat prosedur persalinan yang tidak aseptik. Pada kondisi tertentu, bakteri yang awalnya bersifat komensal dapat menjadi patogen oportunistik, terutama bila terdapat kerusakan jaringan atau penurunan daya tahan tubuh ibu.

   Infeksi biasanya dimulai sebagai endometritis postpartum, kemudian dapat menyebar ke miometrium, parametrium, bahkan ke aliran darah. Bila respons inflamasi sistemik berkembang secara berlebihan, kondisi tersebut berlanjut menjadi sepsis dengan risiko disfungsi organ.

2. Jalur Masuk dan Sumber Infeksi

   Setelah persalinan, kavum uteri merupakan area terbuka dengan luka implantasi plasenta yang luas dan vaskularisasi tinggi. Keadaan ini menjadikan uterus sebagai tempat yang rentan terhadap kolonisasi bakteri. Selain itu, robekan perineum, episiotomi, maupun luka operasi sesar juga menjadi pintu masuk potensial bagi mikroorganisme.

   Ketuban pecah sebelum persalinan dalam waktu lama meningkatkan risiko kontaminasi asenden dari vagina ke kavum uteri. Setiap manipulasi intrauterin, terutama bila dilakukan berulang tanpa indikasi jelas atau tanpa teknik aseptik yang ketat, dapat memperbesar kemungkinan invasi bakteri ke dalam jaringan.

3. Faktor Risiko Obstetrik

   Sejumlah kondisi obstetrik diketahui meningkatkan risiko terjadinya sepsis puerperalis. Ketuban pecah lama, khususnya lebih dari 18 jam sebelum persalinan, memberi kesempatan bagi bakteri untuk naik ke dalam rongga uterus. Persalinan lama atau partus macet menyebabkan kelelahan ibu, trauma jaringan yang lebih luas, serta meningkatnya frekuensi pemeriksaan vaginal.

Tindakan operatif seperti ekstraksi vakum, forsep, maupun seksio sesarea juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko infeksi, terutama bila disertai perdarahan banyak atau teknik pencegahan infeksi yang kurang optimal. Retensio plasenta atau sisa jaringan dalam uterus dapat menjadi media pertumbuhan bakteri yang mempercepat perkembangan infeksi (Cunningham et al., 2022).

4. Faktor Maternal dan Kondisi Umum

   Kondisi umum ibu turut menentukan kerentanan terhadap infeksi. Anemia menurunkan kapasitas oksigenasi jaringan dan memengaruhi respons imun, sehingga memperlambat proses penyembuhan luka. Malnutrisi dan defisiensi mikronutrien juga berdampak pada penurunan imunitas seluler maupun humoral.

   Penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, obesitas, atau gangguan imunologis semakin meningkatkan risiko infeksi postpartum. Dalam praktik kebidanan, pengkajian status kesehatan ibu sejak masa antenatal menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi.

5. Faktor Higiene dan Praktik Pelayanan

   Prinsip pencegahan infeksi memiliki peran sentral dalam menekan kejadian sepsis puerperalis. Higiene yang buruk, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah, meningkatkan kemungkinan kontaminasi luka persalinan. Penggunaan alat yang tidak steril, kurangnya kebersihan tangan, serta lingkungan persalinan yang tidak memenuhi standar sanitasi merupakan faktor yang dapat dicegah.

   Penerapan standar prosedur operasional terkait antisepsis, penggunaan antibiotik profilaksis pada tindakan tertentu, serta edukasi ibu tentang perawatan luka nifas terbukti efektif menurunkan risiko infeksi (WHO, 2017).

6. Determinan Sosial dan Akses Pelayanan Kesehatan

   Selain faktor klinis, determinan sosial ekonomi berperan penting dalam terjadinya sepsis puerperalis. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan medis sering kali memperburuk kondisi ibu.

   Model “tiga keterlambatan” (delay in decision making, delay in reaching care, dan delay in receiving adequate care) masih menjadi tantangan dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Oleh karena itu, upaya pencegahan sepsis tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga memerlukan pendekatan sistemik melalui penguatan sistem rujukan dan pemberdayaan masyarakat (WHO, 2019).

Dengan memahami etiologi dan berbagai faktor risiko secara komprehensif, bidan diharapkan mampu melakukan identifikasi dini ibu berisiko tinggi serta menerapkan strategi pencegahan yang tepat guna menurunkan kejadian sepsis puerperalis.

C. Patofisiologi Sepsis Puerperalis

1. Fase Awal: Infeksi Lokal pada Masa Nifas

   Patofisiologi sepsis puerperalis diawali dari infeksi lokal pada jaringan genitalia postpartum, paling sering berupa endometritis. Luka implantasi plasenta yang luas, disertai terbukanya pembuluh darah pada dinding uterus, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kolonisasi dan invasi mikroorganisme. Trauma jalan lahir, episiotomi, maupun luka operasi sesar semakin memperbesar risiko penetrasi bakteri ke dalam jaringan yang lebih dalam.

   Pada tahap awal, sistem imun maternal merespons invasi patogen melalui aktivasi sel-sel imun dan pelepasan mediator inflamasi. Respons ini pada dasarnya bersifat protektif, bertujuan membatasi penyebaran infeksi dan mengeliminasi mikroorganisme penyebab.

2. Aktivasi Respons Inflamasi Sistemik

   Ketika jumlah bakteri meningkat atau virulensi patogen tinggi, respons inflamasi dapat menjadi tidak terkendali. Sel imun seperti makrofag dan neutrofil melepaskan mediator proinflamasi, termasuk tumor necrosis factor (TNF-α), interleukin-1 (IL-1), dan interleukin-6 (IL-6). Mediator ini memicu aktivasi sistem imun secara luas serta memengaruhi sistem vaskular dan koagulasi.

   Dalam konsep sepsis modern, kondisi ini dikenal sebagai disregulasi respons imun terhadap infeksi, yang berujung pada disfungsi organ yang mengancam jiwa (Singer et al., 2016). Pada fase ini, infeksi tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah memicu respons sistemik yang kompleks.

3. Vasodilatasi Sistemik dan Kebocoran Kapiler

   Mediator inflamasi menyebabkan vasodilatasi sistemik yang luas. Pelebaran pembuluh darah ini menurunkan resistensi vaskular sistemik sehingga tekanan darah mulai menurun. Selain itu, terjadi peningkatan permeabilitas kapiler yang mengakibatkan kebocoran cairan intravaskular ke ruang interstisial.

   Kombinasi vasodilatasi dan kebocoran kapiler menyebabkan penurunan volume sirkulasi efektif. Walaupun secara total cairan tubuh mungkin cukup, distribusinya menjadi tidak adekuat untuk mempertahankan perfusi organ vital.

4. Gangguan Perfusi dan Hipoksia Jaringan

   Penurunan tekanan darah dan gangguan mikrosirkulasi mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke jaringan. Sel-sel tubuh mengalami kekurangan oksigen (hipoksia), sehingga metabolisme beralih dari jalur aerobik ke anaerobik. Akibatnya terjadi peningkatan produksi asam laktat dan asidosis metabolik.

   Hipoperfusi yang berlangsung terus-menerus menyebabkan kerusakan sel dan gangguan fungsi organ. Ginjal dapat mengalami penurunan produksi urin, paru dapat mengalami gangguan pertukaran gas, dan sistem saraf pusat dapat menunjukkan penurunan kesadaran. Pada fase ini, gambaran klinis sepsis menjadi semakin berat dan kompleks.

5. Perkembangan Menuju Syok Septik

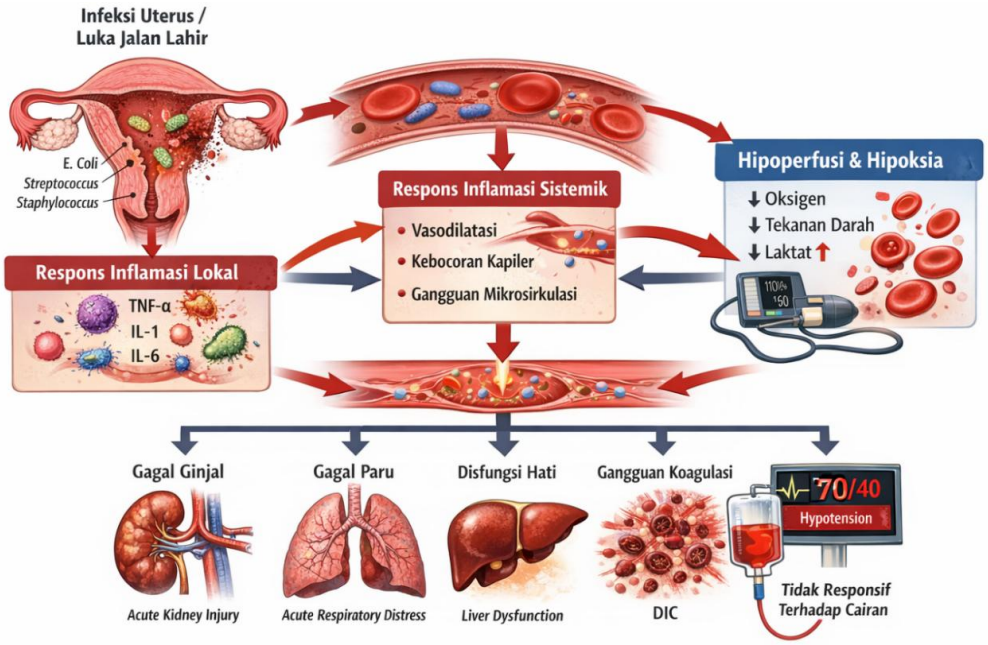
   Apabila hipotensi persisten terjadi meskipun telah diberikan resusitasi cairan yang adekuat, maka kondisi tersebut berkembang menjadi syok septik. Syok septik ditandai oleh ketidakmampuan sistem kardiovaskular mempertahankan perfusi jaringan secara memadai tanpa dukungan vasopresor. Disfungsi organ menjadi semakin nyata dan progresif (Singer et al., 2016).

   Pada ibu nifas, perkembangan menuju syok septik dapat berlangsung cepat, terutama bila terdapat faktor risiko seperti anemia berat, malnutrisi, atau keterlambatan penanganan. Oleh karena itu, pengenalan dini perubahan tanda vital dan gejala sistemik menjadi krusial dalam praktik kebidanan.

6. Kegagalan Multiorgan dan Konsekuensi Klinis

   Tahap akhir dari proses patofisiologi sepsis puerperalis adalah kegagalan multiorgan. Disfungsi ginjal, gangguan koagulasi (termasuk kemungkinan koagulasi intravaskular diseminata), gangguan pernapasan akut, serta gangguan fungsi hati dapat terjadi secara bersamaan. Tanpa intervensi yang cepat dan komprehensif, kondisi ini berisiko tinggi menyebabkan kematian maternal.

   Pemahaman mendalam mengenai patofisiologi sepsis puerperalis memberikan dasar ilmiah bagi bidan dalam melakukan deteksi dini, stabilisasi pra-rujukan, serta komunikasi efektif saat merujuk pasien. Dengan mengenali bahwa proses klinis ini bersifat progresif dan dinamis, tenaga kesehatan diharapkan mampu bertindak cepat sebelum terjadi kerusakan organ yang irreversible.



Gambar 1.1
Gambaran Patofisiologi Sepsis Puerperalis

D. Klasifikasi

Klasifikasi sepsis puerperalis penting untuk menentukan derajat keparahan serta prioritas penanganan klinis. Berdasarkan perkembangan klinis dan respons tubuh, sepsis puerperalis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Infeksi Puerperalis Lokal

   Infeksi terbatas pada area genitalia, seperti endometritis, infeksi luka episiotomi, atau luka operasi. Gejala umumnya bersifat lokal tanpa disertai gangguan sistemik berat.

2. Sepsis (Sepsis Puerperalis)

   Infeksi yang telah menimbulkan respons inflamasi sistemik, ditandai dengan demam, takikardia, takipnea, serta perubahan status mental. Pada tahap ini mulai terjadi gangguan perfusi jaringan.

3. Sepsis Berat (Severe Sepsis)

   Ditandai dengan adanya disfungsi organ, seperti oliguria, penurunan kesadaran, hipoksemia, atau gangguan koagulasi.

4. Syok Septik

   Merupakan kondisi paling berat, ditandai dengan hipotensi persisten meskipun telah diberikan resusitasi cairan adekuat. Membutuhkan penanganan intensif dan memiliki risiko mortalitas tinggi.

E. Tanda Bahaya Sepsis Masa Nifas

Pengenalan tanda bahaya sepsis pada masa nifas merupakan kompetensi esensial dalam praktik kebidanan. Sepsis puerperalis sering kali diawali oleh gejala yang tampak ringan, namun dapat berkembang cepat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, bidan harus mampu membedakan perubahan fisiologis normal masa nifas dengan tanda patologis yang menunjukkan infeksi berat. Kombinasi tanda lokal dan sistemik harus dipandang sebagai kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan respons segera.

1. Tanda Lokal

   Tanda lokal biasanya muncul pada area sumber infeksi, terutama uterus dan luka jalan lahir. Salah satu gejala yang paling sering dilaporkan adalah lokia berbau busuk. Secara fisiologis, lokia memiliki bau khas darah menstruasi, namun tidak menyengat. Bau yang tajam dan tidak sedap mengindikasikan adanya pertumbuhan bakteri patogen di kavum uteri.

   Nyeri uterus yang menetap atau semakin bertambah, terutama bila disertai nyeri tekan pada palpasi fundus, merupakan tanda inflamasi endometrium. Dalam kondisi normal, uterus akan berangsur mengecil dan nyeri berkurang dari hari ke hari. Bila nyeri justru meningkat, kondisi tersebut patut dicurigai sebagai endometritis.

   Subinvolusi uterus juga menjadi indikator penting. Involusi yang tidak sesuai usia nifas dapat menunjukkan adanya infeksi atau sisa jaringan plasenta yang menjadi media pertumbuhan bakteri. Tinggi fundus uteri yang tidak turun sesuai hari postpartum perlu dikaji secara menyeluruh.

   Selain itu, luka episiotomi, robekan perineum, atau luka operasi sesar yang tampak kemerahan, bengkak, nyeri, atau mengeluarkan cairan bernanah menunjukkan infeksi lokal pada jaringan tersebut. Luka yang terinfeksi dapat menjadi pintu masuk bakteri ke dalam aliran darah.

2. Tanda Sistemik

   Ketika infeksi lokal berkembang dan memicu respons inflamasi sistemik, muncul tanda-tanda sistemik yang lebih berat. Demam dengan suhu tubuh ≥38°C merupakan indikator awal yang sering ditemukan. Demam yang persisten, terutama setelah 24 jam pertama postpartum, harus dicurigai sebagai tanda infeksi (WHO, 2017).

   Menggigil hebat (rigor) menunjukkan adanya bakteremia atau respons inflamasi yang signifikan. Takikardia, yang ditandai dengan peningkatan frekuensi nadi di atas normal, sering kali menjadi tanda awal gangguan hemodinamik. Peningkatan frekuensi napas (takipnea) dapat mengindikasikan respons kompensasi terhadap asidosis metabolik akibat hipoperfusi jaringan.

Hipotensi merupakan tanda yang lebih serius dan menunjukkan gangguan sirkulasi sistemik. Penurunan tekanan darah yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi syok septik. Pada tahap lanjut, pasien dapat mengalami penurunan kesadaran akibat gangguan perfusi otak atau disfungsi multiorgan (Singer et al., 2016).

3. Interpretasi Klinis dan Kewaspadaan Dini

Dalam praktik kebidanan, tanda bahaya tidak selalu muncul secara bersamaan. Namun, kombinasi antara tanda lokal dan sistemik harus segera ditindaklanjuti sebagai kondisi gawat darurat. Misalnya, ibu nifas dengan lokia berbau dan demam tinggi disertai takikardia harus segera dilakukan evaluasi menyeluruh dan stabilisasi awal sebelum rujukan.

Keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian maternal akibat infeksi. Oleh karena itu, pemantauan tanda vital secara teratur, pengkajian fundus uteri, serta observasi kondisi luka merupakan bagian integral dari asuhan nifas komprehensif.

Bidan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, seperti demam tinggi, bau lokia yang tidak normal, atau kelemahan yang memburuk. Pendekatan yang responsif, sistematis, dan empatik sangat menentukan keberhasilan penanganan dini sepsis puerperalis. Prinsip yang harus dipegang adalah lebih baik melakukan rujukan lebih awal daripada terlambat menangani kondisi kegawatdaruratan pada masa nifas.

F. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang bertujuan untuk menegakkan diagnosis, menilai derajat keparahan, serta memantau respons terapi. Dalam praktik kebidanan, pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi:

1. Pemeriksaan Laboratorium
   a. Hitung darah lengkap (leukositosis/ leukopenia)
   b. CRP atau prokalsitonin sebagai penanda inflamasi
   c. Laktat serum untuk menilai hipoperfusi
   d. Kultur darah dan lokia (bila tersedia)
2. Pemeriksaan Urin
   Untuk menilai fungsi ginjal dan kemungkinan infeksi saluran kemih
3. Pemeriksaan Penunjang Lain
   a. USG uterus untuk mendeteksi sisa plasenta atau abses
   b. Foto toraks (jika ada gangguan pernapasan)

Dalam fasilitas terbatas, penilaian klinis tetap menjadi dasar utama pengambilan keputusan.

G. Komplikasi Sepsis Puerperalis

Sepsis puerperalis yang tidak ditangani secara cepat dan tepat dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan mengancam jiwa. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi antara lain:

1. Syok septik

   Terjadi akibat penurunan tekanan darah yang menetap meskipun telah diberikan cairan, sehingga perfusi jaringan sangat terganggu.
2. Gagal ginjal akut

   Disebabkan oleh hipoperfusi ginjal yang berkepanjangan, ditandai dengan penurunan produksi urin (oliguria).
3. Gangguan pernapasan (ARDS)

   Terjadi akibat inflamasi sistemik yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen di paru-paru.
4. Koagulasi intravaskular diseminata (DIC)

   Gangguan pembekuan darah yang ditandai dengan pembentukan trombus dan perdarahan secara bersamaan.
5. Kegagalan multiorgan

   Melibatkan beberapa organ vital seperti ginjal, paru, hati, dan otak akibat hipoperfusi yang berat.
6. Kematian maternal

   Merupakan komplikasi paling berat apabila penanganan terlambat atau tidak adekuat. Komplikasi tersebut menunjukkan bahwa sepsis puerperalis bersifat progresif dan dapat memburuk dengan cepat, sehingga memerlukan deteksi dini dan intervensi segera.

H. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan sepsis puerperalis dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan tujuan mengatasi infeksi, memperbaiki perfusi jaringan, serta mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Tatalaksana meliputi:

1. Terapi Farmakologis

   Pemberian antibiotik spektrum luas secara empiris harus dilakukan sesegera mungkin setelah sepsis dicurigai, tanpa menunggu hasil kultur. Setelah hasil kultur dan uji sensitivitas tersedia, terapi disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan.

2. Terapi Cairan

   Resusitasi cairan menggunakan kristaloid diberikan untuk meningkatkan volume sirkulasi, memperbaiki tekanan darah, serta mengoptimalkan perfusi jaringan dan organ vital.

3. Terapi Suportif

   Meliputi pemberian oksigen untuk meningkatkan oksigenasi jaringan, pemantauan ketat tanda vital (tekanan darah, nadi, respirasi, suhu), serta dukungan fungsi organ sesuai kebutuhan, seperti pemantauan urin atau rujukan ke perawatan intensif.

4. Penanganan Sumber Infeksi

   Fokus infeksi harus diatasi untuk menghentikan progresivitas penyakit, seperti evakuasi sisa jaringan plasenta, drainase abses, atau perawatan luka yang terinfeksi.

Rujukan

Rujukan harus dilakukan segera pada kondisi berat atau bila fasilitas tidak memadai, setelah dilakukan stabilisasi awal, untuk mendapatkan penanganan definitif di fasilitas yang lebih lengkap.

Penatalaksanaan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, artinya intervensi diberikan tanpa penundaan, sesuai indikasi klinis, serta melibatkan kerja sama tim kesehatan guna menjamin keselamatan ibu.

I. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada sepsis puerperalis dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan manajemen kebidanan. Data yang disajikan berikut merupakan data fokus, yaitu data utama yang relevan untuk mengidentifikasi kegawatan dan menentukan tindakan segera.

1. Pengkajian (Data Fokus)

   Pengkajian difokuskan pada tanda-tanda kegawatan, meliputi:

   a. Tanda vital: suhu, tekanan darah, nadi, frekuensi napas
   b. Keluhan ibu: demam, menggigil, nyeri perut bawah, lemah
   c. Kondisi lokia: berbau, jumlah, warna
   d. Kondisi luka: episiotomi/SC (kemerahan, bengkak, bernanah)
   e. Status kesadaran dan perfusi (CRT, urin)

2. Diagnosis/ Masalah

   Berdasarkan data fokus, masalah yang dapat ditegakkan:

   a. Suspek sepsis puerperalis
   b. Risiko atau tanda syok septik

c. Gangguan perfusi jaringan

3. Perencanaan

   Perencanaan asuhan berfokus pada penyelamatan ibu:

   a. Stabilisasi kondisi (ABCDE)
   b. Pemberian terapi awal
   c. Monitoring ketat
   d. Persiapan rujukan
   e. Edukasi kepada ibu dan keluarga

4. Implementasi

   a. Tindakan Mandiri Bidan
      1) Melakukan penilaian cepat (ABCDE)
      2) Memberikan oksigen
      3) Memasang infus dan memberikan cairan kristaloid
      4) Monitoring tanda vital secara berkala
      5) Menjaga kenyamanan dan posisi ibu
      6) Memberikan dukungan emosional
   b. Tindakan Kolaborasi
      1) Pemberian antibiotik sesuai kewenangan/ kolaborasi
      2) Konsultasi dengan dokter
      3) Persiapan tindakan lanjutan sesuai indikasi
   c. Tindakan Rujukan
      1) Menentukan indikasi rujukan segera
      2) Melakukan stabilisasi sebelum rujukan
      3) Menyiapkan dokumen dan komunikasi rujukan (SBAR)
      4) Mendampingi pasien selama proses rujukan

5. Evaluasi

   Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan:

   a. Respons terhadap terapi (perbaikan tanda vital)
   b. Perubahan kondisi klinis ibu
   c. Tanda perburukan atau komplikasi

Pendekatan asuhan kebidanan ini menekankan pada *continuity of care*, keselamatan pasien, serta respons cepat terhadap kondisi kegawatdaruratan. Bidan memiliki peran penting dalam deteksi dini, stabilisasi awal, dan koordinasi rujukan guna mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

J. Dokumentasi Asuhan Kebidanan

Dokumentasi asuhan kebidanan pada kasus sepsis puerperalis merupakan bagian penting dalam proses pelayanan yang bertujuan untuk mencatat seluruh data klinis, tindakan, serta respons pasien secara sistematis dan berkesinambungan. Penggunaan model SOAP Notes (Subjective, Objective, Assessment, Plan) membantu bidan dalam mengorganisasi informasi secara terstruktur sehingga memudahkan pengambilan keputusan klinis, komunikasi antar tenaga kesehatan, serta mendukung aspek legal dalam praktik. Format ini dapat digunakan di berbagai tingkat pelayanan, baik di TPMB, Puskesmas, maupun Rumah Sakit, dengan penyesuaian sesuai kewenangan. Tabel berikut menyajikan format SOAP Notes yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pencatatan asuhan kebidanan pada kasus sepsis puerperalis.

Tabel 1.1
Format Dokumentasi Asuhan Kebidanan (SOAP Notes)

Komponen	Uraian
S (Subjective)	- Identitas pasien (nama, umur, paritas, hari nifas) - Keluhan utama - Riwayat keluhan (demam, nyeri, menggigil, dll) - Riwayat persalinan - Riwayat kesehatan
O (Objective)	- Keadaan umum - Kesadaran - Tanda vital (TD, N, RR, Suhu) - Kondisi lokia (bau, warna, jumlah) - Kondisi luka (episiotomi/SC) - Pemeriksaan uterus - CRT / urin / tanda perfusi - Pemeriksaan penunjang (jika ada)
A (Assessment)	- Diagnosis kebidanan - Masalah/ diagnosis potensial - Risiko komplikasi
P (Plan)	*Mencakup rencana dan tindakan yang disesuaikan dengan kewenangan dan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.* **Pelayanan Mandiri Bidan (TPMB):** - Deteksi Dini tanda bahaya - Stabilisasi awal (ABCDE sederhana) - Pemberian oksigen - Infu Pemasangan infus dan cairan kristaloid sesuai kewenangan - Monitoring tanda-tanda vital - Edukasi terkait kondisi, dan persiapan rujukan segera.

	Catatan: Fokus utama di TPMB adalah **stabilisasi awal dan rujukan cepat**, bukan penanganan definitif. **Pelayanan di Puskesmas :** - Semua tindakan mandiri bidan - Pemberian antibiotik empiris sesuai protokol - Monitoring lebih intensif - Kolaborasi dengan dokter - Penilaian respons terapi awal - Persiapan rujukan lanjutan bila kondisi tidak stabil **Catatan:** Puskesmas berperan dalam **stabilisasi lanjutan dan terapi awal sebelum rujukan**. **Pelayanan di Rumah Sakit:** - Semua tindakan mandiri bidan - Pemberian antibiotik empiris sesuai protokol - Monitoring lebih intensif - Kolaborasi dengan dokter - Penilaian respons terapi awal - Persiapan rujukan lanjutan bila kondisi tidak stabil **Catatan:** Puskesmas berperan dalam **stabilisasi lanjutan dan terapi awal sebelum rujukan**. **Evaluasi** - Respons terhadap terapi (tanda vital membaik atau tidak) - Perubahan kondisi ibu - Tanda perburukan
Waktu/ Tanggal	- Waktu pengkajian - Waktu tindakan - Waktu rujukan

Kolaborasi dan rujukan merupakan komponen penting dalam penatalaksanaan sepsis puerperalis untuk menjamin keselamatan ibu. Kolaborasi dilakukan melalui konsultasi dengan dokter serta koordinasi tim kesehatan agar terapi dapat disesuaikan dengan kondisi klinis secara tepat. Rujukan harus segera dilakukan bila terdapat tanda kegawatan, dengan tetap memastikan stabilisasi awal terlebih dahulu. Dokumentasi yang lengkap, termasuk SOAP, tindakan, dan waktu terapi, harus disertakan, serta komunikasi rujukan dilakukan secara sistematis menggunakan metode SBAR agar proses transfer pasien berlangsung aman, cepat, dan efektif.

K. Stabilisasi Pra-Rujukan

Stabilisasi pra-rujukan merupakan 22efinit krusial dalam penanganan sepsis puerperalis. Tujuannya adalah mempertahankan kondisi hemodinamik ibu agar tetap stabil selama proses persiapan dan perjalanan menuju fasilitas rujukan yang memiliki kemampuan penatalaksanaan lanjut. Pada kasus sepsis, setiap menit memiliki arti penting karena keterlambatan terapi berhubungan dengan peningkatan risiko disfungsi organ dan kematian (Singer et al., 2016).

1. Pendekatan Stabilisasi

   Pendekatan stabilisasi dilakukan secara sistematis menggunakan prinsip ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure). Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan melakukan penilaian dan intervensi secara cepat, terstruktur, serta berorientasi pada prioritas keselamatan pasien.

   a. Airway (Jalan Napas)

      Penilaian pertama adalah memastikan jalan napas ibu dalam keadaan bebas hambatan. Penurunan kesadaran akibat sepsis berat dapat meningkatkan risiko obstruksi jalan napas. Bila ditemukan gangguan, dilakukan 22efiniti pembebasan jalan napas seperti reposisi kepala atau pemasangan alat bantu sederhana sesuai kompetensi dan kewenangan.

   b. Breathing (Pernapasan)

      Frekuensi napas, pola napas, dan saturasi oksigen harus dinilai segera. Takipnea sering menjadi tanda awal gangguan 22efinitiv akibat hipoperfusi jaringan. Pemberian oksigen melalui kanul nasal atau masker sederhana dianjurkan untuk meningkatkan oksigenasi jaringan, terutama bila saturasi <94% atau terdapat tanda 22efiniti pernapasan.

   c. Circulation (Sirkulasi)

      Komponen ini menjadi 22efin utama pada pasien dengan kecurigaan sepsis. Pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nadi, pengisian kapiler, dan produksi urin memberikan 22efiniti status perfusi. Pada kondisi hipotensi atau tanda hipoperfusi, segera dilakukan pemasangan jalur intravena dengan ukuran yang adekuat.

      Pemberian cairan kristaloid intravena secara cepat bertujuan meningkatkan volume sirkulasi efektif dan memperbaiki perfusi jaringan. Resusitasi cairan harus dilakukan dengan pemantauan ketat terhadap respons hemodinamik pasien.

   d. Disability (Status Neurologis)

      Penilaian tingkat kesadaran penting untuk mendeteksi gangguan perfusi otak. Penurunan kesadaran dapat menjadi tanda perburukan sepsis. Evaluasi dapat dilakukan secara sederhana menggunakan respons terhadap rangsang verbal

dan nyeri. Perubahan status mental harus dicatat dan dikomunikasikan saat rujukan.

e. Exposure (Pemeriksaan Menyeluruh)

Pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk mengidentifikasi sumber infeksi, seperti luka 23efinitive yang bernanah atau tanda peradangan pada uterus. Suhu tubuh diukur secara akurat untuk menilai derajat demam. Selama pemeriksaan, privasi dan kenyamanan ibu tetap dijaga.

2. Tindakan Awal Terapi

Selain pendekatan ABCDE, terdapat beberapa intervensi penting yang harus segera dilakukan sebelum proses rujukan. Pemasangan infus intravena bertujuan untuk memungkinkan pemberian cairan dan terapi obat secara efektif. Pemberian cairan kristaloid dilakukan untuk meningkatkan tekanan darah serta memperbaiki perfusi organ.

Pemberian antibiotik empiris spektrum luas harus dilakukan sedini mungkin setelah sepsis dicurigai. World Health Organization merekomendasikan pemberian antibiotik segera pada kasus infeksi maternal berat tanpa menunggu hasil kultur, karena keterlambatan terapi dapat meningkatkan risiko mortalitas (WHO, 2015). Pemilihan antibiotik disesuaikan dengan pedoman nasional serta pola kuman setempat.

Monitoring ketat terhadap tanda vital, keseimbangan cairan, dan respons terhadap terapi harus dilakukan secara berkala selama proses persiapan rujukan. Dokumentasi yang lengkap mengenai waktu onset gejala, terapi yang telah diberikan, serta respons klinis ibu sangat penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan di fasilitas rujukan.

Stabilisasi pra-rujukan bukan sekadar tindakan teknis, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab profesional bidan dalam memastikan kondisi ibu berada pada tingkat paling aman sebelum mendapatkan penanganan definitif. Kecepatan, ketepatan, serta koordinasi tim menjadi kunci keberhasilan dalam fase kritis ini.

L. Komunikasi Rujukan dalam Kasus Sepsis

1. Pendekatan SBAR

Komunikasi rujukan merupakan bagian integral dari manajemen sepsis puerperalis. Keputusan merujuk tidak hanya membutuhkan pertimbangan klinis yang tepat, tetapi juga penyampaian informasi yang sistematis, jelas, dan akurat kepada fasilitas penerima. Dalam situasi kegawatdaruratan seperti sepsis, komunikasi yang tidak terstruktur dapat menyebabkan keterlambatan penanganan dan meningkatkan risiko komplikasi.

Salah satu metode komunikasi yang direkomendasikan dalam praktik klinis adalah pendekatan SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Metode ini membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi penting secara ringkas, terarah, dan mudah dipahami oleh tim penerima rujukan.

a. Situation (Situasi)

   Pada tahap ini, bidan menyampaikan kondisi terkini pasien secara singkat dan jelas. Informasi mencakup identitas ibu, usia nifas, keluhan utama, serta kondisi vital saat ini. Contohnya, ibu nifas hari ke-5 dengan demam tinggi, takikardia, dan hipotensi yang dicurigai sebagai sepsis.

   Penyampaian situasi harus langsung pada inti masalah sehingga fasilitas rujukan dapat segera mempersiapkan penanganan lanjutan sebelum pasien tiba.

b. Background (Latar Belakang)

   Bagian ini memuat riwayat obstetri dan faktor risiko yang relevan. Informasi dapat meliputi jenis persalinan, lama ketuban pecah, adanya tindakan operatif, riwayat anemia, atau komplikasi selama persalinan. Data mengenai waktu mulai gejala dan perkembangan kondisi juga perlu disampaikan.

   Latar belakang yang komprehensif membantu dokter atau tim di fasilitas rujukan memahami konteks klinis dan mempercepat proses pengambilan keputusan terapeutik.

c. Assessment (Penilaian)

   Pada tahap assessment, bidan menyampaikan hasil pengkajian klinis terkini. Informasi meliputi suhu tubuh, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, tingkat kesadaran, serta temuan lokal seperti lokia berbau atau luka bernanah. Tindakan stabilisasi yang telah dilakukan, misalnya pemberian cairan intravena, oksigen, dan antibiotik empiris, harus dijelaskan secara rinci, termasuk waktu pemberiannya.

   Penilaian yang objektif dan berbasis data akan meningkatkan kepercayaan serta koordinasi antar tenaga kesehatan.

d. Recommendation (Rekomendasi)

   Bagian terakhir berisi tujuan rujukan dan harapan terhadap fasilitas penerima, misalnya permohonan evaluasi lanjutan, perawatan intensif, atau penanganan di unit perawatan intensif maternal. Rekomendasi harus disampaikan secara profesional dan kolaboratif, menegaskan bahwa rujukan dilakukan demi keselamatan ibu.

Pendekatan SBAR terbukti meningkatkan keselamatan pasien melalui komunikasi yang lebih efektif dan terstandar dalam situasi kritis (WHO, 2015).

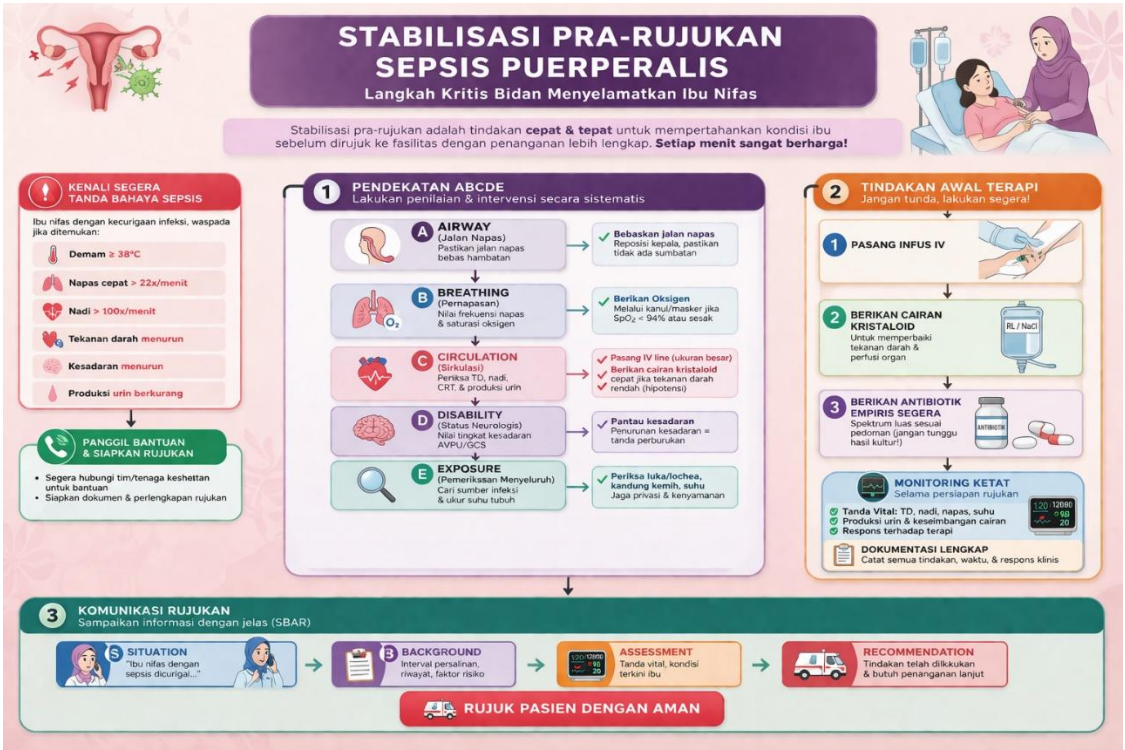
2. Edukasi dan Pendekatan Empatik kepada Keluarga

Selain komunikasi antar tenaga kesehatan, bidan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan penjelasan kepada keluarga. Dalam kasus sepsis, keluarga sering mengalami kecemasan dan ketakutan karena kondisi ibu dapat memburuk secara cepat.

Edukasi harus diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menjelaskan bahwa infeksi telah memengaruhi kondisi tubuh ibu secara menyeluruh dan memerlukan penanganan di fasilitas yang lebih lengkap. Sikap empatik, kontak mata yang hangat, serta kesempatan bagi keluarga untuk bertanya akan membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kepanikan.

Komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi medis, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan dukungan emosional. Dalam konteks kebidanan, pendekatan humanis ini merupakan bagian dari asuhan komprehensif yang menghargai martabat ibu dan keluarganya.

Dengan komunikasi rujukan yang sistematis melalui SBAR serta edukasi yang empatik, proses transfer pasien dapat berlangsung lebih aman, cepat, dan terkoordinasi, sehingga peluang keselamatan ibu semakin meningkat.



Gambar 1.2
Stabilisasi Pra-Rujukan Sepsis Puerperalis

M. Latihan Soal

Soal

1. Seorang ibu nifas hari ke-4 datang dengan keluhan demam 38,5°C, lokia berbau, dan nyeri perut bawah. Pemeriksaan menunjukkan nadi 110x/menit dan RR 26x/menit. Tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah:
   A. Memberikan analgesik dan observasi
   B. Menunggu hasil laboratorium
   C. Melakukan stabilisasi awal dan persiapan rujukan
   D. Memberikan vitamin dan edukasi
   E. Menyarankan istirahat di rumah

2. Seorang ibu nifas dengan kecurigaan sepsis mengalami penurunan kesadaran. Bidan menemukan jalan napas tidak optimal. Tindakan prioritas berdasarkan prinsip ABCDE adalah:
   A. Memberikan antibiotik segera
   B. Mengukur tekanan darah
   C. Membebaskan jalan napas
   D. Memberikan cairan infus
   E. Melakukan rujukan langsung

3. Ibu nifas hari ke-5 mengalami takipnea dan saturasi oksigen 90%. Intervensi yang paling tepat pada tahap Breathing adalah:
   A. Memberikan cairan kristaloid
   B. Memberikan oksigen
   C. Memberikan antibiotic
   D. Memasang kateter urin
   E. Mengukur suhu tubuh

4. Seorang ibu nifas mengalami hipotensi (TD 80/50 mmHg) dan pengisian kapiler memanjang. Tindakan yang paling tepat pada aspek Circulation adalah:
   A. Memberikan analgesic
   B. Mengobservasi tanpa tindakan
   C. Memasang infus dan resusitasi cairan
   D. Memberikan edukasi keluarga
   E. Memberikan oksigen saja

5. Seorang ibu nifas menunjukkan penurunan kesadaran dan tampak gelisah. Interpretasi klinis yang paling tepat adalah:
   A. Kondisi normal masa nifas
   B. Tanda anemia ringan
   C. Tanda gangguan perfusi otak akibat sepsis
   D. Efek kelelahan pasca persalinan
   E. Reaksi psikologis

6. Seorang ibu nifas dengan sepsis telah diberikan cairan infus. Bidan akan melanjutkan tindakan awal terapi sebelum rujukan. Tindakan berikutnya yang paling tepat adalah:
   A. Menunggu hasil kultur
   B. Memberikan antibiotik empiris segera
   C. Memberikan suplemen zat besi
   D. Menghentikan terapi cairan
   E. Menunda tindakan hingga rujukan

7. Dalam komunikasi rujukan metode SBAR, bidan menyampaikan kondisi ibu nifas saat ini: demam, hipotensi, dan takikardia. Informasi tersebut termasuk dalam komponen:
   A. Background
   B. Assessment
   C. Recommendation
   D. Situation
   E. Evaluation

8. Seorang ibu nifas dirujuk dengan informasi riwayat persalinan lama dan ketuban pecah >18 jam. Informasi tersebut termasuk dalam komponen SBAR:
   A. Situation
   B. Background
   C. Assessment
   D. Recommendation
   E. Planning

9. Seorang ibu nifas menunjukkan tanda berikut: lokia berbau, demam, takikardia, dan hipotensi. Analisis kondisi tersebut menunjukkan:
   A. Infeksi lokal ringan
   B. Kondisi fisiologis nifas
   C. Sepsis dengan tanda sistemik
   D. Gangguan psikologis

E. Dehidrasi ringan

10. Seorang bidan telah melakukan stabilisasi, memberikan cairan dan antibiotik, serta mencatat semua tindakan. Langkah selanjutnya yang paling tepat adalah:
    A. Menghentikan penanganan
    B. Menunggu kondisi membaik
    C. Melakukan komunikasi rujukan dan merujuk pasien
    D. Memberikan edukasi saja
    E. Memulangkan pasien

N. Kunci Jawaban

1. C
2. C
3. B
4. C
5. C
6. B
7. D
8. B
9. C
10. C

O. Minicase (Diskusi Kelompok)

Kasus 1: Demam Tinggi pada Ibu Nifas Hari ke-3

Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, postpartum hari ke-3, datang ke Puskesmas dengan keluhan demam tinggi sejak 2 hari yang lalu. Perempuan tersebut mengeluh nyeri perut bagian bawah, badan lemas, serta keluar cairan berbau tidak sedap dari jalan lahir. Persalinan sebelumnya berlangsung di rumah dengan bantuan dukun, tanpa prosedur steril yang adekuat.

Hasil pemeriksaan:

1. Kesadaran: compos mentis
2. Tekanan darah: 90/60 mmHg
3. Nadi: 112 x/menit
4. Suhu: 39°C
5. Frekuensi napas: 26 x/menit
6. Uterus teraba lembek dan nyeri tekan
7. Lokia berbau menyengat

Panduan Diskusi

Diskusikan kasus di atas dalam kelompok kecil (4–6 orang), kemudian jawab pertanyaan berikut:

1. Apa diagnosis kerja yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jelaskan alasan klinisnya.
2. Identifikasi tanda bahaya yang ditemukan pada ibu tersebut.
3. Faktor risiko apa saja yang berkontribusi terhadap kondisi ini?
4. Bagaimana patofisiologi terjadinya kondisi pada kasus ini secara singkat?
5. Tindakan stabilisasi pra-rujukan apa saja yang harus segera dilakukan?
6. Bagaimana langkah komunikasi rujukan yang efektif pada kasus ini?
7. Sikap empatik apa yang perlu ditunjukkan bidan kepada ibu dan keluarga?

Kasus 2: Syok Septik pada Masa Nifas

Seorang perempuan umur 32 tahun, P3A0, postpartum hari ke-5, dirujuk dari klinik ke rumah sakit dengan kondisi penurunan kesadaran. Riwayat persalinan spontan di fasilitas kesehatan, namun ibu mengalami demam sejak hari ke-2 postpartum dan tidak segera mendapatkan penanganan optimal.

Hasil pemeriksaan:

1. Kesadaran: apatis
2. Tekanan darah: 80/50 mmHg
3. Nadi: 130 x/menit, lemah
4. Suhu: 39,5°C
5. Frekuensi napas: 30 x/menit
6. Produksi urin menurun (<30 ml/jam)

Panduan Diskusi

1. Apa kondisi kegawatan yang dialami ibu?
2. Jelaskan perbedaan antara sepsis dan syok septik pada kasus ini.
3. Apa saja tanda-tanda syok yang terlihat?
4. Bagaimana prioritas tindakan bidan pada kondisi ini?
5. Apa saja kesalahan atau keterlambatan yang mungkin terjadi pada kasus sebelumnya?
6. Bagaimana strategi pencegahan agar kasus serupa tidak terulang?

Petunjuk Pelaksanaan Diskusi

1. Setiap kelompok menunjuk satu fasilitator dan satu notulis.
2. Diskusi dilakukan selama 30–45 menit.
3. Hasil diskusi dipresentasikan secara singkat (5–10 menit per kelompok).
4. Kelompok lain memberikan tanggapan dan klarifikasi.
5. Dosen/fasilitator memberikan penguatan dan umpan balik.

Refleksi Pembelajaran

Setelah diskusi, peserta didik diharapkan melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut secara individu:

1. Apa hal baru yang Anda pelajari dari kasus ini?
2. Bagian mana yang masih Anda anggap sulit dipahami?
3. Bagaimana Anda akan menerapkan pengetahuan ini dalam praktik klinik?

Catatan untuk Pengajar

Minicase ini dirancang untuk melatih kemampuan analisis klinis, pengambilan keputusan cepat, serta komunikasi dalam situasi kegawatdaruratan maternal. Fasilitator diharapkan mengarahkan diskusi agar tetap berbasis bukti dan kontekstual dengan praktik pelayanan kebidanan di lapangan.

Soal OSCE dan Rubrik Penilaian

1. Praktik/ Simulasi Stabilisasi Pra-Rujukan
   a. Skenario OSCE

      Seorang perempuan umur 31 tahun, P1A0, nifas hari ke-3, datang ke Puskesmas dengan keluhan demam tinggi, nyeri perut bawah, dan lokia berbau. Hasil pemeriksaan menunjukkan:

      1) TD: 90/60 mmHg
      2) Nadi: 112 x/menit
      3) RR: 26 x/menit
      4) Suhu: 39°C

      Peserta didik diminta untuk melakukan stabilisasi pra-rujukan pada pasien dengan dugaan sepsis puerperalis.

   b. Instruksi untuk Peserta

      Lakukan penatalaksanaan awal (stabilisasi pra-rujukan) secara sistematis pada pasien sesuai standar pelayanan kebidanan. Anda memiliki waktu 10 menit.

c. Rubrik Penilaian

No	Komponen yang Dinilai	Kriteria Penilaian	Skor
1	Persiapan tindakan	Mencuci tangan, menggunakan APD, menjelaskan tindakan	0–2
2	Penilaian awal (ABCDE)	Melakukan penilaian airway, breathing, circulation secara sistematis	0–4
3	Pemasangan infus	Teknik aseptik, pemilihan jalur IV tepat	0–3
4	Pemberian cairan	Memberikan cairan kristaloid dengan indikasi tepat	0–3
5	Pemberian antibiotik	Menyebutkan/menyiapkan antibiotik empiris spektrum luas	0–3
6	Monitoring	Memantau tanda vital dan kondisi umum pasien	0–3
7	Dokumentasi	Menyampaikan pentingnya pencatatan tindakan	0–2
8	Persiapan rujukan	Menjelaskan kesiapan pasien sebelum dirujuk	0–2

Total Skor: 22

Kategori Penilaian:

- 18–22 = Kompeten
- 14–17 = Cukup kompeten
- <14 = Belum kompeten

Simulasi Komunikasi Rujukan

1. Skenario OSCE

   Peserta didik diminta melakukan komunikasi rujukan kepada rumah sakit menggunakan metode terstruktur untuk pasien dengan dugaan sepsis puerperalis yang telah distabilisasi.

2. Instruksi untuk Peserta

   Lakukan komunikasi rujukan kepada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi menggunakan metode yang efektif dan profesional. Waktu: 7 menit.

Penerapan DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) merupakan metode penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap keterampilan klinis peserta didik saat melakukan prosedur pada pasien nyata atau simulasi. Metode ini memungkinkan penilai (dosen atau preseptor klinik) untuk mengevaluasi kemampuan teknis, pengambilan keputusan klinis, serta sikap profesional peserta didik secara komprehensif.

Dalam konteks asuhan kebidanan, DOPS menjadi alat penting untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan secara aman, efektif, dan sesuai standar pelayanan.

Penerapan DOPS dalam pembelajaran bertujuan untuk:

1. Menilai keterampilan prosedural peserta didik secara langsung dan objektif.
2. Meningkatkan kemampuan klinis melalui umpan balik segera (*immediate feedback*).
3. Mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki.
4. Menjamin keselamatan pasien melalui praktik yang sesuai standar.
5. Mendorong pembelajaran reflektif dan berkelanjutan.

Pada bab ini, DOPS difokuskan pada keterampilan:

1. Stabilisasi pra-rujukan pada kasus sepsis puerperalis.
2. Pemasangan infus intravena.
3. Pemberian terapi cairan awal.
4. Pemberian antibiotik empiris.
5. Monitoring kondisi pasien.
6. Dokumentasi tindakan klinis.
7. Komunikasi rujukan secara efektif.

Skenario DOPS

Peserta didik melakukan tindakan pada pasien nifas dengan dugaan sepsis puerperalis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Penilai mengamati secara langsung seluruh proses tindakan mulai dari pengkajian hingga persiapan rujukan.

Prosedur Pelaksanaan DOPS

1. Peserta didik diberi penjelasan mengenai prosedur yang akan dinilai.
2. Penilai mengamati tindakan peserta didik secara langsung di lahan praktik atau laboratorium keterampilan.
3. Penilaian dilakukan menggunakan checklist yang telah disiapkan.
4. Setelah tindakan selesai, penilai memberikan umpan balik secara langsung dan konstruktif.
5. Peserta didik melakukan refleksi terhadap performa yang telah dilakukan.

Umpan Balik (*Feedback*)

Umpan balik dalam DOPS harus:

1. Spesifik (menyebutkan aspek yang dinilai)
2. Objektif (berdasarkan observasi)
3. Konstruktif (memberikan saran perbaikan)
4. Tepat waktu (segera setelah tindakan)

Contoh: Teknik pemasangan infus Anda sudah baik dan aseptik, namun perlu meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan terkait pemberian cairan.

Refleksi Peserta didik

Setelah pelaksanaan DOPS, peserta didik diminta menjawab:

1. Apa yang sudah saya lakukan dengan baik?
2. Apa yang perlu saya perbaiki?
3. Bagaimana rencana saya untuk meningkatkan keterampilan tersebut?

Catatan untuk Pengajar

1. Pastikan lingkungan aman bagi pasien dan peserta didik
2. Gunakan pendekatan pembelajaran suportif, bukan menghakimi
3. Fokus pada peningkatan kompetensi, bukan sekadar penilaian angka
4. Integrasikan DOPS dengan metode pembelajaran lain seperti OSCE dan diskusi kasus

DOPS merupakan metode yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dalam konteks kegawatdaruratan maternal seperti sepsis puerperalis, keterampilan yang dinilai melalui DOPS dapat berkontribusi langsung terhadap keselamatan ibu.

P. Ringkasan Materi

Sepsis puerperalis merupakan infeksi pada masa nifas yang berpotensi berkembang menjadi kegawatdaruratan apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Kondisi ini umumnya terjadi akibat masuknya mikroorganisme ke dalam saluran genital setelah persalinan, terutama pada praktik yang tidak memenuhi prinsip asepsis. Faktor risiko meliputi persalinan tidak steril, ketuban pecah dini, anemia, serta keterlambatan deteksi dan penanganan. Secara patofisiologis, infeksi lokal dapat berkembang menjadi respons inflamasi sistemik yang ditandai dengan demam, takikardia, takipnea, dan gangguan perfusi organ. Oleh karena itu, pengenalan tanda bahaya seperti demam tinggi, nadi cepat, pernapasan meningkat, nyeri abdomen, lokia berbau, hipotensi, dan penurunan kesadaran menjadi sangat penting.

Penatalaksanaan awal menekankan prinsip deteksi dini, stabilisasi, dan rujukan cepat. Pendekatan dilakukan secara sistematis menggunakan prinsip ABCDE, dilanjutkan dengan stabilisasi pra-rujukan berupa pemasangan akses intravena, pemberian cairan kristaloid, antibiotik empiris spektrum luas, serta monitoring ketat kondisi ibu. Dokumentasi yang lengkap dan akurat juga menjadi bagian penting dalam kesinambungan pelayanan. Selain itu, komunikasi rujukan yang efektif menggunakan metode SBAR diperlukan untuk memastikan informasi klinis tersampaikan dengan jelas kepada fasilitas rujukan. Dalam praktiknya, bidan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis, tetapi juga sikap profesional dan empatik dalam memberikan asuhan. Dengan demikian, keberhasilan penanganan sepsis puerperalis sangat ditentukan oleh ketepatan tindakan awal, kualitas komunikasi, serta peran aktif bidan dalam menjaga keselamatan ibu.

Q. *Red flag*

Red flag pada sepsis puerperalis merupakan tanda bahaya yang menunjukkan kondisi ibu nifas berada dalam situasi kegawatdaruratan dan memerlukan penanganan segera serta rujukan tanpa penundaan. Tanda-tanda tersebut meliputi demam tinggi ≥38°C yang menetap, nadi cepat (>100 x/menit), pernapasan cepat (>24 x/menit), tekanan darah rendah (hipotensi), penurunan kesadaran, serta produksi urin yang menurun. Selain itu, adanya lokia berbau busuk, nyeri abdomen hebat, dan kondisi umum yang semakin memburuk juga menjadi indikator penting terjadinya infeksi berat.

Kondisi *red flag* ini mengarah pada kemungkinan perkembangan sepsis menjadi syok septik, yang ditandai dengan gangguan perfusi organ dan risiko kematian yang tinggi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan, harus mampu mengenali tanda-tanda tersebut secara cepat, melakukan stabilisasi awal

sesuai kewenangan, serta segera melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Keterlambatan dalam mengenali dan menangani red flag dapat berdampak fatal terhadap keselamatan ibu.

R. Glosarium

ABCDE : *Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*; pendekatan sistematis untuk penilaian awal kondisi kegawatdaruratan pasien.

PUS : Pasangan Usia Subur; pasangan suami istri dengan rentang usia reproduksi (±15–49 tahun).

SC (Sectio Caesarea) : Prosedur persalinan melalui pembedahan dengan membuat insisi pada dinding abdomen dan uterus.

WHO (World Health Organization) : Organisasi kesehatan dunia yang menetapkan standar dan pedoman kesehatan global.

SBAR : *Situation, Background, Assessment, Recommendation*; metode komunikasi terstruktur dalam pelayanan kesehatan.

MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Score) : Sistem skor untuk mendeteksi dini kondisi kegawatan pada pasien obstetri berdasarkan parameter klinis.

Sepsis : Respons sistemik tubuh terhadap infeksi yang dapat menyebabkan disfungsi organ.

Sepsis puerperalis : Infeksi pada masa nifas yang disertai tanda-tanda sistemik dan berpotensi berkembang menjadi kondisi berat.

Syok septik : Kondisi lanjutan dari sepsis yang ditandai dengan hipotensi persisten dan gangguan perfusi organ meskipun telah diberikan terapi cairan.

Nifas (Puerperium) : Masa setelah persalinan hingga ±6 minggu, di mana organ reproduksi kembali ke keadaan sebelum hamil.

Lokia : Cairan yang keluar dari uterus melalui vagina setelah persalinan, terdiri dari darah, lendir, dan jaringan sisa kehamilan.

Antibiotik empiris : Pemberian antibiotik berdasarkan dugaan klinis sebelum hasil pemeriksaan kultur diketahui.

Stabilisasi pra-rujukan : Tindakan awal untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap.

Triase : Proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan untuk menentukan prioritas penanganan.

Perfusi : Proses aliran darah ke jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi.

Hipotensi : Kondisi tekanan darah lebih rendah dari normal yang dapat mengganggu perfusi organ.

Takikardia : Peningkatan frekuensi denyut jantung di atas normal (>100 x/menit pada dewasa).

Takipnea : Peningkatan frekuensi pernapasan di atas normal (>20–24 x/menit pada dewasa).

Asepsis : Upaya mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh untuk menghindari infeksi.

Endometritis : Peradangan pada lapisan dalam uterus (endometrium), sering menjadi penyebab sepsis puerperalis.

S. Referensi

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2018). *Williams obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill Education.

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. Kementerian Kesehatan RI.

Singer, M., Deutschman, C. S., Seymour, C. W., et al. (2016). The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). *JAMA, 315*(8), 801–810.

World Health Organization. (2015). *WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections*. World Health Organization.

World Health Organization. (2017). *WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections*. World Health Organization.

World Health Organization. (2019). *Trends in maternal mortality 2000–2017*. World Health Organization.

BAB 2

GANGGUAN LAKTASI: BENDUNGAN ASI, PUTING LECET, DAN TEKNIK KOREKSI MENYUSUI

CPL

Kode	Ranah	Rumusan CPL
CPL-1	Sikap	Mampu menunjukkan sikap profesional, etis, empatik, bertanggung jawab, serta menghormati privasi dan martabat ibu dalam pemberian asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui.
CPL-2	Pengetahuan	Mampu menguasai konsep teoretis mengenai fisiologi laktasi, gangguan laktasi, perawatan payudara, serta prinsip menyusui yang benar.
CPL-3	Keterampilan Umum	Mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan informasi serta edukasi kepada ibu dan keluarga sesuai kebutuhan dan tingkat pemahamannya.
CPL-4	Keterampilan Khusus	Mampu melakukan pengkajian, pemeriksaan terfokus, perumusan diagnosis atau masalah, penatalaksanaan awal, serta evaluasi asuhan kebidanan pada ibu nifas yang mengalami gangguan laktasi sesuai kewenangan bidan.

CPMK

Kode	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fisiologi laktasi serta pengertian gangguan laktasi pada ibu nifas secara tepat.
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan penyebab, faktor risiko, tanda, dan gejala bendungan ASI serta puting lecet.
CPMK-3	Mahasiswa mampu membedakan kondisi payudara penuh, bendungan ASI, puting lecet, dan gangguan laktasi lainnya berdasarkan hasil pengkajian.
CPMK-4	Mahasiswa mampu melakukan anamnesis terarah pada ibu nifas yang mengalami nyeri, pembengkakan payudara, kesulitan menyusui, atau puting lecet.
CPMK-5	Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan payudara secara terfokus, sistematis, aman, serta menjaga kenyamanan dan privasi ibu.
CPMK-6	Mahasiswa mampu menganalisis data subjektif dan objektif untuk menetapkan diagnosis atau masalah kebidanan pada ibu dengan gangguan laktasi.
CPMK-7	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penatalaksanaan awal bendungan ASI, meliputi kompres hangat sebelum menyusui, pengeluaran sebagian ASI, pengosongan payudara secara efektif, dan kompres dingin setelah menyusui.
CPMK-8	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik menyusui yang benar, meliputi posisi ibu, posisi bayi, perlekatan, cara melepas isapan, serta menyendawakan bayi.
CPMK-9	Mahasiswa mampu melakukan koreksi posisi dan perlekatan menyusui pada ibu yang mengalami kesulitan menyusui atau puting lecet.
CPMK-10	Mahasiswa mampu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai frekuensi menyusui, perawatan payudara dan puting, pencegahan bendungan ASI, serta tanda bahaya yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
CPMK-11	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan kebidanan pada kasus gangguan laktasi melalui simulasi atau OSCE secara sistematis, aman, dan profesional.

Keterkaitan CPL dan CPMK

CPMK	CPL yang Didukung
CPMK-1	CPL-2
CPMK-2	CPL-2
CPMK-3	CPL-2, CPL-4
CPMK-4	CPL-3, CPL-4
CPMK-5	CPL-1, CPL-4
CPMK-6	CPL-2, CPL-4
CPMK-7	CPL-1, CPL-4
CPMK-8	CPL-3, CPL-4
CPMK-9	CPL-3, CPL-4
CPMK-10	CPL-1, CPL-3
CPMK-11	CPL-1, CPL-3, CPL-4

Uraian Materi

A. Pengertian Bendungan ASI

Bendungan ASI adalah peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk laktasi. Hal ini bukan disebabkan overdistensi dari Saluran Sistem laktasi. Bendungan terjadi akibat bendungan berlebihan pada limfatik dan vena Sebelum laktasi (Walyani & Purwoastuti, 2022).

Bendungan Air Susu Ibu adalah terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri di sertai kenaikan suhu badan (Maryunani, 2015). Bendungan ASI dapat terjadi karena adanya penyempitan duktus laktiferus pada payudara ibu dan dapat terjadi apabila ibu memiliki kelainan puting susu misalnya puting susu datar, terbenam dan cekung. Kejadian ini biasanya disebabkan karena air susu yang terkumpul tidak segera dikeluarkan sehingga menjadi sumbatan.

Gejala yang sering muncul pada saat terjadi bendungan ASI antara lain payudara bengkak, payudara terasa panas dan keras, payudara terasa nyeri saat di tekan, payudara berwarna kemerahan dan suhu tubuh ibu sampai 380C. Bendungan ASI tersebut dapat dicegah dengan cara perawatan payudara yang dilakukan oleh ibu itu sendiri (Jannah, 2019).

Untuk mencegah terjadinya bendungan ASI yaitu pada saat antenatal, dimana ibu diberikan penyuluhan tentang perawatan payudara pada saat trimester II dan III, perawatan pada ibu hamil sampai dengan saat menyusui perlu dilakukan.

B. Faktor yang dapat menyebabkan bendungan ASI, yaitu

1. Pengosongan mammae yang tidak sempurna (dalam masa laktasi, terjadi peningkatan produksi ASI pada ibu yang produksi ASI-nya berlebihan. Apabila bayi sudah kenyang dan selesai menyusu payudara tidak dikosongkan, makamasih terdapat sisa ASI didalam payudara. Sisa ASI tersebut jika tidak dikeluarkan dapat menimbulkan bendungan ASI).
2. Faktor hisapan bayi yang tidak aktif (pada masa laktasi, bila ibu tidakmenyusukan bayinya sesering mungkin atau jika bayi tidak aktif menghisap, maka akan menimbulkan bendungan ASI).
3. Faktor posisi menyusui bayi yang tidak benar (teknik yang salah dalam menyusui dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet dan menimbulkan rasa nyeri pada saat bayi menyusu. Akibatnya, ibu tidak mau menyusui bayinya dan terjadi bendungan ASI).
4. Puting susu terbenam (puting susu terbenam akan menyulitkan bayi dalam menyusu. Karena bayi tidak dapat menghisap puting dan areola, bayi tidak maumenyusu dan akibatnya terjadi bendungan ASI).

5. Puting susu terlalu panjang (puting susu yang panjang menimbulkan kesulitan pada saat bayi menyusu karena bayi tidak dapat menghisap areola dan merangsang sinus laktiferus untuk mengeluarkan ASI. Akibatnya, ASI tertahan dan menimbulkan bendungan ASI.

C. Tanda dan gejala bendungan ASI

Tanda dan gejala bendungan ASI antara lain dengan ditandainya dengan pembengkakan payudara bilateral dan secara palpasi keras, kadang terasa nyeri serta seringkali disertai peningkatan suhu tubuh ibu, tetapi tidak dapat tanda kemerahan dan demam (Prawiroharjo, 2020).

Payudara yang mengalami pembengkakan tersebut sangat sukar disusu oleh bayi karena kalang payudara lebih menonjol, puting lebih datar dan sukar di hisap oleh bayi. Bila keadaan sudah demikian, kulit pada payudara nampak lebih mengkilat, ibu merasa demam dan payudara ibu terasa nyeri. Oleh karna itu sebelum disusukan pada bayi, ASI harus diperas dengan tangan atau pompa terlebih dahulu agar payudara lebih lunak, sehingga bayi lebih mudah menyusu (Mansyur, 2014).

Perlu dibedakan antara payudara bengkak dengan payudara penuh. Pada payudara bengkak: payudara oedem, sakit, puting susu kencang, kulit mengkilat walau tidak merah, dan ASI tidak keluar kemudian badan menjadi demam setelah 24 jam. Sedangkan pada payudara penuh: payudara terasa berat, panas dan keras. Bila ASI dikeluarkan tidak ada demam (Marmi, 2015).

D. Penatalaksanaan bendungan ASI

Penatalaksanaan Kasus pada ibu nifas dengan bendungan ASI adalah:

1. Cara menyusui yang baik dan benar

   Menurut (Munir & Fitria, 2023), cara menyusui yang baik dan benar adalah sebagai berikut:

   a. Sebelum menyusui, keluarkan sedikit ASI untuk mengolesi puting ibu agar bayi mencium aromanya dan lebih berselera menyusu.
   b. Susui bayi setiap kali ia menginginkannya dan selama yang ia mau.
   c. Saat menyusui, letakan bayi dalam pangkuan sedemikian rupa hingga wajah dan tubuhnya menghadap ke payudara ibu. Posisinya harus lurus searah dari telinga, hidung, dan badannya. Dagunya menempel di payudara ibu.
   d. Duduklah dalam posisi yang nyaman dan tegak, jangan membungkuk, kalau perlu sangga tubuh bayi dengan bantal. Ibu yang baru saja menjalani persalinan dengan operasi sesar tak perlu khawatir karena posisi bayi berada di atas perut.
   e. Jika paudara menyusu pada payudra kiri, letakkan kepalanya di siku lengan kiri ibu. Lengan kiri bayi bebas ke arah payudara. Begitu pula sebalikya.
   f. Topanglah payudara dengan meletakan ibu jari tangan ibu diatas puting dan keempat jari menyangga payudara.
   g. Usai menyusui, bayi akan melepaskan isapannya. Kalau tidak lepaskan puting dengan memasukan jari kelingking ibu ke mulut bayi melalui sudut mulut atau tekan dagu bayi agar bibir bawahnya terbuka. Jangan langsung menarik puting terlalu kuat selagi masih berada didalam mulut bayi karena akan membuatnya lecet.
   h. Bila puting lecet, lakukan kompres dingin di payudara dan tetaplah menyusui bayi. Usai menyusui, usapkan tetesan ASI untuk pelumasan dan pelindungan. Jika menggunakan obat dokter, seka puting dengan air atau waslap basah yang lembut setiap kali menyusui.

2. Perawatan Payudara

   Perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara terutama pada masa nifas (masa menyusui) untuk memperlancar pengeluaran ASI. Perawatan payudara adalah perawatan payudara setelah melahirkan dan menyusui yang merupakan suatu cara yang dilakukan untuk merawat payudara agar air susu keluar dengan lancar. Perawatan payudara sangat penting dilakukan selama hamil sampai masa menyusui (Fatmawati dkk., 2019).

   a. Tujuan perawatan payudara
      1) Untuk menjaga kebersihan payudara sehingga terhindar dari infeksi.
      2) Untuk mengenyalkan puting susu, supaya tidak mudah lecet.

3) Untuk menonjolkan puting susu yang terbenam.
4) Menjaga bentuk buah dada tetap bagus.
5) Untuk mencegah terjadinya penyumbatan.
6) Untuk memperbanyak produksi ASI.
7) Untuk mengetahui adanya kelainan.

Dampak bendungan ASI yaitu statis pada pembuluh limfe akan mengakibatkan tekanan intraduktal yang akan mempengaruhi berbagai segmen pada payudara, sehingga tekanan seluruh payudara meningkat, akibatnya payudara sering terasa penuh, tegang, dan nyeri walaupun tidak disertai dengan demam. Pada ibu yang mengalami bendungan ASI

3. Puting Lecet

a. Pengertian puting lecet

Puting susu yang sakit adalah cedera yang ditandai dengan luka, retakan, atau celah pada puting, salah satu masalah yang sering dialami oleh ibu menyusui dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan hingga penghentian menyusui dini (Wirakhmi & Purnawan, 2021).

Nipple crack adalah suatu trauma pada putting susu yang ditandai dengan adanya luka lecet atau retak atau retak bahkan sampai berdarah pada putting. Jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi mastitis jika terjadi infeksi oleh bakteri Stapyhylococus aureus.

b. Penyebab puting lecet

Kurangnya pemahaman tentang posisi menyusui dan perlekatan terbuktiberkontribusi pada kejadian putting lecet, rasa nyeri saat menyusui, dan rendahnya angka keberhasilan menyusui (Ayu & Novita, 2026).

Posisi menyusui yang baik pada dasarnya ditentukan oleh posisi ibu. tingkat kenyamanan dan relaksasi sebelum melahirkan (Mayangsari et al., 2021). Puting lecet sering terjadi pada ibu menyusui dan sering disebabkan oleh teknik menyusui yang tidak tepat, seperti bayi tidak menyusu sampai payudara atau melepaskan isapan yang salah, yang tidak berlangsung cukup lama untuk mengosongkan payudara sepenuhnya, sehingga puting lecet mengakibatkan trauma dan rasa sakit bagi ibu (Wahyuni et al., 2021).

Moniliasis pada mulut bayi yang menular pada putting susu ibu, akibat dari pemakaian sabun, alcohol, krim, atau zatiritan lainnya untuk mencuci putting susu, dapat terjadi pada bayi dengan tali lidah (frenulum lingue) yang pendek, sehingga penyebabkan bayi sulit menghisap sampai kalang payudara dan hisapan hanya pada putting saja, melepas penghisapan yang salah.

c. Cara mengatasi putting lecet
   1) Memperhatikan teknik menyusui.
   2) Memeriksakan bayi untuk memastikan bayi tidak menderita monialisis, jika ditemukan.
   3) Perawatan payudara yang benar yaitu tidak membersihkan putting dengan sabun, alcohol atau lainnya. Pada putting susu dibubuhkan minyak kelapa yang sudah dimasak terlebih dahulu.
   4) Menyusui lebih sering (8-12 kali dalam 24 jam) sehingga payudara tidak sampai terlalu penuh.
   5) Perawatan putting susu lecet bisa diistirahatkan sedikitnya selama 24 jam.
   6) Putting susu lecet bisa diobati dengan menggunakan salep levertran.
   7) Jika perlu pada meneteki mempergunakan alat pelindung putting susu.

d. Cara mencegah putting susu lecet

   Dengan cara menyusui yang benar. Ciri-ciri bayi telah menyusui dengan benar adalah..
   1) Bayi tampak tenang.
   2) Badan bayi menempel pada perut ibu.
   3) Mulut bayi terbuka lebar.
   4) Dagu menempel pada payudara ibu.
   5) Sebagian besar payudara masuk ke dalam mulut bayi.
   6) Bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan.
   7) Putting susu ibu tidak terasa nyeri
   8) Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus.
   9) Kepala tidak menengadah.

E. Teknik koreksi menyusui

1. Pengertian Teknik Menyusui Yang Benar Teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan asi kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar .
2. Persiapan memperlancar pengeluaran ASI dilaksanakan dengan jalan membersihkan puting susu dengan air atau minyak, sehingga epitel yang lepas tidak menumpuk. Puting susu ditariktarik setiap mandi, sehingga menonjol untuk memudahkan isapan bayi. Bila puting susu belum menonjol dapat memakai pompa susu atau dengan jalan operasi.

3. Langkah-langkah menyusui yang benar.
   a. Ibu mencucui tangan sebelum menyusui bayinya.
   b. Ibu duduk dengan santai dan nyaman, posisi punggung tegak sejajar punggung kursi dan kaki diberi alas sehingga tidak menggantung.
   c. Mengeluarkan sedikit ASI dan mengoleskan pada puting susu dan aerola sekitarnya.
   d. Bayi dipegang dengan satu lengan, kepala terletak pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan.
   e. Ibu menempelkan perut bayi pada perut ibu dengan meletakkan satu tangan bayi di belakang ibu dan yang satu di depan, kepala bayi menghadap ke payudara.
   f. Ibu memposisikan bayi dengan telinga dan lengan pada garis lurus.
   g. Ibu memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah serta tidak menekan puting susu atau areola.
   h. Ibu menyentuhkan puting susu pada bagian sudut mulut bayi sebelum menyusui.
   i. Setelah bayi mulai menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau disangga lagi.
   j. Ibu menatap bayi saat menyusui.
4. Pasca Menyusui Melepas isapan bayi dengan cara jari kelingking di masukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut bayi atau dagu bayi ditekan ke bawah. Setelah bayi selesai menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan aerola, biarkan kering dengan sendirinya. Menyendawakan bayi dengan bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu kemudian punggung ditepuk perlahan-lahan atau bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggungnya di tepuk perlahan-lahan. Menganjurkan ibu agar menyusui bayinya setiap saat bayi menginginkan (*on demand*).
5. Lama dan frekuensi menyusui Menyusui bayi tidak perlu dijadwal, sehingga tindakan menyusui bayi dilakukan setiap saat bayi membutuhkan. ASI dalam lambung bayi kosong dalam 2 jam. Bayi yang sehat akan menyusu dan mengogongkan payudara selama 5-7 menit.
6. Tanda-tanda posisi bayi menyusui yang benar Tubuh bagian depan bayi menempel pada tubuh ibu. Dagu bayi menempel pada payudara ibu. Dada bayi menempel pada dada ibu yang berada di dasar payudara (payudara bagian bawah). Telinga bayi berada dalam satu garis dengan leher dan lengan bayi. Mulut bayi terbuka lebar dengan bibir bawah yang terbuka. Sebagian besar areola tidak tampak. Bayi menghisap dalam dan perlahan. Bayi puas dan tenang

pada akhir menyusu. Terkadang terdengar suara bayi menelan. Puting susu tidak terasa sakit atau lecet.

Contoh :

Seorang perempuan berumur 29 tahun, P1A0 postpartum hari ke-6 datang ke Praktik Mandiri Bidan (PMB) dengan keluhan payudara terasa keras dan sakit. Hasil pemeriksaan: S 37°C, payudara bengkak, pengeluaran ASI sedikit.
Pertanyaannya:

a. Apa tindakan awal yang paling tepat untuk mengatasi kondisi tersebut!
b. Apa penyebab utama masalah tersebut!
c. Manakah tanda perlekatan yang benar saat menyusui!
d. Apakah edukasi yang paling tepat diberikan bidan!
e. Apa koreksi posisi yang tepat!

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Nifas : gangguan laktasi : bendungan ASI, putting lecet dan teknik koreksi menyusui
3	Kasus	Gangguan laktasi
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan 5. KIE/konseling 6. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 25 tahun, P1A0, hari ke 3 postpartum, datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan payudara terasa nyeri, tegang, dan bengkak. Hasil anamnesis: ibu mengatakan bayinya jarang menyusu Karena kesulitan melekat. Hasil pemeriksaan: TD 100/80 mmHg,S 37,8°C, payudara tampak membesar, kulit mengkilap, dan terasa hangat. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus.

No.	Komponen	Isi
		3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi payudara dan pemijatan kepada payudara ibu/pijat laktasi, penguji memberikan data: payudara terasa nyeri, tegang, dan bengkak. 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan. 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu .- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas- Memposisikan ibu senyaman mungkin. -Melakukan pengompresan payudara dengan menggunakan kain basah dan hangat selama 5 menit, - Melakukan pengurutan payudara dari arah pangkal menuju puting susu atau gunakan sisir untuk mengurut payudara dengan arah "Z" menuju puting susu, - Melakukan pengeluaran ASI sebagian dari bagian depan payudara sehingga puting susu menjadi lunak. Kemudian bersihkan kedua payudara, - Menganjurkan ibu untuk menyusukan bayinya setiap 2-3 jam sekali. Apabila tidak dapat menghisap seluruh ASI dikeluarkan dengan tangan, - Meletakkan kain dingin pada payudara setelah menyusui dan

No.	Komponen	Isi
		mengeringkan payudara, - Menganjurkan ibu untuk menggunakan BH yang menyokong payudara. 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu menyusui 2. PS tampak merasa nyeri pada payudaranya, tegang dan bengkak. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dilakukan pemijatan bendungan ASI, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: payudara saya nyeri, tegang dan bengkak bu? Peserta: baik saya melakukan pemijatan untuk menangani bendungan asi. PS: baik bu.. Peserta : saya sudah melakukan pemijatan, kemudian bisa segera disusukan lagi sama bayi anda bu. PS : baik bu.. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom dada atau payudara

No.	Komponen	Isi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom dada atau payudara — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. kapas putting dan minyak steril pada tempatnya - 1 6.handuk besar — 2 7. waslap — 2 8. waskom — 2 9. botol asi steril— 1 botol 10. bengkok— 1
13	Penulis	Pipit Indra Lestari.....
14	Referensi	2. Astuti. 2010. *Manajemen Laktasi Buku Panduan Bagi Bidan dan Petugas Kesehatan di Puskesmas*. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat: Jakarta. 3. Maryunani, A. 2009. *Asuhan Pada Ibu Dalam Masa Nifas*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirahardjo. 4. Widyasih, H., dkk. 2012. *Perawatan Masa Nifas*. Yogyakarta 5. Kuswanti, I,.& Wulandari, R.S. 2020. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Yogyakarta : ZAHIR PUBLISHING. Yogyakarta

F. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 26 tahun, P1A0, postpartum hari ke-4 datang ke Praktik Mandiri Bidan. Hasil anamnesis: kedua payudara terasa bengkak, keras, dan nyeri sejak satu hari terakhir. Bayi sulit melekat dan hanya menyusu tiga kali sehari. Hasil pemeriksaan: suhu 37,8°C, payudara bilateral bengkak, kulit mengkilat, puting tegang dan tampak lebih datar, serta ASI sulit keluar.
   Apakah tindakan awal yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Mengistirahatkan kedua payudara selama 24 jam
   B. Memerah sedikit ASI hingga payudara lebih lunak, kemudian menyusui bayi dengan perlekatan yang benar
   C. Membersihkan puting menggunakan sabun dan alkohol sebelum menyusui
   D. Menghentikan pemberian ASI dan menggantinya dengan susu formula
   E. Membatasi waktu menyusui selama lima menit setiap empat jam

2. Seorang perempuan berusia 30 tahun, P2A0, postpartum hari ke-3 datang untuk kunjungan nifas. Hasil anamnesis: payudara terasa berat, hangat, dan keras menjelang bayi menyusu. Keluhan berkurang setelah bayi selesai menyusu. Hasil pemeriksaan: suhu 36,8°C, tidak terdapat kemerahan atau luka pada puting, ASI dapat keluar, dan payudara menjadi lebih lunak setelah dikosongkan.
   Apakah masalah laktasi yang paling mungkin dialami perempuan tersebut?
   A. Bendungan ASI
   B. Puting susu lecet
   C. Puting susu terbenam
   D. Payudara penuh
   E. Moniliasis pada putting

3. Seorang perempuan berusia 24 tahun, P1A0, postpartum hari ke-8 datang dengan keluhan puting terasa sangat sakit saat menyusui. Hasil anamnesis: bayi hanya memasukkan bagian puting ke dalam mulut dan ibu biasa menarik puting secara langsung ketika bayi belum melepaskan isapan. Hasil pemeriksaan: terdapat retakan dan sedikit perdarahan pada puting, tetapi payudara tidak bengkak dan tidak kemerahan.
   Apakah penyebab utama masalah pada kasus tersebut?
   A. Produksi ASI yang berlebihan
   B. Bayi menyusu terlalu sering
   C. Perlekatan dan cara melepas isapan bayi yang tidak tepat
   D. Kebiasaan menyendawakan bayi setelah menyusu
   E. Pengolesan ASI pada puting setelah menyusui

4. Seorang perempuan berusia 28 tahun, P1A0, postpartum hari ke-5 sedang menyusui bayinya di Praktik Mandiri Bidan. Hasil pengamatan: tubuh bayi tidak menempel pada tubuh ibu, kepala bayi menoleh ke arah payudara, mulut hanya mencakup puting, dagu tidak menempel pada payudara, dan ibu tampak membungkuk. Bayi beberapa kali melepaskan isapan dan terlihat tidak tenang.
   Apakah koreksi posisi dan perlekatan yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Menempelkan tubuh bayi pada tubuh ibu, menghadapkan kepala dan badan bayi ke payudara, serta memastikan dagu menempel dan mulut terbuka lebar
   B. Membaringkan bayi telentang di pangkuan ibu dan membiarkan kepala bayi menoleh ke arah putting
   C. Memasukkan puting ke mulut bayi tanpa menunggu mulut bayi terbuka lebar
   D. Menekan puting dan areola selama bayi menyusu agar ASI keluar lebih banyak

E. Meminta ibu membungkukkan tubuh agar payudara lebih mudah dijangkau bayi

5. Seorang perempuan berusia 32 tahun, P2A0, postpartum hari ke-7 datang untuk kontrol setelah sebelumnya mengalami bendungan ASI dan puting lecet ringan. Hasil anamnesis: keluhan sudah berkurang setelah ASI dikeluarkan dan posisi menyusui diperbaiki. Ibu meminta penjelasan agar keluhan tidak berulang. Hasil pemeriksaan: suhu 36,7°C, payudara lunak, ASI keluar, dan puting tidak mengalami perdarahan.
   Apakah edukasi yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut?
   A. Menyusui bayi secara terjadwal setiap empat jam agar payudara dapat beristirahat
   B. Membersihkan puting dengan sabun atau alkohol setiap sebelum menyusui
   C. Menghentikan pemberian ASI ketika puting mulai terasa nyeri
   D. Menarik puting secara langsung dari mulut bayi setelah selesai menyusui
   E. Menyusui sesuai keinginan bayi, memperbaiki perlekatan, melepas isapan dengan jari kelingking, serta mengoleskan ASI pada puting setelah menyusui

Kunci Jawaban

1. B
2. D
3. C
4. A
5. E

Pembahasan

1. Jawaban: **B**. Memerah sedikit ASI hingga payudara lebih lunak, kemudian menyusui bayi dengan perlekatan yang benar.
   Kata kunci: postpartum hari ke-4, payudara bilateral bengkak, keras, mengkilat, puting tegang, ASI sulit keluar, bayi sulit melekat.
   Kasus tersebut menunjukkan bendungan ASI. Penumpukan ASI menyebabkan payudara membengkak, keras, tegang, terasa nyeri, dan kulit tampak mengkilat. Pembengkakan juga membuat puting serta areola menjadi lebih tegang atau datar sehingga bayi kesulitan melakukan perlekatan.
   Tindakan awal yang tepat adalah mengeluarkan sedikit ASI dengan tangan atau pompa hingga payudara dan daerah areola menjadi lebih lunak. Setelah itu, bayi segera disusui dengan posisi dan perlekatan yang benar. Ibu juga perlu

dianjurkan menyusui sesuai keinginan bayi agar pengosongan payudara berlangsung lebih efektif.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. **A:** Mengistirahatkan kedua payudara dapat memperburuk penumpukan ASI.
b. **C:** Penggunaan sabun dan alkohol dapat mengiritasi serta membuat puting menjadi kering.
c. **D:** Bendungan ASI bukan alasan untuk menghentikan pemberian ASI.
d. **E:** Pembatasan frekuensi dan durasi menyusui meningkatkan risiko pengosongan payudara yang tidak sempurna.

2. Jawaban: **D**. Payudara penuh.

Kata kunci: payudara berat, hangat dan keras, tidak demam, ASI tetap keluar, payudara lunak setelah menyusui.

Payudara penuh merupakan kondisi fisiologis ketika produksi ASI meningkat dan payudara belum dikosongkan. Payudara dapat terasa berat, panas, atau keras, tetapi ASI masih dapat dikeluarkan. Setelah bayi menyusu atau ASI diperah, payudara akan terasa lebih lunak dan ibu tidak mengalami demam.

Kondisi tersebut berbeda dengan bendungan ASI. Pada bendungan ASI, pembengkakan lebih nyata, payudara dapat terasa nyeri, kulit mengkilat, puting menjadi tegang atau datar, dan ASI sulit keluar. Bayi juga dapat mengalami kesulitan melekat pada payudara.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. **A:** Bendungan ASI biasanya disertai pembengkakan, nyeri, puting tegang, dan kesulitan mengeluarkan ASI.
b. **B:** Puting lecet ditandai luka, retakan, atau perdarahan pada puting.
c. **C:** Puting terbenam merupakan bentuk anatomis puting yang menyulitkan bayi melekat.
d. **E:** Moniliasis berkaitan dengan infeksi jamur yang dapat ditularkan dari mulut bayi ke puting ibu.

3. Jawaban: **C**. Perlekatan dan cara melepas isapan bayi yang tidak tepat.

Kata kunci: bayi hanya mengisap puting, ibu menarik puting saat bayi masih mengisap, puting retak dan berdarah.

Puting lecet paling sering berhubungan dengan teknik menyusui yang tidak tepat. Pada perlekatan yang baik, bayi tidak hanya memasukkan puting, tetapi juga memasukkan sebagian besar areola ke dalam mulut. Apabila bayi hanya mengisap puting, tekanan dan gesekan akan terpusat pada puting sehingga menimbulkan nyeri, retakan, luka, bahkan perdarahan.

Menarik puting secara langsung ketika bayi masih mengisap juga dapat menimbulkan trauma. Isapan seharusnya dilepaskan dengan memasukkan jari

kelingking melalui sudut mulut bayi atau dengan menekan dagu bayi ke bawah sampai bibir bawah terbuka. Setelah itu, puting dapat dilepaskan tanpa menimbulkan cedera tambahan.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. **A:** Produksi ASI berlebihan lebih berhubungan dengan payudara penuh atau bendungan ASI.
b. **B:** Frekuensi menyusui yang sering tidak menyebabkan lecet apabila posisi dan perlekatan sudah benar.
c. **D:** Menyendawakan bayi merupakan bagian perawatan setelah menyusui dan bukan penyebab puting lecet.
d. **E:** Mengoleskan ASI pada puting merupakan bagian perawatan setelah menyusui, bukan penyebab luka.

4. Jawaban: A. Menempelkan tubuh bayi pada tubuh ibu, menghadapkan kepala dan badan bayi ke payudara, serta memastikan dagu menempel dan mulut terbuka lebar.

   Kata kunci: tubuh bayi tidak menempel, kepala menoleh, hanya mengisap puting, dagu tidak menempel, bayi tidak tenang.

   Pada posisi menyusui yang benar, tubuh bagian depan bayi harus menempel pada tubuh ibu. Kepala dan badan bayi menghadap ke arah payudara sehingga bayi tidak perlu memutar lehernya. Telinga dan lengan bayi berada dalam satu garis lurus, dagu menempel pada payudara, serta mulut bayi terbuka lebar.

   Perlekatan yang baik ditandai dengan masuknya puting dan sebagian besar areola ke dalam mulut bayi. Bayi mengisap secara dalam dan perlahan, terkadang terdengar suara menelan, bayi tampak tenang, dan ibu tidak merasakan nyeri pada puting. Ibu juga harus duduk dalam posisi nyaman dan tegak, bukan membungkuk menuju bayi.

   Alasan opsi lain tidak tepat:

   a. **B:** Posisi telentang dengan kepala menoleh membuat kepala dan tubuh bayi tidak berada dalam satu garis.
   b. **C:** Puting tidak boleh dimasukkan sebelum mulut bayi terbuka lebar karena menyebabkan perlekatan dangkal.
   c. **D:** Menekan puting atau areola dapat mengganggu perlekatan dan aliran ASI.
   d. **E:** Ibu seharusnya membawa bayi mendekati payudara, bukan membungkukkan tubuh ke arah bayi.

5. Jawaban: **E.** Menyusui sesuai keinginan bayi, memperbaiki perlekatan, melepas isapan dengan jari kelingking, serta mengoleskan ASI pada puting setelah menyusui.

Kata kunci: pencegahan bendungan ASI dan puting lecet, menyusui sesuai keinginan bayi, perlekatan benar, perawatan puting.

Pencegahan bendungan ASI dilakukan dengan menyusui bayi sesering mungkin sesuai kebutuhannya atau secara *on demand*. Dalam materi disebutkan bahwa ibu dapat menyusui sekitar 8–12 kali dalam 24 jam. Pengosongan payudara yang efektif mencegah ASI tertahan dan menumpuk di dalam payudara.

Untuk mencegah puting lecet, ibu perlu memastikan mulut bayi terbuka lebar, dagu menempel pada payudara, dan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Setelah menyusui, isapan dilepaskan dengan memasukkan jari kelingking melalui sudut mulut bayi. Sedikit ASI dapat dioleskan pada puting dan areola, kemudian dibiarkan mengering dengan sendirinya.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. **A:** Jadwal menyusui yang terlalu jarang dapat menyebabkan payudara tidak dikosongkan secara optimal.
b. **B:** Sabun dan alkohol dapat menyebabkan puting kering dan mengalami iritasi.
c. **C:** Menghentikan menyusui dapat menyebabkan ASI tertahan dan memperberat bendungan.
d. **D:** Menarik puting ketika bayi masih mengisap dapat menimbulkan lecet atau trauma pada puting.

G. Ringkasan Materi

Bendungan ASI dapat terjadi karena adanya penyempitan duktus laktiferus pada payudara ibu dan dapat terjadi apabila ibu memiliki kelainan puting susu misalnya puting susu datar, terbenam dan cekung. Kejadian ini biasanya disebabkan karena air susu yang terkumpul tidak segera dikeluarkan sehingga menjadi sumbatan. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat kondisi ibu, pemeriksaan, dan pemijatan yang dilakukan untuk menangani bendungan ASI.

Posisi menyusui yang baik pada dasarnya ditentukan oleh posisi ibu. tingkat kenyamanan dan relaksasi sebelum melahirkan (Mayangsari et al., 2021). Puting lecet sering terjadi pada ibu menyusui dan sering disebabkan oleh teknik menyusui yang tidak tepat, seperti bayi tidak menyusu sampai payudara atau melepaskan isapan yang salah, yang tidak berlangsung cukup lama untuk mengosongkan payudara sepenuhnya, sehingga puting lecet mengakibatkan trauma dan rasa sakit bagi ibu (Wahyuni et al., 2021). Sebaiknya petugas kesehatan memberikan edukasi atau pendidikan terhadap ibu nifas tentang cara menangani bendungan ASI, putting lecet dengan teknik menyusui yang benar.

H. Referensi

Anik Maryunani. (2015). Inisiasi Menyusu Dini, Asi Eksklusif dan Manajemen Laktasi. Jakarta

Astuti. 2010. *Manajemen Laktasi Buku Panduan Bagi Bidan dan Petugas Kesehatan di Puskesmas*. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat: Jakarta.

Fatmawati, L. 2019. *Pengaruh Perawatan Payudara Terhadap pengeluaran ASI Ibu Post Partum*. Jurnal Ilmiah Keperawatan Vol 10 .

Jannah. (2021). Penatalaksanaan Produksi Asi Tidak Lancar Pada Ibu Nifas Post Sc Di Bpm Siti Hotijah S.ST,. M. M Kes. Bd. Naskah Publikasi

Kuswanti, I,.& Wulandari, R.S. 2020. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui.* Yogyakarta : ZAHIR PUBLISHING. Yogyakarta

Mansyur, N., & Dahlan, K. A. (2014). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Malang: Selaksa Kelompok Penerbit Intrans.

Marmi, S., et al. (2016). *Manajemen Bendungan ASI pada Ibu Nifas*. Jurnal Kebidanan Indonesia, 9(3), 180-195**.**

Maryunani, A. 2009. *Asuhan Pada Ibu Dalam Masa Nifas*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirahardjo.

Mayangsari, D., Puryati, & Nurhayati, S. (2021). *Manfaat pijat oketani dan teknik menyusui terhadap derajat putting susu lecet*. Jurnal SMART Kebidanan, 8(2), 155–162.

Prawirohardjo S. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2020.

Walyani ES, Purwoastuti E. 2022. Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui. Yogyakarta;

Widyasih, H., dkk. 2012. *Perawatan Masa Nifas*. Yogyakarta

Wirakhmi, I. N., & Purnawan, I. (2021). *Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi*. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, 12(2), 327-333.

Yuliana, W., & Hakim, B. (2020). Emodemo dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

BAB 3

MASTITIS DAN ABSES PAYUDARA: TANDA KLINIS, TATALAKSANA AWAL, DAN KRITERIA RUJUKAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas (anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital) untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5, CPMK-7, CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.
CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.
CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Komplikasi Masa Nifas: Fisiologi Nifas, Faktor Risiko, dan Keselamatan Ibu	1.1 Menguraikan parameter fisiologis nifas normal dan deviasi yang mengarah pada komplikasi.	1.2 Mengidentifikasi faktor risiko dan menerapkan prinsip keselamatan ibu pada pelayanan nifas.	CPMK-1	CPMK-2
Bab 2. Pengkajian Ibu Nifas dengan Keluhan: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Tanda Vital	2.1 Melakukan anamnesis terfokus berbasis keluhan dan red flags komplikasi nifas.	2.2 Melakukan pemeriksaan fisik dan interpretasi tanda vital untuk menentukan prioritas masalah.	CPMK-2	CPMK-1
Bab 3. Perdarahan Postpartum: Klasifikasi, Penyebab (4T), dan Tindakan	3.1 Menentukan klasifikasi perdarahan postpartum dan menelusuri penyebab dengan pendekatan 4T.	3.2 Menyusun dan menerapkan langkah tindakan awal serta monitoring sesuai	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Awal di Pelayanan Primer		algoritme di pelayanan primer.		
Bab 4. Atonia Uteri dan Subinvolusi: Deteksi Dini, Stabilisasi, dan Indikasi Rujukan	4.1 Melakukan deteksi dini atonia uteri/subinvolusi melalui temuan klinis nifas.	4.2 Melaksanakan stabilisasi awal dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan tingkat kegawatan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 5. Retensio Plasenta dan Sisa Plasenta: Tanda Klinis, Penanganan Awal, dan Rujukan	5.1 Mengidentifikasi tanda retensio/sisa plasenta serta risiko perdarahan dan infeksi.	5.2 Melaksanakan penanganan awal, persiapan, dan komunikasi rujukan sesuai kebutuhan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 6. Laserasi Jalan Lahir dan Hematoma: Identifikasi, Penatalaksanaan Awal, dan Rujukan	6.1 Mengidentifikasi laserasi jalan lahir/hematoma melalui inspeksi dan tanda klinis.	6.2 Menyusun tatalaksana awal, monitoring, dan keputusan rujukan berdasarkan kondisi klinis.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 7. Infeksi Masa Nifas: Endometritis, Infeksi Luka, dan Pencegahan Penyebaran	7.1 Membedakan endometritis dan infeksi luka berdasarkan gejala, faktor risiko, dan pemeriksaan.	7.2 Menerapkan tatalaksana awal serta pencegahan penyebaran (PPI) pada infeksi masa nifas.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-1
Bab 8. Sepsis Puerperalis: Tanda Bahaya, Stabilisasi Pra-Rujukan, dan Komunikasi Rujukan	8.1 Mengidentifikasi tanda bahaya sepsis puerperalis dan menilai derajat kegawatan.	8.2 Melaksanakan stabilisasi pra-rujukan dan komunikasi rujukan terstruktur kepada fasilitas rujukan.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-2
Bab 9. Gangguan Laktasi: Bendungan ASI, Puting Lecet, dan Teknik Koreksi Menyusui	9.1 Mengkaji masalah menyusui dan mengidentifikasi penyebab bendungan ASI/puting lecet.	9.2 Mendemonstrasikan koreksi teknik menyusui dan konseling perawatan payudara.	CPMK-5	CPMK-7; CPMK-2
Bab 10. Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan	10.1 Mengidentifikasi mastitis/abses payudara dan menilai tingkat keparahan serta komplikasi.	10.2 Menyusun tatalaksana awal, monitoring, dan kriteria rujukan/kolaborasi.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 11. Tromboemboli dan Komplikasi Sistemik Nifas: Deteksi Dini, Tanda Bahaya, dan Rujukan	11.1 Melakukan deteksi dini tromboemboli/komplikasi sistemik berdasarkan gejala, faktor risiko, dan tanda bahaya.	11.2 Melaksanakan triase, stabilisasi, dan rujukan segera disertai dokumentasi klinis.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-1
Bab 12. Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan Lain: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid	12.1 Mengkaji retensi urine, konstipasi, dan hemoroid serta faktor pencetus dan derajat keluhan.	12.2 Menyusun asuhan awal, edukasi self-care, dan kriteria rujukan bila terdapat tanda bahaya.	CPMK-2	CPMK-7; CPMK-1
Bab 13. Kesehatan Mental Ibu Nifas: Baby Blues, Depresi Postpartum, Risiko Bunuh Diri, dan Dukungan Keluarga	13.1 Melakukan skrining kesehatan mental nifas dan menilai risiko bunuh diri/krisis.	13.2 Menyusun dukungan awal, pelibatan keluarga, dan rujukan/kolaborasi sesuai tingkat risiko.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-1
Bab 14. Edukasi Tanda Bahaya Nifas, Dokumentasi, dan Tindak Lanjut: Kunjungan Nifas, Konseling KB, dan Continuity of Care	14.1 Melaksanakan edukasi tanda bahaya nifas, jadwal kunjungan, dan konseling KB berbasis kebutuhan.	14.2 Menyusun dokumentasi, rencana tindak lanjut, dan continuity of care termasuk rujukan balik bila diperlukan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6

Uraian Materi

Mastitis merupakan infeksi pada payudara yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Kondisi ini sering disertai demam, serta rasa nyeri, kemerahan dan pembengkakan pada area payudara yang terkena. Umumnya mastitis dan abses payudara lebih sering ditemukan pada ibu menyusui, tetapi juga bisa dialami oleh Wanita yang tidak sedang menyusui dengan faktor komorbid seperti diabetes melitus maupun gangguan imunitas lainnya.

Gejala mastitis terkadang mirip kanker payudara dan penyakit peradangan seperti flu, ciri-ciri mastitis pada payudara yang perlu diwaspadai yaitu payudara terasa sakit atau nyeri, payudara kemerahan, payudara bengkak, saat diraba ada penebalan jaringan atau benjolan pada payudara, saat disentuh payudara terasa panas, lunak dan perih, badan panas dingin, demam tinggi atau menggigil kedinginan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, dan terkadang disertai mual dan muntah. Gejala mastitis terasa sangat menyakitkan, banyak ibu menyusui bisa meminta bantuan konsultasi laktasi. Ciri-ciri mastitis pada payudara diatas biasanya bertahan 10 hari sampai 1 minggu tergantung tingkat keparahan peradangan.

Penyebab mastitis pada payudara, mastitis biasanya terjadi karena bakteri dari kulit atau air liur masuk kejaringan payudara lewat saluran susu atau kulit yang terluka di payudara. Terdapat beberapa faktor yang bisa jadi penyebab mastitis antara lain: putting pecah-pecah atau sakit, teknik pelekatan saat menyusui tidak tepat, ibu terlalu banyak menggunakan salah satu sisi payudara saat menyusui, jeda jarak waktu menyusui yang terlalu lama, penyumbatan saluran susu, penggunaan bra atau pakaian dalam terlalu ketat.

Patofisiologi terjadinya mastitis diawali dengan peningkatan tekanan di dalam ductus (saluran ASI) akibat stasis ASI, bila ASI tidak segera dikeluarkan maka terjadi tegangan alveoli yang berlebihan dan mengakibatkan sel epitel yang memproduksi ASI menjadi datar dan tertekan, sehinga permeabilitas jaringan ikat meningkat. Beberapa komponen (terutama protein kekebelan tubuh dan natrium) dari plasma masuk kedalam ASI dan selanjutnya ke jaringan sekitar sel sehingga memicu respons imun, stasis ASI, adanya respons inflamsi dan kerusakan jaringan memudahkan terjadinya infeksi. Terdapat beberapa cara masuknya kuman yaitu melalui ductus laktiferus ke lobus sekresi, melalui putting yang retaj ke kelenjar limfe sekitar ductus (Periduktal) atau melalui penyebaran hematogen (pembuluh darah). Organismes yang paling sering adalah Staphylococcus aureus, Escherecia coli dan Streptococcus. Kadang -kadang ditemukan pula mastitis tuberculosis yang menyebabkan bayi dapat

menderita tuberkulosa tonsil. Pada daerah endemis tuberkulosa kejadian mastitis tuberculosis mencapai 1 %.

Pencegahan terhadap kejadian mastitis dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor Risiko diatas. Bila payudara penuh dan bengkak (engorgement), bayi biasanya menjadi sulit melekat dengan baik, karena permukaan payudara menjadi sangat tegang. Ibu dibantu untuk mengeluarkan sebagian ASI setiap 3-4 jam dengan cara memerah dengan tangan atau pompa ASI yang direkomendasikan. Sebelum memerah ASI pijatan di leher dan punggung dapat merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang menyebabkan ASI mengalir dan rasa nyeri berkurang. Teknik memerah dengan tangan yang benar perlu diperhatikan dan diajarkan kepada ibu agar perahan tersebut efektif. ASI hasil perahan dapat diminumkan ke bayi dengan menggunakan cangkir atau sendok. Pembengakkan payudara ini perlu segera ditangani untuk mencegah terjadina *Feedback inhibitor of Lactin* (FIL) yang menghambat penyaluran ASI.

Pengosongan yang tidak sempurna atau tertekan ductus akibat pakaian yang ketat dapat menyebabkan ASI terbendung. Ibu dianjurkan untuk segera memeriksa payudara bila teraba benjolan, terasa nyeri dan kemerahan. Selain itu ibu juga perlu beristirahat, meningkatkan frekuensi menyusui terutama pada sisi payudara yang bermasalah serta melakukan pijatan dan kompres hangat didaerah benjolan. Kelelahan sering menjadi pencetus terjadinya mastitis. Seseorang tenaga Kesehatan harus selalu menganjurkan ibu menyusui cukup beristirahat dan juga meningatkan anggota keluarga lainnya bahwa seorang ibu menyusui membutuhkan lebih banyak bantuan.

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lain untuk menunjang diagnosis tidak selalu diperlukan. *Word Health Organization* (WHO) menganjurkan pemeriksaan kultur dan uji senstivitas pada beberapa keadaan yaitu bila: pengobatan dengan antibiotic tidak memperlihatkan respons yang baik dalam 2 hari, terjadi mastitis berulang, mastitis terjadi di rumah sakit, penderita alergi terhadap antibiotic atau pada kasus yang berat. Bahan kultur diambil dari ASI pancar Tengah hasil dari perahan tangan yang berlangsung ditampung menggunakan penampungan urin steril. Putting harus dibersihkan terlebih dulu dan bibir penampung diusahakan tidak menyentuh putting untuk mengurangi kontaminasi dari kuman yang terdapat dikulit yang dapat memberikan hasil positif palsu dari kultur.

Tatalaksana suportif mastisis dimulai dengan memperbaiki Teknik menyusui ibu. Aliran ASI yang baik merupakan hal penting dalam tata laksana mastitis karena stasis ASI merupakan masalah yang biasanya mengawali terjadinya mastitis. Ibu dianjurkan agar lebih sering menyusui dimulai dari payudara yang bermasalah. Tetapi bila ibu merasa sangat nyeri, ibu dapat mulai menyusui dari sisi payudara yang sehat,

kemudian sesegera mungkin dipindahkan ke payudara bermasalah, bila Sebagian ASI telah menetas (*Let down)* dan neyri sudah berkurang. Posisikan bayi pada payudara sedemikian rupa sehingga dagu dan ujung hidung berada pada tempat yang mengalami sumbatan. Pemberian Analgesik diberikan untuk mengurangi rasa nyeri pada mastitis, analgesic yang dianjurkan adalah obat anti inflamasi seperti ibuprofen. Ibuprofen lebih efektif dalam menurunkan gejala yang berhubungan dengan peradangan dibandingkan parasetamol atau asetaminofen. Ibuprofen sampai dosis 1,6 gram per hari tidak terdeteksi pada ASI sehingga direkomendasikan untuk ibu menyusui yang mengalami mastitis. Pemberian antibiotik diberikan jika gejala mastitis ringan dan berlangsung kurang dari 24 jam, maka perawatan konservatif (mengalirkan ASI dan perawatan suportif) sudah cukup membantu. Jika tidak terlihat perbaikan gejala dalam 12-24 jam atau jika ibu tampaj sakit berat, antibiotic harus segera diberikan. Jenis antibiotic yang biasa digunakan adalah dikloksasilin atau flukloksasin 500 mg setiap 6 jam secara oral. Dikloksasilin mempunyai waktu paruh yang lebih singkat dalam darah dan lebih banyak.

Abses payudara adalah kumpulan nanah yang terbentuk di jaringan payudara akibat infeksi bakteri yang tidak tertangani dengan baik, biasanya merupakan komplikasi dari mastitis laktasi. Abses ini terjadi ketika infeksi menyebabkan kerusakan jaringan sehingga terbentuk rongga yang berisi pus (nanah). Kondisi ini paling sering terjadi pada ibu menyusui, terutama pada beberapa minggu pertama setelah persalinan.

Pada masa laktasi, abses payudara biasanya diawali dengan mastitis yang tidak tertangani atau pengosongan payudara yang tidak adekuat sehingga terjadi sumbatan saluran ASI dan infeksi bakteri. Bila tidak segera diatasi, proses inflamasi akan berkembang menjadi pembentukan abses yang memerlukan tindakan medis seperti drainase.

Gejala dan tanda gejala pada abses payudara yang umum yang muncul antara lain nyeri hebat pada payudara, terdapat benjola yang terasa lunak atau berisi cairan, kulit payudara kemerahan, bengkak dan terasa hangat. Payudara tegang, demam > 38°C, badan lemas dan mengigil, pada kasus lanjut dapat terlihat fluktuasi (tanda adanya Kumpulan nanah) dan kadang keluar cairan nanah dari putting atau kulit payudara.

Etiologi dari abses payudara paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang masuk melalui luka pada putting atau akiba sumbatan saluran ASI. Penyebab yang sering terjadi yaitu infeksi bakteri terutama staphylococcus aureus (penyebab tersering), streptococcus dan bakteri gram negative. Selain iti ada faktor predisposisi yaitu mastitis yang tidak diobati, bendungan ASI, putting lecet atau luka dan Teknik

menyusui yang tidak benar, pengosongan payudara tidak optimal, system imun ibu menurun dan kebersihan payudara kurang baik.

Patofisiologi abses payudara Proses terjadinya abses payudara dimulai dari adanya sumbatan pada saluran ASI yang menyebabkan penumpukan ASI. Penumpukan ini dapat menimbulkan tekanan pada jaringan payudara dan memicu terjadinya inflamasi. Bakteri yang masuk melalui luka pada puting atau saluran ASI kemudian berkembang biak di jaringan payudara dan menyebabkan infeksi. Infeksi tersebut memicu respon inflamasi berupa pembengkakan, nyeri, dan peningkatan aliran darah ke area tersebut. Apabila infeksi tidak segera ditangani, sel-sel imun akan berkumpul di lokasi infeksi dan menyebabkan kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ini akhirnya membentuk rongga yang berisi nanah (pus), yang disebut abses. Rongga abses dapat semakin membesar dan menyebabkan nyeri hebat serta gangguan pada proses menyusui.

Penatalaksanaan pada abses payudara adalah terapi medis pemberian antibiotic sesuai anjuran tenaga Kesehatan, analgesic atau antipiretik untuk mengurangi nyeri dan demam serta pemberian antibiotik yang sering digunakan misalnya amoksillin aatau dikloksasilin (sesuai indikasi medis). Drainase abses jka abses sudah terbentuk diperlukan Tindakan untuk mengeluarkan nanah, yaitu dengan aspirasi jarum (needle aspiration) dan insisi dan drainase (I&D) oleh tenaga medis, manajemen laktasi menyusui tetap dianjurkan pada payudara yang tidak terkena, pada payudara yang terkena dapat dilakukan pengosongan dengan pumping, perbaikan Teknik menyusui, perawatan payudara kompres hangat sebelum menyusui, istirahat cukup, asupan nutrisi yang baik dan menjaga kebersihan payudara.

Kriteria rujukan dengan abses payudara perlu dirujukan ke fasilitas Kesehatan yang lebih lengkap apabila ditemukan kondisi berikut: terdapat benjolan dengan fluktasi yang menunjukkan adanya Kumpulan nanah, nyeri hebat dan pembengkakan payudara semakin membesar, demam tinggi yang tidak membaik setelah terapi awal, tidak membaik setelah pemberian antibiotic 48-72 jam, terjadi keluarnya nanah dari payudara, abses berukuran besar, kondisi umum ibu memburuk, dan dicuriga adanya komplikasi atau infeski sistemik

A. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang Perempuan usia 25 tahun P2A0 Postpartum hari ke 7 datang ke TPMB mengeluh payudara nya bengkak. Hasil anamesisi ibu mengeluh payudara bengkak, nyeri, kemerahan dan disertai demam. Hasil pemeriksaan: Payudara bengkak dan kemerahan, palpasi payudara terasa padat dan adanya nyeri tekan. TD: 110/80 mmHg, S: 38,5°C, N: 88x/m, R: 24x/m.

Pertanyaan Diskusi

1. Apakah diagnose yang tepat pada kasus diatas?
2. Jelaskan Penyebab Terjadinya kasus diatas?
3. Bagaimana Pencegahan pada kasus diatas ?
4. Jelaskan Tanda dan gejala dari mastitis?

Jawaban:

1. Diagnosa Mastitis pada ibu nifas pada hari ke 7
2. Penyebab terjadinya mastitis adalah putting pecah-pecah atau sakit, teknik pelekatan saat menyusui tidak tepat, ibu terlalu banyak menggunakan salah satu sisi payudara saat menyusui, jeda jarak waktu menyusui yang terlalu lama, penyumbatan saluran susu, penggunaan bra atau pakaian dalam terlalu ketat.
3. Pencegahan adalah Ibu dibantu untuk mengeluarkan sebagian ASI setiap 3-4 jam dengan cara memerah dengan tangan atau pompa ASI yang direkomendasikan. Sebelum memerah ASI pijatan di leher dan punggung dapat merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang menyebabkan ASI mengalir dan rasa nyeri berkurang.
4. Tanda dan gejala mastitis adalah payudara terasa sakit atau nyeri, payudara kemerahan, payudara bengkak, saat diraba ada penebalan jaringan atau benjolan pada payudara, saat disentuh payudara terasa panas, lunak dan perih, badan panas dingin, demam tinggi atau menggigil kedinginan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, dan terkadang disertai mual dan muntah

Aktivitas 2 — *Shows How (*Simulasi/skill lab)

1. Simulasi Tanda Klinis pada Mastitis dan Abses Payudara
2. Tujuan Simulasi Tanda Klinis pada Mastitis dan Abses Payudara
   Tindakan
   a. Melakukan persiapan alat dan lingkungan sebelum pemeriksaan.
   b. Melakukan anamnesis terkait keluhan payudara pada ibu menyusui.

c. Melakukan inspeksi payudara untuk mengidentifikasi tanda kemerahan, pembengkakan, atau luka pada puting.
d. Melakukan palpasi payudara secara sistematis untuk menemukan nyeri tekan, benjolan, atau fluktuasi.
e. Mengidentifikasi tanda klinis mastitis dan abses payudara secara tepat.

3. Komunikasi
   a. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada pasien.
   b. Menggunakan komunikasi terapeutik yang sopan dan empatik selama pemeriksaan.
   c. Memberikan penjelasan kepada pasien mengenai hasil pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dipahami.
   d. Memberikan edukasi terkait perawatan payudara dan tanda bahaya.
4. Aspek Keselamatan
   a. Melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.
   b. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai.
   c. Menjaga privasi dan kenyamanan pasien selama pemeriksaan.
   d. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan teknik yang aman dan tidak menimbulkan cedera atau nyeri berlebihan pada pasien.

Persiapan simulasi Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal dan Kriteria Rujukan

Kategori	Keterangan
Peralatan dan Bahan	1. Sarung tangan bersih/steril untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi. 2. Masker medis sebagai alat pelindung diri. 3. Termometer untuk mengukur suhu tubuh pasien (menilai adanya demam). 4. Kapas alkohol atau alkohol swab untuk menjaga kebersihan alat dan tangan. 5. Kasa steril untuk perawatan luka atau membersihkan area payudara. 6. Model payudara (breast model/manekin) untuk simulasi pemeriksaan. 7. Buku catatan atau format lembar observasi/OSCE untuk dokumentasi hasil pemeriksaan. 8. Alat tulis untuk pencatatan hasil anamnesis dan pemeriksaan.
Lingkungan	1. Ruangan praktik yang bersih dan nyaman. 2. Pencahayaan yang cukup agar pemeriksaan payudara dapat dilakukan dengan jelas. 3. Tersedia tempat tidur atau bed pemeriksaan. 4. Tersedia tirai atau pembatas untuk menjaga privasi pasien. 5. Lingkungan simulasi dibuat menyerupai situasi klinis yang nyata agar mahasiswa dapat berlatih secara optimal.

Kategori	Keterangan
Peran	1. **Mahasiswa/Bidan**: berperan sebagai tenaga kesehatan yang melakukan anamnesis, pemeriksaan payudara, dan identifikasi tanda klinis. 2. **Pasien simulasi (standardized patient)**: berperan sebagai ibu menyusui yang mengalami keluhan mastitis atau abses payudara. 3. **Instruktur/Penguji**: mengamati jalannya simulasi dan melakukan penilaian menggunakan checklist.
Aturan Dasar	1. Mahasiswa harus mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai standar praktik kebidanan 2. Menjaga komunikasi terapeutik selama simulasi berlangsung. 3. Menjaga keselamatan dan kenyamanan pasien simulasi. 4. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan cedera. 5. Semua tindakan harus didokumentasikan pada lembar observasi yang telah disediakan.

Tahapan Simulasi Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal dan Kriteria Rujukan

Tahapan	Kegiatan Utama	Fokus Penilaian	Detail Pelaksanaan
Pra Interaksi	Persiapan sebelum bertemu pasien	Kesiapan tindakan dan keselamatan	Mahasiswa menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan seperti sarung tangan, masker, termometer, kasa, dan format dokumentasi. Mahasiswa melakukan cuci tangan serta menggunakan alat pelindung diri sebelum memulai tindakan.
Orientasi	Membangun hubungan terapeutik dengan pasien	Komunikasi terapeutik dan etika	Mahasiswa memberi salam, memperkenalkan diri, memverifikasi identitas pasien, menjelaskan tujuan pemeriksaan payudara, meminta persetujuan pasien (informed consent), dan menjaga privasi pasien dengan menutup tirai atau menggunakan ruang pemeriksaan yang tertutup.
Anamnesis / Pengkajian	Menggali keluhan pasien	Ketepatan pengumpulan data	Mahasiswa menanyakan keluhan utama seperti nyeri payudara, demam, pembengkakan, adanya benjolan, riwayat menyusui, puting lecet, serta lama keluhan. Mahasiswa juga

Tahapan	Kegiatan Utama	Fokus Penilaian	Detail Pelaksanaan
			menanyakan riwayat mastitis sebelumnya dan kebiasaan menyusui.
Pemeriksaan Payudara (Inspeksi)	Mengamati kondisi payudara	Ketelitian dalam identifikasi tanda klinis	Mahasiswa mengamati bentuk payudara, warna kulit, adanya kemerahan, pembengkakan, luka pada puting, atau keluarnya cairan dari puting. Pemeriksaan dilakukan dengan tetap menjaga kenyamanan pasien.
Pemeriksaan Payudara (Palpasi)	Meraba jaringan payudara	Keterampilan pemeriksaan fisik	Mahasiswa melakukan palpasi secara sistematis untuk menilai adanya nyeri tekan, benjolan, peningkatan suhu lokal, atau fluktuasi yang menunjukkan kemungkinan abses payudara.
Identifikasi Tanda Klinis	Menentukan kemungkinan mastitis atau abses	Kemampuan analisis klinis	Mahasiswa mengidentifikasi tanda mastitis seperti kemerahan, nyeri, pembengkakan, dan demam. Mahasiswa juga mengenali tanda abses seperti benjolan lunak, fluktuasi, nyeri hebat, dan kemungkinan adanya nanah.
Penatalaksanaan Awal	Memberikan penanganan awal	Ketepatan intervensi	Pada mastitis, mahasiswa menjelaskan pentingnya tetap menyusui, melakukan pengosongan payudara, kompres hangat, serta istirahat yang cukup. Pada abses payudara, mahasiswa menjelaskan kemungkinan perlunya tindakan drainase dan pengobatan antibiotik sesuai indikasi.
Sistem Rujukan	Menentukan kebutuhan rujukan	Pengambilan keputusan klinis	Mahasiswa menjelaskan indikasi rujukan seperti abses payudara, demam tinggi yang tidak membaik, nyeri hebat, atau tidak ada perbaikan setelah terapi awal. Mahasiswa juga menjelaskan prosedur rujukan kepada pasien.
Terminasi	Mengakhiri interaksi dengan pasien	Edukasi dan dokumentasi	Mahasiswa menyimpulkan hasil pemeriksaan, memberikan edukasi mengenai perawatan payudara dan

Tahapan	Kegiatan Utama	Fokus Penilaian	Detail Pelaksanaan
			tanda bahaya, memberikan kesempatan pasien bertanya, serta melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindakan yang telah dilakukan.

Contoh Skenario tanda klinis pada mastitis dan abses payudara

Seorang Perempuan usia 28 tahun P2A0 Postpartum hari ke 10 datang ke Fasilitas Kesehatan dengan keluhan pada payudara kiri sejak 3 hari yang lalu. Ibu mengatakan payudara terasa bengkak, kemerahan dan terasa panas, ibu menyusui bayinya secara langsung, tetapi sejak payudara terasa nyeri ibu menjadi jarang menyusui pada payudara kiri, ibu juga mengatakan putting susu sempat lecet beberapa hari setelah melahirkan. Hasil pemeriksaan: Payudara kiri tampak bengkak dan kemerahan, palpasi payudara terasa padat dan adanya nyeri tekan. TD: 110/80 mmHg, S: 38,5°C, N: 88x/m, R: 24x/m.

Fokus Latihan:

1. Komunikasi: Bagaimana cara melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien dan menjelasakan prosedur pemeriksaan sebelum tindakan. Contoh: "payudara saya terasa sangat sakit saat ditekan, dan apakah saya masih bisa boleh menyusui bayi saya?"
2. Tindakan: Menyesuaikan daftar pertanyaan dan melakukan anamesis pada ibu menyusui dengan keluhan payudara, melakukan inspeksi dan palpasi payudara secara sitematis, mengidentifikasi tanda klinis mastitis dan abses payudara, menentukan penatalaksanaan awal yang sesuai
3. Keselamatan: Menjamin kerahasiaan berulang kali, dan pastikan pasien nyaman, dan informed consent, serta melakukan prosedur pengambilan sampel dengan aman dan sopan.

Daftar Periksa Simulasi Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal dan Kriteria Rujukan

Aspek	Kriteria Penilaian
Tindakan	1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan sebelum tindakan.
	2. Melakukan anamnesis terkait keluhan payudara pada ibu menyusui.
	3. Mengidentifikasi keluhan seperti nyeri payudara, demam, dan pembengkakan.

Aspek	Kriteria Penilaian
	4. Melakukan inspeksi payudara untuk melihat kemerahan, pembengkakan, atau luka pada puting.
	5. Melakukan palpasi payudara secara sistematis untuk menilai nyeri tekan atau benjolan.
	6. Mengidentifikasi tanda klinis mastitis (kemerahan, nyeri, bengkak, demam).
	7. Mengidentifikasi tanda klinis abses payudara (benjolan lunak, fluktuasi, kemungkinan nanah).
	8. Menjelaskan penatalaksanaan awal mastitis seperti pengosongan payudara, kompres hangat, dan istirahat.
	9. Menjelaskan kemungkinan tindakan pada abses payudara seperti drainase dan terapi antibiotik.
	10. Menentukan indikasi rujukan pada kondisi abses payudara atau tidak membaik setelah terapi awal.
Komunikasi	1. Memberi salam dan memperkenalkan diri kepada pasien.
	2. Menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada pasien.
	3. Meminta persetujuan pasien sebelum melakukan pemeriksaan.
	4. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pasien.
	5. Memberikan edukasi mengenai kondisi mastitis atau abses payudara.
	6. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya.
Keselamatan	1. Melakukan cuci tangan sebelum tindakan.
	2. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai.
	3. Menjaga privasi pasien selama pemeriksaan.
	4. Melakukan pemeriksaan dengan teknik yang aman dan lembut.
	5. Melakukan cuci tangan setelah tindakan.
	6. Melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindakan.

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	3 (Asuhan Nifas)
2	Judul	Nifas : Mastitis dan Abses Payudara
3	Kasus	Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta ujian mampu menunjukkan tanda klinis, tatalaksana awal dan kriteria rujukan
5	Kompetensi	1. Mampu melakukan Anamnesis 2. Mampu Melakukan Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Mampu merumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Mampu Menentukan Prosedur tindakan klinis 5. Mampu melakukan KIE/konseling 6. Mampu melakukan Kolaborasi/rujukan 7. Mampu memberikan Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	**SKENARIO KLINIK** Seorang Perempuan usia 25 tahun P2A0 Postpartum hari ke 7 datang ke TPMB mengeluh payudara nya bengkak. Hasil anamesisi ibu mengeluh payudara bengkak, nyeri, kemerahan dan disertai demam. Hasil pemeriksaan: Payudara bengkak dan kemerahan, palpasi payudara terasa padat dan adanya nyeri tekan. TD: 110/80 mmHg, S: 38,5°C, N: 88x/m, R: 24x/m. **TUGAS** 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	**INSTRUKSI UMUM** 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta

No.	Komponen	Isi
		b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. **INSTRUKSI KHUSUS** 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi payudara, penguji memberikan data:- payudara keras dan bengkak kemerahan dan adanya nyeri tekan serta suhu tubuh 38,5°C 3. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: • Melakukan Pengkajian awal • Mengosongkan payudara • Kompres hangat • Memperbaiki Teknik menyusui • Istirahat dan nutrisi • Pemberian obat jika diperlukan • Observasi dan tindak lanjut • Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera • Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. **INSTRUKSI TAMBAHAN** 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	**Instruksi PS:** 6. PS berperan sebagai ibu postpartum P2A0 7. PS tampak cemas, demam, nyeri pada bagian payudara

No.	Komponen	Isi
		8. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 9. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Payudara saya terasa sakit dan bengkak ? Peserta: sejak kapan ibu merasakan keluhan ini? PS: sejak 2 hari yang lalu Peserta: "apakah ibu juga merasakan demam atau mengigil ? PS: iya, saya seempat demam tadi malam bu bidann Peserta: Apakah ibu tetap menyusui bayi ibu ? PS: saya agak takut menyusui bayi saya bu, karena sakit kl disentuh payudara nya. Peserta: ibu tidak perlu khawatir, pada kondisi seperti ini ibu tetap dianjurkan untuk menyusui atau memerah ASI agar payudara tidak semakin penuh dan membantu proses penyembuhan Peserta: "ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara ibu, mohon ijin membuka pakaian bagian atas ibu secukupnya, dan saya akan menjada privasi ibu" PS: Baik bu Peserta: saya akan mulai memeriksa payudara ibu secara perlahan, jika terasa nyeri silahkan beritahu saya" (peserta melakukan inspeksi dan palpasi) Peserta: "dari hasil pemeriksaan, payudara ibu tampak kemerahan, bengkak dan terasa hangat. Kondisi ini mengarahkan pada mastitis atau peradangan pada payudara" PS: apakah berbahaya ibu bidan ? Peserta: biasanya kondisi ini dapat membaik jika payudara sering dikosongkan, ibu cukup istirahar dan melakukan kompres hangat sebelum menyusui. Peserta: ibu dianjurkan untuk tetap menyusi bayi sesering mungkin, mengompres payudara dengan air hangat sebelum menyusui Memperbaiki posisi menyusui dan istirahat yang cukup dan minum banyak cairan. PS : Baik, terima kasih atas informasinya bu bidan

No.	Komponen	Isi
		Bila di temukan Abses Payudara Peserta : ibu, dari hasil pemeriksaan saya menemukan adanya benjolan yang kemungkinan merupakan abses atau Kumpulan nanah pada payudara ibu. PS : apakah harus dioperasi bu bidan ? Peserta : untuk memastikan dan mendapatkan penangganan yang tepat, ibu perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan yang lebih lengkap agar dapat dilakukan penangganan seperti pengeluarab nanah dan pemberian obat yang sesuai Peserta : apakah ada yang ingin ibu tanyakan mengenai kondisi ibu PS: tidak ada bu bidan Peserta : Baik bu, terima kasi atas kerjasamanya. Saya akan mencatat hasil pemeriksaan ibu dan memberikan anjuran yang telah saya sampaikan" Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom payudara - Lembar catatan
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom payudara — 1 3. Lembar catatan — 1 set 4. Tensimeter — 1 5. Stetoskop — 1 6. Termometer — 1 7. Sarung tangan bersih — 1 pasang 8. Kain penutup/selimut — 1 9. Tisu — 1 pack 10. Formulir rujukan — 1 lembar 11. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 12. Pena — 1
13	Penulis	Bdn. Sri Hennyati A, S.ST.,M.Kes.,M.Tr.Keb

No.	Komponen	Isi
14	Referensi	6. Lopez-Gonzalez & Kopparapu. Postpartum Care of The New Mother. Penerbit NCBI Bookshelf. 2022 7. Fitri Khairani Yosefa Dkk. Panduan Kebidanan Pada Masa Nifas (Post Partum); Penerbit Get Press Indonesia. 2025 8. Wulan Wijaya, Tetty Oktavia Limbong, Devi Yulianti. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas: Untuk Sarjana Akademik dan Profesi.; Penerbit Nem. 2023 9. Margareta Rinjani, Iin Wahyuni, dkk. Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas dan Menyusui Berdasarkan Evidance Based. Penerbit Salemba Medika. 2024

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 3: Asuhan Nifas

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Menanyakan sejak kapan keluhan muncul		
3. Menanyakan gejala mastitis (nyeri, bengkak, kemerahan, demam)		
4. Menanyakan riwayat menyusui		
5. Menanyakan apakah ASI tetap keluar atau ada sumbatan		
6. Menanyakan adanya luka atau lecet pada puting		
7. Menanyakan riwayat demam atau menggigil		
8. Menanyakan riwayat masalah payudara sebelumnya		
9. Menanyakan dampak keluhan terhadap proses menyusui		
10. Menggunakan komunikasi terapeutik (ramah, empati)		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 10 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 7-9 dari 10 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–6 dari 10 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Melakukan inspeksi payudara		
b. Melakukan palpasi payudara dengan Teknik yang benar		
c. Mengidentifikasi tanda mastitis (kemerahan, nyeri, bengkak, panas)		
d. Mengidentifikasi tanda abses payudara		
e. Memberikan penatalaksanaan awal mastitis (edukasi menyusui, kompres hangat, istirahat)		
f. menentukan indikasi rujukan pada abses payudara		
3. Pasca tindakan		
a. Memberikan edukasi kepada pasien		
b. Membersihkan dan merapikan alat		
c. Melepas sarung tangan dengan benar		
k. Melakukan cuci tangan setelah tindakan		
l. Melakukan dokumentasi tindakan		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–17 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Membina hubungan baik dengan pasien (salam, sikap ramah)		
2. Menjelaskan kondisi mastitis kepada pasien		
3. Menjelaskan penyebab mastitis		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
4. Memberikan edukasi tentang menyusui atau memerah ASI		
5. Memberikan edukasi tentang kompres hangat dan perawatan payudara		
6.Memberikan edukasi tentang posisi dan perlengkatan menyusui yang benar		
7. Menjelaskan tanda bahaya mastitis dan abses payudara		
8. Menjelasakan perlunya rujukan jika terjadi abses payudara		
9.memberikan kesempatan pasien untuk bertanya		
10. Menyimpulkan hasil konseling dan memastikan pasien memahami		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3**= Jika peserta ujian melakukan semua 10 langkah dengan benar.
- **2**= Jika peserta melakukan 7-9 dari 10 langkah dengan benar.
- **1**= Jika peserta melakukan 1–6 dari 10 langkah dengan benar.
- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Berpenampilan rapi dan sesuai standar praktik (seragam, identitas)		
2. menunjukan sikap sopan dan menghargai pasien		
3. Menjaga privasi dan kerahasian pasien		
4. menunjukkan empati terhadap kondisi pasien		
5. Menggunakan komunikasi yang santun dan mudah dipahami		
6.Bersikaptenang dan percaya diri saat melakukan Tindakan		
7. menghormati Keputusan pasien		
8. Bertanggung jawab terhadap Tindakan yang dilakukan		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 6-7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–5 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 *(dicatat di rubrik penilaian)*

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{45} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mastitis dan Abses Payudara
Metode Penilaian	Metode penilaian keterampilan klinis melalui observasi langsung oleh pembimbing saat mahasiswa melakukan tindakan pada pasien atau simulasi kasus.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan pemeriksaan payudara, mengidentifikasi mastitis, serta memberikan edukasi dan rujukan pada kasus abses payudara.
Tujuan Penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan keterampilan klinis, komunikasi, dan sikap profesional dalam praktik kebidanan.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda mastitis, melakukan pemeriksaan payudara secara benar, memberikan penatalaksanaan awal, dan menentukan indikasi rujukan pada abses payudara.
Kasus Klinik	Skenario kasus yang digunakan dalam penilaian DOPS.	Ibu nifas hari ke-7 mengeluh payudara nyeri, bengkak, kemerahan, dan demam. Pada pemeriksaan ditemukan area kemerahan dan nyeri tekan pada payudara. Pada kasus lain ditemukan benjolan lunak dengan tanda fluktuasi yang mengarah pada abses payudara.
Aktivitas Mahasiswa yang Diamati	Kegiatan mahasiswa saat melakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan kasus.	Mahasiswa melakukan anamnesis, pemeriksaan payudara (inspeksi dan palpasi), mengidentifikasi tanda mastitis/abses, memberikan edukasi menyusui, serta menjelaskan indikasi rujukan pada abses.
Aspek yang Dinilai	Kompetensi yang dinilai selama proses observasi.	Pengumpulan data subjektif, pemeriksaan objektif payudara, penatalaksanaan mastitis, edukasi menyusui, komunikasi terapeutik, serta perilaku profesional.
Fokus Observasi Pembimbing	Hal-hal yang menjadi perhatian utama pembimbing saat mengamati mahasiswa.	Ketepatan teknik pemeriksaan payudara, kemampuan mengenali tanda mastitis dan abses, kemampuan memberikan edukasi yang benar, serta sikap profesional terhadap pasien.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mastitis dan Abses Payudara
Umpan Balik	Masukan yang diberikan pembimbing setelah observasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.	Pembimbing memberikan saran agar mahasiswa melakukan palpasi payudara lebih sistematis dan meningkatkan kejelasan saat menjelaskan tanda bahaya abses kepada pasien.
Keputusan Penilaian	Hasil penilaian terhadap performa mahasiswa setelah observasi dilakukan.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan pemeriksaan payudara dengan benar, mengidentifikasi mastitis, memberikan edukasi yang tepat, dan menentukan rujukan pada abses payudara.
Makna dalam OBE (Outcome Based Education)	Hubungan antara penilaian dengan capaian pembelajaran mahasiswa.	DOPS membantu memastikan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran klinik, yaitu mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan masalah mastitis dan abses payudara secara aman, efektif, dan profesional.

Tabel. Portofolio pada Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mastitis dan Abses Payudara
Hakikat Portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti pembelajaran mahasiswa yang menggambarkan perkembangan kompetensi klinik selama praktik.	Mahasiswa mengumpulkan dokumentasi kasus ibu nifas dengan mastitis atau abses payudara yang pernah ditangani atau disimulasikan selama praktik klinik.
Tujuan Portofolio	Untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan melalui refleksi, dokumentasi kasus, dan evaluasi pembimbing.	Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan dalam melakukan pengkajian, pemeriksaan payudara, penatalaksanaan mastitis, serta menentukan rujukan pada abses payudara.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mastitis dan Abses Payudara
OSCE dan DOPS	Metode penilaian keterampilan klinik yang menjadi bagian dari portofolio mahasiswa.	Mahasiswa mengikuti OSCE pemeriksaan payudara pada kasus mastitis dan dinilai melalui DOPS saat melakukan anamnesis, pemeriksaan payudara, serta memberikan edukasi kepada pasien.
Catatan Kasus Singkat	Ringkasan kasus klinik yang pernah ditangani atau diamati oleh mahasiswa.	Ibu nifas hari ke-5 mengeluh payudara kiri nyeri, bengkak, kemerahan, dan demam. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan dan area kemerahan yang mengarah pada mastitis. Pada kasus lain ditemukan benjolan lunak dengan fluktuasi yang mengarah pada abses payudara sehingga pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih lanjut.
Refleksi Patient Safety	Refleksi mahasiswa mengenai keselamatan pasien selama melakukan asuhan kebidanan.	Mahasiswa menyadari pentingnya teknik pemeriksaan payudara yang lembut, menjaga kebersihan tangan, serta memberikan edukasi kepada ibu untuk tetap menyusui guna mencegah komplikasi lebih lanjut.
Feedback CI / Dosen	Masukan dari Clinical Instructor atau dosen pembimbing terhadap kinerja mahasiswa.	Pembimbing menyarankan mahasiswa untuk meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi tanda abses payudara dan memperjelas edukasi mengenai tanda bahaya yang memerlukan rujukan.
Karakteristik Penilaian	Penilaian bersifat komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis bukti kinerja mahasiswa.	Penilaian dilakukan melalui dokumentasi kasus, hasil OSCE, observasi DOPS, refleksi mahasiswa, serta evaluasi dari pembimbing klinik.
Bukti Konsistensi Kompetensi	Bukti bahwa mahasiswa mampu menunjukkan kompetensi secara konsisten dalam berbagai situasi klinik.	Mahasiswa mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan payudara, memberikan edukasi menyusui, serta mengidentifikasi mastitis dan abses payudara pada beberapa kasus yang berbeda.
Makna dalam OBE (Outcome Based Education)	Menunjukkan ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam pendidikan kebidanan berbasis hasil.	Portofolio menjadi bukti bahwa mahasiswa telah mencapai kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan masalah mastitis dan abses payudara secara aman, efektif, dan profesional.

Tabel: Case Report pada Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mastitis dan Abses Payudara
Hakikat Case Report	Case report merupakan laporan tertulis yang menggambarkan pengalaman mahasiswa dalam menangani suatu kasus klinik secara sistematis, mulai dari pengkajian, diagnosis, hingga penatalaksanaan.	Mahasiswa membuat laporan tentang penanganan ibu nifas yang mengalami mastitis dan kasus abses payudara berdasarkan hasil pengkajian dan tindakan yang dilakukan selama praktik klinik.
Tujuan	Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus klinik secara komprehensif serta mengintegrasikan teori dengan praktik.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda mastitis, melakukan pemeriksaan payudara dengan benar, memberikan penatalaksanaan awal, serta menentukan indikasi rujukan pada kasus abses payudara.
Isi Laporan	Laporan berisi identitas pasien, riwayat kesehatan, hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis kebidanan, penatalaksanaan, dan evaluasi.	Contoh isi laporan: Ibu nifas hari ke-6 mengeluh payudara kiri nyeri, bengkak, kemerahan, dan demam. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan dan pembengkakan pada payudara yang mengarah pada mastitis. Pada kasus lain ditemukan benjolan lunak dengan tanda fluktuasi yang menunjukkan abses payudara sehingga pasien dirujuk untuk penanganan lebih lanjut.
Fokus Penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis kasus klinik dan pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan.	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, pemeriksaan payudara, penegakan diagnosis mastitis atau abses, penatalaksanaan awal, serta pemberian edukasi kepada pasien.
Nilai Edukatif	Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa melalui analisis kasus nyata.	Mahasiswa memahami penyebab mastitis seperti sumbatan saluran ASI atau teknik menyusui yang tidak tepat, serta pentingnya deteksi dini abses payudara untuk mencegah komplikasi.
Makna dalam OBE (Outcome	Case report digunakan untuk menilai ketercapaian capaian	Case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan ilmu kebidanan dalam penanganan ibu nifas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mastitis dan Abses Payudara
Based Education)	pembelajaran mahasiswa secara nyata melalui analisis kasus klinik.	dengan masalah mastitis dan abses payudara secara tepat, aman, dan profesional sesuai kompetensi yang diharapkan.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mastitis dan Abses Payudara
Hakikat Refleksi Patient Safety	Refleksi patient safety merupakan proses evaluasi diri mahasiswa terhadap praktik klinik yang dilakukan dengan fokus pada keselamatan pasien.	Mahasiswa merefleksikan tindakan saat melakukan pemeriksaan payudara pada ibu nifas dengan mastitis serta mempertimbangkan langkah-langkah untuk mencegah risiko komplikasi seperti abses payudara.
Tujuan	Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya keselamatan pasien dalam setiap tindakan klinik.	Mahasiswa memahami pentingnya menjaga kebersihan tangan, melakukan pemeriksaan dengan teknik yang benar, dan memberikan edukasi yang tepat kepada ibu menyusui.
Fokus Refleksi	Aspek-aspek keselamatan pasien yang diperhatikan selama proses asuhan kebidanan.	Fokus refleksi pada teknik pemeriksaan payudara yang aman, komunikasi yang jelas kepada pasien, serta pemberian edukasi mengenai tanda bahaya mastitis dan abses payudara.
Risiko yang Diidentifikasi	Potensi risiko atau masalah yang dapat terjadi pada pasien selama proses pelayanan.	Risiko keterlambatan penanganan mastitis yang dapat berkembang menjadi abses payudara, risiko infeksi akibat teknik pemeriksaan yang tidak steril, serta risiko penghentian menyusui karena kurangnya edukasi kepada ibu.
Tindakan Pencegahan	Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko terhadap pasien.	Melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, menggunakan sarung tangan saat pemeriksaan payudara, melakukan palpasi secara lembut, serta memberikan edukasi kepada ibu agar tetap menyusui atau memerah ASI secara teratur.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Mastitis dan Abses Payudara
Pembelajaran Mahasiswa	Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh mahasiswa dari refleksi kasus klinik.	Mahasiswa memahami pentingnya deteksi dini mastitis, teknik pemeriksaan yang benar, serta edukasi menyusui untuk mencegah komplikasi seperti abses payudara.
Makna dalam OBE (Outcome Based Education)	Refleksi patient safety menunjukkan ketercapaian kompetensi mahasiswa dalam memberikan pelayanan kebidanan yang aman dan berkualitas.	Melalui refleksi ini mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan mastitis dan abses payudara.

B. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 27 tahun P1A0, postpartum hari ke-8, datang ke TPMB. Hasil anamnesis: payudara kiri terasa nyeri, bengkak, dan kemerahan sejak dua hari. Ibu mengalami demam dan menggigil. Puting kiri sempat lecet sehingga ibu jarang menyusui dari payudara tersebut. Hasil pemeriksaan: suhu 38,6°C, payudara kiri tampak kemerahan, teraba panas, padat, dan nyeri tekan, tanpa fluktuasi atau pengeluaran nanah.
   Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Bendungan ASI
   B. Mastitis laktasi
   C. Abses payudara
   D. Sumbatan saluran ASI tanpa inflamasi
   E. Kanker payudara inflamatorik

2. Seorang perempuan berusia 29 tahun P2A0, postpartum hari ke-5, datang ke fasilitas kesehatan. Hasil anamnesis: sejak 10 jam terakhir payudara kanan terasa penuh dan nyeri. Ibu sering menunda menyusui dan merasa pelekatan bayinya belum tepat. Hasil pemeriksaan: suhu 38°C, terdapat kemerahan lokal, payudara teraba padat dan nyeri tekan, tetapi tidak ditemukan benjolan lunak atau fluktuasi. Kondisi umum ibu masih baik.
   Apakah penatalaksanaan awal yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Menghentikan pemberian ASI dari payudara kanan selama 48 jam
   B. Mengurangi asupan cairan dan menggunakan bra yang lebih ketat
   C. Memperbaiki pelekatan, meningkatkan pengosongan payudara, memberikan kompres hangat, dan menganjurkan istirahat

D. Melakukan insisi dan drainase pada bagian payudara yang kemerahan
E. Mengobservasi ibu tanpa intervensi sampai keluhan menghilang sendiri

3. Seorang perempuan berusia 26 tahun P1A0, postpartum hari ke-9, telah mendapat penatalaksanaan konservatif karena mastitis. Hasil anamnesis: setelah 24 jam melakukan pengosongan payudara, kompres hangat, dan istirahat, keluhan tidak membaik. Ibu merasa semakin lemah dan demam tinggi. Hasil pemeriksaan: suhu 39°C, daerah kemerahan semakin luas, payudara teraba panas dan nyeri, tetapi belum ditemukan fluktuasi.
   Apakah penatalaksanaan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Melanjutkan penatalaksanaan konservatif saja selama tiga hari
   B. Menghentikan menyusui dan membuang seluruh ASI yang diproduksi
   C. Melakukan aspirasi jarum pada daerah kemerahan tanpa pemeriksaan lebih lanjut
   D. Memberikan antibiotik sesuai indikasi disertai pengosongan payudara dan perawatan suportif
   E. Membalut payudara dengan tekanan kuat untuk mengurangi produksi ASI

4. Seorang perempuan berusia 31 tahun P3A0, postpartum hari ke-18, datang ke puskesmas. Hasil anamnesis: ibu pernah mengalami mastitis empat hari sebelumnya, tetapi tidak menjalani pengobatan secara adekuat. Saat ini nyeri payudara semakin hebat, benjolan semakin membesar, disertai demam dan menggigil. Hasil pemeriksaan: suhu 39,1°C, payudara tampak merah dan bengkak, serta teraba benjolan lunak dengan fluktuasi. Kondisi umum ibu tampak lemah.
   Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Menganjurkan kompres hangat dan pemantauan mandiri di rumah
   B. Menghentikan seluruh proses pengosongan payudara sampai demam turun
   C. Melakukan pemijatan kuat agar benjolan pecah secara spontan
   D. Menjadwalkan kunjungan ulang satu minggu kemudian tanpa terapi tambahan
   E. Merujuk ibu untuk tindakan drainase dan pemberian antibiotik sesuai indikasi

5. Seorang perempuan berusia 30 tahun P2A0, postpartum hari ke-14, mengalami mastitis dan telah mendapatkan antibiotik selama 48 jam. Hasil anamnesis: demam, kemerahan, dan nyeri payudara belum menunjukkan perbaikan. Hasil pemeriksaan: payudara tetap teraba panas dan nyeri tekan. Tenaga kesehatan

merencanakan pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas ASI untuk menentukan terapi selanjutnya.

Bagaimanakah teknik pengambilan bahan kultur yang paling tepat?

A. Membersihkan puting, kemudian menampung ASI pancar tengah hasil perahan tangan ke dalam wadah steril tanpa menyentuhkan bibir wadah pada putting
B. Menampung tetesan pertama ASI tanpa membersihkan puting ke dalam botol susu yang biasa digunakan
C. Mengambil bahan kultur dengan mengusap permukaan kulit payudara yang kemerahan menggunakan kapas biasa
D. Memompa seluruh ASI ke dalam botol penyimpanan rumah tangga dan mengirimkannya ke laboratorium
E. Menampung ASI yang keluar dari puting menggunakan kasa, kemudian memeras kasa ke dalam wadah pemeriksaan

Kunci Jawaban

1. **B**. Mastitis laktasi
2. **C**. Memperbaiki pelekatan, meningkatkan pengosongan payudara, memberikan kompres hangat, dan menganjurkan istirahat
3. **D**. Memberikan antibiotik sesuai indikasi disertai pengosongan payudara dan perawatan suportif
4. **E**. Merujuk ibu untuk tindakan drainase dan pemberian antibiotik sesuai indikasi
5. **A**. Membersihkan puting, kemudian menampung ASI pancar tengah hasil perahan tangan ke dalam wadah steril tanpa menyentuhkan bibir wadah pada puting

Pembahasan

1. Jawaban: **B**. Mastitis laktasi

   Kata kunci: postpartum hari ke-8, ibu menyusui, puting lecet, jarang menyusui, demam, kemerahan, payudara panas, padat, dan nyeri tekan.

   Kasus menunjukkan gambaran khas mastitis laktasi. Pengosongan payudara yang tidak optimal karena ibu jarang menyusui dari payudara kiri menyebabkan stasis ASI dan peningkatan tekanan di dalam saluran ASI. Puting yang lecet juga dapat menjadi jalan masuk bakteri ke jaringan payudara. Keadaan tersebut memicu peradangan dan infeksi yang ditandai dengan nyeri, kemerahan, pembengkakan, peningkatan suhu lokal, demam, serta menggigil.

   Alasan opsi lain tidak tepat:

a. A. Bendungan ASI: dapat menyebabkan payudara penuh dan tegang, tetapi tanda inflamasi sistemik seperti demam dan menggigil lebih mendukung mastitis.
b. C. Abses payudara: biasanya ditandai benjolan lunak dengan fluktuasi atau kumpulan nanah. Pada kasus belum ditemukan fluktuasi.
c. D. Sumbatan saluran ASI tanpa inflamasi: tidak sesuai karena sudah terdapat kemerahan, demam, dan tanda peradangan.
d. E. Kanker payudara inflamatorik: gejalanya dapat menyerupai mastitis, tetapi faktor laktasi, puting lecet, stasis ASI, dan onset akut lebih mendukung mastitis.

2. Jawaban: C. Memperbaiki pelekatan, meningkatkan pengosongan payudara, memberikan kompres hangat, dan menganjurkan istirahat

   Kata kunci: keluhan kurang dari 24 jam, kondisi umum baik, pelekatan tidak tepat, jeda menyusui panjang, tidak ada fluktuasi.

   Pada mastitis dengan gejala ringan yang berlangsung kurang dari 24 jam, penatalaksanaan konservatif dapat dilakukan terlebih dahulu. Fokus utama adalah memperbaiki aliran ASI karena stasis ASI merupakan masalah yang sering mengawali mastitis. Ibu dianjurkan lebih sering menyusui atau memerah ASI, memperbaiki posisi dan pelekatan bayi, melakukan kompres hangat, serta cukup beristirahat.

   Menyusui dapat dimulai dari payudara yang bermasalah. Namun, apabila nyeri sangat berat, ibu dapat mulai menyusui dari payudara yang sehat dan segera memindahkan bayi ke payudara yang bermasalah setelah refleks pengeluaran ASI terjadi.

   Alasan opsi lain tidak tepat:

   a. **A:** menghentikan menyusui dapat memperberat stasis ASI.
   b. **B:** penggunaan bra ketat merupakan salah satu faktor risiko tertekannya saluran ASI.
   c. **D:** insisi dan drainase dilakukan apabila telah terbentuk abses, bukan pada mastitis tanpa fluktuasi.
   d. **E:** observasi tanpa pengosongan payudara dapat menyebabkan peradangan berkembang menjadi abses.

3. Jawaban: **D**. Memberikan antibiotik sesuai indikasi disertai pengosongan payudara dan perawatan suportif

   Kata kunci: tidak membaik setelah 24 jam, demam tinggi, kondisi umum memburuk, kemerahan meluas.

   Materi menyebutkan bahwa apabila mastitis ringan berlangsung kurang dari 24 jam, perawatan konservatif dapat diberikan. Namun, apabila tidak terdapat

perbaikan dalam 12–24 jam atau ibu tampak sakit berat, antibiotik perlu segera diberikan. Pengobatan antibiotik tetap harus disertai upaya memperlancar aliran ASI, memperbaiki teknik menyusui, mengurangi nyeri, dan mencukupi kebutuhan istirahat ibu.

Dalam materi, antibiotik yang biasa digunakan antara lain dikloksasilin atau flukloksasilin 500 mg setiap enam jam secara oral sesuai indikasi. Pemberian obat harus mengikuti penilaian klinis dan tata laksana tenaga kesehatan yang berwenang.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. **A**: melanjutkan terapi konservatif saja dapat memperlambat penanganan infeksi.
b. **B**: penghentian menyusui dapat meningkatkan stasis ASI.
c. **C**: aspirasi dilakukan pada abses yang telah terbentuk; kasus belum menunjukkan fluktuasi.
d. **E:** tekanan kuat pada payudara dapat semakin menghambat aliran ASI dan meningkatkan nyeri.

4. Jawaban: **E**. Merujuk ibu untuk tindakan drainase dan pemberian antibiotik sesuai indikasi

   Kata kunci: riwayat mastitis tidak tertangani, nyeri hebat, benjolan membesar, demam tinggi, kondisi lemah, dan fluktuasi.

   Fluktuasi menunjukkan adanya kumpulan cairan atau nanah di dalam jaringan payudara. Kombinasi nyeri hebat, pembengkakan, kemerahan, demam tinggi, dan benjolan lunak dengan fluktuasi sangat mengarah pada abses payudara sebagai komplikasi mastitis yang tidak tertangani dengan baik.

   Abses payudara memerlukan tindakan medis untuk mengeluarkan nanah, yaitu melalui aspirasi jarum atau insisi dan drainase. Antibiotik, analgesik, atau antipiretik dapat diberikan sesuai indikasi. Ibu perlu dirujuk karena telah ditemukan benjolan berfluktuasi, demam tinggi, pembengkakan yang membesar, dan kondisi umum yang memburuk.

   Alasan opsi lain tidak tepat:

   a. **A**: kompres hangat saja tidak dapat mengeluarkan kumpulan nanah.
   b. **B**: menghentikan pengosongan payudara dapat memperburuk stasis ASI.
   c. **C**: pemijatan kuat berisiko menambah nyeri dan kerusakan jaringan.
   d. **D**: penundaan selama satu minggu berisiko menyebabkan infeksi semakin luas atau berkembang menjadi infeksi sistemik.

5. Jawaban: A. Membersihkan puting, kemudian menampung ASI pancar tengah hasil perahan tangan ke dalam wadah steril tanpa menyentuhkan bibir wadah pada puting

Kata kunci: tidak membaik setelah antibiotik selama 48 jam, kultur dan uji sensitivitas, ASI pancar tengah, wadah steril.

Pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas dianjurkan ketika pengobatan antibiotik tidak memberikan respons yang baik dalam dua hari. Pemeriksaan tersebut juga dapat dipertimbangkan pada mastitis berulang, mastitis yang terjadi di rumah sakit, kasus berat, atau apabila pasien memiliki alergi terhadap antibiotik.

Bahan kultur diambil dari ASI pancar tengah hasil perahan tangan. Puting harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ASI ditampung menggunakan wadah steril, seperti penampung urin steril. Bibir wadah tidak boleh menyentuh puting karena kontak tersebut dapat menyebabkan kontaminasi bakteri dari kulit dan menimbulkan hasil kultur positif palsu.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. **B**: tetesan awal dan puting yang tidak dibersihkan meningkatkan risiko kontaminasi.
b. **C**: swab kulit tidak menggambarkan organisme yang terdapat di dalam ASI.
c. **D**: botol rumah tangga tidak menjamin sterilitas bahan pemeriksaan.
d. **E**: penggunaan kasa berisiko mencemari dan menyerap sebagian bahan kultur.

C. Ringkasan Materi

Mastitis merupakan peradangan pada jaringan payudara yang sering terjadi pada ibu menyusui, terutama pada masa nifas. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sumbatan saluran ASI, pengosongan payudara yang tidak optimal, teknik menyusui yang tidak tepat, atau adanya luka pada puting yang memungkinkan masuknya bakteri. Bakteri yang paling sering menyebabkan mastitis adalah *Staphylococcus aureus*. Mastitis umumnya terjadi pada minggu pertama hingga minggu keenam setelah persalinan.

Gejala mastitis meliputi nyeri pada payudara, pembengkakan, kemerahan, payudara terasa hangat, demam, serta rasa tidak nyaman saat menyusui. Pada pemeriksaan dapat ditemukan area payudara yang keras dan nyeri saat ditekan. Penanganan mastitis bertujuan untuk mengurangi peradangan, memperlancar aliran ASI, dan mencegah komplikasi. Ibu dianjurkan untuk tetap menyusui atau memerah ASI secara teratur, melakukan kompres hangat sebelum menyusui, memperbaiki posisi dan perlekatan bayi saat menyusui, serta cukup istirahat dan menjaga asupan nutrisi.

Jika mastitis tidak ditangani dengan baik atau terjadi keterlambatan penanganan, kondisi ini dapat berkembang menjadi abses payudara, yaitu kumpulan nanah di dalam jaringan payudara akibat infeksi yang lebih lanjut. Abses payudara ditandai dengan nyeri hebat, pembengkakan lokal, kemerahan, demam

tinggi, serta adanya benjolan lunak dengan tanda fluktuasi. Penatalaksanaan abses payudara biasanya memerlukan tindakan drainase atau pengeluaran nanah serta pemberian antibiotik. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan mastitis sangat penting untuk mencegah terjadinya abses payudara serta menjaga keberlangsungan proses menyusui.

D. Alur asuhan Singkat

Produksi ASI tidak dikosongkan dengan baik Terjadi sumbatan saluran ASI ASI tertahan dalam payudara Terjadi peradangan jaringan payudara (Mastitis) Muncul gejala: nyeri, kemerahan, bengkak, demam Jika tidak ditangani dengan baik Infeksi berkembang dan terbentuk kumpulan nanah Terjadi Abses Payudara lakukan rujuan lakukan drainase pada payudara.

Tabel Red Flags & Eskalasi pada Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan

Kondisi Klinis	Tanda Klinis (Red Flags)	Tatalaksana Awal	Kriteria Rujukan / Eskalasi
Mastitis ringan	Nyeri pada payudara, kemerahan lokal, payudara terasa hangat, pembengkakan ringan, demam ringan (<38,5°C)	Anjurkan tetap menyusui atau memerah ASI, kompres hangat sebelum menyusui, perbaiki posisi dan perlekatan menyusui, istirahat cukup, meningkatkan asupan cairan	Observasi dan evaluasi dalam 24–48 jam
Mastitis sedang	Nyeri payudara semakin berat, kemerahan meluas, demam ≥38,5°C, tubuh lemah	Penatalaksanaan mastitis + pemberian analgesik/antipiretik, edukasi pengosongan payudara secara teratur	Rujuk jika tidak membaik dalam 48 jam
Curiga abses payudara	Nyeri hebat, pembengkakan lokal, benjolan lunak dengan fluktuasi, kemerahan luas, demam tinggi	Hentikan pemijatan pada area abses, berikan edukasi kepada ibu, pertahankan pengosongan ASI dari payudara yang tidak terkena	Rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut
Abses payudara	Benjolan berisi nanah, nyeri sangat hebat, demam tinggi, kemungkinan keluar cairan/nanah dari payudara	Stabilkan kondisi ibu, berikan edukasi dan dukungan menyusui	Rujuk untuk tindakan medis seperti drainase abses dan terapi antibiotik

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Bab: Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik/Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian mastitis pada ibu menyusui	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian abses payudara	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda klinis mastitis (nyeri, kemerahan, bengkak, demam)	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda klinis abses payudara (benjolan dengan fluktuasi, nyeri hebat, demam)	☐	☐	
5	Saya sudah bisa melakukan pengkajian awal pada ibu dengan keluhan nyeri payudara	☐	☐	
6	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan payudara secara sistematis (inspeksi dan palpasi)	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menjelaskan tatalaksana awal mastitis	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu untuk tetap menyusui atau memerah ASI	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menjelaskan penggunaan kompres hangat pada mastitis	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang teknik menyusui yang benar	☐	☐	
11	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya atau red flags pada mastitis	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan kapan pasien perlu dirujuk	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menjelaskan penatalaksanaan awal pada kasus abses payudara	☐	☐	
14	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya penanganan abses payudara	☐	☐	
15	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

E. Referensi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kemenkes RI.

Saleha, S. (2022). *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Salemba Medika.

Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). London: Elsevier.

Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2021). *Varney's Midwifery* (6th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

World Health Organization. (2022). *Postpartum Care of the Mother and Newborn*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2000). *Mastitis: Causes and Management*. Geneva: WHO.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Jakarta: Kemenkes RI.

International Confederation of Midwives. (2023). *Essential Competencies for Midwifery Practice*.

Mitchell, K. B., et al. (2022). *Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol: The Mastitis Spectrum*. Breastfeeding Medicine.

World Health Organization. 2023. *Breastfeeding counselling: a training course*. Geneva.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar*.

International Confederation of Midwives. 2021. *Essential Competencies for Midwifery Practice*.

Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2022. *Pedoman Praktik Klinis Laktasi dan ASI*.

BAB 4

Tromboemboli dan Komplikasi Sistemik Nifas: Deteksi Dini, Tanda Bahaya, dan Rujukan

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, dokumentasi, dan tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5; CPMK-7; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.
CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.

CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

Uraian Materi

Masa nifas merupakan periode transisi fisiologis yang penting, tetapi juga menjadi fase dengan peningkatan risiko komplikasi maternal yang serius, termasuk tromboemboli vena dan berbagai komplikasi sistemik yang dapat mengancam jiwa ibu. Risiko tromboemboli meningkat terutama pada minggu-minggu awal pascapersalinan karena tubuh ibu berada dalam keadaan hiperkoagulabel sebagai mekanisme fisiologis untuk mencegah perdarahan. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut justru meningkatkan kecenderungan terbentuknya trombus, terutama bila disertai faktor risiko seperti seksio sesarea, imobilisasi, obesitas, infeksi, perdarahan postpartum, usia maternal lanjut, atau riwayat tromboemboli sebelumnya (Blondon & Skeith, 2022; Maughan et al., 2022).

Secara klinis, tromboemboli pada masa nifas paling sering bermanifestasi sebagai trombosis vena dalam (deep vein thrombosis/DVT) dan emboli paru (pulmonary embolism/PE). DVT umumnya terjadi pada vena dalam ekstremitas bawah atau pelvis, sedangkan PE terjadi ketika sebagian trombus terlepas dan terbawa ke sirkulasi paru sehingga menimbulkan gangguan pertukaran gas, hipoksemia, gangguan hemodinamik, bahkan kematian mendadak bila tidak segera dikenali. Selain tromboemboli, bidan juga harus mampu mempertimbangkan komplikasi sistemik lain yang dapat memberikan gambaran klinis serupa, seperti sepsis puerperalis, postpartum preeclampsia/eclampsia, edema paru, dan peripartum cardiomyopathy (Hauspurg & Jeyabalan, 2022; WHO, 2022).

Karena gejala awal kerap tidak spesifik dan dapat saling tumpang tindih, maka pendekatan yang aman di pelayanan primer adalah melakukan pengkajian cepat dan sistematis, mengenali tanda bahaya, melakukan stabilisasi dasar sesuai kewenangan, dan merujuk ibu secara cepat dan tepat. Prinsip ini sejalan dengan rekomendasi penatalaksanaan VTE akut pada kehamilan dan puerperium yang menekankan pentingnya respons awal yang cepat dan komunikasi rujukan yang efektif (RCOG, 2023; Queensland Clinical Guidelines, 2025).

F. Definisi

Tromboemboli adalah keadaan terbentuknya trombus di dalam sistem vena yang dapat menetap di tempat asal atau terlepas dan menyumbat pembuluh darah di organ lain. Pada masa nifas, bentuk yang paling penting adalah DVT, yaitu pembentukan trombus pada vena dalam—umumnya di tungkai atau pelvis—serta PE, yaitu penyumbatan arteri pulmonalis atau cabangnya oleh embolus yang biasanya berasal dari trombus vena dalam. PE merupakan salah satu komplikasi paling berbahaya karena dapat menyebabkan hipoksemia, instabilitas hemodinamik, hingga kolaps mendadak (Maughan et al., 2022).

Komplikasi sistemik nifas adalah gangguan kesehatan pada masa postpartum yang tidak hanya terbatas pada organ reproduksi, tetapi melibatkan sistem tubuh secara luas, seperti sistem respirasi, kardiovaskular, neurologis, dan imunologis. Dalam konteks bab ini, komplikasi sistemik nifas yang penting dibedakan dari tromboemboli meliputi sepsis puerperalis, hipertensi postpartum dengan komplikasi neurologis atau edema paru, serta peripartum cardiomyopathy (WHO, 2022; Hauspurg & Jeyabalan, 2022).

G. Etiologi

Etiologi tromboemboli pada masa nifas bersifat multifaktorial dan terutama dijelaskan melalui triad Virchow, yaitu hiperkoagulabilitas, stasis vena, dan cedera endotel. Hiperkoagulabilitas pada postpartum merupakan bagian dari adaptasi fisiologis kehamilan dan persalinan. Stasis vena dipengaruhi oleh berkurangnya mobilitas, nyeri pascapersalinan, tirah baring, dan perubahan sirkulasi selama kehamilan dan nifas. Cedera endotel dapat terjadi akibat trauma persalinan, tindakan operatif seperti seksio sesarea, inflamasi, maupun infeksi. Interaksi ketiga faktor ini menyebabkan meningkatnya kemungkinan terbentuknya trombus pada ibu nifas (Blondon & Skeith, 2022; Maughan et al., 2022).

Etiologi komplikasi sistemik nifas lainnya bergantung pada penyebab dasar masing-masing. Sepsis puerperalis terjadi akibat infeksi yang berkembang menjadi respons inflamasi sistemik dan berpotensi menimbulkan disfungsi organ. Postpartum preeclampsia/eclampsia berkaitan dengan disfungsi endotel dan gangguan regulasi vaskular yang dapat menetap atau baru muncul setelah persalinan. Sementara itu, peripartum cardiomyopathy merupakan bentuk gagal jantung yang timbul pada akhir kehamilan atau dalam beberapa bulan setelah persalinan akibat gangguan fungsi miokard (WHO, 2022; Sigauke et al., 2024).

H. Faktor Risiko

Faktor risiko tromboemboli pada masa nifas meliputi riwayat VTE sebelumnya, trombofilia, obesitas, usia maternal yang lebih tua, merokok, imobilisasi, seksio sesarea, perdarahan postpartum, infeksi, transfusi darah, dan komorbid tertentu. Faktor-faktor ini dapat berdiri sendiri atau saling memperkuat sehingga meningkatkan risiko terbentuknya trombus. Dalam praktik, riwayat tromboemboli dan trombofilia merupakan faktor risiko kuat, sedangkan obesitas, usia di atas 35 tahun, seksio sesarea, infeksi, dan komplikasi obstetri lain meningkatkan kewaspadaan klinis, terutama bila hadir bersamaan (RCOG, 2023; Maughan et al., 2022).

Faktor risiko komplikasi sistemik nifas lain juga harus dinilai sejak awal. Risiko sepsis meningkat pada ibu dengan ketuban pecah lama, infeksi luka operasi atau luka jalan lahir, manipulasi intrauterin, dan higiene yang buruk. Risiko postpartum preeclampsia meningkat pada ibu dengan riwayat hipertensi dalam kehamilan atau preeklampsia. Risiko peripartum cardiomyopathy lebih patut dicurigai pada ibu dengan gejala gagal jantung yang tidak sesuai dengan perubahan nifas normal (WHO, 2022; Hauspurg & Jeyabalan, 2022).

I. Patofisiologi

Patofisiologi tromboemboli nifas berawal dari terbentuknya trombus vena akibat kombinasi hiperkoagulabilitas, stasis aliran darah, dan kerusakan endotel. Trombus yang terbentuk pada vena dalam tungkai atau pelvis dapat menyebabkan obstruksi lokal sehingga timbul nyeri, edema, kemerahan, dan rasa hangat pada tungkai. Bila sebagian trombus terlepas, embolus dapat mencapai sirkulasi paru dan menyumbat arteri pulmonalis. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian ventilasi-perfusi, hipoksemia, peningkatan beban jantung kanan, dan pada kasus berat dapat berkembang menjadi syok obstruktif (Maughan et al., 2022).

Pada komplikasi sistemik lain, mekanismenya berbeda. Sepsis puerperalis menimbulkan vasodilatasi sistemik, peningkatan permeabilitas kapiler, hipotensi, dan gangguan perfusi organ akibat respons inflamasi berat. Postpartum preeclampsia menyebabkan disfungsi endotel dan vasospasme yang dapat memicu hipertensi berat, edema paru, gangguan neurologis, dan eklampsia. Peripartum cardiomyopathy menyebabkan penurunan fungsi sistolik ventrikel kiri sehingga timbul kongesti paru dan gejala gagal jantung (Hauspurg & Jeyabalan, 2022; Sigauke et al., 2024).

J. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis DVT biasanya berupa nyeri tungkai, bengkak unilateral, kemerahan, rasa hangat, dan nyeri tekan pada betis atau paha. Keluhan ini sering tampak progresif dan harus dibedakan dari edema tungkai postpartum biasa yang umumnya bilateral dan tidak disertai nyeri lokal bermakna. Emboli paru umumnya memberikan gejala yang lebih akut, seperti sesak napas mendadak, nyeri dada pleuritik, takipnea, takikardia, penurunan saturasi oksigen, pusing, sinkop, dan kadang hemoptisis. Pada kondisi yang lebih berat dapat ditemukan hipotensi, sianosis, penurunan kesadaran, atau kolaps sirkulasi (Maughan et al., 2022; Moroi et al., 2024).

Manifestasi komplikasi sistemik nifas lain perlu dibedakan secara cermat. Sepsis puerperalis dapat muncul dengan demam atau hipotermia, menggigil,

takipnea, takikardia, hipotensi, dan penurunan kondisi umum. Postpartum preeclampsia sering muncul pada minggu pertama hingga kedua postpartum dengan nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, hipertensi, dan dapat disertai sesak akibat edema paru. Peripartum cardiomyopathy biasanya menimbulkan sesak progresif, orthopnea, edema, kelelahan, batuk, atau ronki paru (WHO, 2022; Hauspurg & Jeyabalan, 2022; Sigauke et al., 2024).

K. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada suspek tromboemboli bertujuan untuk menegakkan diagnosis dan menilai tingkat keparahan. Pada suspek DVT, pemeriksaan yang paling umum digunakan adalah ultrasonografi Doppler vena. Pada suspek PE, pemeriksaan di fasilitas rujukan dapat meliputi elektrokardiografi, foto toraks, analisis gas darah, serta pencitraan definitif seperti CT pulmonary angiography atau ventilation-perfusion scan sesuai indikasi klinis (RCOG, 2023; Maughan et al., 2022).

Untuk komplikasi sistemik lain, pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan kecurigaan klinis. Pada sepsis diperlukan darah lengkap, kultur, dan penilaian fungsi organ. Pada postpartum preeclampsia diperlukan pengukuran tekanan darah serial dan evaluasi organ target. Pada peripartum cardiomyopathy, pemeriksaan EKG dan ekokardiografi sangat membantu. Di layanan primer, bidan tidak menunggu seluruh pemeriksaan definitif untuk memutuskan rujukan; fokus utama tetap pada tanda vital, saturasi oksigen, penilaian klinis, dan dokumentasi temuan secara akurat (WHO, 2022; Queensland Clinical Guidelines, 2025).

Tabel 4.1 Stratifikasi risiko VTE pada masa nifas

Kelompok Risiko	Faktor Risiko	Implikasi Tindak Lanjut
Tinggi	Riwayat VTE; trombofilia kuat; imobilisasi berat; sepsis/perdarahan masif; operasi besar	Waspada red flags; rujuk emergensi bila gejala; rencana profilaksis biasanya oleh RS/DPJP.
Sedang	Seksio sesarea; obesitas; usia ≥35; merokok; varises berat; infeksi; transfusi; preeklampsia	Edukasi mobilisasi/hidrasi; skrining gejala; rendah ambang untuk rujukan.
Rendah	Tanpa faktor risiko tambahan	Edukasi universal: mobilisasi dini, hidrasi cukup, kenali tanda bahaya.

Sumber: diolah dari RCOG (2023), Maughan et al. (2022), dan prinsip keselamatan layanan primer.

L. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan tromboemboli dan komplikasi sistemik nifas di layanan primer berfokus pada deteksi dini, stabilisasi awal, dan rujukan cepat. Bila terdapat kecurigaan terhadap PE atau komplikasi sistemik berat, bidan harus segera melakukan penilaian ABCDE, mengukur tanda vital lengkap termasuk SpO_2, menjaga jalan napas, memberikan oksigen bila diperlukan, memosisikan ibu semi-Fowler bila sesak, meminimalkan aktivitas, dan memasang akses intravena sesuai kewenangan serta SOP bila ada indikasi. Pada suspek DVT, tungkai tidak boleh dipijat atau dimanipulasi berlebihan. Semua tindakan, respons pasien, dan waktu kejadian harus didokumentasikan secara sistematis (RCOG, 2023; Queensland Clinical Guidelines, 2025).

Pendekatan ABCDE di layanan primer dilakukan sebagai berikut:

1. A (Airway)

   Pastikan jalan napas paten dan nilai kemampuan ibu berbicara.
2. B (Breathing)

   Ukur frekuensi napas dan SpO_2; berikan oksigen bila SpO_2 rendah atau ibu tampak distress.
3. C (Circulation)

   Nilai nadi, tekanan darah, CRT, dan tanda syok; pasang akses IV dan siapkan cairan sesuai SOP bila diperlukan.
4. D (Disability)

   Nilai kesadaran (AVPU/GCS), pusing/sinkop, serta gejala neurologis seperti kejang atau defisit fokal.
5. E (Exposure)

   Periksa tungkai untuk bengkak unilateral, tanda infeksi, atau perdarahan; jaga privasi dan kehangatan pasien.

Tabel 4.2 Red flags yang memerlukan rujukan emergensi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan
Sesak mendadak dengan SpO_2 <94% atau memburuk cepat	Suspek PE/kompromi respirasi	Oksigen, monitoring, rujuk emergensi (ambulans bila tersedia).
Nyeri dada hebat, hemoptisis, sinkop/kolaps	PE berat/risiko kolaps	Aktifkan rujukan emergensi dan transport aman.
Takikardia menetap, hipotensi, tanda syok	Kompromi sirkulasi	Akses IV + stabilisasi sesuai SOP; rujuk segera.
Nyeri/bengkak tungkai unilateral signifikan + dispnea	DVT dengan risiko embolisasi	Minimalkan mobilisasi; rujuk emergensi.

Defisit neurologis/kejang/nyeri kepala hebat + hipertensi	Suspek eklampsia postpartum/stroke	Stabilisasi sesuai SOP; rujuk emergensi.
Demam tinggi/hipotermia + kondisi memburuk	Suspek sepsis puerperalis	PPI ketat; stabilisasi awal; rujuk emergensi.

Sumber: diolah dari RCOG (2023), WHO (2022), dan Queensland Clinical Guidelines (2025).

M. Dokumentasi Klinis Pra-Rujukan

Karena Sub-CPMK 11.2 menekankan triase, stabilisasi, rujukan segera, dan dokumentasi klinis, maka dokumentasi pra-rujukan harus dibuat ringkas, jelas, dan dapat ditindaklanjuti oleh fasilitas penerima. Dokumentasi yang baik juga menunjukkan ketercapaian CPMK-1 (profesionalisme, keselamatan, dan dokumentasi) serta CPMK-2 (ketepatan pengkajian dan interpretasi tanda vital).

Unsur minimal dokumentasi klinis pra-rujukan adalah sebagai berikut:

1. Identitas pasien dan usia nifas.
2. Keluhan utama, onset, dan faktor risiko yang relevan.
3. Hasil pengkajian cepat: kesadaran, TTV, SpO_2, dan temuan fisik penting.
4. Red flags yang ditemukan dan diagnosis kerja/ masalah prioritas.
5. Tindakan awal yang telah dilakukan, waktu pelaksanaan, dan respons pasien.
6. Keputusan rujukan, tujuan rujukan, nama petugas/ rujukan penerima, serta waktu keberangkatan.

Contoh format SOAP singkat pra-rujukan:

S	Ibu nifas hari ke-8 mengeluh sesak mendadak sejak 2 jam, nyeri dada saat tarik napas, dan pusing.
O	TD 90/60 mmHg, N 124 x/menit, RR 30 x/menit, SpO_2 90% RA, tungkai kiri bengkak dan nyeri tekan.
A	Suspek tromboemboli/emboli paru dengan risiko kegawatan respirasi dan sirkulasi.
P	ABCDE, oksigen, monitoring serial, siapkan rujukan emergensi, lakukan SBAR dan resume rujukan.

Setelah stabilisasi awal, sistem rujukan harus segera diaktifkan. Komunikasi dengan fasilitas penerima sebaiknya menggunakan format SBAR agar informasi penting tersampaikan secara cepat dan jelas. Resume rujukan perlu memuat identitas pasien, usia nifas, faktor risiko, onset keluhan, hasil pengkajian, tanda vital, saturasi oksigen, temuan red flags, tindakan awal yang telah dilakukan, dan respons pasien (RCOG, 2023).

Contoh format komunikasi SBAR:

S (Situation)	Ibu nifas hari ke-… dengan sesak mendadak/nyeri dada; suspek PE.
B (Background)	Riwayat persalinan (SC/normal), faktor risiko VTE, dan riwayat penyakit/obat.
A (Assessment)	TTV dan SpO_2 terakhir; temuan klinis seperti bengkak unilateral, nyeri dada, atau tanda syok.
R (Recommendation)	Mohon penerimaan rujukan emergensi; kebutuhan penanganan lanjutan di fasilitas rujukan.
Read-back	Konfirmasi instruksi, waktu kedatangan, dan nama penerima rujukan.

Tabel 4.3

Prioritas rujukan dan tindakan pra-rujukan (primer)

Kondisi/Red Flags	Prioritas	Tindakan Pra-Rujukan (Primer)	Catatan Komunikasi
Suspek PE: sesak/nyeri dada, SpO_2 menurun, takikardia/hipotensi	Emergensi	ABCDE, O_2, posisi nyaman, akses IV, monitor, siapkan transport	SBAR + onset + respons O_2; closed-loop
DVT: nyeri/bengkak tungkai unilateral tanpa instabilitas	Segera	Evaluasi red flags, edukasi, rujuk konfirmasi	Catat faktor risiko dan durasi keluhan
Sepsis puerperalis: demam/hipotermia + memburuk	Emergensi	PPI, ABCDE, stabilisasi sesuai SOP, rujuk	SBAR + TTV serial
Hipertensi postpartum berat/kejang/nyeri kepala hebat	Emergensi	ABCDE, tata laksana awal sesuai SOP, rujuk	SBAR + TD + gejala neuro
Gagal jantung/peripartum cardiomyopathy/edema paru	Emergensi	O_2, posisi duduk, monitor, rujuk	SBAR + ronki/orthopnea + SpO_2

Sumber: diolah dari RCOG (2023), WHO (2022), dan Queensland Clinical Guidelines (2025).

N. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang ibu nifas hari ke-8, usia 32 tahun, P2A0, datang ke Puskesmas dengan keluhan sesak napas mendadak sejak 2 jam, nyeri dada saat menarik napas, dan pusing. Riwayat persalinan: seksio sesarea 8 hari lalu. Sejak pulang, ibu lebih banyak berbaring karena nyeri luka. Riwayat medis: obesitas (IMT 32), tidak ada riwayat asma. Pemeriksaan awal: kesadaran compos mentis, TD 90/60 mmHg, N 124 x/menit, RR 30 x/menit, SpO_2 90% RA, suhu 36,9°C. Pada tungkai kiri tampak bengkak dibanding kanan dan terasa nyeri saat ditekan.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Keluhan respirasi akut dengan instabilitas awal (RR meningkat, SpO_2 menurun).
2. Terdapat faktor risiko kuat tromboemboli: seksio sesarea, imobilisasi, dan obesitas.
3. Ditemukan gejala perifer yang mendukung DVT, yaitu bengkak unilateral dan nyeri tekan betis.
4. Kasus memerlukan triase cepat, stabilisasi dasar, dan rujukan emergensi.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama dan diagnosis kerja yang paling mungkin?
2. Data apa saja yang mendukung kecurigaan tromboemboli?
3. Sebutkan minimal 5 faktor risiko VTE pada kasus ini.
4. Red flags apa yang sudah muncul? Tentukan tingkat kegawatan.
5. Apa langkah tindakan awal berbasis ABCDE yang harus dilakukan bidan di layanan primer?
6. Informasi penting apa yang harus disampaikan kepada ibu/keluarga sebelum rujukan?
7. Susun komunikasi rujukan singkat dengan format SBAR.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok, identifikasi data kunci, dan susun prioritas masalah secara berurutan.
2. Gunakan sumber referensi yang relevan untuk mendukung jawaban, lalu kaitkan dengan deteksi dini, keselamatan pasien, dan urgensi rujukan.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis, menggunakan bahasa ilmiah, logis, dan ringkas.

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab triase ibu nifas dengan kecurigaan tromboemboli/komplikasi sistemik. Fokus urutan tindakan (ABCDE) + komunikasi SBAR + keselamatan (PPI/K3) + dokumentasi pra-rujukan.

Desain simulasi/skill lab:

1. Setting: ruang tindakan Puskesmas/klinik; pasien simulasi ibu nifas dengan sesak + faktor risiko VTE.
2. Tujuan latihan: mahasiswa mampu melakukan triase cepat, stabilisasi dasar, dan menyiapkan rujukan dengan komunikasi SBAR.
3. Output: (1) checklist tindakan ABCDE, (2) resume rujukan singkat, (3) SBAR lisan (role-play).
4. Durasi: 10–12 menit/stasiun; debrief 5 menit (umpan balik keselamatan dan komunikasi).

Checklist langkah inti (skill lab):

1. Hand hygiene, APD, identifikasi pasien, dan privasi.
2. Penilaian cepat ABCDE + TTV + SpO_2.
3. Pemberian oksigen bila perlu dan reposisi.
4. Akses IV dan persiapan cairan sesuai SOP bila syok.
5. Monitoring ulang, catat waktu dan respons.
6. Keputusan rujukan: emergensi; aktifkan ambulans/transport.
7. Komunikasi SBAR + closed-loop; siapkan resume rujukan.
8. Edukasi singkat kepada ibu/keluarga (bahasa sederhana).

Asesmen (Piramida Miller)

Tabel 4.4.
Asesmen Bab 11 berbasis Piramida Miller

Level Miller	Metode Asesmen
Knows / Knows How	Self-check (MCQ) + analisis mini-case tertulis
Shows How	OSCE Triase dan Rujukan Komplikasi Sistemik Nifas (suspek tromboemboli)
Does	DOPS di lahan praktik + portofolio (catatan kasus singkat + refleksi patient safety)

OSCE (Shows How)

Critical items (WAJIB LULUS): hand hygiene dan pencegahan infeksi; identifikasi ibu dan privasi; ABCDE + SpO_2; eskalasi bila red flags muncul.

Tabel 4.5
Template Soal OSCE Kebidanan (Bab 11)

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	4
2	Judul	Nifas: Suspek Tromboemboli/Emboli Paru (PE) - Tindakan Awal dan Rujukan
3	Kasus	Komplikasi sistemik nifas dengan kecurigaan emboli paru/tromboemboli vena yang memerlukan triase cepat, stabilisasi awal, dan rujukan.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang ibu nifas hari ke-8 pasca seksio sesarea datang ke Puskesmas dengan sesak mendadak sejak 2 jam, nyeri dada saat tarik napas, dan pusing. Hasil pemeriksaan: TD 90/60 mmHg, N 124 x/menit, RR 30 x/menit, SpO_2 90% RA, suhu 36,9°C. Tungkai kiri tampak bengkak dan nyeri. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan cepat (ABCDE) dan nilai kegawatan. 3. Sampaikan diagnosis kerja/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan. 6. Lakukan komunikasi rujukan SBAR (role-play) dan isi resume rujukan singkat.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian 2. Tulislah nomor peserta sesuai ketentuan institusi.

		3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta meminta SpO_2 ulang setelah oksigen, berikan hasil: 94%. 2. Peserta meminta pemeriksaan paru, berikan data: suara napas vesikuler, tanpa wheezing, takipnea. 3. Jika peserta meminta pemeriksaan tungkai, berikan data: bengkak unilateral kiri dan nyeri tekan betis. 4. Jika peserta menyatakan rujuk emergensi, PS setuju setelah penjelasan singkat.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	PS berperan sebagai ibu nifas sesak, tampak cemas, bicara pendek-pendek. Bila peserta menenangkan dan menjelaskan langkah, PS kooperatif. Bila peserta menunda rujukan, PS tampak makin panik.
9	Dialog PS (contoh)	Peserta: Selamat pagi Bu, saya bidan ..., apakah ibu bersedia diperiksa? PS: Iya Bu... saya sesak sekali. Peserta: Sejak kapan sesaknya? PS: Sejak 2 jam lalu, tiba-tiba. Peserta: Ada nyeri dada? PS: Iya, sakit kalau tarik napas. Peserta: Ada batuk darah atau pingsan? PS: Tidak batuk darah, tapi pusing sekali. Peserta: Kaki ada yang bengkak atau nyeri? PS: Kaki kiri saya bengkak dan nyeri. Peserta: Ibu baru melahirkan kapan dan bagaimana caranya? PS: 8 hari lalu, operasi. Peserta: Baik Bu, ini kondisi berbahaya, kita perlu tindakan awal dan rujuk segera ke RS. PS: Baik Bu, tolong bantu saya.
10	Kebutuhan manikin	Manekin/PS + alat ukur TTV; tidak memerlukan phantom obstetri.
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan alat. - Memastikan oksigen dummy dan form rujukan tersedia. - Merapikan stasiun setelah ujian.

12	Kebutuhan alat	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Pulse oximeter 4. Oksigen set (dummy) + masker 5. Handrub 6. Sarung tangan 7. Infus set (dummy) + cairan (dummy) 8. Form SBAR 9. Resume rujukan 10. Pena 11. Jam/stopwatch 12. Kain penutup/privasi
13	Penulis	.....
14	Referensi	1. Blondon, M., & Skeith, L. (2022). Preventing postpartum venous thromboembolism in 2022. 2. Maughan, B. C., et al. (2022). Venous thromboembolism during pregnancy and postpartum. 3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2023). Thrombosis and embolism during pregnancy and the puerperium: Acute management.

Tabel 4.6
Rubrik ringkas OSCE (skala 1–4)

Domain	4	3	2	1
Keselamatan pasien (PPI/K3)	Aman dan konsisten	Minor tidak berdampak	Ada risiko kecil	Tidak aman/abaikan critical items
Asesmen dan keputusan triase	Tepat, cepat, dan jelas	Tepat namun kurang cepat	Ragu/kurang lengkap	Keliru (prioritas salah)
Stabilisasi pra-rujukan	Lengkap sesuai SOP	Cukup, ada yang terlewat minor	Tidak sistematis	Tidak dilakukan/tidak tepat
Komunikasi rujukan (SBAR)	Runtut + closed-loop	Runtut namun belum closed-loop	Kurang runtut	Tidak jelas/tidak dilakukan

Catatan kelulusan: nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan; critical items wajib lulus.

DOPS di Lahan Praktik (Does)

Observasi langsung triase dan stabilisasi pra-rujukan ibu nifas (suspek tromboemboli/ komplikasi sistemik).

Checklist + umpan balik singkat. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial.

DOPS menilai performa nyata mahasiswa di lahan praktik saat melakukan triase dan stabilisasi pra-rujukan pada ibu nifas dengan kecurigaan komplikasi sistemik. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung, diikuti umpan balik singkat dan rencana perbaikan.

Tabel 4.7
Form DOPS ringkas (Skor 1–4)

Domain	Skor (1–4)	Catatan Kekuatan	Area Perbaikan
Informed consent dan privasi			
Hand hygiene/APD dan patient safety			
Pengkajian cepat (ABCDE, TTV, SpO_2)			
Tindakan awal stabilisasi sesuai SOP			
Komunikasi SBAR + koordinasi rujukan			
Dokumentasi dan resume rujukan			
Sikap profesional dan empati			

Keputusan DOPS: ☐ Kompeten ☐ Perlu supervisi ☐ Remedial
Tindak lanjut: .....

Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Rubrik ini digunakan untuk melengkapi penilaian performa mahasiswa pada Bab 11 setelah OSCE dan DOPS, dengan fokus pada deteksi dini, triase, stabilisasi pra-rujukan, komunikasi rujukan, dokumentasi klinis, dan perilaku profesional.

Stase: Komplikasi Sistemik Nifas — Suspek Tromboemboli

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Keluhan utama (sesak napas, nyeri dada, pusing, lemah)		
Onset dan karakter keluhan (mendadak/bertahap, sejak kapan, memberat atau tidak)		
Gejala penyerta (sinkop, hemoptisis, berdebar, demam, penurunan kesadaran)		

Keluhan tungkai (nyeri, bengkak unilateral, rasa berat, hangat)		
Riwayat persalinan/nifas (hari nifas ke berapa, SC/normal, komplikasi persalinan)		
Faktor risiko tromboemboli (imobilisasi, obesitas, riwayat VTE, merokok, preeklampsia, infeksi, perdarahan, transfusi)		
Riwayat penyakit/obat/alergi (asma, penyakit jantung, hipertensi, antikoagulan, alergi)		
Dukungan keluarga dan aktivitas harian relevan (mobilisasi, asupan cairan, pendamping, kemampuan berjalan)		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis (Triase, Stabilisasi Pra-Rujukan, dan Dokumentasi Klinis)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Menyapa ibu dengan sopan, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan meminta persetujuan		
Menjaga privasi dan melakukan hand hygiene/APD		
Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu (AVPU/GCS sederhana)		
Melakukan penilaian cepat ABCDE		
Mengukur tanda vital lengkap (TD, N, RR, suhu) dan SpO_2		
Mengidentifikasi red flags kegawatan (sesak mendadak, nyeri dada, sinkop, hipoksia, hipotensi, tanda syok)		
Memposisikan ibu semi-Fowler/miring kiri sesuai kondisi		
Memberikan oksigen bila diperlukan		
Menilai tanda DVT/temuan tungkai secara aman		
Menyiapkan atau memasang akses IV/cairan sesuai kewenangan dan SOP bila ada indikasi		
Melakukan monitoring ulang kondisi ibu setelah tindakan awal		
Menetapkan diagnosis kerja/masalah prioritas (suspek tromboemboli/komplikasi sistemik nifas)		
Menentukan kebutuhan rujukan emergensi secara tepat		
Menyiapkan resume rujukan/dokumentasi klinis pra-rujukan secara ringkas dan tepat		
Mendokumentasikan temuan penting, tindakan, respons pasien, dan waktu pelaksanaan		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= melakukan 13–15 langkah dengan tepat dan sistematis;
- 2= melakukan 9–12 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat;

- 1= melakukan 1–8 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat;
- 0= tidak melakukan apa pun atau semua langkah tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling dan Komunikasi Rujukan

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Menyapa ibu/keluarga dengan tenang dan empatik		
Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu dengan bahasa sederhana		
Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
Menjelaskan perlunya rujukan segera dan alasan keselamatan ibu		
Melibatkan keluarga/pendamping dalam pengambilan keputusan dan dukungan		
Memberi kesempatan bertanya dan menjawab dengan jelas		
Menyampaikan komunikasi rujukan singkat dengan format SBAR		

Skoring KOMPETENSI 3: 3 = melakukan semua 7 langkah dengan benar; 2 = melakukan 5–6 langkah dengan benar; 1 = melakukan 1–4 langkah dengan benar; 0 = tidak melakukan apa pun.

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= melakukan semua 7 langkah dengan benar;
- 2= melakukan 5–6 langkah dengan benar;
- 1= melakukan 1–4 langkah dengan benar
- 0= tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional dan Patient Safety

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Melaksanakan tindakan secara sistematis dan terstruktur		
Menjaga privasi, keselamatan pasien, dan pencegahan infeksi		
Responsif terhadap kondisi ibu yang gawat/berubah cepat		
Komunikasi jelas, tenang, empatik, dan informatif		
Percaya diri, tidak ragu-ragu, dan mampu mengambil keputusan awal dengan tepat		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

Total Skor Mentah = Skor Kompetensi 1 + Kompetensi 2 + Kompetensi 3 + Kompetensi 4

Skor Maksimal = 12

Nilai Akhir = (Jumlah skor diperoleh / 12) × 100

Interpretasi Kelulusan:

≥ 80 = Lulus;

70–79 = Borderline / Perlu penguatan;

< 70 = Tidak lulus / Remedial.

Catatan penting: peserta tidak dinyatakan lulus bila gagal pada critical items keselamatan meskipun nilai total memenuhi batas lulus.

Critical items wajib lulus: hand hygiene/APD; penilaian cepat ABCDE; pengukuran SpO_2; identifikasi red flags; keputusan rujukan emergensi; dokumentasi klinis pra-rujukan inti.

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR
☐	☐	☐	☐

Jumlah skor didapat: _____

Nilai akhir: _____

(Kota), _____

Penguji,

_____

Nama: _____

Portofolio

Tabel 4.8

Portofolio pada Bab 11 (Komplikasi Sistemik Nifas)

Komponen	Deskripsi	Contoh Bukti
OSCE	Hasil OSCE triase dan rujukan suspek tromboemboli (checklist + rubrik).	Skor OSCE + lembar critical items.
DOPS	Observasi langsung performa di lahan praktik.	Form DOPS terisi + umpan balik.
Catatan kasus singkat	Ringkasan 1 kasus nifas suspek komplikasi sistemik (anonim).	SOAP singkat + rencana rujukan.
Refleksi patient safety	Analisis risiko keterlambatan rujukan dan pencegahan kesalahan.	Refleksi ½–1 halaman.
Materi edukasi	Leaflet/skrip edukasi tanda bahaya nifas dan kapan harus kembali.	Produk edukasi + evaluasi teach-back.
Feedback CI/dosen	Umpan balik berulang untuk bukti konsistensi.	Catatan pembimbing/CI.

O. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 32 tahun, P2A0, datang ke Puskesmas pada hari kedelapan masa nifas. Hasil anamnesis: ibu mengeluh sesak napas mendadak sejak dua jam, nyeri dada saat menarik napas, dan pusing. Persalinan dilakukan melalui seksio sesarea. Sejak pulang, ibu lebih banyak berbaring karena nyeri luka operasi dan memiliki IMT 32 kg/m². Hasil pemeriksaan/pengkajian: TD 90/60 mmHg, nadi 124 kali/menit, frekuensi napas 30 kali/menit, SpO_2 90% tanpa oksigen, suhu 36,9°C, serta tungkai kiri tampak bengkak dan nyeri tekan.
   Apakah diagnosis kerja yang paling mungkin pada kasus tersebut?
   A. Edema paru akibat preeklampsia postpartum
   B. Sepsis puerperalis dengan disfungsi organ
   C. Emboli paru yang berasal dari trombosis vena dalam
   D. Peripartum cardiomyopathy
   E. Edema tungkai fisiologis pada masa nifas

2. Seorang perempuan berusia 29 tahun, P1A0, datang ke klinik pada hari keenam masa nifas. Hasil anamnesis: ibu mengeluh tungkai kiri terasa nyeri dan membengkak sejak dua hari terakhir. Ibu tidak mengeluh sesak napas maupun nyeri dada. Selama tiga hari pertama setelah persalinan, ibu lebih banyak berbaring karena nyeri perineum. Hasil pemeriksaan/pengkajian: kesadaran compos mentis, TD 118/76 mmHg, nadi 92 kali/menit, frekuensi napas 20 kali/menit, SpO_2 98%, suhu 36,8°C, serta tungkai kiri tampak lebih besar, hangat, dan nyeri tekan dibandingkan tungkai kanan.

Apakah tindakan bidan yang paling tepat pada kasus tersebut?

A. Memijat tungkai dan menganjurkan ibu segera berjalan
B. Menilai red flags, tidak memijat tungkai, dan merujuk untuk konfirmasi diagnosis
C. Memberikan diuretik dan melakukan observasi selama enam jam
D. Menjelaskan bahwa pembengkakan merupakan perubahan fisiologis masa nifas
E. Menganjurkan tirah baring di rumah dan kontrol tiga hari kemudian

3. Seorang perempuan berusia 35 tahun, P3A0, datang ke Puskesmas pada hari kesepuluh masa nifas. Hasil anamnesis: ibu mengeluh nyeri kepala hebat, pandangan kabur, mual, dan nyeri ulu hati sejak pagi. Ibu tidak memiliki keluhan nyeri tungkai, nyeri dada, ataupun demam. Hasil pemeriksaan/pengkajian: kesadaran compos mentis, TD 170/110 mmHg, nadi 96 kali/menit, frekuensi napas 24 kali/menit, SpO_2 96%, dan suhu 36,7°C.

   Apakah komplikasi yang paling mungkin pada kasus tersebut?

   A. Emboli paru
   B. Sepsis puerperalis
   C. Peripartum cardiomyopathy
   D. Preeklampsia postpartum dengan tanda bahaya neurologis
   E. Perubahan fisiologis tekanan darah pada masa nifas

4. Seorang perempuan berusia 34 tahun, P2A0, dibawa keluarganya ke Puskesmas pada hari keempat setelah menjalani seksio sesarea. Hasil anamnesis: ibu mengalami demam tinggi, menggigil, lemah, dan nyeri pada luka operasi. Sebelum persalinan, ibu mengalami ketuban pecah dalam waktu lama. Hasil pemeriksaan/pengkajian: ibu tampak sangat lemah, TD 84/54 mmHg, nadi 128 kali/menit, frekuensi napas 32 kali/menit, SpO_2 93%, suhu 39,4°C, dan luka operasi tampak meradang.

   Apakah penatalaksanaan awal yang paling tepat pada kasus tersebut?

   A. Melakukan ABCDE, menerapkan PPI, memberikan stabilisasi sesuai SOP, dan merujuk secara emergensi
   B. Menunggu hasil pemeriksaan darah dan kultur sebelum menentukan rujukan
   C. Memberikan antibiotik oral kemudian memperbolehkan ibu pulang
   D. Membersihkan luka operasi dan menjadwalkan kontrol keesokan harinya
   E. Menganjurkan ibu melakukan mobilisasi dan meningkatkan asupan cairan di rumah

5. Seorang perempuan berusia 30 tahun, P2A0, datang ke fasilitas kesehatan pada hari ke-21 masa nifas. Hasil anamnesis: ibu mengeluh sesak yang semakin berat sejak enam hari terakhir, terutama ketika berbaring, sehingga harus tidur dengan beberapa bantal. Keluhan disertai cepat lelah, batuk, dan pembengkakan pada kedua pergelangan kaki. Hasil pemeriksaan/pengkajian: TD 110/70 mmHg, nadi 116 kali/menit, frekuensi napas 30 kali/menit, SpO_2 91%, suhu 36,8°C, terdengar ronki pada kedua paru, serta tidak ditemukan nyeri atau pembengkakan tungkai unilateral.

   Apakah diagnosis kerja yang paling mungkin pada kasus tersebut?

   A. Trombosis vena dalam tanpa embolisasi
   B. Emboli paru akut
   C. Sepsis puerperalis
   D. Preeklampsia postpartum
   E. Peripartum cardiomyopathy

Kunci Jawaban

1. **C**. Emboli paru yang berasal dari trombosis vena dalam
2. **B**. Menilai red flags, tidak memijat tungkai, dan merujuk untuk konfirmasi diagnosis
3. **D**. Preeklampsia postpartum dengan tanda bahaya neurologis
4. **A**. Melakukan ABCDE, menerapkan PPI, memberikan stabilisasi sesuai SOP, dan merujuk secara emergensi
5. **E**. Peripartum cardiomyopathy

Pembahasan

1. Jawaban: **C**. Emboli paru yang berasal dari trombosis vena dalam

   Kata kunci: nifas hari kedelapan, seksio sesarea, imobilisasi, obesitas, sesak mendadak, nyeri dada pleuritik, SpO_2 90%, hipotensi, takikardia, dan bengkak tungkai unilateral.

   Gambaran klinis pada kasus ini paling sesuai dengan emboli paru yang kemungkinan berasal dari trombosis vena dalam pada tungkai kiri. Ibu memiliki beberapa faktor risiko tromboemboli, yaitu seksio sesarea, imobilisasi, obesitas, dan masa nifas awal yang secara fisiologis berada dalam keadaan hiperkoagulabel. Bengkak dan nyeri tungkai unilateral mendukung dugaan DVT. Sesak mendadak, nyeri dada saat menarik napas, takipnea, takikardia, penurunan SpO_2, dan hipotensi menunjukkan embolisasi ke sirkulasi paru dengan gangguan respirasi serta sirkulasi. Kasus termasuk kegawatdaruratan sehingga bidan harus segera melakukan penilaian ABCDE, memberikan oksigen, meminimalkan

aktivitas ibu, menyiapkan akses intravena sesuai SOP, dan mengaktifkan rujukan emergensi. Tungkai yang dicurigai mengalami DVT tidak boleh dipijat atau dimanipulasi.

Alasan opsi lain:

a. A salah: preeklampsia postpartum biasanya disertai hipertensi, nyeri kepala, gangguan penglihatan, atau nyeri epigastrium.
b. B salah: sepsis puerperalis umumnya disertai demam atau hipotermia, menggigil, tanda infeksi, dan perburukan kondisi umum.
c. C benar: terdapat kombinasi gejala DVT dan tanda emboli paru akut.
d. D salah: peripartum cardiomyopathy lebih sering menimbulkan sesak progresif, orthopnea, edema bilateral, dan tanda gagal jantung.
e. E salah: edema fisiologis umumnya bilateral dan tidak disertai nyeri lokal, sesak mendadak, hipoksemia, maupun hipotensi.

2. Jawaban: B. Menilai red flags, tidak memijat tungkai, dan merujuk untuk konfirmasi diagnosis

   Kata kunci: nyeri tungkai, bengkak unilateral, hangat, nyeri tekan, imobilisasi, tanpa sesak atau instabilitas hemodinamik.

   Bengkak, rasa hangat, dan nyeri tekan yang hanya terjadi pada satu tungkai merupakan manifestasi klinis yang mengarah pada trombosis vena dalam. Kondisi tersebut berbeda dari edema postpartum fisiologis yang umumnya terjadi secara bilateral dan tidak disertai nyeri lokal yang bermakna. Riwayat lebih banyak berbaring juga meningkatkan risiko stasis vena.

   Meskipun ibu belum menunjukkan tanda emboli paru dan tanda vital masih stabil, diagnosis DVT memerlukan konfirmasi di fasilitas yang memiliki pemeriksaan ultrasonografi Doppler vena. Bidan harus menilai kemungkinan red flags, seperti sesak mendadak, nyeri dada, hemoptisis, sinkop, penurunan SpO_2, takikardia, atau hipotensi. Tungkai tidak boleh dipijat karena manipulasi berlebihan berpotensi mengganggu trombus. Rujukan dilakukan segera untuk pemeriksaan dan penatalaksanaan lanjutan.

   Alasan opsi lain:

   a. A salah: pemijatan tungkai yang dicurigai mengalami DVT harus dihindari.
   b. B benar: sesuai dengan prinsip deteksi dini, pencegahan manipulasi, dan rujukan untuk konfirmasi.
   c. C salah: diuretik tidak mengatasi trombus dan dapat menunda penanganan definitif.
   d. D salah: edema unilateral yang nyeri dan hangat tidak dapat dianggap sebagai perubahan fisiologis.

e. E salah: tirah baring tanpa evaluasi dan rujukan dapat menunda diagnosis serta meningkatkan risiko embolisasi.

3. Jawaban: D. Preeklampsia postpartum dengan tanda bahaya neurologis
   Kata kunci: nifas hari kesepuluh, TD 170/110 mmHg, nyeri kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri epigastrium.
   Preeklampsia postpartum dapat menetap dari masa kehamilan atau baru muncul setelah persalinan, terutama pada minggu pertama hingga kedua masa nifas. Manifestasinya meliputi hipertensi, nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, dan pada kondisi berat dapat berkembang menjadi kejang, gangguan neurologis, atau edema paru.
   Tekanan darah 170/110 mmHg disertai nyeri kepala dan pandangan kabur merupakan red flags yang menunjukkan risiko komplikasi neurologis. Nyeri epigastrium juga mendukung adanya gangguan organ target. Bidan harus melakukan penilaian ABCDE, mengurangi rangsangan yang tidak perlu, memantau kesadaran dan tanda vital, melakukan tata laksana awal sesuai SOP dan kewenangan, serta merujuk ibu secara emergensi. Data tekanan darah, gejala neurologis, tindakan awal, dan respons pasien harus disampaikan melalui komunikasi SBAR.
   Alasan opsi lain:
   a. A salah: emboli paru lebih sering ditandai sesak mendadak, nyeri dada pleuritik, hipoksemia, atau tanda DVT.
   b. B salah: tidak terdapat demam, hipotermia, menggigil, maupun sumber infeksi.
   c. C salah: peripartum cardiomyopathy ditandai gejala gagal jantung seperti sesak progresif, orthopnea, edema, dan ronki.
   d. D benar: hipertensi berat disertai nyeri kepala dan gangguan penglihatan merupakan gambaran khas preeklampsia postpartum.
   e. E salah: tekanan darah 170/110 mmHg dengan gejala neurologis bukan perubahan fisiologis masa nifas.
4. Jawaban: **A**. Melakukan ABCDE, menerapkan PPI, memberikan stabilisasi sesuai SOP, dan merujuk secara emergensi
   Kata kunci: demam tinggi, menggigil, ketuban pecah lama, luka operasi meradang, takipnea, takikardia, hipotensi, dan kondisi memburuk.
   Kasus tersebut paling mengarah pada sepsis puerperalis dengan gangguan sirkulasi. Ketuban pecah lama dan infeksi luka operasi merupakan faktor risiko infeksi pada masa nifas. Demam tinggi, menggigil, takipnea, takikardia, hipotensi, dan penurunan kondisi umum menunjukkan bahwa infeksi telah menimbulkan respons sistemik dan kemungkinan gangguan perfusi organ.

Penanganan di layanan primer tidak boleh ditunda untuk menunggu hasil pemeriksaan penunjang. Bidan harus segera melakukan penilaian ABCDE, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi, memberikan oksigen karena SpO_2 di bawah 94%, memasang akses intravena serta menyiapkan cairan sesuai SOP apabila terdapat tanda syok, melakukan monitoring ulang, dan merujuk secara emergensi. Waktu tindakan, tanda vital serial, respons pasien, dan identitas petugas penerima rujukan harus didokumentasikan.

Alasan opsi lain:

a. A benar: sepsis dengan hipotensi dan gangguan respirasi memerlukan stabilisasi segera serta rujukan emergensi.
b. B salah: hasil laboratorium atau kultur tidak boleh menjadi alasan untuk menunda rujukan.
c. C salah: pemberian obat oral dan pemulangan tidak aman pada pasien dengan tanda syok.
d. D salah: perawatan luka saja tidak cukup karena sudah terdapat manifestasi infeksi sistemik.
e. E salah: mobilisasi dan hidrasi di rumah tidak sesuai untuk ibu dengan hipotensi, hipoksemia, dan perburukan kondisi umum.

5. Jawaban: E. Peripartum cardiomyopathy

Kata kunci: sesak progresif, orthopnea, cepat lelah, batuk, edema bilateral, ronki paru, dan hipoksemia.

Peripartum cardiomyopathy merupakan gangguan fungsi miokard yang dapat muncul pada akhir kehamilan atau dalam beberapa bulan setelah persalinan. Penurunan fungsi sistolik ventrikel kiri menyebabkan kongesti paru dan manifestasi gagal jantung, antara lain sesak progresif, orthopnea, kelelahan, batuk, edema, penurunan saturasi oksigen, dan ronki paru.

Pola keluhan yang berkembang selama beberapa hari, bertambah berat ketika berbaring, disertai edema kedua tungkai dan ronki bilateral lebih mendukung peripartum cardiomyopathy daripada emboli paru. Ibu memerlukan penilaian ABCDE, posisi duduk atau semi-Fowler, pemberian oksigen, pemantauan tanda vital dan SpO_2, serta rujukan emergensi. Pemeriksaan EKG dan ekokardiografi diperlukan di fasilitas rujukan untuk membantu menegakkan diagnosis dan menilai fungsi jantung.

Alasan opsi lain:

a. A salah: DVT biasanya menimbulkan nyeri dan pembengkakan tungkai unilateral, bukan orthopnea dan ronki bilateral.
b. B salah: emboli paru cenderung menimbulkan sesak mendadak, nyeri dada pleuritik, sinkop, atau tanda DVT.

c. C salah: tidak terdapat demam, hipotermia, menggigil, atau tanda sumber infeksi.
d. D salah: tidak ditemukan hipertensi, nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, atau nyeri epigastrium.
e. E benar: sesak progresif, orthopnea, edema bilateral, dan ronki merupakan gambaran gagal jantung akibat peripartum cardiomyopathy.

P. Ringkasan Materi

Tromboemboli dan komplikasi sistemik pada masa nifas merupakan kegawatdaruratan yang memerlukan pengenalan dini dan rujukan cepat untuk mencegah morbiditas dan kematian maternal. Di layanan primer, bidan berfokus pada keselamatan: mengenali faktor risiko, mengidentifikasi gejala kunci DVT/PE, serta membedakan kemungkinan kondisi lain yang menyerupai. Triase dilakukan secara cepat dan sistematis dengan pendekatan ABCDE disertai pengukuran tanda vital lengkap termasuk SpO_2. Red flags seperti sesak mendadak dengan SpO_2 <94%, nyeri dada hebat, sinkop, takikardia-hipotensi, tanda syok, atau penurunan kesadaran menuntut rujukan emergensi segera. Stabilisasi pra-rujukan dilakukan sesuai SOP, diikuti komunikasi rujukan SBAR dan penyusunan resume rujukan yang lengkap.

Alur asuhan singkat (flow): ibu nifas dengan keluhan sesak/nyeri dada → nilai cepat ABCDE + TTV + SpO_2 → identifikasi faktor risiko dan red flags → stabilisasi dasar → tetapkan prioritas rujukan → komunikasi SBAR + closed-loop → dokumentasi dan transport aman → rujukan diterima.

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Nama Mahasiswa: ……

NIM: ……

Tanggal: ……

Tempat Praktik / Skill Lab: ……

Petunjuk: Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya dapat menjelaskan perbedaan DVT dan PE pada masa nifas.	☐	☐	
2	Saya dapat menyebutkan faktor risiko utama VTE pada ibu nifas.	☐	☐	
3	Saya dapat mengenali red flags sesak/nyeri dada pada nifas.	☐	☐	
4	Saya dapat melakukan triase cepat ABCDE + TTV + SpO_2.	☐	☐	
5	Saya dapat melakukan stabilisasi dasar pra-rujukan sesuai SOP.	☐	☐	
6	Saya dapat menyusun dan menyampaikan SBAR rujukan dengan jelas.	☐	☐	
7	Saya dapat menyiapkan resume rujukan (data, tindakan, respons).	☐	☐	
8	Saya menjaga patient safety (hand hygiene, identifikasi, privasi, eskalasi).	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

_____

_____

_____

Q. Glosarium

DVT: Trombus pada vena dalam, sering pada tungkai.

PE: Emboli paru akibat trombus yang menyumbat pembuluh paru.

VTE: Venous thromboembolism (DVT + PE).

ABCDE: Pendekatan triase kegawatdaruratan: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure.

SpO_2: Saturasi oksigen perifer (pulse oximetry).

SBAR: Situation–Background–Assessment–Recommendation (komunikasi klinis terstruktur).

Closed-loop: Komunikasi yang dikonfirmasi kembali untuk memastikan pesan diterima benar.

OSCE: Objective Structured Clinical Examination (uji keterampilan terstruktur).

DOPS: Direct Observation of Procedural Skills (observasi langsung di lahan praktik).

R. Daftar Pustaka

Blondon, M., & Skeith, L. (2022). Preventing postpartum venous thromboembolism in 2022: A narrative review. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 9, 886416. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.886416

Hauspurg, A., & Jeyabalan, A. (2022). Postpartum preeclampsia or eclampsia: Defining its place and management among the hypertensive disorders of pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 226(2 Suppl), S1211–S1221.

Maughan, B. C., et al. (2022). Venous thromboembolism during pregnancy and the postpartum period: Risk factors, diagnostic testing, and treatment. Obstetrics & Gynecology Survey, 77(7), 433–444.

Moroi, Ș.-I., et al. (2024). Pregnancy-related thromboembolism—Current challenges at the emergency department. Journal of Personalized Medicine, 14(9), 926.

Queensland Clinical Guidelines. (2025). VTE prophylaxis in pregnancy and the puerperium (Guideline No. MN25.9-V8-R30). Queensland Health.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2023). Thrombosis and embolism during pregnancy and the puerperium: Acute management (Green-top Guideline No. 37b).

Sigauke, F. R., Ntsinjana, H., & Tsabedze, N. (2024). Peripartum cardiomyopathy: A contemporary review. Heart Failure Reviews, 29(6), 1261–1278.

World Health Organization. (2022). WHO recommendations: Maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization.

BAB 5

GANGGUAN ELIMINASI DAN MASALAH PASCAPERSALINAN LAIN: RETENSI URINE, KONSTIPASI, DAN HEMOROID

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas (anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital) untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5, CPMK-7, CPMK-1

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.
CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.
CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Komplikasi Masa Nifas: Fisiologi Nifas, Faktor Risiko, dan Keselamatan Ibu	1.1 Menguraikan parameter fisiologis nifas normal dan deviasi yang mengarah pada komplikasi.	1.2 Mengidentifikasi faktor risiko dan menerapkan prinsip keselamatan ibu pada pelayanan nifas.	CPMK-1	CPMK-2
Bab 2. Pengkajian Ibu Nifas dengan Keluhan: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Tanda Vital	2.1 Melakukan anamnesis terfokus berbasis keluhan dan red flags komplikasi nifas.	2.2 Melakukan pemeriksaan fisik dan interpretasi tanda vital untuk menentukan prioritas masalah.	CPMK-2	CPMK-1
Bab 3. Perdarahan Postpartum: Klasifikasi, Penyebab (4T), dan Tindakan	3.1 Menentukan klasifikasi perdarahan postpartum dan menelusuri penyebab dengan pendekatan 4T.	3.2 Menyusun dan menerapkan langkah tindakan awal serta monitoring sesuai	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Awal di Pelayanan Primer		algoritme di pelayanan primer.		
Bab 4. Atonia Uteri dan Subinvolusi: Deteksi Dini, Stabilisasi, dan Indikasi Rujukan	4.1 Melakukan deteksi dini atonia uteri/subinvolusi melalui temuan klinis nifas.	4.2 Melaksanakan stabilisasi awal dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan tingkat kegawatan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 5. Retensio Plasenta dan Sisa Plasenta: Tanda Klinis, Penanganan Awal, dan Rujukan	5.1 Mengidentifikasi tanda retensio/sisa plasenta serta risiko perdarahan dan infeksi.	5.2 Melaksanakan penanganan awal, persiapan, dan komunikasi rujukan sesuai kebutuhan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 6. Laserasi Jalan Lahir dan Hematoma: Identifikasi, Penatalaksanaan Awal, dan Rujukan	6.1 Mengidentifikasi laserasi jalan lahir/hematoma melalui inspeksi dan tanda klinis.	6.2 Menyusun tatalaksana awal, monitoring, dan keputusan rujukan berdasarkan kondisi klinis.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 7. Infeksi Masa Nifas: Endometritis, Infeksi Luka, dan Pencegahan Penyebaran	7.1 Membedakan endometritis dan infeksi luka berdasarkan gejala, faktor risiko, dan pemeriksaan.	7.2 Menerapkan tatalaksana awal serta pencegahan penyebaran (PPI) pada infeksi masa nifas.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-1
Bab 8. Sepsis Puerperalis: Tanda Bahaya, Stabilisasi Pra-Rujukan, dan Komunikasi Rujukan	8.1 Mengidentifikasi tanda bahaya sepsis puerperalis dan menilai derajat kegawatan.	8.2 Melaksanakan stabilisasi pra-rujukan dan komunikasi rujukan terstruktur kepada fasilitas rujukan.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-2
Bab 9. Gangguan Laktasi: Bendungan ASI, Puting Lecet, dan Teknik Koreksi Menyusui	9.1 Mengkaji masalah menyusui dan mengidentifikasi penyebab bendungan ASI/puting lecet.	9.2 Mendemonstrasikan koreksi teknik menyusui dan konseling perawatan payudara.	CPMK-5	CPMK-7; CPMK-2
Bab 10. Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan	10.1 Mengidentifikasi mastitis/abses payudara dan menilai tingkat keparahan serta komplikasi.	10.2 Menyusun tatalaksana awal, monitoring, dan kriteria rujukan/kolaborasi.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 11. Tromboemboli dan Komplikasi Sistemik Nifas: Deteksi Dini, Tanda Bahaya, dan Rujukan	11.1 Melakukan deteksi dini tromboemboli/komplikasi sistemik berdasarkan gejala, faktor risiko, dan tanda bahaya.	11.2 Melaksanakan triase, stabilisasi, dan rujukan segera disertai dokumentasi klinis.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-1
Bab 12. Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan Lain: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid	12.1 Mengkaji retensi urine, konstipasi, dan hemoroid serta faktor pencetus dan derajat keluhan.	12.2 Menyusun asuhan awal, edukasi self-care, dan kriteria rujukan bila terdapat tanda bahaya.	CPMK-2	CPMK-7; CPMK-1
Bab 13. Kesehatan Mental Ibu Nifas: Baby Blues, Depresi Postpartum, Risiko Bunuh Diri, dan Dukungan Keluarga	13.1 Melakukan skrining kesehatan mental nifas dan menilai risiko bunuh diri/krisis.	13.2 Menyusun dukungan awal, pelibatan keluarga, dan rujukan/kolaborasi sesuai tingkat risiko.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-1
Bab 14. Edukasi Tanda Bahaya Nifas, Dokumentasi, dan Tindak Lanjut: Kunjungan Nifas, Konseling KB, dan Continuity of Care	14.1 Melaksanakan edukasi tanda bahaya nifas, jadwal kunjungan, dan konseling KB berbasis kebutuhan.	14.2 Menyusun dokumentasi, rencana tindak lanjut, dan continuity of care termasuk rujukan balik bila diperlukan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Tes tertulis (MCQ/SAQ) + audit dokumentasi kasus	Kepatuhan item keselamatan (PPI/K3/identifikasi) pada checklist; kelengkapan dan ketepatan format dokumentasi klinis; kesesuaian keputusan	10	Lembar jawaban tes; lembar audit dokumentasi; daftar rujukan pedoman

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		dengan pedoman/evidence yang dirujuk		
CPMK-2	OSCE pengkajian + ujian kasus tertulis	Kelengkapan data kunci anamnesis–pemeriksaan fisik; akurasi interpretasi tanda vital; ketepatan penetapan prioritas masalah dan rencana awal	15	Checklist OSCE; jawaban kasus tertulis
CPMK-3	Simulasi/OSCE perdarahan postpartum + kuis algoritme	Akurasi klasifikasi PPH dan identifikasi 4T; ketepatan urutan tindakan awal–stabilisasi; ketepatan keputusan rujukan dan monitoring terdokumentasi	20	Checklist simulasi; log monitoring; jawaban kuis
CPMK-4	CBT berbasis kasus infeksi/sepsis + simulasi tatalaksana awal	Ketepatan identifikasi infeksi/sepsis dan red flags; konsistensi penerapan PPI; kesesuaian tatalaksana awal dan evaluasi respons	15	Skor CBT; checklist simulasi; catatan evaluasi
CPMK-5	OSCE konseling laktasi + penilaian praktik (video/observasi)	Akurasi identifikasi masalah laktasi; ketepatan demonstrasi koreksi posisi/perlekatan; kualitas konseling dan rencana tindak lanjut/kriteria rujukan	15	Checklist OSCE; rekaman video/lembar observasi; rencana tindak lanjut
CPMK-6	Simulasi pra-rujukan + role-play komunikasi SBAR + penilaian resume rujukan	Ketepatan triase dan stabilisasi pra-rujukan; kelengkapan komunikasi SBAR; kelengkapan resume rujukan (diagnosis kerja, tindakan, respons, rencana)	15	Checklist simulasi; rekaman/lembar penilaian SBAR; resume rujukan
CPMK-7	Portofolio edukasi & follow-up + praktik	Kelengkapan skrining (instrumen tervalidasi) dan keputusan tindak lanjut;	10	Portofolio edukasi; lembar skrining &

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
	skrining kesehatan mental (role-play)	kualitas materi edukasi (tanda bahaya, KB, menyusui); kejelasan rencana continuity of care (jadwal, media, jejaring rujukan)		rencana tindak lanjut; rencana CoC

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan keselamatan pasien & PPI/K3	>2 langkah kritis terlewat; praktik berisiko; tidak konsisten menggunakan APD/hand hygiene	Langkah dasar dilakukan namun ada 1–2 kekeliruan/terlewat; perlu arahan	Langkah kritis terlaksana konsisten; hanya kekurangan minor	Proaktif mengidentifikasi risiko, melakukan mitigasi, dan mengedukasi; tanpa kekeliruan
1.2 Dokumentasi & penggunaan pedoman/evidence	Dokumentasi tidak runtut/tidak lengkap; rasional tidak jelas; rujukan tidak relevan	Dokumentasi cukup tetapi ada data kunci hilang; rasional masih lemah; rujukan terbatas	Dokumentasi lengkap dan jelas; rasional sesuai pedoman; rujukan relevan	Dokumentasi sangat lengkap untuk continuity; rasional kuat; rujukan pedoman mutakhir dan kontekstual

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Anamnesis terfokus & pemeriksaan fisik sistematis	Data tidak terarah; komponen penting banyak terlewat	Data utama terkumpul namun belum sistematis; beberapa komponen terlewat	Sistematis, lengkap, dan komunikatif; kekurangan minor	Sangat sistematis, menggali red flags, menyesuaikan prioritas, komunikasi sangat efektif
2.2 Interpretasi tanda vital &	Salah menafsir tanda vital/red	Menafsir sebagian benar;	Menafsir tepat; menetapkan	Menafsir sangat tepat (termasuk

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
prioritisasi masalah	flags; prioritas tidak tepat	prioritas belum konsisten	prioritas masalah dan rencana awal dengan rasional	kewaspadaan dini); prioritas dan rencana monitoring jelas dan terukur

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Klasifikasi PPH & identifikasi 4T	Klasifikasi salah; penyebab tidak terpetakan	Klasifikasi cukup; 1–2 komponen 4T teridentifikasi	Klasifikasi tepat; 4T disaring lengkap; penyebab paling mungkin ditetapkan berbasis temuan	Analisis komprehensif (kemungkinan multipel); menyusun kebutuhan konfirmasi dan pemantauan lanjutan
3.2 Tindakan awal–stabilisasi & monitoring	Urutan tindakan tidak sesuai; respons lambat; monitoring tidak terdokumentasi	Tindakan dasar dilakukan namun urutan/monitoring belum konsisten	Tindakan awal dan stabilisasi sesuai algoritme & kewenangan; monitoring dan keputusan rujukan tepat	Sangat cepat dan tepat; monitoring komprehensif; persiapan rujukan terkoordinasi dengan baik

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi infeksi/sepsis & derajat kegawatan	Tanda bahaya tidak dikenali; penilaian derajat tidak dilakukan	Gejala umum dikenali, namun red flags/derajat belum lengkap	Tanda klinis kunci dikenali; derajat kegawatan dan diagnosis kerja tepat	Penilaian sangat tajam; memetakan risiko komplikasi dan rencana monitoring terukur
4.2 Tatalaksana awal & pencegahan penyebaran	PPI diabaikan; tatalaksana awal tidak sesuai	PPI sebagian; tatalaksana awal sebagian sesuai; monitoring terbatas	PPI konsisten; tatalaksana awal sesuai protokol/kewenangan; evaluasi respons dilakukan	Komprehensif; koordinasi kolaborasi/rujukan tepat; dokumentasi lengkap dan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pengkajian masalah laktasi	Penilaian teknik menyusui tidak dilakukan; masalah tidak teridentifikasi	Penilaian dasar dilakukan namun belum lengkap; penyebab belum jelas	Pengkajian lengkap (ibu–bayi–teknik); penyebab utama tepat	Analisis menyeluruh termasuk faktor psikososial; prioritas masalah dan target perbaikan jelas
5.2 Koreksi teknik menyusui & konseling	Demonstrasi keliru/berisiko; konseling tidak jelas	Demonstrasi cukup tetapi masih ada kesalahan; konseling belum individual	Demonstrasi benar; konseling jelas; rencana tindak lanjut dan kriteria rujukan tepat	Coaching sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; follow-up terstruktur dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Triase & stabilisasi pra-rujukan	Kegawatan tidak dikenali; stabilisasi tidak tepat/tidak dilakukan	Kegawatan dikenali sebagian; stabilisasi dasar ada namun belum lengkap	Triase tepat; stabilisasi sesuai protokol/kewenangan; monitoring berkelanjutan	Sangat cepat, antisipatif, dan terkoordinasi; menyiapkan kebutuhan transport/alat secara optimal
6.2 Komunikasi rujukan & resume	Informasi kritis hilang; komunikasi tidak runtut; resume tidak lengkap	Komunikasi cukup runtut tetapi ada data kunci terlewat; resume perlu perbaikan	SBAR lengkap; resume rujukan jelas (tindakan, respons, rencana)	Closed-loop communication; memastikan penerimaan; rencana transport & rujukan balik terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Skrining kesehatan mental & tindak lanjut	Skrining tidak dilakukan; risiko krisis tidak dinilai	Skrining dilakukan terbatas; tindak lanjut belum jelas	Menggunakan instrumen tervalidasi; menilai risiko; dukungan awal dan rujukan sesuai	Komprehensif; safety plan jelas; pelibatan keluarga kuat; follow-up terjadwal dan terdokumentasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.2 Edukasi tanda bahaya/KB & continuity of care	Materi edukasi tidak lengkap; tanpa rencana tindak lanjut	Materi cukup namun belum disesuaikan; tindak lanjut umum	Materi lengkap dan terstruktur; metode sesuai; rencana follow-up jelas	Edukasi sangat efektif (teach-back + media); continuity of care rinci (kunjungan/telefollow-up/rujukan balik)

Uraian Materi

Gangguan eliminasi postpartum adalah ketidakmampuan atau gangguan ibu nifas dalam proses pengeluaran urine dan feses akibat perubahan fisiologis, trauma persalinan, maupun faktor psikologis.

1. Retensi urine postpartum: ketidakmampuan berkemih spontan ≥6 jam setelah persalinan atau setelah pelepasan kateter
2. Konstipasi postpartum: kesulitan defekasi ditandai feses keras, nyeri, dan mengejan
3. Hemoroid postpartum: pembengkakan vena di rektum/anus akibat tekanan selama kehamilan dan persalinan

A. Retensi Urine Postpartum

1. Etiologi Retensi Urine Postpartum

   Retensi urine postpartum terjadi akibat gangguan mekanik, neurologis, dan fungsional pada sistem perkemihan setelah persalinan. Etiologi utamanya meliputi:

   a. Trauma Jaringan Perineum

      Trauma perineum seperti episiotomi, laserasi derajat I–IV, maupun tekanan kepala janin saat persalinan dapat menyebabkan:

      1) Nyeri hebat pada area perineum
      2) Spasme refleks otot sfingter uretra
      3) Hambatan relaksasi saat miksi

      Secara fisiologis, nyeri akan menghambat refleks miksi melalui aktivasi sistem saraf simpatis sehingga terjadi retensi urine.

   b. Edema Uretra dan Jaringan Sekitar

      Selama persalinan, tekanan kepala janin pada uretra dan jaringan sekitarnya menyebabkan:

      1) Edema mukosa uretra
      2) Penyempitan lumen uretra
      3) Hambatan aliran urine

      Edema ini biasanya bersifat sementara, tetapi dapat menyebabkan retensi urine dalam 24–48 jam pertama postpartum.

   c. Gangguan Persarafan Kandung Kemih

      Persalinan, terutama yang lama atau menggunakan alat (forceps/vakum), dapat menyebabkan:

      1) Cedera saraf pudendus
      2) Gangguan impuls saraf ke otot detrusor

3) Penurunan sensasi penuh kandung kemih

Akibatnya, ibu tidak merasakan keinginan berkemih meskipun kandung kemih penuh (retensi urine covert).

d. Efek Anestesi (Regional/Spinal/Epidural)

Anestesi selama persalinan dapat menyebabkan:

1) Penurunan sensitivitas kandung kemih
2) Hambatan refleks miksi
3) Relaksasi otot detrusor

Efek ini dapat bertahan beberapa jam hingga >24 jam postpartum, tergantung jenis anestesi.

2. Faktor Risiko Retensi Urine Postpartum (Berbasis Penelitian)

Retensi urine postpartum merupakan kondisi multifaktorial yang sangat berkaitan dengan proses persalinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor obstetrik memiliki kontribusi dominan terhadap gangguan fungsi kandung kemih setelah persalinan.

a. Episiotomi / Laserasi Perineum

Episiotomi maupun laserasi perineum menyebabkan trauma jaringan lunak di sekitar uretra dan dasar panggul. Trauma ini memicu:

1) edema jaringan periuretra
2) nyeri hebat saat berkemih

b. Persalinan Lama (Prolonged Labor)

Persalinan lama menyebabkan tekanan berkepanjangan pada kandung kemih dan jaringan sekitarnya, yang berdampak pada:

1) iskemia otot detrusor
2) gangguan kontraktilitas kandung kemih
3) neuropati sementara
4) Penelitian menyebutkan bahwa durasi persalinan yang memanjang meningkatkan risiko retensi urine postpartum secara signifikan (Zahra, 2022).
5) Semakin lama fase kala II, semakin tinggi risiko disfungsi miksi akibat kompresi saraf pelvis.

c. Persalinan dengan Alat (Instrumental Delivery)

Penggunaan alat seperti vakum atau forceps meningkatkan risiko trauma mekanik pada:

1) Dasar Panggul
2) Uretra
3) Saraf Pelvis
4) Hal ini menyebabkan:

5) penurunan sensasi berkemih

d. Berat Badan Bayi > 3800 gram (Makrosomia)

Bayi dengan berat lahir besar menyebabkan:

1) tekanan berlebih pada kandung kemih
2) peregangan berlebihan otot dasar panggul
3) trauma saraf pelvis
4) Akibatnya terjadi:
5) gangguan kontraksi kandung kemih
6) penurunan sensitivitas terhadap distensi

3. Patofisiologi Retensi Urine Postpartum

Retensi urine postpartum terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor mekanik, neurologis, dan fisiologis yang terjadi selama proses persalinan.

a. Trauma Mekanik dan Edema

Selama persalinan, terutama pada persalinan lama, tindakan episiotomi, atau penggunaan alat (forceps/vakum), terjadi trauma jaringan perineum, uretra, dan dasar panggul. Trauma ini menyebabkan:

1) Edema pada uretra dan jaringan periuretra
2) Kompresi lumen uretra

b. Gangguan Neurologis (Disfungsi Neurogenik Sementara)

Tekanan kepala janin pada pleksus saraf pelvis (terutama nervus pudendus) dapat menyebabkan:

1) Penurunan sensitivitas kandung kemih
2) Hilangnya refleks miksi
3) Gangguan koordinasi antara otot detrusor dan sfingter uretra Akibatnya, ibu tidak merasakan dorongan untuk berkemih meskipun kandung kemih sudah penuh.
4) Disfungsi Otot Detrusor
5) Trauma dan overstretching kandung kemih selama persalinan menyebabkan:
6) Penurunan kontraktilitas otot detrusor
7) Atonia kandung kemih sementara

   Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan kandung kemih untuk berkontraksi secara efektif dalam mengeluarkan urin.
8) Distensi Kandung Kemih
9) Akumulasi urine yang tidak dapat dikeluarkan menyebabkan:
   a) Distensi kandung kemih berlebihan
   b) Penurunan sensitivitas reseptor regang
   c) Kerusakan lebih lanjut pada otot detrusor

10) Retensi urine yang tidak ditangani akan menyebabkan:
    a) Stasis urine → media pertumbuhan bakteri
    b) Risiko infeksi saluran kemih (ISK)
    c) Refluks vesikoureter
    d) Atonia kandung kemih permanen (pada kasus berat) Referensi (Penelitian & Literatur Terkini)
11) Klasifikasi Retensi Urine Postpartum

    Retensi urine postpartum diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama berdasarkan manifestasi klinis dan temuan objektif:

    a) *Overt Postpartum Urinary Retention (PUR)*

        Adalah kondisi di mana ibu tidak mampu berkemih secara spontan dalam ≥6 jam setelah persalinan pervaginam atau setelah pelepasan kateter pasca seksio sesarea.

        Karakteristik:

        - Gejala jelas (simptomatik)
        - Kandung kemih teraba penuh/distensi
        - Nyeri suprapubik
        - Tidak ada urin yang keluar

4. Covert Postpartum Urinary Retention

    Adalah kondisi asimptomatik, di mana ibu masih dapat berkemih spontan tetapi terdapat residu urine ≥150–200 mL setelah miksi.

    Karakteristik:

    a. Tidak ada keluhan khas
    b. Volume urin keluar tampak normal
    c. Ditemukan residu tinggi melalui bladder scan

5. Manifestasi Klinis

    Manifestasi retensi urine postpartum dapat bervariasi dari ringan hingga berat, meliputi:

    a. Gejala Subjektif
        1) Tidak dapat berkemih spontan
        2) Rasa penuh atau tekanan di perut bagian bawah
        3) Nyeri suprapubik
        4) Sensasi tidak tuntas setelah berkemih
    b. Tanda Objektif
        1) Distensi kandung kemih (teraba di atas simfisis pubis)
        2) Output urin minimal atau tidak ada
        3) Gelisah atau ketidaknyamanan ibu

6. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk memastikan diagnosis dan menentukan tingkat keparahan:

a. Bladder Scan (USG Kandung Kemih)
   1) Metode non-invasif
   2) Mengukur volume residu urine
   3) Digunakan untuk skrining covert PUR
   4) Nilai abnormal:
   5) Residual urine ≥150–200 mL
b. Kateterisasi Diagnostik

   Mengukur volume urin secara langsung dilakukan jika bladder scan tidak tersedia
c. Monitoring Output Urine

   Observasi jumlah urin & Frekuensi berkemih
d. Pemeriksaan Tambahan (bila komplikasi) Urinalisis untuk deteksi infeksi dan Kultur urin lakukan konfirmasi ISK

7. Komplikasi

Jika tidak ditangani dengan tepat, retensi urine postpartum dapat menyebabkan:

a. Komplikasi Jangka Pendek
   1) Infeksi saluran kemih (ISK)
   2) Overdistensi kandung kemih
   3) Nyeri hebat
b. Komplikasi Jangka Panjang
   1) Atonia kandung kemih (gangguan kontraksi detrusor)
   2) Disfungsi miksi kronis
   3) Inkontinensia urin
c. Dampak Klinis
   1) Memperpanjang masa rawat
   2) Mengganggu proses pemulihan postpartum

8. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan bertujuan untuk mengembalikan fungsi miksi normal dan mencegah komplikasi, meliputi:

a. Kateterisasi
   1) Kateterisasi intermiten (pilihan utama)
   2) Kateter tetap (indwelling) bila retensi berat

      Indikasi:
b. Tidak berkemih >6 jam

Residu urine tinggi (>200–300 mL)

c. Bladder Training
   1) Latihan berkemih terjadwal (setiap 2–3 jam)
   2) Stimulasi refleks miksi (air hangat, suara air)
   3) Posisi duduk/berdiri saat BAK
d. Mobilisasi Dini
   1) Membantu merangsang fungsi kandung kemih
   2) Meningkatkan aliran darah ke organ pelvis
e. Terapi Non-Farmakologis
   1) Kompres hangat suprapubik
   2) Relaksasi
   3) Privasi saat berkemih
f. Terapi Farmakologis (bila perlu)
   1) Analgesik → mengurangi nyeri
   2) Agen kolinergik (jarang digunakan, indikasi khusus)
g. Edukasi
   1) Tidak menahan BAK
   2) Minum cukup (2–3 liter/hari)
   3) Segera melapor jika tidak bisa berkemih

B. Konstipasi Postpartum

1. Etiologi

   Konstipasi postpartum merupakan kondisi multifaktorial yang disebabkan oleh kombinasi faktor fisiologis, psikologis, dan iatrogenik selama masa nifas. Berikut penjelasan etiologi secara komprehensif:

   a. Penurunan Motilitas Usus

      Setelah persalinan, terjadi penurunan aktivitas peristaltik usus akibat:
      1) Pengaruh hormon progesteron yang masih tinggi selama kehamilan yang menyebabkan relaksasi otot polos usus
      2) Efek anestesi (epidural/spinal) yang menekan refleks gastrointestinal
      3) Penurunan aktivitas fisik ibu

      Akibatnya, waktu transit usus menjadi lebih lama sehingga penyerapan air meningkat dan feses menjadi keras.

   b. Nyeri Perineum

      Nyeri akibat:
      1) Episiotomi
      2) Laserasi perineum
      3) Edema jaringan

menyebabkan ibu:

1) Takut mengejan saat defekasi
2) Menunda keinginan BAB
3) Penundaan ini mengakibatkan:
4) Penumpukan feses di rektum

Penyerapan air berlebih

Terbentuknya feses keras

c. Diet Rendah Serat

Selama masa nifas, asupan nutrisi sering tidak adekuat, khususnya:

Rendah serat (buah, sayur, whole grain)

Kurang cairan

Serat berfungsi:

1) Menambah massa feses
2) Merangsang peristaltik usus
3) Kekurangan serat menyebabkan: Volume feses kecil dan Transit usus lambat

2. Faktor Risiko (Konstipasi Postpartum)

Konstipasi pada masa nifas dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis, psikologis, dan perilaku. Faktor risiko utama meliputi:

a. Kurang mobilisasi

Imobilisasi setelah persalinan menyebabkan penurunan aktivitas peristaltik usus sehingga memperlambat transit feses. Penelitian menunjukkan bahwa ibu nifas yang melakukan mobilisasi dini memiliki risiko konstipasi lebih rendah dibandingkan yang tirah baring lama.

b. Asupan serat rendah

Diet rendah serat menyebabkan berkurangnya massa dan kelembapan feses sehingga feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Serat berperan meningkatkan volume feses dan merangsang peristaltik usus.

c. Ketakutan mengejan

Rasa takut akibat nyeri luka perineum, episiotomi, atau hemoroid menyebabkan ibu menahan defekasi. Hal ini memperlama waktu transit usus sehingga air lebih banyak diserap kembali oleh kolon, mengakibatkan feses menjadi keras.

d. Faktor tambahan (evidence-based)

1) Nyeri perineum/episiotomi
2) Penggunaan analgesik opioid
3) Dehidrasi
4) Perubahan hormonal (penurunan progesteron)

5) Riwayat konstipasi sebelumnya

3. Patofisiologi

   Konstipasi postpartum terjadi melalui mekanisme berikut:

   Penurunan aktivitas fisik, nyeri perineum dan asupan serat rendah

   a. Penurunan Motilitas Usus
   b. Waktu Transit Usus Memanjang
   c. Reabsorpsi Air Meningkat Di Kolon
   d. Feses Menjadi Keras Dan Kering
   e. Kesulitan Defekasi (Konstipasi)
   f. Peningkatan Tekanan Intraabdomen Saat Mengejan
   g. Dilatasi Vena Rektal
   h. Terjadi Hemoroid

4. Manifestasi Klinis

   Gejala konstipasi postpartum meliputi:

   a. Perubahan pola defekasi
      1) Tidak BAB ≥3 hari
      2) Frekuensi BAB menurun dari kebiasaan normal
   b. Karakteristik feses
      1) Feses keras, kering, dan sulit dikeluarkan
      2) Volume kecil
   c. Keluhan saat defekasi

      Nyeri saat BAB

      Mengejan berlebihan

      Perasaan tidak tuntas (incomplete evacuation)
   d. Gejala penyerta
      1) Perut kembung
      2) Rasa tidak nyaman pada abdomen
      3) Penurunan nafsu makan

5. Komplikasi

   Jika tidak ditangani dengan baik, konstipasi postpartum dapat menyebabkan:

   a. Hemoroid

      Peningkatan tekanan intraabdomen saat mengejan menyebabkan dilatasi vena hemoroidalis sehingga timbul hemoroid.
   b. Fisura ani

      Feses keras dapat menyebabkan robekan mukosa anus yang menimbulkan nyeri hebat saat defekasi.

c. Infeksi
   Retensi feses dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri dan risiko infeksi lokal.
d. Prolaps rektum (kasus berat)
   Mengejan kronis dapat menyebabkan penonjolan rektum.
e. Gangguan psikologis
   Ketidaknyamanan berkepanjangan dapat menimbulkan kecemasan dan stres pada ibu nifas.

C. Penatalaksanaan Konstipasi Postpartum

Penatalaksanaan konstipasi postpartum bertujuan untuk mengembalikan fungsi eliminasi usus normal, mencegah komplikasi (seperti hemoroid), serta meningkatkan kenyamanan ibu nifas. Pendekatan dilakukan secara non-farmakologis sebagai lini pertama, dilanjutkan farmakologis bila diperlukan.

1. Diet Tinggi Serat
   a. Konsep Serat meningkatkan massa feses dan merangsang peristaltik usus sehingga mempercepat defekasi.
   b. Jenis Serat: Serat larut: menyerap air → melembutkan feses Serat tidak larut: meningkatkan volume feses
   c. Sumber Serat: Sayur: bayam, brokoli, wortel, Buah: pepaya, pisang, apel, Biji-bijian: gandum, oatmeal
2. Cairan Adekuat
   a. Konsep: Cairan membantu melunakkan feses dan mencegah dehidrasi yang memperparah konstipasi.
   b. Kebutuhan: Minimal 2–3 liter/hari, Lebih tinggi pada ibu menyusui
3. Mobilisasi Dini
   a. Konsep: Aktivitas fisik meningkatkan motilitas gastrointestinal melalui stimulasi refleks parasimpatis.
   b. Bentuk Mobilisasi: Duduk dalam 6–8 jam postpartum, Berjalan ringan 24 jam postpartum dan Senam nifas.
4. Laksatif (Bila Diperlukan)
   a. Indikasi
      1) Tidak BAB >3 hari
      2) Nyeri saat defekasi berat
      3) Tidak membaik dengan terapi non-farmakologis
   b. Jenis Laksatif
      1) Bulk-forming: psyllium
      2) Osmotik: laktulosa

3) Stool softener: docusate sodium

c. Prinsip Penggunaan
   1) Sesuai indikasi medis
   2) Aman untuk ibu menyusui
   3) Hindari penggunaan jangka panjang

5. Penatalaksanaan Tambahan (Evidence-Based)
   a. Edukasi Perilaku Defekasi: Tidak menahan BAB dan Posisi jongkok atau modifikasi posisi fisiologis.
   b. Manajemen Nyeri Perineum: Kompres hangat dan Analgesik untuk Mengurangi ketakutan mengejan.
   c. Dukungan Psikologis: Mengurangi kecemasan postpartum dan Meningkatkan kenyamanan
6. Pendekatan Asuhan Kebidanan
   a. Monitoring: Frekuensi BAB, Konsistensi feses dan Nyeri saat defekasi.
   b. Kolaborasi: Dengan dokter untuk terapi farmakologis dan Nutrisionis untuk pengaturan diet.
7. Outcome yang Diharapkan
   a. BAB teratur (≥3 kali/minggu)
   b. Feses lunak
   c. Tidak ada nyeri saat defekasi
   d. Tidak terjadi komplikasi (hemoroid)

D. Hemoroid Postpartum

1. Etiologi

   Hemoroid postpartum terjadi akibat dilatasi dan inflamasi pleksus vena hemoroidalis yang dipicu oleh:
   a. Peningkatan tekanan vena selama kehamilan akibat pembesaran uterus yang menekan vena pelvis
   b. Mengejan kuat saat persalinan (proses kala II)
   c. Stasis vena karena penurunan aliran balik vena
   d. Perubahan hormonal (progesteron) yang menyebabkan relaksasi dinding vena
   e. Konstipasi yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen
2. Faktor Risiko

   Faktor yang meningkatkan kejadian hemoroid postpartum antara lain:
   a. Konstipasi kronis selama kehamilan dan nifas
   b. Multiparitas (sering melahirkan)
   c. Persalinan lama terutama kala II memanjang
   d. Bayi dengan berat lahir besar (>3500 gram)

e. Kurangnya aktivitas fisik (imobilisasi)
f. Riwayat hemoroid sebelumnya

3. Patofisiologi

Kehamilan peningkatan tekanan intraabdomen lalu kompresi vena pelvis maka aliran balik vena terganggu dilatasi pleksus hemoroidalis saat persalinan terjadi peningkatan tekanan (mengejan) lalu vena semakin melebar dan inflamasi dan edema terbentuk hemoroid dan akan terjadi trombosis dan perdarahan.

4. Klasifikasi
   a. Berdasarkan lokasi:
      1) Hemoroid internal (di atas linea dentata)
      2) Hemoroid eksternal (di bawah linea dentata)
   b. Berdasarkan derajat (internal):
      1) Derajat I: tidak prolaps
      2) Derajat II: prolaps saat mengejan, masuk spontan
      3) Derajat III: prolaps, perlu reposisi manual
      4) Derajat IV: prolaps permanen
5. Manifestasi Klinis
   a. Nyeri pada daerah anus (terutama hemoroid eksternal)
   b. Perdarahan saat BAB (darah merah segar)
   c. Benjolan di anus
   d. Rasa tidak nyaman atau gatal
   e. Sulit duduk
6. Pemeriksaan Penunjang
   a. Inspeksi dan palpasi anus
   b. Anoskopi / rektoskopi
   c. Pemeriksaan Hb (jika perdarahan)
7. Komplikasi
   a. Trombosis hemoroid
   b. Anemia akibat perdarahan kronis
   c. Infeksi local
   d. Prolaps menetap
8. Penatalaksanaan
   a. Non-farmakologis
      1) Diet tinggi serat
      2) Asupan cairan ≥2 liter/hari
      3) Mobilisasi dini
      4) Sitz bath (rendam air hangat)
      5) Hindari mengejan berlebihan

b. Farmakologis
    1) Salep/topikal antihemoroid
    2) Analgesik
    3) Laksatif ringan
c. Tindakan medis
    1) Ligasi karet
    2) Skleroterapi
    3) Hemoroidektomi (kasus berat)

E. Asuhan Kebidanan

1. Pengkajian
    a. Keluhan nyeri anus, perdarahan
    b. Riwayat konstipasi
    c. Lama persalinan
    d. Pola diet dan eliminasi
    e. Pemeriksaan perineum
2. Diagnosis Kebidanan
    a. Gangguan eliminasi: konstipasi
    b. Nyeri akut berhubungan dengan hemoroid
    c. Gangguan kenyamanan
3. Luaran (Outcome)
    a. Nyeri berkurang/hilang
    b. BAB lancar tanpa nyeri
    c. Tidak ada perdarahan
    d. Ibu mampu melakukan perawatan mandiri
4. Intervensi
    a. Monitor eliminasi BAB
    b. Edukasi diet tinggi serat
    c. Anjurkan cairan cukup
    d. Ajarkan teknik relaksasi saat BAB
    e. Kolaborasi pemberian obat
5. Implementasi
    a. Melakukan sitz bath
    b. Memberikan edukasi nutrisi
    c. Observasi tanda komplikasi
6. Evaluasi
    a. Nyeri berkurang
    b. Tidak ada perdarahan

c. BAB normal

7. Edukasi
   a. Konsumsi sayur, buah, dan cairan
   b. Tidak menahan BAB
   c. Hindari duduk terlalu lama
   d. Perawatan kebersihan perineum
8. Dokumentasi
   Menggunakan SOAP:
   S: ibu mengeluh nyeri saat BAB
   O: tampak hemoroid
   A: hemoroid postpartum
   P: edukasi, terapi, monitoring
9. Patofisiologi Hemoroid Postpartum (Lengkap)
   a. Hemoroid postpartum terjadi akibat kombinasi perubahan fisiologis kehamilan dan proses persalinan:
   b. Selama kehamilan, terjadi peningkatan tekanan intraabdomen akibat pembesaran uterus → menekan vena pelvis dan vena rektalis
   c. Hormon progesteron menyebabkan relaksasi dinding vena → meningkatkan distensibilitas vena
   d. Aliran balik vena terganggu → terjadi stasis vena
   e. Saat persalinan, terutama kala II (mengejan), terjadi peningkatan tekanan intraabdomen secara drastic
   f. Tekanan ini menyebabkan dilatasi dan kongesti pleksus vena hemoroidalis
   g. Dilatasi kronis → terbentuk hemoroid internal atau eksternal
   h. Trauma saat persalinan + konstipasi postpartum → memperparah kondisi
   i. Terjadi inflamasi, edema, dan trombosis pada vena → menimbulkan nyeri dan perdarahan
10. Manifestasi Klinis (Lengkap dan Klinis Kebidanan)

    Manifestasi hemoroid postpartum bervariasi tergantung derajat dan jenisnya:

    a. Gejala utama
       Nyeri pada anus (terutama saat duduk atau BAB)
       Perdarahan segar (merah terang) saat atau setelah defekasi
       Benjolan di anus (prolaps hemoroid)
    b. Gejala tambahan
       1) Rasa tidak nyaman atau penuh di rectum
       2) Gatal (pruritus ani)
       3) Sensasi terbakar

4) Keluar lendir

c. Berdasarkan jenis

1) Hemoroid internal: sering tidak nyeri, perdarahan dominan
2) Hemoroid eksternal: nyeri hebat, terutama jika trombosis

11. Penatalaksanaan Hemoroid Postpartum (Komprehensif Berbasis Evidence)

Penatalaksanaan bertujuan mengurangi gejala, mencegah komplikasi, dan memperbaiki fungsi eliminasi.

a. Terapi Non-Farmakologis (Utama)

1) Sitz bath (rendam air hangat) : Dilakukan 10–15 menit, 2–3 kali/hari dan Efek: meningkatkan sirkulasi, mengurangi nyeri dan edema dan Diet tinggi serat
2) Sayur, buah, biji-bijian, Serat 25–30 gram/hari dan Mencegah konstipasi
3) Peningkatan asupan cairan dan Minimal 2–3 liter/hari
4) Mobilisasi dini untuk Meningkatkan peristaltik usus
5) Hindari mengejan berlebihan

b. Terapi Farmakologis

1) Salep/topikal antihemoroid : Mengandung anestesi lokal atau antiinflamasi dan Mengurangi nyeri dan inflamasi
2) Analgesik : Paracetamol atau NSAID (sesuai indikasi)
3) Laksatif (bila konstipasi) : Bulk-forming (psyllium) atau stool softener

c. Terapi Lanjutan (Jika Berat)

1) Skleroterapi
2) Ligasi pita karet
3) Hemoroidektomi (jarang pada postpartum, indikasi khusus)

F. Asuhan Kebidanan *(Obe Approach)*

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses asuhan kebidanan yang bertujuan mengidentifikasi kondisi ibu nifas secara menyeluruh terkait gangguan eliminasi (retensi urine, konstipasi, dan hemoroid) melalui pendekatan biologis, psikologis, sosial, dan budaya.

Data Subjektif (Anamnesis) : Data yang diperoleh dari keluhan ibu:

Keluhan Utama:

a. Sulit buang air kecil (BAK)
b. Tidak bisa BAK spontan >6 jam postpartum
c. Sulit buang air besar (BAB)
d. Nyeri saat BAB (dischezia)
e. Nyeri pada daerah anus/perineum

f. Perasaan tidak tuntas setelah BAK/BAB

2. Riwayat Keluhan Sekarang
   a. Waktu mulai keluhan (sejak kapan setelah persalinan)
   b. Frekuensi BAK/BAB
   c. Jumlah dan karakter urine/feses
   d. Adanya nyeri, panas, atau perdarahan
   e. Upaya yang sudah dilakukan (minum, obat, posisi)
3. Riwayat Obstetri
   a. Jenis persalinan (spontan, vakum, forceps, SC)
   b. Lama persalinan
   c. Riwayat episiotomi atau laserasi perineum
   d. Berat badan bayi lahir
   e. Penggunaan anestesi/analgesia
4. Riwayat Kesehatan
   a. Riwayat konstipasi sebelumnya
   b. Riwayat hemoroid saat hamil
   c. Penyakit penyerta (DM, neurologis, dll.)
5. Pola Eliminasi
   a. Kebiasaan BAK sebelum dan sesudah persalinan
   b. Kebiasaan BAB (frekuensi, konsistensi, warna)
6. Pola Nutrisi dan Cairan
   a. Asupan cairan harian
   b. Konsumsi serat (sayur, buah)
7. Aktivitas dan Mobilisasi

   Waktu mulai mobilisasi postpartum dan Hambatan mobilisasi (nyeri, lemah)
8. Aspek Psikologis

   Rasa takut mengejan (karena luka jahitan) dan Kecemasan atau stres postpartum

Data Objektif (Pemeriksaan Fisik dan Observasi)

1. Keadaan Umum : Kesadaran : Tanda vital (TD, Nadi, RR, Suhu).
2. Pemeriksaan Abdomen : Palpasi kandung kemih (distensi atau penuh) dan Nyeri tekan suprapubic
3. Pemeriksaan Genitalia dan Perineum
   a. Luka episiotomi/laserasi (derajat, edema, hematoma)
   b. Tanda infeksi
   c. Nyeri tekan

4. Observasi Eliminasi Urine
    a. Frekuensi BAK
    b. Volume urine
    c. Warna dan bau urine
    d. Adanya retensi atau inkontinensia
5. Observasi Eliminasi Feses
    a. Frekuensi BAB
    b. Konsistensi feses (keras/lunak)
    c. Adanya darah pada feses
6. Pemeriksaan Anus
    a. Adanya hemoroid (internal/eksternal)
    b. Pembengkakan, nyeri, perdarahan
7. Pemeriksaan Penunjang (jika tersedia)

    Bladder scan (volume residu urine) USG kandung kemih dan Pemeriksaan laboratorium (jika dicurigai infeksi)

Data Riwayat Persalinan (Faktor Predisposisi)

1. Persalinan lama (>18 jam)
2. Penggunaan alat bantu persalinan
3. Trauma jalan lahir
4. Retensi urine sebelumnya
5. Konstipasi selama kehamilan

Analisis Data (Sintesis Pengkajian)

Hasil pengkajian digunakan untuk mengidentifikasi masalah:

1. Retensi urine postpartum
2. Konstipasi postpartum
3. Hemoroid postpartum
4. Risiko infeksi saluran kemih
5. Gangguan kenyamanan

Pendekatan OBE dalam Pengkajian

Pengkajian difokuskan pada capaian pembelajaran: Capaian (Learning Outcome): Mahasiswa mampu melakukan pengkajian komprehensif pada ibu nifas dengan gangguan eliminasi secara tepat dan berbasis bukti.

Indikator:

1. Mengidentifikasi data subjektif dan objektif secara lengkap
2. Menghubungkan faktor risiko dengan kondisi pasien

3. Mendokumentasikan data secara sistematis (SOAP)

Diagnosis Kebidanan

Diagnosis kebidanan ditegakkan berdasarkan data subjektif dan objektif yang diperoleh saat pengkajian.

1. Retensi Urine Postpartum Definisi diagnosis: Ketidakmampuan ibu nifas untuk mengosongkan kandung kemih secara spontan dalam waktu ≥6 jam postpartum atau terdapat residu urine ≥150 ml.
   Data pendukung:
   a. DS: ibu mengeluh tidak bisa BAK, nyeri suprapubik
   b. DO: kandung kemih teraba penuh, distensi abdomen bawah
2. Konstipasi Postpartum
   Definisi diagnosis:
   Gangguan eliminasi fekal ditandai dengan kesulitan BAB, frekuensi <3 kali/minggu, dan feses keras.
   Data pendukung:
   a. DS: nyeri saat BAB, takut mengejan
   b. DO: feses keras, abdomen kembung
3. Hemoroid Postpartum
   Definisi diagnosis:
   Pembesaran vena hemoroid akibat peningkatan tekanan intraabdomen selama kehamilan/persalinan.
   Data pendukung:
   a. DS: nyeri anus, BAB berdarah
   b. DO: benjolan di anus, inflamasi

Luaran (Outcome) – Berbasis SLKI

Luaran ditetapkan secara spesifik, terukur, dan berorientasi hasil:

1. Eliminasi Urine Normal
   a. Ibu mampu BAK spontan dalam 6–8 jam postpartum
   b. Tidak ada distensi kandung kemih
   c. Tidak ada nyeri saat berkemih
2. Eliminasi Fekal Normal
   a. Frekuensi BAB normal (≥1 kali/hari atau sesuai kebiasaan)
   b. Konsistensi feses lunak
   c. Tidak ada nyeri saat defekasi

3. Nyeri Teratasi
    a. Skala nyeri ≤3 (skala 0–10)
    b. Tidak ada keluhan nyeri perineum/anus

Intervensi Kebidanan – Berbasis SIKI

1. Monitoring Eliminasi
    a. Observasi frekuensi, jumlah, dan karakteristik BAK/BAB
    b. Palpasi kandung kemih
    c. Identifikasi tanda retensi urine/konstipasi
2. Manajemen Eliminasi Urine
    a. Anjurkan BAK setiap 2–3 jam
    b. Stimulasi BAK (air hangat, posisi duduk)
    c. Kateterisasi bila indikasi
3. Manajemen Eliminasi Fekal
    a. Anjurkan diet tinggi serat
    b. Peningkatan intake cairan
    c. Latihan relaksasi saat BAB
4. Mobilisasi Dini
    a. Anjurkan ambulasi dalam 6–8 jam postpartum
    b. Latihan ringan
5. Manajemen Nyeri
    a. Kompres hangat/dingin
    b. Sitz bath (hemoroid)
    c. Kolaborasi analgesik
6. Edukasi Kesehatan
    a. Nutrisi tinggi serat
    b. Perawatan perineum
    c. Kebiasaan eliminasi sehat

Implementasi

Pelaksanaan tindakan kebidanan dilakukan sesuai rencana intervensi:

1. Melakukan observasi eliminasi secara berkala
2. Membantu ibu mobilisasi dini
3. Memberikan edukasi langsung dan demonstrasi
4. Melakukan tindakan kateterisasi sesuai indikasi dan SOP
5. Memberikan perawatan hemoroid (sitz bath)
6. Berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi farmakologis

Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien dengan luaran yang telah ditetapkan:

Kriteria evaluasi:

1. Ibu mampu BAK spontan tanpa nyeri
2. Tidak ada distensi kandung kemih
3. BAB lancar tanpa nyeri
4. Hemoroid berkurang
5. Tidak ada komplikasi

Dokumentasi evaluasi:

S: ibu mengatakan sudah bisa BAK/BAB

O: tidak ada distensi, feses lunak

A: masalah teratasi/sebagian teratasi

P: lanjutkan/akhiri intervensi

Edukasi

Edukasi diberikan secara komprehensif dan berkelanjutan:

1. Kebutuhan Cairan : Minum ≥2–3 liter/hari
2. Nutrisi : Konsumsi makanan tinggi serat (sayur, buah, biji-bijian)
3. Kebiasaan Eliminasi : Tidak menahan BAK/BAB dan BAB secara teratur
4. Perawatan Perineum : Menjaga kebersihan area genital, Menggunakan air hangat dan Menghindari mengejan berlebihan
5. Aktivitas : Mobilisasi dinidan Latihan ringan

DOKUMENTASI (SOAP)

1. Definisi Dokumentasi SOAP

   Dokumentasi SOAP adalah metode pencatatan sistematis dalam asuhan kebidanan yang terdiri dari:

   S (Subjective): data subjektif dari keluhan ibu

   O (Objective): data hasil pemeriksaan

   A (Assessment): analisis/diagnosis kebidanan

   P (Plan): rencana tindakan dan evaluasi

   Dokumentasi ini digunakan untuk menjamin kontinuitas asuhan, legalitas, dan mutu pelayanan kebidanan.

Komponen Dokumentasi SOAP pada Gangguan Eliminasi Postpartum

1. Subjective (Data Subjektif) : Berisi keluhan ibu nifas terkait eliminasi:
   Retensi urine:
   a. Ibu mengatakan tidak bisa BAK sejak melahirkan
   b. Perasaan penuh di perut bawah
   c. Nyeri saat mencoba berkemih

   Konstipasi:
   a. Ibu mengatakan belum BAB >3 hari
   b. Feses keras dan sulit keluar
   c. Takut mengejan karena nyeri luka

   Hemoroid:
   a. Nyeri di anus
   b. Keluar darah saat BAB
   c. Ada benjolan di sekitar anus

2. Objective (Data Objektif)
   Hasil pemeriksaan bidan:
   Retensi urine:
   a. Kandung kemih teraba penuh
   b. Distensi suprapubic
   c. Output urine < normal

   Konstipasi:
   a. Abdomen kembung
   b. Peristaltik usus menurun
   c. Feses keras (jika dilakukan pemeriksaan)

   Hemoroid:
   a. Tampak benjolan di anus
   b. Perdarahan ringan
   c. Tanda inflamasi (kemerahan, edema)

3. Assessment (Analisis/Diagnosis Kebidanan)
   Contoh diagnosis kebidanan:
   a. Retensi urine postpartum
   b. Konstipasi postpartum
   c. Hemoroid postpartum

   Dapat ditambahkan masalah lain:
   a. Nyeri akut
   b. Risiko infeksi
   c. Gangguan kenyamanan

4. Plan (Perencanaan dan Tindakan)
   a. Retensi Urine
      1) Observasi pola BAK
      2) Anjurkan mobilisasi dini
      3) Kompres hangat suprapubic
      4) Kateterisasi bila perlu
   b. Konstipasi
      1) Anjurkan diet tinggi serat
      2) Peningkatan cairan ≥2 liter/hari
      3) Mobilisasi dini
      4) Laksatif sesuai indikasi
   c. Hemoroid
      1) Sitz bath (rendam air hangat)
      2) Edukasi tidak mengejan berlebihan
      3) Salep topikal sesuai indikasi
      4) Analgesik bila nyeri

Contoh Dokumentasi SOAP (Kasus Terintegrasi)
S: Ibu mengatakan belum bisa BAK sejak 8 jam setelah melahirkan, perut terasa penuh. Ibu juga belum BAB sejak 3 hari dan mengeluh nyeri pada anus saat mencoba BAB.
O: KU baik, TD 110/70 mmHg, Nadi 84x/menit
Kandung kemih teraba penuh, distensi suprapubik
Abdomen kembung
Tampak hemoroid eksternal

A:

1. Retensi urine postpartum
2. Konstipasi postpartum
3. Hemoroid postpartum

P:

1. Observasi eliminasi urine dan feses
2. Anjurkan mobilisasi dini
3. Kompres hangat suprapubic
4. Edukasi diet tinggi serat dan cairan
5. Sitz bath 2x/hari
6. Kolaborasi kateterisasi jika tidak BAK dalam 6 jam berikutnya
7. Evaluasi 24 jam

Prinsip Dokumentasi yang Baik

1. Akurat dan factual
2. Lengkap dan sistematis
3. Ditulis segera setelah tindakan
4. Menggunakan istilah medis yang tepat
5. Bersifat legal (ditandatangani petugas)

G. Aktivitas 1 — Knows How

Seorang perempuan usia 26 tahun, P1A0, 8 jam postpartum setelah persalinan spontan pervaginam di Puskesmas PONED. Persalinan berlangsung selama 15 jam dengan kala II memanjang ±90 menit. Bayi lahir dengan berat 3900 gram. Ibu mendapatkan anestesi epidural dan dilakukan episiotomi mediolateral.
Hasil pemeriksaan awal pukul 10.00:

keadaan umum baik
TD 110/70 mmHg
nadi 88 x/menit
suhu 36,8°C
TFU sesuai masa nifas
kandung kemih belum dikosongkan sejak persalinan
ibu mengeluh belum bisa BAK sejak melahirkan
perut bagian bawah terasa penuh dan nyeri
ibu juga belum BAB dan takut mengejan karena nyeri jahitan

Pemeriksaan fisik menunjukkan:
distensi kandung kemih teraba di atas simfisis pubis
nyeri tekan suprapubik
luka episiotomi tampak edema ringan
ibu masih tirah baring dan tampak gelisah

Pemantauan dilakukan secara serial.
<u>Pukul 14.00 didapatkan:</u>
ibu masih belum dapat BAK spontan
nadi 98 x/menit
perut bawah semakin tegang
keluar urin menetes sedikit (overflow/dribbling)
ibu mengeluh nyeri saat duduk dan muncul benjolan kecil di sekitar anus

<u>Pukul 18.00:</u>
ibu belum BAB >24 jam
feses terasa keras dan sulit keluar
ibu mengeluh nyeri anus saat mencoba BAB
tampak hemoroid eksternal dengan edema ringan
ibu tampak semakin tidak nyaman dan lelah

Pertanyaan Diskusi

Apa masalah utama pada kasus di atas?
Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
Berdasarkan faktor etiologi, apa penyebab utama kondisi tersebut?
Tinjau dari faktor:
trauma perineum
anestesi epidural
persalinan lama
bayi makrosomia

Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada ibu?
Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
Apakah kasus ini masih dapat ditangani di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.

Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	**Komponen**	**Isi**
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Gangguan Eliminasi Pascapersalinan
3	Kasus	Retensi urine postpartum disertai konstipasi dan hemoroid
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kompetensi asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan gangguan eliminasi :
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik sederhana 3. Diagnosis kebidanan 4. Tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 27 tahun, P1A0, 8 jam postpartum setelah persalinan spontan pervaginam di Puskesmas PONED. Riwayat persalinan:

No.	Komponen	Isi
		kala II memanjang ±90 menit bayi lahir dengan berat 3900 gram dilakukan episiotomi ibu mendapat anestesi epidural Keluhan utama: belum dapat BAK sejak melahirkan perut bawah terasa penuh dan nyeri belum BAB takut mengejan karena nyeri jahitan nyeri pada anus saat duduk Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg N 96 x/menit P 20 x/menit S 36,9°C kandung kemih teraba penuh distensi suprapubik luka episiotomi edema ringan tampak hemoroid eksternal ringan TUGAS Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. Lakukan pemeriksaan fisik terfokus sesuai kasus. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga. Jelaskan rencana kolaborasi atau rujukan bila diperlukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: • Actual mark (0/1/2/3) • Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi suprapubik, penguji memberikan data: kandung kemih teraba penuh nyeri tekan suprapubik Jika peserta meminta data eliminasi: tidak BAK >8 jam belum BAB sejak persalinan Tindakan awal yang diharapkan: cuci tangan dan komunikasi terapeutik menilai tanda vital palpasi kandung kemih anjurkan mobilisasi dini stimulasi BAK (air hangat/privasi) siapkan kateterisasi sesuai SOP edukasi cairan dan serat sitz bath untuk hemoroid kolaborasi bila retensi menetap Penguji hanya memberikan data tambahan jika diminta peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu postpartum 8 jam setelah melahirkan. 2. PS tampak: 3. cemas 4. memegang perut bawah 5. tampak tidak nyaman saat duduk 6. mengeluh nyeri anus

No.	Komponen	Isi
		7. Jika peserta memberi penjelasan, PS kooperatif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Bu. PS: Pagi, Bu. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya belum bisa kencing sejak melahirkan, Bu. Peserta: Sejak kapan? PS: Dari setelah melahirkan sampai sekarang. Peserta: Apa yang ibu rasakan? PS: Perut bawah saya terasa penuh dan sakit. Peserta: Sudah BAB? PS: Belum, Bu, saya takut mengejan karena jahitannya sakit. Peserta: Ada keluhan lain? PS: Duduk terasa sakit, seperti ada benjolan di anus. Peserta: Baik Bu, saya akan membantu melakukan pemeriksaan dan tindakan awal. PS: Iya, Bu.Peserta: BAK terakhir kapan? PS: Tadi pagi, sedikit sekali. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan pertama saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, persalinannya belum maju dan bayi perlu segera ditolong di rumah sakit. PS: Baik, Bu, tolong bantu saya dan bayi saya ya. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu.
10	Kebutuhan manikin	• phantom abdomen postpartum • phantom perineum/anus • model kateterisasi urin wanita
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - menyiapkan alat

No.	Komponen	Isi
		- merapikan station - mengganti lembar instruksi
12	Kebutuhan alat	1. tempat tidur pemeriksaan 2. tensimeter 3. stetoskop 4. termometer 5. sarung tangan 6. handrub 7. set kateter dummy 8. urine bag dummy 9. kompres hangat 10. kain penutup 11. phantom postpartum 12. phantom anus/perineum 13. lembar SOAP 14. pena
13	Penulis	.....
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan. Jakarta: Kemenkes RI. 2. Dokumen ini menjadi acuan utama kompetensi bidan dalam pelayanan masa nifas dan gangguan pascapersalinan. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan. Jakarta: Kemenkes RI. 4. World Health Organization (WHO). (2013). WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. Geneva: WHO. 5. World Health Organization (WHO). (2022). WHO recommendations: maternal and newborn care for a positive postnatal experience. Geneva: WHO. 6. Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2015). Varney's Midwifery (5th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning. 7. Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). Williams Obstetrics (26th ed.). New York: McGraw-Hill. 8. Materi pembelajaran internal: Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan Lain: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid. 9. Template penyusunan OSCE kebidanan institus

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Gangguan Eliminasi Pascapersalinan

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Keluhan utama (tidak bisa BAK/BAB, nyeri anus)		
2. Waktu mulai keluhan sejak postpartum		
3. Riwayat persalinan (lama persalinan, episiotomi, anestesi)		
4. Riwayat eliminasi urine (BAK terakhir, jumlah, nyeri)		
5. Riwayat eliminasi fekal (BAB terakhir, konsistensi feses)		
6. Riwayat nyeri perineum / takut mengejan		
7. Riwayat hemoroid / konstipasi saat hamil		
8. Asupan cairan, serat, dan mobilisasi postpartum		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menanyakan dan menilai pola BAK		
d. Menanyakan dan menilai pola BAB		
e. Palpasi kandung kemih / suprapubik		
f. Menilai luka episiotomi / edema		
g. Menilai adanya hemoroid		
h. Menetapkan retensi urine postpartum		
i. Menetapkan konstipasi postpartum		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
j. Menetapkan hemoroid postpartum		
k. Menganjurkan mobilisasi dini		
l. Stimulasi BAK (air hangat / privasi)		
m. Menyiapkan kateterisasi sesuai SOP		
n. Menganjurkan diet tinggi serat dan cairan		
o. Menjelaskan sitz bath / kompres hangat		
p. Menyiapkan kolaborasi / rujukan bila perlu		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil pemeriksaan		
b. Menjelaskan rencana tindakan		
c. Mencuci tangan kembali dan Merapikan alat		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= melakukan 18–25 langkah dengan tepat
- 2= melakukan 12–17 langkah dengan tepat
- 1= melakukan 1–11 langkah dengan tepat
- 0= tidak melakukan

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan penyebab retensi / konstipasi / hemoroid		
4. Menjelaskan pentingnya cairan dan serat		
5. Menjelaskan mobilisasi dini		
6. Memberi kesempatan bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= semua 6 langkah benar
- 2= 4–5 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 *(dicatat di rubrik penilaian)*

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	**BORDERLINE**	**LULUS**	**SUPERIOR**

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji:.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan Lain: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal**
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa saat melakukan tindakan klinik. Penilai mengamati prosedur secara langsung dan memberikan umpan balik segera setelah tindakan selesai. Domain yang dinilai meliputi informed consent, persiapan, kemampuan teknis, komunikasi, keselamatan pasien, dan profesionalisme.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pengkajian ibu nifas dengan gangguan eliminasi, palpasi kandung kemih, penilaian konstipasi dan hemoroid, serta tindakan awal seperti stimulasi BAK, mobilisasi dini, edukasi diet, dan persiapan kateterisasi bila diperlukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah Menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, sistematis, dan evidence-based pada ibu postpartum dengan gangguan eliminasi.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan teori, tetapi dari kemampuan melakukan pengkajian, menetapkan masalah prioritas, melakukan tindakan awal, serta memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata lahan praktik sesuai capaian pembelajaran profesi bidan.menempatkan penggunaan partograf serta identifikasi tanda obstruksi sebagai bagian penting dalam pengelolaan persalinan lama dan obstruktif.	Seorang ibu usia 27 tahun, P1A0, 8 jam postpartum, mengeluh belum dapat BAK sejak melahirkan, perut bawah terasa penuh, belum BAB, dan nyeri anus saat duduk. Pemeriksaan menunjukkan distensi kandung kemih, edema episiotomi, dan hemoroid eksternal ringan.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur klinik secara nyata, bukan hanya diskusi kasus.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, melakukan anamnesis, memeriksa tanda vital, palpasi suprapubik, mengidentifikasi retensi urine postpartum, menilai konstipasi dan hemoroid, melakukan tindakan awal, serta menjelaskan rencana tindak lanjut.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Aspek yang dinilai	Indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan, kemampuan teknis, komunikasi, keselamatan pasien, dan tindak lanjut.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan riwayat persalinan lama, episiotomi, anestesi, dan makrosomia sebagai faktor risiko gangguan eliminasi postpartum.
Fokus observasi pembimbing	Mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan klinik.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa melakukan prioritas tindakan secara tepat: identifikasi retensi urine, stimulasi miksi, mobilisasi dini, edukasi serat dan cairan, serta indikasi kateterisasi.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi selesai.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan ketelitian palpasi kandung kemih atau edukasi pencegahan konstipasi dan hemoroid.
Keputusan penilaian	Kompeten / perlu supervisi / remedial	Kompeten bila mahasiswa mampu melakukan prosedur secara runtut, aman, dan tepat. Perlu supervisi bila langkah utama benar namun masih memerlukan arahan. Remedial bila gagal mengenali retensi urine atau salah prioritas tindakan.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran level does	Mahasiswa tidak hanya memahami teori gangguan eliminasi postpartum, tetapi mampu menerapkan asuhan kebidanan secara langsung dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 5.1
Portofolio pada Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Pada topik ini, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian ibu nifas, mengidentifikasi gangguan eliminasi, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa pernah menangani ibu dengan retensi urine atau konstipasi, tetapi juga menunjukkan perkembangan kemampuan setelah mendapatkan masukan dari CI/dosen.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS merupakan bagian penting dari portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur dan performa nyata.	OSCE memuat kemampuan identifikasi retensi urine postpartum, konstipasi, dan hemoroid serta tindakan awal. DOPS memuat observasi langsung saat mahasiswa melakukan palpasi kandung kemih, edukasi, dan tindakan awal di lahan praktik.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Catatan kasus singkat	Catatan kasus berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa, termasuk data penting, diagnosis, tindakan, dan hasil.	. Mahasiswa menuliskan kasus ibu postpartum yang tidak bisa BAK >6 jam, kandung kemih distensi, belum BAB, serta adanya hemoroid, tindakan yang dilakukan, dan hasil evaluasi.
Refleksi patient safety	Refleksi menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien dan merencanakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa retensi urine dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan overdistensi kandung kemih, serta konstipasi dapat memperburuk hemoroid jika tidak ditangani dengan tepat.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI/dosen menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan ketepatan identifikasi retensi
Karakteristik penilaian	Penilaian portofolio bersifat berkelanjutan dan menilai konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kasus, bukan satu kasus saja, untuk melihat konsistensi kemampuan dalam menangani gangguan eliminasi postpartum.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kualitas performa dalam berbagai situasi klinik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, dan refleksi terlihat mahasiswa konsisten mampu mengidentifikasi masalah eliminasi dan memberikan asuhan yang tepat.
Makna dalam OBE	Portofolio merupakan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai pada level does.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan kebidanan pada ibu postpartum secara langsung, aman, dan profesional.

Tabel 5.2
Case Report pada Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan faktor risiko, diagnosis kebidanan, tindakan awal, edukasi, dan perkembangan kondisi ibu setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan ibu usia 27 tahun, P1A0, 8 jam postpartum, tidak BAK sejak melahirkan, belum BAB, nyeri anus, kandung kemih distensi, hemoroid eksternal ringan, lalu menganalisis retensi urine postpartum disertai konstipasi dan hemoroid.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan persalinan lama, episiotomi, anestesi, dan bayi makrosomia sebagai faktor predisposisi gangguan eliminasi postpartum.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini mahasiswa belajar pentingnya deteksi dini retensi urine, pencegahan konstipasi, dan penanganan hemoroid pada masa nifas.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu menyusun laporan kasus yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	secara sistematis dan bertanggung jawab.	menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh dan berbasis bukti.

Tabel 5.3
Refleksi Patient Safety pada Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus ibu postpartum, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali retensi urine, konstipasi, atau hemoroid dapat memperburuk kondisi ibu dan meningkatkan risiko komplikasi.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan identifikasi gangguan eliminasi dapat menyebabkan distensi kandung kemih, infeksi saluran kemih, konstipasi berat, dan hemoroid yang semakin parah.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah overdistensi kandung kemih, infeksi, nyeri berat, hemoroid, serta gangguan kenyamanan ibu postpartum.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis retensi urine postpartum, kurangnya mobilisasi dini, asupan cairan yang kurang, konstipasi yang tidak tertangani, dan trauma perineum yang memperburuk hemoroid.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya observasi BAK dalam 6 jam pertama postpartum, palpasi kandung kemih, stimulasi BAK, edukasi cairan dan serat,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		mobilisasi dini, sitz bath, serta kolaborasi kateterisasi bila diperlukan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pemantauan eliminasi pada masa nifas harus dilakukan secara aktif dan tidak boleh menunggu ibu mengeluh, karena beberapa kasus retensi urine dapat bersifat covert.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan mutu asuhan kebidanan secara berkelanjutan.

H. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 26 tahun, P1A0, berada di ruang nifas 8 jam setelah persalinan spontan pervaginam. Persalinan berlangsung selama 15 jam dengan kala II selama 90 menit. Bayi lahir dengan berat 3.900 gram. Ibu mendapatkan anestesi epidural dan episiotomi mediolateral.
   Hasil anamnesis: ibu mengatakan belum dapat BAK sejak melahirkan, perut bagian bawah terasa penuh dan nyeri.
   Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, nadi 96 kali/menit, suhu 36,8°C, kandung kemih teraba penuh di atas simfisis pubis, terdapat distensi suprapubik, dan urine hanya menetes sedikit.
   Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Inkontinensia urine postpartum
   B. Overt postpartum urinary retention
   C. Covert postpartum urinary retention
   D. Infeksi saluran kemih postpartum
   E. Gangguan eliminasi fekal postpartum

2. Seorang perempuan berusia 29 tahun, P2A0, berada di ruang nifas 10 jam setelah persalinan dengan bantuan vakum. Ibu mengalami laserasi perineum derajat II dan mendapatkan anestesi epidural.

Hasil anamnesis: ibu mengatakan sudah BAK sebanyak kurang lebih 350 mL dan tidak mengeluhkan nyeri suprapubik, tetapi merasa kandung kemihnya belum sepenuhnya kosong.
Hasil pemeriksaan: keadaan umum baik, kandung kemih tidak tampak sangat distensi, dan pemeriksaan bladder scan setelah miksi menunjukkan residu urine sebanyak 220 mL.
Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut?

A. Overt postpartum urinary retention
B. Infeksi saluran kemih postpartum
C. Pola eliminasi urine postpartum normal
D. Covert postpartum urinary retention
E. Inkontinensia urine akibat tekanan

3. Seorang perempuan berusia 24 tahun, P1A0, berada di ruang nifas 7 jam setelah persalinan pervaginam. Ibu menjalani episiotomi dan sebelumnya memperoleh anestesi spinal.
Hasil anamnesis: ibu mengatakan belum dapat BAK, perut bawah terasa penuh, dan nyeri bertambah ketika mencoba duduk.
Hasil pemeriksaan: kandung kemih teraba penuh, terdapat nyeri tekan suprapubik, dan bladder scan menunjukkan volume urine sekitar 340 mL. Bidan telah memberikan privasi, membantu mobilisasi, melakukan kompres hangat, dan menstimulasi miksi dengan suara air, tetapi ibu tetap belum dapat berkemih.
Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut?

A. Menganjurkan ibu menahan BAK sampai nyeri perineum berkurang
B. Melanjutkan stimulasi miksi saja selama enam jam berikutnya
C. Melakukan kateterisasi intermiten sesuai prosedur
D. Memasang kateter menetap pada semua kasus tanpa evaluasi lanjutan
E. Memberikan agen kolinergik sebagai terapi rutin tanpa kolaborasi

4. Seorang perempuan berusia 27 tahun, P1A0, datang ke Puskesmas pada hari keempat masa nifas. Persalinan berlangsung spontan dengan episiotomi.
Hasil anamnesis: ibu mengatakan belum BAB selama tiga hari, feses terasa keras, perut kembung, dan takut mengejan karena luka jahitan terasa nyeri. Ibu jarang mengonsumsi sayur dan buah serta hanya minum sekitar empat gelas sehari.
Hasil pemeriksaan: keadaan umum baik, tanda vital normal, abdomen sedikit kembung, tidak terdapat nyeri tekan berat, dan tidak ditemukan benjolan pada anus.
Apakah penatalaksanaan awal yang paling tepat pada kasus tersebut?

A. Menganjurkan diet tinggi serat, cairan 2–3 liter per hari, mobilisasi, dan tidak menahan BAB
B. Menganjurkan tirah baring, diet rendah serat, dan pembatasan cairan
C. Merujuk ibu untuk menjalani hemoroidektomi
D. Memberikan antibiotik dan melakukan kultur urine
E. Memberikan laksatif jangka panjang tanpa intervensi nonfarmakologis

5. Seorang perempuan berusia 33 tahun, P3A0, datang pada hari ketiga postpartum dengan keluhan perdarahan saat BAB. Ibu memiliki riwayat konstipasi selama kehamilan dan menjalani kala II persalinan yang memanjang.
   Hasil anamnesis: ibu mengatakan darah yang keluar berwarna merah segar. Terdapat benjolan dari anus ketika mengejan. Benjolan tersebut tidak masuk kembali secara spontan, tetapi dapat dimasukkan menggunakan tangan.
   Hasil pemeriksaan: keadaan umum baik, tidak ditemukan perdarahan aktif, dan tampak prolaps hemoroid dari anus saat ibu mengejan.
   Apakah klasifikasi hemoroid yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Hemoroid eksternal
   B. Hemoroid internal derajat I
   C. Hemoroid internal derajat II
   D. Hemoroid internal derajat IV
   E. Hemoroid internal derajat III

Kunci Jawaban

1. B. Overt postpartum urinary retention
2. D. Covert postpartum urinary retention
3. C. Melakukan kateterisasi intermiten sesuai prosedur
4. A. Menganjurkan diet tinggi serat, cairan 2–3 liter per hari, mobilisasi, dan tidak menahan BAB
5. E. Hemoroid internal derajat III

Pembahasan

1. Jawaban: **B**. Overt postpartum urinary retention
   Kata kunci: tidak dapat BAK selama delapan jam, distensi kandung kemih, nyeri suprapubik, urine hanya menetes.
   Retensi urine postpartum tipe overt ditandai dengan ketidakmampuan ibu berkemih secara spontan dalam waktu minimal enam jam setelah persalinan pervaginam atau setelah pelepasan kateter. Pada kasus ini, ibu belum mampu BAK selama delapan jam serta mengalami rasa penuh, nyeri suprapubik, dan

distensi kandung kemih. Urine yang hanya menetes menunjukkan kemungkinan overflow akibat kandung kemih yang terlalu penuh.

Risiko retensi urine pada ibu semakin kuat karena terdapat persalinan lama, kala II memanjang, bayi dengan berat 3.900 gram, penggunaan anestesi epidural, dan episiotomi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan edema periuretra, gangguan kontraksi otot detrusor, penurunan sensasi kandung kemih, dan spasme refleks sfingter uretra.

Alasan opsi lain:

a. A salah: inkontinensia ditandai ketidakmampuan menahan urine, bukan ketidakmampuan mengeluarkan urine.
b. C salah: covert retention terjadi ketika ibu masih mampu BAK, tetapi residu urine tetap tinggi.
c. D salah: tidak terdapat demam, urine berbau, rasa panas saat BAK, atau bukti urinalisis.
d. E salah: masalah utama pada kasus berhubungan dengan eliminasi urine, bukan eliminasi feses.

2. Jawaban: **D**. Covert postpartum urinary retention

Kata kunci: ibu dapat BAK, gejala minimal, residu urine setelah miksi 220 mL.

Covert postpartum urinary retention merupakan retensi urine yang tidak menunjukkan keluhan khas. Ibu masih dapat berkemih spontan, tetapi terdapat sisa urine dalam kandung kemih minimal sekitar 150–200 mL setelah miksi. Pada kasus ini, ibu telah mengeluarkan urine sebanyak 350 mL, tetapi bladder scan menunjukkan residu 220 mL. Temuan tersebut memenuhi karakteristik covert postpartum urinary retention.

Persalinan dengan bantuan vakum, laserasi perineum, dan anestesi epidural menjadi faktor predisposisi. Persalinan instrumental dapat menyebabkan trauma pada dasar panggul, uretra, dan saraf pelvis. Anestesi epidural juga dapat mengurangi sensasi penuh kandung kemih serta menghambat refleks miksi. Kondisi ini perlu dipantau karena residu urine yang menetap dapat menyebabkan stasis urine, infeksi saluran kemih, dan gangguan kontraktilitas kandung kemih.

Alasan opsi lain:

a. A salah: overt retention ditandai ketidakmampuan BAK spontan selama minimal enam jam.
b. B salah: belum terdapat tanda infeksi, seperti demam, rasa panas saat BAK, atau urine berbau.
c. C salah: residu 220 mL setelah miksi bukan temuan normal menurut materi.
d. E salah: inkontinensia ditandai urine keluar tanpa dapat dikendalikan, bukan residu urine yang tinggi.

3. Jawaban: **C**. Melakukan kateterisasi intermiten sesuai prosedur

   Kata kunci: belum BAK lebih dari enam jam, kandung kemih penuh, residu 340 mL, stimulasi miksi tidak berhasil.

   Ibu telah mengalami ketidakmampuan berkemih selama tujuh jam disertai distensi kandung kemih, nyeri suprapubik, dan volume urine sekitar 340 mL. Upaya nonfarmakologis berupa pemberian privasi, mobilisasi, kompres hangat, posisi yang sesuai, dan stimulasi suara air telah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, tindakan berikutnya adalah mengosongkan kandung kemih melalui kateterisasi.

   Kateterisasi intermiten merupakan pilihan utama pada retensi urine postpartum. Tindakan ini bertujuan mencegah overdistensi kandung kemih, kerusakan lebih lanjut pada otot detrusor, stasis urine, dan infeksi saluran kemih. Kateter menetap dapat dipertimbangkan apabila retensi berat atau berulang, tetapi pemasangannya tidak dilakukan secara otomatis pada semua pasien dan tetap memerlukan evaluasi klinis.

   Alasan opsi lain:

   a. **A salah:** menahan BAK akan memperberat distensi dan berisiko merusak fungsi kandung kemih.
   b. **B salah:** observasi berkepanjangan tidak tepat karena sudah terdapat retensi dan volume kandung kemih yang tinggi.
   c. **D salah:** kateter menetap digunakan berdasarkan tingkat keparahan, bukan untuk semua kasus.
   d. **E salah:** agen kolinergik jarang digunakan dan hanya untuk indikasi khusus melalui kolaborasi.

4. Jawaban: **A**. Menganjurkan diet tinggi serat, cairan 2–3 liter per hari, mobilisasi, dan tidak menahan BAB

   Kata kunci: belum BAB tiga hari, feses keras, asupan cairan dan serat rendah, takut mengejan.

   Ibu mengalami konstipasi postpartum yang ditandai tidak BAB selama tiga hari, feses keras, perut kembung, serta ketakutan mengejan akibat nyeri episiotomi. Asupan serat dan cairan yang rendah semakin memperlambat transit usus. Semakin lama feses berada di kolon, semakin banyak air yang diserap kembali sehingga feses menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan.

   Penanganan awal konstipasi postpartum adalah intervensi nonfarmakologis. Ibu dianjurkan meningkatkan konsumsi sayur, buah, dan biji-bijian; minum sekitar 2–3 liter per hari; melakukan mobilisasi dini; dan tidak menunda keinginan BAB. Manajemen nyeri perineum juga diperlukan untuk mengurangi rasa takut mengejan. Laksatif seperti psyllium, laktulosa, atau stool softener dapat

digunakan melalui kolaborasi apabila intervensi awal tidak berhasil atau sesuai indikasi.

Alasan opsi lain:

a. **B salah**: tirah baring, rendah serat, dan pembatasan cairan memperburuk konstipasi.
b. **C salah**: tidak ditemukan hemoroid berat yang memerlukan tindakan operasi.
c. **D salah**: kasus tidak menunjukkan infeksi saluran kemih.
d. **E salah**: laksatif bukan satu-satunya intervensi awal dan tidak dianjurkan digunakan jangka panjang tanpa indikasi.

5. Jawaban: **E**. Hemoroid internal derajat III

Kata kunci: prolaps saat mengejan, tidak masuk spontan, dapat direposisi secara manual.

Hemoroid internal diklasifikasikan berdasarkan derajat prolapsnya. Hemoroid internal derajat III mengalami prolaps ketika ibu mengejan dan tidak dapat masuk kembali secara spontan, tetapi masih dapat dimasukkan atau direposisi menggunakan tangan. Karakteristik tersebut sesuai dengan temuan pada kasus.

Konstipasi selama kehamilan dan kala II yang memanjang merupakan faktor risiko penting. Mengejan meningkatkan tekanan intraabdomen dan tekanan pada vena rektalis sehingga terjadi kongesti serta dilatasi pleksus vena hemoroidalis. Darah merah segar saat BAB juga merupakan manifestasi yang sering ditemukan pada hemoroid internal. Penatalaksanaan awal umumnya meliputi diet tinggi serat, cairan 2–3 liter per hari, mobilisasi, menghindari mengejan berlebihan, dan sitz bath. Kasus yang menetap atau berat memerlukan kolaborasi untuk tindakan lanjutan.

Alasan opsi lain:

a. **A salah**: hemoroid eksternal berada di bawah linea dentata dan umumnya tampak sebagai benjolan nyeri di luar anus.
b. **B salah**: derajat I tidak mengalami prolaps.
c. **C salah**: derajat II mengalami prolaps saat mengejan, tetapi masuk kembali secara spontan.
d. **D salah**: derajat IV mengalami prolaps permanen dan tidak dapat direposisi secara manual.
e. **E benar**: prolaps memerlukan reposisi manual merupakan ciri hemoroid internal derajat III.

I. Ringkasan Materi

Gangguan eliminasi pada masa postpartum merupakan masalah yang sering terjadi akibat perubahan fisiologis, trauma persalinan, pengaruh anestesi, serta faktor psikologis ibu nifas. Masalah utama yang sering ditemukan meliputi retensi urine postpartum, konstipasi postpartum, dan hemoroid postpartum.

Retensi urine postpartum adalah ketidakmampuan ibu untuk berkemih spontan dalam waktu ≥6 jam setelah persalinan atau setelah pelepasan kateter. Kondisi ini dapat disebabkan oleh trauma perineum, edema uretra, gangguan saraf kandung kemih, efek anestesi, persalinan lama, serta bayi makrosomia. Manifestasi klinis meliputi tidak dapat BAK, rasa penuh di suprapubik, nyeri perut bawah, dan distensi kandung kemih. Penatalaksanaan meliputi stimulasi miksi, mobilisasi dini, kompres hangat, bladder training, dan kateterisasi bila diperlukan.

Konstipasi postpartum terjadi akibat penurunan motilitas usus, kurang mobilisasi, asupan serat dan cairan yang rendah, serta rasa takut mengejan karena nyeri luka perineum. Gejalanya berupa tidak BAB ≥3 hari, feses keras, nyeri saat defekasi, dan perut kembung. Penatalaksanaan utama adalah diet tinggi serat, cairan adekuat, mobilisasi dini, edukasi perilaku BAB yang benar, serta penggunaan laksatif bila diindikasikan.

Hemoroid postpartum merupakan pelebaran vena hemoroidalis akibat peningkatan tekanan intraabdomen selama kehamilan dan persalinan, terutama pada ibu dengan konstipasi atau mengejan berlebihan. Gejala yang sering muncul adalah nyeri anus, perdarahan saat BAB, benjolan di anus, dan rasa tidak nyaman saat duduk. Penanganan meliputi sitz bath, diet tinggi serat, peningkatan cairan, mobilisasi, serta terapi topikal dan analgesik sesuai indikasi.

Dalam asuhan kebidanan, bidan berperan melakukan pengkajian komprehensif, diagnosis kebidanan, intervensi berbasis evidence, edukasi, dan dokumentasi SOAP untuk mencegah komplikasi seperti infeksi saluran kemih, hemoroid berat, dan gangguan eliminasi kronis.

J. Tabel Red Flags & Eskalasi

Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Tidak BAK ≥6–8 jam postpartum	Retensi urine overt	Stimulasi miksi, mobilisasi, kompres hangat Kateterisasi segera
Kandung kemih distensi + nyeri suprapubik	Overdistensi kandung kemih	Palpasi, monitoring urine Kateterisasi + observasi ketat

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Urine menetes (overflow incontinence)	Retensi berat	Evaluasi residu urine Kolaborasi dokter
Tidak ada sensasi ingin BAK	Gangguan saraf kandung kemih	Bladder training Rujuk bila menetap
Demam + nyeri BAK	Infeksi saluran kemih (ISK)	Observasi, edukasi cairan Rujuk untuk antibiotik
Tidak BAB ≥3 hari	Konstipasi signifikan	Diet serat, cairan, mobilisasi Laksatif bila perlu
Nyeri hebat saat BAB	Risiko trauma anus/fisura	Edukasi relaksasi, analgesik Kolaborasi bila berat
Feses sangat keras	Impaksi feses	Intervensi non-farmakologis Rujuk jika tidak membaik
Perut kembung berat	Gangguan motilitas usus	Monitoring eliminasi Evaluasi lanjut
Disertai perdarahan	Komplikasi (hemoroid/fisura)	Observasi Rujuk bila berlanjut
Nyeri anus hebat	Hemoroid trombosis	Sitz bath, analgesik Kolaborasi
Perdarahan saat BAB	Risiko anemia	Observasi jumlah darah Rujuk bila banyak
Benjolan tidak masuk (prolaps permanen)	Hemoroid derajat III–IV	Edukasi, posisi nyaman Rujuk
Edema dan inflamasi berat	Peradangan aktif	Kompres hangat Kolaborasi
Tidak bisa duduk/aktivitas terganggu	Gangguan kualitas hidup	Manajemen nyeri Rujuk bila berat

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Bab: Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan Lain Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid

Nama Mahasiswa: _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Menjelaskan definisi retensi urine postpartum	☐	☐	_____
2	Menjelaskan definisi konstipasi postpartum	☐	☐	_____
3	Menjelaskan definisi hemoroid postpartum	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
4	Mengidentifikasi faktor risiko retensi urine	☐	☐	_____
5	Mengidentifikasi faktor risiko konstipasi	☐	☐	_____
6	Mengidentifikasi faktor risiko hemoroid	☐	☐	_____
7	Melakukan anamnesis gangguan eliminasi secara sistematis	☐	☐	_____
8	Mengkaji pola BAK dan BAB ibu postpartum	☐	☐	_____
9	Melakukan palpasi suprapubik untuk distensi kandung kemih	☐	☐	_____
10	Mengidentifikasi tanda hemoroid eksternal	☐	☐	_____
11	Menentukan diagnosis kebidanan sesuai kasus	☐	☐	_____
12	Menyusun rencana tindakan awal	☐	☐	_____
13	Memberikan KIE tentang cairan dan serat	☐	☐	_____
14	Menjelaskan mobilisasi dini postpartum	☐	☐	_____
15	Menentukan indikasi kolaborasi/rujukan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Bab: Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan

Nama Mahasiswa: _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Menyapa pasien dan menjelaskan tindakan	☐	☐	_____
2	Melakukan hand hygiene	☐	☐	_____
3	Menjaga privasi pasien	☐	☐	_____
4	Menilai keadaan umum dan tanda vital	☐	☐	_____
5	Menanyakan waktu terakhir BAK	☐	☐	_____
6	Menanyakan waktu terakhir BAB	☐	☐	_____
7	Menilai nyeri perineum/anus	☐	☐	_____
8	Palpasi kandung kemih	☐	☐	_____
9	Menilai adanya distensi suprapubik	☐	☐	_____
10	Menilai hemoroid / benjolan anus	☐	☐	_____
11	Anjurkan mobilisasi dini	☐	☐	_____
12	Stimulasi BAK (air hangat / privasi)	☐	☐	_____
13	Anjurkan cairan cukup	☐	☐	_____
14	Anjurkan diet tinggi serat	☐	☐	_____
15	Edukasi sitz bath / kompres hangat	☐	☐	_____
16	Siapkan kateterisasi bila indikasi	☐	☐	_____
17	Menjelaskan tanda bahaya	☐	☐	_____
18	Menentukan kebutuhan rujukan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

_____

_____

_____

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Bab: Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Menyapa pasien dan menjelaskan tindakan	☐	☐	_____
2	Melakukan hand hygiene	☐	☐	_____
3	Menjaga privasi pasien	☐	☐	_____
4	Menilai keadaan umum dan tanda vital	☐	☐	_____
5	Menanyakan waktu terakhir BAK	☐	☐	_____
6	Menanyakan waktu terakhir BAB	☐	☐	_____
7	Menilai nyeri perineum/anus	☐	☐	_____
8	Palpasi kandung kemih	☐	☐	_____
9	Menilai adanya distensi suprapubik	☐	☐	_____
10	Menilai hemoroid / benjolan anus	☐	☐	_____
11	Anjurkan mobilisasi dini	☐	☐	_____
12	Stimulasi BAK (air hangat / privasi)	☐	☐	_____
13	Anjurkan cairan cukup	☐	☐	_____
14	Anjurkan diet tinggi serat	☐	☐	_____
15	Edukasi sitz bath / kompres hangat	☐	☐	_____
16	Siapkan kateterisasi bila indikasi	☐	☐	_____
17	Menjelaskan tanda bahaya	☐	☐	_____
18	Menentukan kebutuhan rujukan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

_____

_____

_____

K. Referensi

Abramowitz, L., et al. (2010). The prevalence of hemorrhoids in postpartum women. Diseases of the Colon & Rectum.

Alonso-Coello, P., et al. (2021). Meta-analysis hemorrhoid treatment.

Bayu, B., et al. (2019). Postpartum urinary retention.

Bharucha, A. E., et al. (2020). Mechanisms, evaluation, and management of constipation. Gastroenterology.

Carley, M. E., & Carley, J. M. (2020). Voiding dysfunction after childbirth. Obstetrics & Gynecology Clinics.

Carley, M. E., et al. (2019). Postpartum voiding dysfunction. Obstetrics & Gynecology.

Cochrane Review. (2022). Interventions for postpartum constipation.

Cunningham, F. G. (2022). Williams Obstetrics (26th ed.).

Hapitria, I. H. (2023). Retensi urine postpartum.

Hidayati, N. (2023). Penatalaksanaan konstipasi postpartum. Jurnal Kebidanan.

Kekre, A. N., et al. (2017). Postpartum urinary retention incidence and risk factors. International Journal of Gynecology & Obstetrics.

Lim, J. L. (2019). Postpartum voiding dysfunction. International Journal of Women's Health.

Muawanah, & Nindya. (2017). Hubungan asupan serat dengan konstipasi postpartum. Media Gizi Indonesia.

Poskus, T., et al. (2014). Hemorrhoids and pregnancy. International Journal of Colorectal Disease.

Poskus, T., et al. (2020). Hemorrhoids and pregnancy outcomes.

Prawirohardjo, S. (2020). Ilmu Kebidanan.

Puspasari, I. H., & Rahmawati, A. L. (2025). Asuhan kebidanan retensi urin postpartum.

Putri, A. A. S. (2020). Midwifery care urinary retention.

Riss, S., et al. (2012). The prevalence of hemorrhoids. International Journal of Colorectal Disease.

Rizki, L. K. (2017). Hubungan ambulasi dini dengan eliminasi postpartum.

Staroselsky, A., et al. (2008). Hemorrhoids in pregnancy and postpartum. Canadian Family Physician.

Sun, Z., et al. (2022). Postpartum hemorrhoid management.

Syalfina, A. D. (2017). Konstipasi pada ibu nifas. Jurnal Kebidanan.

Turawa, E., et al. (2021). Postpartum bowel dysfunction. BMC Pregnancy and Childbirth.

Varney, H. (2021). Varney's Midwifery.

World Health Organization (WHO). (2022). Postnatal care guidelines.

Yip, S. K., et al. (2019). Postpartum urinary retention. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Yip, S. K., et al. (2020). Urinary retention in the postpartum period. BJOG.

Zahra, Y. Z. (2022). Gangguan berkemih postpartum.

BAB 6

KESEHATAN MENTAL IBU NIFAS: BABY BLUES / POST PARTUM BLUES, DEPRESI POSTPARTUM, RISIKO BUNUH DIRI, DAN DUKUNGAN KELUARGA

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 13. Kesehatan Mental Ibu Nifas: Baby Blues, Depresi Postpartum, Risiko Bunuh Diri, dan Dukungan Keluarga	13.1 Melakukan skrining kesehatan mental nifas dan menilai risiko bunuh diri/krisis.	13.2 Menyusun dukungan awal, pelibatan keluarga, dan rujukan/kolaborasi sesuai tingkat risiko.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-1

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-7	Portofolio edukasi & follow-up + praktik skrining kesehatan mental (role-play)	Kelengkapan skrining (instrumen tervalidasi) dan keputusan tindak lanjut; kualitas materi edukasi (tanda bahaya, KB, menyusui); kejelasan rencana continuity of care (jadwal, media, jejaring rujukan)	10	Portofolio edukasi; lembar skrining & rencana tindak lanjut; rencana CoC

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Skrining kesehatan mental & tindak lanjut	Skrining tidak dilakukan; risiko krisis tidak dinilai	Skrining dilakukan terbatas; tindak lanjut belum jelas	Menggunakan instrumen tervalidasi; menilai risiko; dukungan awal dan rujukan sesuai	Komprehensif; safety plan jelas; pelibatan keluarga kuat; follow-up terjadwal dan terdokumentasi
7.2 Edukasi tanda bahaya/KB & continuity of care	Materi edukasi tidak lengkap; tanpa rencana tindak lanjut	Materi cukup namun belum disesuaikan; tindak lanjut umum	Materi lengkap dan terstruktur; metode sesuai; rencana follow-up jelas	Edukasi sangat efektif (teach-back + media); continuity of care rinci (kunjungan/telefollow-up/rujukan balik)

Uraian Materi

Masa nifas merupakan periode adaptasi fisik dan psikologis yang kompleks bagi seorang ibu. Perubahan hormonal, kelelahan, serta tuntutan peran baru sebagai ibu dapat memicu berbagai gangguan emosional, mulai dari baby blues/post partum blues, depresi postpartum, hingga psikosis postpartum. Dalam praktik kebidanan, penilaian kesehatan mental ibu nifas tidak boleh hanya berdasarkan satu gejala, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi emosional, pola tidur, kemampuan merawat bayi, dukungan sosial, serta adanya pikiran menyakiti diri atau bayi.

A. Baby Blues /Post Partum Blues

1. Pengertian Baby Blues / Postpartum Blues

   Baby Blues /Post partum blues Adalah perasaan sedih yang dibawa ibu sejak hamil yang berhubungan dengan kesulitan Ibu menerima kehadiran bayinya perubahan ini sebenarnya merupakan respon alami dari kelelahan pasca persalinan (Pieter dan Lubis, 2010).

   Post partum blus Adalah perasaan sedih yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, hal ini berkaitan dengan bayinya. postpartumbus adalah gangguan suasana hati yang berlangsung selama 3 sampai 4 hari pasca melahirkan. post partum ini sering terjadi dalam 14 Hari pertama setelah melahirkan, dan cenderung lebih buruk Pada hari ketiga dan keempat (Mansur, 2009).

2. Gejala Postpartum Blues

   Gejala postpartum Blues yaitu suatu keadaan yang tidak dapat dijelaskan merasa sedih, mudah tersinggung, gangguan pada nafsu makan dan tidur. Gejala-gejala postpartum blues Ini bisa terlihat dari perubahan sikap seorang ibu. Gejala tersebut biasanya muncul pada hari ketiga atau hari ke-6 setelah melahirkan (Noval dan Broom, 2009).

3. Menurut Murtiningsih (2012) beberapa perubahan sikap tersebut diantaranya :
   a. Sering tiba-tiba menangis karena merasa tidak bahagia
   b. Penakut
   c. Tidak mau makan
   d. Tidak mau bicara
   e. Sakit kepala
   f. Sering berganti mood
   g. Mudah tersinggung
   h. Merasa terlalu sensitive dan cemas berlebihan
   i. Tidak bergairah (khususnya tehadap hal yang semula sangat diminati)
   j. Tidak mampu berkonsentrasi dan sangat sulit membuat keputusan

k. Merasa tidak mempunyai ikatan batin dengan sikecil yang baru saja Anda lahirkan
l. Insomnia yang berlebih

Gejala-gejala itu mulai setelah persalinan dan pada umumnya akan menghilang dalam waktu antara beberapa jam sampai beberapa hari. Namun jika masih berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan didapat disebut postpartum depression (Murtiningsih, 2012).

Menurut Yanti & Sundawati (2011) hal-hal yang disarankan pada ibu adalah sebagai berikut:

a. Minta bantuan suami atau keluarga jika ibu ingin istirahat
b. Beritahu suami tentang apa yang disarankan oleh ibu
c. Buang rasa cemas dan khawatir akan kemampuan merawat bayi
d. Meluangkan waktu dan cari hiburan untuk diri sendiri
e. Faktor Penyebab Postpartum Blues

4. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya postpartum blues

Faktor-faktor yang mempengaruhi postpartum blues, biasanya tidak berdiri sendiri sehingga gejala dan tanda postpartum blues sebenarnya adalah suatu mekanisme multi- faktoria. Sejauh ini belum ada mekanisme biokimia atau neuron dokrin yang jelas (Irawati, 2014).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya postpartum blues yaitu:

a. Faktor Demografi

Faktor demografi meliputi umur dan paritas. Ibu primpara yang tidak mempunyai pengalaman dalam mengasuh anak, ibu yang berusia remaja, ibu yang berusia lebih dari 35 tahun adalah yang beresiko terkena postpartum blues (Bobak, Laudermilk, Jenesn, et all, 2005).

Menurut BKKBN (2012) yang menganjurkan batasan umur dalam pernikahan yakni 20 tahun ke atas, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk menikah dalam rentang umur tersebut. Pernikahan, kehamilan, persalinan, dan perawatan anak akan membawa banyak perubahan. Seseorang akan mengalami perubahan peran dari seorang remaja menjadi seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya hal ini tentu saja memerlukan kesiapan fisik dan psikologis dari ibu tersebut.Seorang wanita yang berumur 20-35 tahun sudah dianggap siap secara fisik dan psikologis untuk melahirkan dan merawat anak. Karena pada umur seperti itu tingkat kedewasaan, cara berfikir dan berperilaku juga akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya umur. Umur 20-35 tahun dianggap ideal untuk menjalani kehamilan dan persalinan,

direntang usia ini kondisi fisik wanita dalam keadaan prima. Rahim sudah mampu memberi perlindungan atau kondisi yang maksimal untuk kehamilan dan umumnya secara mental pun siap, yang dapat berdampak pada perilaku merawat dan menjaga kehamilannya secara hati-hati.

b. Faktor Psikologis

Berkurangnya perhatian keluarga, terutama suami karena semua perhatian tertuju pada anak yang baru lahir. Padahal usia persalinan si ibu merasa lelah dan sakit pasca persalinan membuat ibu membutuhkan perhatian. Kecewa terhadap penampilan fisik bayi karena tidak sesuai dengan yang diinginkan juga bisa memicu postpartum blues. Ibu yang melahirkan secara operasi akan merasa bingung dan sedih terutama jika operasi tersebut dilakukan karena keadaan yang darurat (tidak direncanakan sebelumnya) (Kasdu, 2007).

c. Faktor Fisik

Kelelahan fifik karena aktivitas mengasuh bayi, menyusui, memandikan, mengganti popok, dan menimang sepanjang hari bahkan tak jarang di malam buta sangatlah menguras tenaga. Apalagi jika tidak ada dari suami atau anggota yang lain (Nirwana, 2011).

d. Faktor Sosial

Tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak direncakan sebelumnya dan keadaan social ekonomi juga berpengaruh terhadap kejadian postpartum blues (Afrian, 2012). Kekhawatiran pada keadaan social ekonomi, seperti tinggal bersama mertua, lingkungan rumah tidak nyaman, dan keadaan ibu yang harus kembali bekerja setelah melahirkan.

Berdasarkan beberapa faktor yang dikemukakan oleh ahli-ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya postpartum blues dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok:

e. Faktor Biologis

1) Faktor Hormonal, yang terjadinya perubahan kadar sejumlah horman dalam tubuh ibu pasca persalinan secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar, yaitu progesteron, estrogen, kelenjar tiroid, endorphin, estradiol, cortisol, dan prolactin yang menimbulkan reaksi afektif tertentu.
2) Faktor Kelelahan Fisik, yaitu kelelahan fisik akibat proses persalinan yang baru dilaluinya. Dehidrasi, kehilangan banyak darah, atau faktor fisik lain yang dapat menurunkan stamina ibu.
3) Faktor Kesehatan, seperti sejarah premenstrual syndrome.

f. Faktor Psikologis

1) Faktor Kepribadian, yaitu:
   a) Wanita yang menilai dirinya lebih maskulin

b) Wanita perfeksionis dengan penghargaan yang tidak realistis dan selalu berusaha menyenangkan orang lain
c) Ibu dengan harga diri yang rendah
d) Wanita yang mudah mengalami kecemasan, ketakutan akan tugas dan terjadinya depresi selama kehamilan.

2) Karakteristik lain individu, yaitu:
a) Ibu primipara (melahirkan anak pertama)
b) Ibu yang berusia remaja

g. Faktor Sosial

1) Respon terhadap kehamilan dan persalinan, yaitu:
a) Kehamilan yang tidak diinginkan
b) Perasaan bingung antara penerimaan dan penolakan terhadap peran baru sebagai ibu.
c) Tidak ada pengalaman dalam pengasuhan anak.

2) Kenyataan persalinan yang tidak sesuai dengan harapan, yaitu:
a) Kesibukan mengurus bayi dan perasaan ibu yang merasa tidak mampu atau khawatir akan tanggung jawab barunya sebagai ibu.
b) Perasaan kecewa dengan keadaan fisik dirinya juga bayinya.

3) Keadaan sosial ekonomi, yaitu:
a) Wanita yang harus kembali bekerja setelah melahirkan
b) Keadaan sosial ekonomi yang tidak mendukung

4) Dukungan sosial, yaitu:
a) Ketegangan dalam hubungan pernikahan dan keluarga
b) Penyesuaian social yang buruk
c) Kurangnya dukungan dari suami dan orang-orang sekitar
d) Wanita yang tidak bersuami

5. Penyebab postpartum blues bisa juga dilihat pada bayi dan hubungan orang yaitu sebagai berikut:

a. Pada Bayi

Ibu yang depresi juga tidak mampu merawat bayinya dengan optimal, karena merasa tidak berdaya atau tidak mampu sehingga akan menghindar dari tanggung jawabnya, akibatnya kondisi kebersihan dan kesehatan bayinya yang menjadi tidak optimali juga tidak bersemangat menyusui bayinya sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayinya tidak seperti bayi yang ibunya sehat. Akibat lainnya adalah hubungan antara ibu dan bayi juga tidak optimal. Bayinya sangat senang berkomunikasi dengan ibunya. Komunikasi ini dilakukannya dengan cara dan dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya senyuman, tatapan mata, celoteh, tangisan, gerak tubuh yang

berubah-ubah yang semua itu perlu ritanggapi dengan respons yang sesuai dan optimal, namun bila hal ini tidak terpenuhi, anak menjadi kecewa, sedih bahkan frustasi. Kejadian seperti ini membuat perkembangan tidak optimal, sehingga membuat kepribadiannya kurang matang (Elvira, 2006).

b. Pada Hubungan Orang Tua

Perkawinan dan kelahiran seorang bayi biasanya dapat mengubah suatu hubungan dan psikolog menemukan kaitan antara depresi pasca melahirkan dan hubungan yang tidak memuaskan pasangan. Pada kenyataannya, tekanan karena harus merawat semua keretakan lama muncul dan banyak keretakan baru juga. Dampak paling negatife dari seseorang yang mengalami postpartum blues adalah symptom-simptom itu berlangsung lebih dari 10 hari, kondisi seseorang tersebut tidak dikatakan sekedar mengalami postpartum blues lagi tetapi mengalami postpartum depression atau depresi pasca salin (Nirwana, 2011).

6. Klasifikasi Depresi Postpartum Blues

Menurut Kusumanto (2010) ada tipe-tipe depresi pada postpartum blues diantaranya yaitu:

a. Depresi ringan (kemurungan)

Inilah tipe depresi yang palig umum. Biasanya singkat dan tidak terlalu mengganggu kegiatan-kegiatan normal. Peristiwa-peristiwa signifikan seperti hari libur, ulang tahun pernikahan, pekerjaan baru, pindah, demikian juga kebosanan dan frustasi bisa mengahasilkan suatu keadaan hati yang murung. Depresi postpartum blues ini merupakan tipe depresi ringan yang paling umum. Namun hal ini bisa juga menjadi meningkat dan dalam keadaan yang demikian seorang harus depresi. Dari tipe ini biasanya tidak diburuhkan penanganan khusus. Perubahan situasi dan langkah biasanya segera bisa mengubah kemurungan itu.

b. Depresi sedang/moderat (perasaan tak berpengharapan)

Gejalanya hampir sama dengan depresi ringan, tetapi lebih kuat dan lebih lama berakhir. Suatu peristiwa yang tidak membahagiakan seperti meninggalkan seorang kakasih, hilangnya karier, kemunduran dan lain-lain biasanya merupakan penyebab, Orang memang sadar akan perasaan tidak bahagia itu, tetapi tidak bisa mencegahnya. Kegiatan sehari-hari memang lebih berat dirasakan (tetapi biasanya bisa diatasi) penanganannya. Di tipe ini bunuh diri merupakan bahaya. Kerana bunuh diri di lihat yang ekstrim tinggi merupakan satu-satunya pemecahan masalah ketika kepedihan itu menjadi lebih buruk. Dalam hal ini pertolongan professional yang dibutuhkan.

c. Depresi berat (terpisah dari realita)

   Kehilangan interes dengan dunia luar dan perubahan tingkah laku yang serius dan berkepanjangan merupakan kharakteristiknya. Ketidakseimbangan daktil yang mendalam biasanya merupakan penyebabnya. Kadang-kadang gangguan yang lain seperti schizophrenia, alkoholisme, atau kecanduan obat yang sering berkaitan dengan depresi. Demikian juga gejala fisik akan menjadi nyata. Orang itu mengalami misalnya delusi bahwa tubuhnya berubah.Penyakit depresi maniak adalah suatu bentuk depresi yang didalamnya mengalami keadaan hati yang ekstrim tinggi dan ekstrim rendah. Adapun postpartum syndrome atau distress postpartum adalah suatu kondisi dimana seseorang ibu seringkali merasa uring-uringan, muram atau merasa tidak bahagia. Fase ini dalam jangka waktu dua hari sampai dua minggu pasca persalinan, syndrome ini masih tergolong normal dan sifatnya sementara.

7. Komplikasi Postpartum Blues
   a. Depresi Postpartum

      Gejala yang timbul adalah perasaan sedih, tertekan, sensitive, merasa bersalah, lelah, cemas, dan tidak mampu merawat dirinya dan bayinya. Keadaan ini memerlukan psikoterapi dan obat-obatan disamping dukungan social (Arfian, 2012).

   b. Postpartum Psikosis

      Depresi berat yaitu dengan gejala proses piker yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa ibu dan bayinya sehingga memerlukan pertolongan dari tenaga professional yaitu psikeater dan pemberian obat (Arfian, 2012).

8. Pencegahan Postpartum Blues

   Menurut Yanti & Sundawati (2011) berikut ini beberapa intervensi yang dapat membantu ibu terhindar dari postpartum blues, antara lain:

   a. Pelajari diri sendiri
   b. Tidur dan makan yang cukup
   c. Olahraga
   d. Hindari perubahan hidup sebelum atau sesudah melahirkan
   e. Beritahukan perasaan
   f. Dukungan keluarga dan orang lain diperlukan
   g. Persiapkan diri dengan baik
   h. Senam hamil

Lakukan pekerjaan rumah tangga

a. Dukungan emosional
b. Dukungan kelompok postpartum blues

9. Penatalaksaan Postpartum Blues

Postpartum blues atau gangguan mental pasca-salin sering kali terabaikan dan tidak ditangani dengan baik. Banyak ibu yang berjuang sendiri dalam beberapa saat setelah melahirkan. Mereka merasakan ada suatu hal yang salah namun mereka sendiri tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang tejadi. Apabila mereka pergi mengunjungi dokter tau sumber-suber lainnya untuk minta pertolongan sering hanya mendapatkan saran untuk beristirahat atau tidur lebih banyak, tidak gelisah, minum obat atau berhenti mengasihani diri sendiri dan mulai merasa gembira menyambut kedatangan bayi yang mereka cintai (Murtiningsih, 2012).

Penanganan gangguan mental pasca-salin pada prinsipnya tidak berbeda dengan penanganan gangguan mental pada momen-momen lainnya. Para ibu yang mengalami postpartum blues membutuhkan pertolongan yang sesungguhnya. Para ibu ini membutuhkan dukungan psikologis seperti juga kebutuhan fisik lainnya yang harus juga dipenuhi.Mereka membutuhkan kesempatan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dari situasi yang menakutkan. Mungkin juga mereka membutuhkan pengobatan atau istirahat, dan seringkali akan merasa gembira mendapat pertolongan yang praktis. Dengan bantuan dari teman dan keluarga, mereka mungkin perlu untuk mengatur atau menata kembali kegiatan rutin sehari-hari, atau mungkin menghilangkan beberapa kegiatan, disesuaikan dengan konsep mereka tentang keibuan dan perawatan bayi. Bila memang diperlukan, dapat diberikan pertolongan dari para ahli, misalnya dari seorang psikolog atau konselor yang berpengalaman dalam bidang tersebut (Murtiningsih, 2012).

Para ahli obstetrik memegang peranan penting untuk mempersipakan para wanita untuk kemungkinan terjadinya gangguan mental pasca-salin dan segera memberikan penanganan yang tepat bila terjadi gangguan tersebut, bahkan merujuk para ahli psikolog/konseling bila memang diperlukan. Dukungan yang memadai dari para petugas obstetric, yaitu dokter dan bidan/perawat sangat diperlukan, misalnya dengan cara memberikan infromasi yang memadai/adekuat tentang proses kehamilan dan persalinan, termasuk penyulit-penyulit yang mungkin timbul dalam masa-masa tersebut serta penanganannya (Murtiningsih, 2012).

Postpartum blues juga dapat dikurangi dengan cara belajar tenang dengan menarik nafas panjang dan meditasi, yidur ketika bayi tidur, berolahraga ringan,

ikhlas dan tulus dengan peran baru sebagai ibu, tidak perfeksionis dalam hal mengurusi bayi membicarakan rasa cemas danmengkomunikasikannya, bersikap fleksibel, bergabung dengan kelompok ibu ibu baru (Murtiningsih, 2012).

Dalam penanganan para ibu yang mengalami postpartum blues dibutuhkan pendekatan menyeluruh/holistic. Pengobatan medis, konseling emosional, bantuan bantuan praktis dan pemahaman secara intelektual tentang pengalaman dan harapan harapan mereka mungkin pada saat saat tertentu. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dibutuhkan penanganan di Tingkat perilaku, emosional, intelektual, social, dan psikologi secara Bersama sama, dengan melibatkan lingkungannya, yaitu suami, keluarga dan juga teman dekatnya (Murtiningsih, 20212).

B. DEPRESI POST PARTUM

1. Pengertian *Postpartum Depression* (Depresi Pasca Melahirkan)

   Postpartum Depression adalah kondisi Dimana seorang ibu yang baru saja melahirkan mengalami perubahan mood yang parah dan persisten selama beberapa bulan atau bahkan setahun atau lebih (Nevid, Rathus & Greene, 2005: 234). Menurut Wisner et al (2002: 194-199) *postpartum depression* merupakan gangguan mood setelah melahirkan yang merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala gejala depresi mayor.

   Postpartum depression merupakan salah satu bentuk depresi mayor dikarenakan periode pasca melahirkan merupakan periode transisi kehidupan baru yang cukup membuat stress, dan tidak hanya pada ibu melahirkan juga dengan ayah. Kondisi transisi ini dapat menurunkan kepuasan pernikahan dan meingkatkan masalah depresi pada beberapa ibu pada beberapa bulan pertama masa kelahiran bayi hingga 1 tahun (Simpson et al, 2003: 1172-1187). Menurut Regina (2011: 72) p*ostpartum depression* adalah depresi yang terjadi setelah tujuh hari melahirkan dan berlangsung selama 30 hari.

   Menurut Kaplan (1997:54) ibu setelah melahirkan sering mengalami kesedihan, Dimana kesedihan oitu bersifat normal sering menangis, distoria, dan ketergantungan namun ibu yang mengalami *postpartum depression* sering ditandai dengan perasaan depresi dan keinginan untuk bunuh diri, untuk kasus *postpartum depression* sering ditandai dengan perasaan depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Untuk kasus *postpartum depression* tingkat berat dapat menjadikan ibu psikotik dengan halusinasi, waham dan pikiran untuk membunuh bayinya.

   Berdasarkan pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa *postpartum depression* adalah sebuah kondisi Dimana ibu yang baru saja

melahirkan mengalami perubahan mood yang merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala gejala depresi mayor yang berlangsung selama tujuh hari sampai satu tahun setelah kelahiran bayi.

Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorder- IV,* terdapat tiga bentuk depresi yang berkaitan dengan stress pasca melahirkan, yaitu:

a. *Postpartum blues* atau *baby blues syndrome,* yang merupakan gangguan mood yang bersifat sementara
b. *Postpartyum depression* tanpa gambaran *psychosis* (postpartum psychosis), yaitu ibu mengalami depresi berat berupa gangguan proses piker yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu dan bayinya sehingga memerlukan bantuan psikiater.

Tabel Perbandingan Gejala Gejala Baby Blues. Postpartum Depression, dan Postpartum Psychosis menurut Cleveland Clinic (2004) dan National Menral Health Associassion (2003)

	Baby Blues	***Postpartum Depression***	***Postpartum Psychosis***
Simtom Fisik	a. Kurang tidur b. Hilang tenaga c. Hilang nafsu makan atau sangat bernafsu untuk makan d. Merasa lelah setelah bangun tidur	a. Cepat lelah b. Gangguan tidur c. Selera makan menurun d. Sakit kepala e. Sakit dada f. Jantung berdebar-debar g. Sesak nafas h. Mual dan muntah	a. Menolak makan b. Tidak mampu c. Menghentikan aktivitas d. Kebingungan akan kelebihan energi
Simtom Emosional	a. Cemas dan khawatir berlebihan b. Bingung c. Mencemaskan kondisi fisik secara berlebihan d. Tidak percaya diri e. Sedih f. Perasaan diabaikan	a. Mudah tersinggung b. Perasaan sedih c. Hilang harapan d. Merasa tidak berdaya e. Mood swings f. Perasaan tidak adekuat sebagai ibu g. Hilang minat h. Pemikiran bunuh diri i. Ingin menyakiti orang lain (termasuk bayi, diri sendiri, dan suami) j. Perasaan bersalah	a. Sangat bingung b. Hilang ingatan c. Tidak koheren d. Halusinasi

Menurut Mansur (2009: 157) *postpartum depression* dan *baby blues* memiliki gejala yang hamper sama, perbedaan keduanya terletak pada frekuensi, intensitas serta durasi yang berlangsunganny gejala-gejala yang timbul .ibu yang mengalam postpartum depression akan merasakan berbagi gejala yang ada pada baby blues syndrome ,namun dengan intensitas yang lebih hebat,lebih sering dan bertahan lebih lama. Hal tersebut sependapat dengan bobak dkk (2005: 557)bahwa postpartum depression berlangsung lebih lama baby blues syndrome,yang teradi dalam kurun enam bulan dan ditandai oleh berbagai gejala.

2. Gejala postpartum depression

Kriteria yang digunakan dalam menegakkan diagnosis berdasarkan pada riwayat dan gejala gejala mengikuti diaginosis dan statistical Manual of Mental disorder iv (DSM-IV)sebagai penunjang untuk menegakkan diagnosis.

Kriteria riset gangguan depresi mayor dengan onset postpartum menurut DSM-IV (frances,2000:77) adalah sebagai berikut:

a. Suatu gangguan mood yang didefinisikan sebagai berikut:
    1) Setidaknya dua (tetapi kurang dari lima) gejala berikut telah ditemukan selama perode 2 minggu dan menunjukan perubahan dari fungsi sebelumnya; setidaknya salah satu dari gejala adalah salah satu dari a)atau b)
        a) Mood yang terdepresi hamper sepanjang hari ,hamper setiap hari,seperti yang ditunjukan oleh laporan subjektif (seperti merasa sedih dan kosong) atau pengamatan oleh orang lain (seperti tampak sedih).
        b) Berkurangnya minat yatu berkurangnya kesenangan secara jelas pada semua atau hampir semua ,aktivitas sepanjang hari,hampir setiap hari (seperti yang ditunjukan olej keterangan sbujektif atau pengamatan yang dilakukkan oleh orang lain).
        c) Penurunan berat badan yang bermakna Ketika tidak mealkukan diet atau penambahan berat badan (seperti perubahan berat badan lebih dari 5% dalm satu bulan),atau penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari.
        d) Insonia atau hypersomnia hampir setiap hari
        e) Agitasi atau retardasi psikomotor hanpir setiap hari (dapat diamati oleh orang lain,tidak semata mata perasaan sukyektif adanya kegelisahan atau menjadi lamban)
        f) kelelahan atau hilangnya energi hampir setiap hari

g) perasaan tidak berharfa atau rasa bersalah yang berlebihan atau tidak dapat (mungkin bersifat waham) hampir setiap hari (tidak semata mata mencela diri sendiri atau menyalahkan karena sakit)
h) berkurangnya kemampuan untuk berfikir atau berkosentrasi atau tidak dapat mengambil Keputusan ,hampir setiap hari (baik secara subjektif atau melalui pengamatan orang lain.
i) pikiran akan kematian yang berulang (bukan hanya takut akan kematian)
j) gagasan bunuh diri yang berulang tanpa rencana spesifik,atau Upaya bunuh diri atau rencana khusus untuk melakukan bunuh diri.

2) gejala menyababkan disentres yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi social ,pekerjaan,atau fungsi penting lain.
3) Gejala bukan karena efek fisiologis langsumg dari suatu zat (seperti penyalahgunaan obat, pengobatan) atau suatu kondisi medis umum (seperti hipotiroidisme).
4) Gejala tidak lebih baik diterangkan oleh duka cita (seperti reaksi normal terhadap kehilangan orang yamg dicintai)

b. Tidak pernah terdapat episode depresi berat, dan tidak memenuhi kriteria untuk gamgguam distimik
c. Tidak pernah terdapat episode menik, episode campuran, episode hipomanik, dan tidak memenuhi kriteria untuk gangguan siklotimik. Catatan: pengecualian ini tidak berlaku jika semua episode mirip manik, campuran, atau hipomanik adalah diakibatkan zat atau terapi
d. Gangguan mood tidak terjadi semata mata selama skizokpremia, gangguan skizokfrenifom, gangguan skizoafektive, gangguan delusional, atau gangguan psikotik yang tidak ditentukan.

3. Menurut Varney dkk (1998: 273) gejala gejala *postpartum depression* adalah sebagai berikut:
   a. Emosi positif berkurang
   b. Kemampuan konsentrasi berkurang
   c. Control terhadap emosi berkurang
   d. Berfikir obsesif menjadi seorang ibu yang jahat
   e. Tujuan dan minat terdahulu hilang dan merasa kosong
   f. Merasa tidak aman, merasa harus menjadi ibu seorang diri
   g. Serangan cemas, merasa gelisah, merasa dirinya diambang ketidakwarasan
   h. Persiapan yang tidak digambarkan, merasa tidak seorang pun mengerti
   i. Merasa takut dan bersalah akan menyakiti anaknya
   j. Berfikir tentang kematian

Menurut Ling dan Doff (2001) mengemukakan bahwa gejala *postpartum depression* yang dialami 60% wanita hampir sama dengan gejala depresi pada umunya tetapi dibandingkan dengan gangguan depresi yang umum,depresi postpartum mempunyai karakteristik yang spesifik antara lain:

a. Mimpi buruk, akibat mimpi mimpi buruk yang menakutkan sehingga sering terbangun dan tidak dapat tidur lagi
b. Insomnia, biasanya timbul sebagai gejala suatu gangguan lain yang mendasari seperti kecemasan dan depresi atau gangguan emosi lain yang terjadi dalam hidup manusia
c. Pobia, rasa takut yang irasional terhadap suatu benda atau keadaan yang tidak dapat dihilangkan atau ditekan oleh ibu, walaupun diketahuinya bahwa hal itu irasional adanya.
d. Kecemasan, rasa tidak aman dan khawatir yang timbul karena dirasakan akan terjadi suatu yang tidak menyenangkan, tetapi sumbernya Sebagian besar tidak diketahuinya.
e. Meningkatkan sensitivitas, periode pasca kelahiran meliputi banyak sekali penyesuaian diri dan pembiasaan diri. Bayi harus diurus, ibu harus pulih Kembali dari persalinan, ibu harus belajar bagaiman cara merawat bayi. Kurangnya pengalaman atau kurangnya rasa percaya diri dengan bayi yang lahir atau waktu dan tuntunan ekstensif akan meningkat sensitivitas ibu.
f. Perubahan mood, *depresi postpartum* muncul dengan gejala sebagai berikut: sedih, murung, perasaan tidak berharga, mudah marah, merasa terganggu dengan perubahan fisik, sulit konsentrasi, kurang nafsu makan, gangguan tidur, dan tidak mempunyai harapan untuk masa depan.

Menurut Anshari (2005), secara global diperkirakan 20% Wanita setelah melahirkan mengalami postpartum dengan gejala gejala yang hampir sama dengan gejala depresi psikosis. Pada *postpartum depression* gejala gejala tresebut lebih khas antara lain:

a. Perasaan yang negative pada bayi yang dilahirkannya
b. Kesulitan untuk tidur
c. Sering menangis
d. Makan terlalu banyak atau terlalu sedikit
e. Rasa tidak berharga dan merasa bersalah
f. Menjauhkan diri dari teman atau keliuarga
g. Kehilangan harapan pesimistik
h. Sakit kepala, nyeri dada, jantung berdebar debar, dan nafas cepat
i. Sulit untuk berkonsentrasi dan tidak dapat membuat Keputusan.

j. Merencanakan dan percobaan bunuh diri

Secara klinis gejala *postpartum depression* mirip dengan kriteria diagnosis gangguan depresi pada umumnya yaitu kurang bergairah dalam menjalankan aktivitas, perubahan berat badan dan nafsu makan, insomnia bahkan hiperinsomnia, gelisah, lambatnya psikomotor, selama merasa Lelah dan kiurang berenergi, serta ciri ciri lainnya yang pada umumnya muncul pada mereka yang menderita gangguan depersi (Sadock &Sadof, 2005).

Wanita yang menderita *postpartum depression* mengalami gejala pada taun pertama pasca melahirkan dampak yang ditimbulkannya adalah dapat mempengaruhi kualitas hidup ibu maupun bayi, perkembangan bayi, ketidakmampuan ibu dalam mendalami kemampuan parenting (Erdogan, 2010).

Berdasarkan pemaparan para ahli, penulis menggunakan *diagnotis* dan *statistika manual of mental disorder IV* (DSM-IV) dengan gejala mood yang terdepresi; berkurangnya minat atau kesenangan secara jelas; penurunan berat badan; insomnia atau hypersomnia; agitarsi atau retardaksi psikomotor; kelelahan atau kehilangan energi; perasaan tidak berharga atau rasa salah yang berlebih atau tidak tepat; berkurangnya kemampuan berfikir atau berkonsentrasi; pikiran akan kematian yang berulang. Gejala tersebut digunakan sebagai penunjang kriteria riset gangguan *postpartum depression* untuk meneggakan diagnosis.

4. Faktor penyebab postpartum depression

Menurut Kruckman (2001), terjadi depresi *postpartum* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Faktor biologis berupa perubahan kadar hormonal seperti esterogen, progesterone, prolactin, dan ekstriol yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam masa melahirkan atau mungkin perubahan hormon tersebut terlaliu cepat atau terlalu lambat
b. Faktor demografi yaitu unur Perempuan yang bersangkutan saat kehamilan dan sering kali dikaitkan dengan kesiapan mental Perempuan tersebut untuk menjadi seorang ibu, umur yang tepat bagi seorang Perempuan untuk melahirkan pada usia antara 20-30 tahun
c. Faktor pengalaman depresi *postpartum* lebih banyak ditemukan pada Perempuan yang baru pertama kali melahirkan (primipara) bahwa peran seorang ibu dan segala yang berkaitan dengan bayinya merupakan situasi yang sama sekali baru bagi dirinya dan dapat menimbulkan stress; 4) faktor Pendidikan, Perempuan yang berpendidikan tinggi menghadapi tekanan social dan konflik peran, antara tuntutan sebagai Perempuan yang memiliki

dorongan untuk bekerja atau melakukan aktivitasnya diluar rumah dengan peran sebagai ibu rumah tangga dan orang tua dari anak anaknya.

d. Faktor selama persalinan hal ini mencakup lamanya persalinan serta intervensi medis yang digunakan selsma proses persalinan.
e. Diduga semakin besar trauma fisik yang ditimbulkan pada saat persalinan, maka akan semakin besar pula trauma psikis yang muncul dan kemungkinan Perempuan yang bersangkutan akan menghadapi deprisi persalinan.
f. Faktor dukungan sosial dari suami dan keluarga yang membantu pada saat kehamilan,persalinan, dan pasca persalinan, beban seorang ibu sedikit banyak.
g. Mansur (2009: 158), mengemukakan bahwa penyebab postpartum depression dan baby blues syndrome adalah faktor yang sama, yang membedakan keduanya hanyalah karakteristik ibu yang mengalami postpartum depression.

Faktor-faktor penyebab postpartum depression antara lain:

a. Faktor Hormonal

   Faktor hormonal berupa kadar estrogen, prolactin, estriol, dan progresteron yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Estrogen memiliki efek supresi terhadap aktivitas suatu enzim otak, yaitu enzim monoamine oksidase yang bekerja menginaktivasi, baik serotin maupun noredrenalin yang berperan dalam suasana hati dan kejadian depresi.
b. Faktor Demografik

   Berupa umur dan paritas. Umur yang terlalu muda atau ibu primipara (melahirkan anak pertama) dikatakan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya postpartum depression, karena ketidak siapan menerima peran barunya sebagai seorang ibu. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dialami oleh ibu yang pernah melahirkan.
c. Pengalaman dalam Proses Kehamilan dan Persalinan

   Kesulitan-kesulitan yang dialami ibu selama kehamilan atau saat persalinan akan memperburuk kondisi ibu pasca melahirkan. Sedangkan pada persalinan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang dapat menimbulkan stress bagi ibu mencakup lamanya persalinan serta intervensi medis yang digunakan selama proses persalinan, seperti ibu yang melahirkan dengan cara operasi caesar (sectio caesarea) akan dapat menimbulkan perasaan takut terhadap peralatan operasi dan jarum.
d. Latar Belakang Psikosoisal

   Latar belakang psikososial wanita yang bersangkutan, seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat

gangguan kejiwaan sebelumnya, status sosial ekonomi, serta keadekuatan dukungan sosial dari lingkungannya (suami, keluarga, dan teman).

e. Fisik

Kelelahan fisik, kelelahan fisik karena aktivitas mengasuh bayi, menyusui, memandikan, mengganti popok, dan menimang sepanjang hari bahkan tak jarang di malam buta sangatlah menguras tenaga. apalagi jika tidak adabantuan dari suami atau anggota keluarga yang lain.

Menurut Robertson et al (2004) faktor penyebab postpartum depression diantaranya adalah riwayat depresi sebelumnya, dukungan sosial, hubungan pernikahan, faktor obstetri (sectio cesaria, persalinan dengan alat), dan faktor demografi. dalam rentang waktu kehamilan hingga melahirkan, seorang ibu juga berpeluang menghadapi permasalahan mengenai perawatan intensif selama kehamilan dan persalinan (Simpson et al, 2003). kondisi kehamilan dan proses melahirkan membutuhkan perhatian tersendiri. jika individu yang bersangkutan atau anggota keluarga kuranga mempersiapkan diri dengan baik, mungkin saja muncul gangguan kesehatan pada ibu yang sedang hamil, atau ibu mengalami hambatan dalam proses melahirkan, periode pasca persalinan juga membutuhkan perhatian tersendiri, setelah melahirkan, seorang ibu harus berusaha untuk memulihkan dirinya ke kondisi normal dan bayi membutuhkan perawatan serta perhatian yang baik dari orang tua.

Menurut kaplan et al (1997: 43), faktor risiko postpartum depression antara lain faktor genetic, faktor neuro endokrin, dukungan suami, faktor usia, paritas, pendidikan ibu, kehidupan penuh tekanan, dan riwayat depresi sebelumnya, "resiko postpartum depression akan meningkat jika terdapat riwayat depresi pada ibu atau keluarga, atau jika sebelumnya ibu pernah menderita suatu penyakit psikiatrik pasca persalinan".

Berdasarkan pemaparan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa postpartum depression disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hormonal (biologis), faktor demografik, faktor kehamilan dan persalinan seperti pengalaman dalam proses kehamilan/persalinan dan faktor obstetric (section cesaria, persalinan dengan alat), riwayat depresi sebelumnya, latar belakang psikososial, dan faktor fisik.

C. PSIKOSIS

1. Psikosis pasca persalinan (Postpartum kejiwaan)

   Postpartum psikosis adalah masalah kejiwaan serius yang dialami ibu setelah proses persalinan dan ditandai dengan agitasi yang hebat, pergantian perasaan yang cepat, depresi dan delusi. Wanita yang mengalami postpartum psikosis ini membutuhkan perawatan segera dan pengobatan psikiater (Nirwana, 2011).

   lalah suatu sindrom yang ditandai oleh depresi berat dan waham. Umumnya terjadi pada minggu pertama dalam 6 minggu setelah melahirkan.perempuan yang menderita bipolar disorder atau masalah psikotik lainnya yangdisebut skizoafektif disorder mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terkena postpartum psikosis. Gejalanya antara lain mengalami delusi, halusinasi, gangguansaat tidur dan obsesi mengenai bayinya. Penderita dapat terkena perubahan moodsecara drastis, dari depresi ke gusaran dan berganti menjadi euforia dalam waktu yang singkat.

   Psikosis adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata dengan kata lain, sulit membedakan antara khayalan dan realitas. psikosis pasca persalinan pada umumnya merupakan gangguan bipolar namun bisa merupakan perburukan dari gangguan depresi mayor. angka kejadian terjadinya psikosis postpartum ini adalah 1-2 per 1000 dari ibu yang baru melahirkan, biasanya terjadi dalam 3 bulan pertama postpartum. psikosis pasca persalinan merupakan bentuk terburuk dari kelainan psikiatri pasca persalinan. Onset terjadi pada minggu ke 2 hingga 4 pasca persalinan.

2. Penyebab Blue syndrome, depresi Dan psikosis post partum penyebab depresi postpartum hampir sama penyebabnya dengan psikosis postpartum. Pitt (Regina dkk, 2001), mengemukakan empat faktor penyebeb depresi dan psikosis postpartum sebagai berikut:

   a. Faktor konstitusional.

      Gangguan postpartum berkaitan dengan status paritas adalah riwayat obstetri pasien yang meliputi riwayat hamil sampai bersalin serta apakah adakomplikasi dari kehamilan dan persalinan sebelumnya dan terjadi lebih banyak pada wanita primipara. wanita primipara lebih umum menderita blues karena setelah melahirkan wanita. primipara berada dalam proses adaptasi, kalau dulu hanya memikirkan diri sendiri begitu bayi lahir jika ibu tidak paham perannya ia akan menjadi bingung sementara bayinya harus tetap dirawat.

b. Faktor fisik

   Perubahan fisik setelah proses kelahiran dan memuncaknya gangguan mental selama 2 minggu pertama menunjukkan bahwa faktor fisik dihubungkan dengan kelahiran pertama merupakan faktor penting. perubahan hormon secara drastis setelah melahirkan dan periode laten selama dua hari diantarakelahiran dan munculnya gejala. perubahan ini sangat berpengaruh pada keseimbangan. Kadang progesteron naik dan estrogen yang menurun secaracepat setelah melahirkan merupakan faktor penyebab yang sudah pasti.

c. Faktor psikologis

   Peralihan yang cepat dari keadaan dua dalam satu pada akhir kehamilan menjadi dua individu yaitu ibu dan anak bergantung pada penyesuaian psikologis individu. klaus dan kennel (regina dkk, 2001), mengindikasikan pentingnya cinta dalam menanggulangi masa peralihan ini untuk memulai hubungan baik antara ibu dan anak.

d. Faktor sosial

   Paykel dan Regina dkk (2001), mengemukakan bahwa pemukiman yang tidak memadai lebih sering menimbulkan depresi pada ibu-ibu, selain kurangnya dukungan dalam perkawinan. Penyebabnya dapat terjadi karena perubahan hormon, rendahnya dukungan sosial dan emosional, rasa rendah diri, merasa terpencil atau bisa jadi masalah keuangan. Gejala tampak ada perbaikan 95% dari ibu dalam 2 sampai 3 bulan.

3. Penyebab

   Penyebab dari gangguan psikosis adalah adanya gangguan keseimbangan zat kimia di dalam saraf otak. Gangguan keseimbangan ini bisa terjadi jika ada kelelahan fisik dan psikis disertai kapasitas mental yang kurang baik, seperti:

   a. Faktor genetik, mereka yang memiliki anggota keluarga yang memiliki masalah/gangguan jiwa lebih rentan atau berisiko untuk terkena psikosis
   b. Terdapat stres yang berat dalam kehidupan sehari-hari, masalah kehidupan, konflik yang tak terselesaikan, keinginan yang tidak tercapai, kekecewaan, kehilangan seseorang yang disayang, kemarahan yang terpendam, dll.
   c. Penggunaan narkoba/napza
   d. Benturan di kepala
   e. Perubahan hormon pada wanita yang mengandung dan melahirkan.

4. Gejala yang timbul akibat postpartum psikosis:

   a. Adanya halusinasi yang diperintahkan oleh kekuatan dari luar untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan
   b. Melihat hal-hal lain yang tidak nyata
   c. Perubahan mood atau tenaga yang ekstrim, perasaan yang labil

d. Ketidakmampuan untuk merawat bayi
e. Terjadi periode kebingungan yang serupa dengan amnesia (memory lapse), perasaan bingung yang intens
f. Hiperaktivitas, insomnia, kesulitan mengingat atau berkonsentrasi, tidak bisa membuat keputusan, delusi
g. Serangan kegelisahan yang tak terkendali
h. Pembicaraannya tidak dimengerti (mengalami gangguan komunikasi), berfikir tidak rasional.
i. Pada psikosis postpartum gejala dapat terjadi dalam jangka waktu setahun setelah melahirkan anak, namun awalnya sering terjadi pada minggu kedua atau minggu ketiga setelah persalinan. Gejala yang khas pada psikosis postpartum yaitu:
   1) Agitasi
   2) Gelisah
   3) Emosi yang labil
   4) Kegembiraan yang berlebihan
   5) Insomnia
   6) Menangis
   7) Bingung
   8) Lama-kelamaan akan timbul episode psikotik yang gawat dengan gambaran mania dan delirium.

5. Tanda dan gejala
   a. Halusinasi
      Gangguan persepsi panca indra, mendengar suara suara bisikan, melihat bayangan, mencium bau-bauan, merasa ada sesuatu di kulit dan di lidah, yang semuanya tidak ada sumbernya.
   b. Delusi/waham
      Keyakinan/pikiran/persepsi yang salah terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti merasa ada yang mengejar-ngejar, memperhatikan, berniat jahat, merasa diomongin dan dijauhi oleh teman-teman, atau merasa punya kekuatan/kehebatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya.
   c. Gangguan perilaku
      Menarik diri dari lingkungan sosial, gangguan tidur dan makan, sulit mengerjakan hal-hal yang sebelumnya mudah dilakukan, gerakan jadi lambat atau sebaliknya terlihat gelisah.
   d. Perubahan mond
      Cemas, sedih, khawatir yang berlebihan

e. Pikiran

   Sering curiga, sulit fokus dan berkonsentrasi, banyak bengong.

f. Pembicaraan

   Berbicara berulang ulang, malas bicara, ngomong tidak nyambung.

6. Dampak depresi Dan psikosis Post partum

   Depresi dan psikosis postpartum mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi penderitanya, setidaknya, depresi berdampak pada biaya, emosi, fisik, dan sosial.

   a. Dampak biaya

      Kinerja menurun, istirahat, cuti, tidak produktif, biaya pengobatan, bahkan hilangnya potensi penghasilan karena penderita merasaingin bunuh diri.

   b. Dampak emosi,

      Hidup dipenuhi dengan perasaan yang tidak nyaman, tidak berdaya, penyesalan mendalam, sedih, putus asa, cemas, dampak fisik, tubuh sakit, psikosomatis, jika ada sakit lebih cenderungmengalami komplikasi, kecepatan pemulihan kondisi kesehatan lebih lamadan lambat.

   c. Dampak sosial,

      Sering timbul konflik dalam keluarga, ketidak mampuan menjalankan fungsi dan peran sebagai orang tua yang baik, perceraian, putusnya persahabatan, perilaku yang merugikan diri sendiri, dan atau orang lain. Seperti mabuk, penggunaan obat-obatan terlarang.

7. Penatalaksaan Tindakan

   a. Penatalaksanaan tindakan yang dapat diberikan dengan rawat inap (hospitalisasi), pemberian obat anti psikotik atau anti depresan atau anti ansietas, sedatif, terapi anti kejang, perawatan bayinya, dukungan sosial dan psikoterapi/pendampingan psikiater. Hal tersebut dikarenakan wanita yang mengalami gangguan kejiwaaan ini tidak mampu atau tidak bersedia berbicara dengan orang di sekitarnya.

   b. Psikosis postpartum merupakan suatu kondisi emergensi dan memerlukan perhatian dan penanganan segera. pasien mungkin akan membutuhkan terapi obat untuk jangka waktu tertentu, seperti haloperidol atau flufenazin, keduanya diberikan dalam dosis 2- 5 mg per os 3 kali perhari. Bila agitasi maka pasien membutuhkan anti psikotika berpotensi tinggi dan diberikan IM. Mood stabilizer seperti lithium, valproid acid, carbamazepine digunakan sebagai terapi akut yang dikombinasi dengan obat anti psikotik dan benzodiapezine. indikasi pemakaian ECT sama seperti psikosis tanpa persalinan tetapi dianjurkan ditunda sampai satu bulan post partum untuk menghindari terjadinya emboli.

8. Kenali Mitos dan fakta mengenai psikosis
    a. Psikosis bukan sesuatu yang dibuat-buat
    b. Psikosis bukan karena pola asuh yang buruk tetapi penyebab yang multifaktor
    c. Psikosis bukan menunjukkan kelemahan/kebodohan/kemalasan tetapi adalah penyakit yang harus diobati
    d. Psikosis bukanlah karena hal hal yang gaib/mistis, Ini adalah gangguan medis
    e. Psikosis bukanlah akhir segalanya, ini dapat disembuhkan dan dipulihkan
9. Apa yang dapat dilakukan oleh keluarga bila ada yang menderita psikosis
    a. Sediakan waktu untuk mendengar apa yang dirasakan
    b. Berikan perhatian yang lebih dalam berbagai hal
    c. Segera kurangi tingkat stresor yang dialami
    d. Cepatlah dibawa ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan yang cepat dan tepat sehingga gejala bisa berkurang dan hilang.
    e. Berkonsultasi secara rutin untuk pengaturan dosis obat dan psikoterapi.
    f. Selalu bersikap positif dan optimis bahwa gangguan ini bisa dipulihkan.
    g. Atur pola hidup sehat, makan yang sehat perbanyak ikan, sayur dan buah, hindari.
    h. penyedap, pewarna dan pengawet berlebihan, hindari mie instan dan junk food, olahraga teratur 30 menit sehari, pola tidur yang cukup 6-8 jam sehari.

D. Mini-case

Ny. M baru melahirkan anak ke-2-nya dua hari yang lalu. Ia merasa senang dan bangga karena telah melahirkan anak yang dikandungnya selama ini dan selalu menceritakan kepada siapa pun tentang pengalaman melahirkannya, terlebih lagi pada kelahiran ini, anak diletakkan di atas perutnya, berbeda dengan kelahiran sebelumnya. Ny. M juga menceritakan tentang kekhawatiran kemampuannya dalam merawat bayinya, meskipun suami dan ibunya sangat memperhatikan bayinya. Suami dan ibunya ingin agar Ny.M lebih banyak

Istirahat untuk memulihkan kondisinya setelah lelah melalui proses persalinan. Sampai dengan hari ke-5 setelah Ny.Mona pulang ke rumah, ia belum mampu merawat bayinya karena segala sesuatunya tetap dilakukan oleh suami dan ibunya, ia merasa bahwa

Semua anggota keluarga hanya memperhatikan bayinya. Ia mulai menarik diri, merasa suami telah mengabaikannya, apalagi dengan kondisi luka perineum yang ada, Ia merasa tidak sempurna nantinya dalam pandangan suaminya. Suami dan keluarga selalu berusaha memberikan dukungan kepada Ny. Mona bahwa ia mampu dan memberikan kesempatan kepadanya dalam melakukan perawatan bayi dengan cara ketika ibu merawat bayi orang tuanya mendampinginya. Dukungan

kepada anak pertama juga diberikan dengan cara melibatkan dalam perawatan adiknya seperti meminta bantuan dalam mengambil pakaian adiknya.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Berdasarkan konsep 3P, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama?
4. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
5. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kesehatan Mental Ibu Nifas: Depresi Postpartum
3	Kasus	Ibu nifas dengan dugaan depresi postpartum
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 25 tahun, P1A0, datang ke Puskesmas pada hari ke-10 postpartum. Ibu mengeluh sering merasa sedih tanpa sebab, mudah menangis, sulit tidur meskipun bayi sedang tidur, dan merasa tidak mampu merawat bayinya. Ibu juga mengatakan tidak bersemangat menyusui dan merasa menjadi ibu yang buruk. Suami mengatakan ibu sering menarik diri dan jarang berinteraksi dengan keluarga. Hasil anamnesis tambahan: tidak ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Persalinan normal. Bayi sehat.

No.	Komponen	Isi
		Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 36,8°C. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh.4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog. 2. Jika peserta mengeksplorasi kondisi psikologis, penguji memberikan data: a. Ibu merasa sedih hampir setiap hari b. Kehilangan minat aktivitas c. Mudah lelah d. Tidak ada ide bunuh diri 3. Diagnosis yang diharapkan: Depresi postpartum (ringan–sedang) 4. Tindakan yang diharapkan dari peserta: a. Memberikan empati dan dukungan emosional b. Mengidentifikasi faktor risiko psikososial c. Menganjurkan dukungan keluarga

No.	Komponen	Isi
		d. Edukasi tentang kondisi ibu (bukan kelemahan pribadi) e. Menganjurkan istirahat cukup dan berbagi peran merawat bayi f. Skrining menggunakan alat sederhana (misal EPDS – jika disebutkan) g. Merencanakan rujukan ke tenaga profesional (psikolog/psikiater) bila perlu 5. Penguji tidak diperbolehkan interupsi. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1, PS berperan sebagai ibu nifas hari ke-10 dengan depresi ringan–sedang. 2, PS tampak sedih, berbicara pelan, kadang menangis. 3. PS menjawab dengan suara lemah dan kurang kontak mata. 4. Jika diberi dukungan, PS sedikit lebih terbuka. 5. Jika disarankan rujukan, PS ragu tetapi bersedia jika dijelaskan dengan baik.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Bu. PS: Pagi, Bu. Peserta: Apa yang ibu rasakan saat ini? PS: Saya sering sedih, Bu… rasanya ingin menangis terus. Peserta: Sejak kapan ibu merasakan hal ini? PS: Sejak beberapa hari setelah melahirkan. Peserta: Bagaimana tidur ibu? PS: Susah tidur, Bu… walaupun bayi tidur. Peserta: Apakah ibu merasa mampu merawat bayi? PS: Tidak, Bu… saya merasa tidak bisa jadi ibu yang baik. Peserta: Apakah ibu masih semangat menyusui?

No.	Komponen	Isi
		PS: Tidak terlalu, Bu… rasanya malas. Peserta: Apakah pernah terpikir menyakiti diri sendiri atau bayi? PS: Tidak, Bu… tapi saya merasa sangat tidak berguna. Peserta: Apakah ada dukungan dari keluarga? PS: Suami sibuk, Bu… saya sering sendiri. Peserta: Ibu, kondisi ini bisa terjadi pada ibu setelah melahirkan dan bisa ditangani. PS: Benarkah, Bu? Saya kira saya lemah. Peserta: Kami akan membantu ibu dan mungkin perlu konsultasi lanjutan. PS: Baik, Bu… saya mau dibantu.
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan manikin khusus (fokus komunikasi dan mental health)
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1 Menyiapkan ruangan yang nyaman untuk simulasi konseling 2 Memastikan lembar instruksi tersedia
12	Kebutuhan alat	1 Kursi dan meja konsultasi 2 Tensimeter 3 Stetoskop 4 Termometer 5 Lembar skrining (EPDS dummy) 6 Lembar rujukan 7 Alat tulis 8 Handrub
13	Penulis	Bdn. Kusumastuti, M.Kes
14	Referensi	1 Kementerian Kesehatan RI. (2020). Standar Profesi Bidan. 2 Kementerian Kesehatan RI. (2022). Standar Kompetensi Bidan. 3 World Health Organization. (2015). Thinking Healthy Programme. 4 Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: EPDS.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Kesehatan Mental Ibu Nifas

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (sedih, menangis, tidak bersemangat)		
2. Lama dan frekuensi keluhan (sejak kapan, setiap hari/tidak)		
3. Pola tidur (insomnia/hipersomnia)		
4. Minat dan motivasi (keinginan merawat bayi/menyusui)		
5. Perasaan diri (merasa tidak berguna, bersalah)		
6. Skrining pikiran menyakiti diri/bayi		
7. Dukungan keluarga/sosial		
8. Riwayat kesehatan mental sebelumnya		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan		
b. Memperkenalkan diri		
c. Menjelaskan tujuan		
d. Informed consent		
e. Menjaga privasi		
f. Hand hygiene		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum ibu		
b. Menilai tanda vital		
c. Menilai kondisi psikologis (afek, mood)		
d. Mengidentifikasi gejala depresi		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
e. Melakukan skrining sederhana (misal EPDS jika disebutkan)		
f. Menentukan tingkat keparahan		
g. Menetapkan diagnosis depresi postpartum		
h. Memberikan dukungan emosional		
i. Memberikan edukasi kondisi ibu		
j. Menganjurkan dukungan keluarga		
k. Menganjurkan istirahat dan coping		
l. Merencanakan rujukan bila perlu		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil kepada ibu		
b. Menyusun rencana tindak lanjut		
c. Dokumentasi		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 *(dicatat di rubrik penilaian)*

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kesehatan Mantal Ibu Nifas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik mahasiswa. Penilai mengamati secara langsung interaksi dan tindakan mahasiswa, kemudian memberikan umpan balik segera setelah kegiatan selesai. Domain yang dinilai meliputi komunikasi terapeutik, pengumpulan data, pemeriksaan status mental sederhana, penetapan diagnosis, pengambilan keputusan, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan komunikasi terapeutik pada ibu nifas dengan keluhan emosional, menggali kondisi psikologis, serta menilai kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi gangguan seperti baby blues, depresi postpartum, atau psikosis postpartum.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam mendeteksi dini, mengidentifikasi, dan melakukan penatalaksanaan awal gangguan kesehatan mental pada ibu nifas secara tepat, empatik, dan berpusat pada ibu. Asuhan harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, serta keselamatan ibu dan bayi.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuan tentang gangguan mental postpartum, tetapi dari kemampuannya membangun hubungan terapeutik, mengenali gejala, membedakan tingkat keparahan, serta menentukan apakah diperlukan dukungan, intervensi, atau rujukan segera.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemui dalam praktik kebidanan, seperti perubahan emosional ringan hingga gangguan mental berat postpartum. Kasus harus mencerminkan capaian pembelajaran dalam deteksi dini dan penanganan awal gangguan psikologis ibu nifas.	Seorang perempuan usia 28 tahun, hari ke-10 postpartum, mengeluh sedih terus-menerus, sulit tidur, merasa tidak mampu merawat bayinya, dan menarik diri dari lingkungan. Pada kasus lain, ibu postpartum hari ke-3 mengalami baby blues, atau ibu hari ke-7 postpartum menunjukkan perilaku aneh, halusinasi,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
		dan berisiko membahayakan bayi (psikosis postpartum).
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan interaksi langsung dengan pasien dalam konteks klinik, terutama pada kemampuan komunikasi terapeutik, penggalian data psikologis, dan pengambilan keputusan klinik. Keterampilan ini menekankan pendekatan holistik, empati, dan patient-centred care.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, melakukan anamnesis psikologis, menilai kondisi emosional ibu, mengidentifikasi tanda baby blues/depresi/psikosis, memberikan dukungan emosional, melakukan edukasi, serta menentukan perlunya kolaborasi atau rujukan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan komunikasi terapeutik, ketepatan anamnesis, kemampuan mengenali tanda dan gejala gangguan mental, ketepatan diagnosis, pengambilan keputusan, edukasi, serta profesionalisme. Pada kasus tertentu juga dinilai kemampuan menjaga keselamatan ibu dan bayi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu membedakan baby blues (ringan), depresi postpartum (sedang), dan psikosis postpartum (berat), serta menentukan tindakan yang sesuai, termasuk dukungan, edukasi, atau rujukan segera.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi adalah performa nyata mahasiswa dalam menghadapi pasien, terutama dalam membangun komunikasi empatik, mengidentifikasi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Pada kondisi kegawatdaruratan, fokus pada keselamatan pasien menjadi prioritas utama.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menunjukkan empati, menggali masalah secara sistematis, mengenali tanda bahaya (misalnya halusinasi atau keinginan menyakiti bayi), serta segera mengambil keputusan rujukan pada kasus psikosis postpartum.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi dan mencakup kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik bersifat	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi empatik, tetapi perlu meningkatkan kemampuan menggali risiko bunuh diri atau meningkatkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
	konstruktif dan spesifik pada keterampilan yang diamati.	ketegasan dalam menentukan rujukan pada kasus berat.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial berdasarkan performa mahasiswa dalam aspek klinik dan profesionalisme.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan komunikasi terapeutik, mengenali gangguan mental, dan menentukan tindakan yang tepat. Perlu supervisi jika langkah sudah benar namun belum sistematis. Remedial jika gagal mengenali kondisi atau salah mengambil keputusan.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian kompetensi pada level *does* karena mahasiswa dinilai berdasarkan performa nyata di lahan praktik. Metode ini sangat sesuai untuk pendidikan kebidanan berbasis kompetensi.	Pada kasus kesehatan mental postpartum, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu melakukan deteksi dini, komunikasi terapeutik, serta penatalaksanaan awal gangguan mental ibu nifas secara langsung, empatik, dan profesional.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel.6.1
Portofolio pada Kesehatan mental ibu nifas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik kesehatan mental ibu nifas, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian psikologis, mengenali perubahan emosi postpartum, membedakan baby blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum, serta melakukan intervensi awal dan rujukan yang tepat.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu nifas dengan gangguan emosional, tetapi juga menunjukkan perkembangan kemampuannya dalam komunikasi terapeutik, deteksi dini gangguan mental, dan pengambilan keputusan klinis setelah mendapatkan umpan balik.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan anamnesis psikologis, identifikasi gejala depresi atau baby blues, serta pemberian KIE. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan komunikasi terapeutik, deteksi dini, dan penanganan awal atau rujukan pada kasus psikosis postpartum.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu postpartum hari ke-10 yang mengalami kesedihan berkepanjangan, sulit tidur, merasa tidak mampu merawat bayi, hasil pengkajian psikologis, diagnosis depresi postpartum, intervensi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
		berupa dukungan emosional dan edukasi, serta rencana rujukan bila diperlukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya deteksi dini gangguan mental postpartum, pengkajian risiko bunuh diri atau menyakiti bayi, pentingnya keterlibatan keluarga, serta tindakan cepat pada kasus psikosis postpartum untuk mencegah bahaya bagi ibu dan bayi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi empatik dan membangun hubungan terapeutik, tetapi perlu meningkatkan kemampuan menggali risiko psikologis lebih dalam serta ketepatan dalam menentukan rujukan pada kasus depresi berat atau psikosis.
Karakteristik penilaian	Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang menekankan konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai situasi klinik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari satu kasus, tetapi dari beberapa pengalaman menangani ibu nifas dengan kondisi emosional berbeda, sehingga terlihat konsistensi dalam deteksi dini dan penanganan gangguan mental postpartum.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan kemampuan mahasiswa mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa mampu secara konsisten melakukan komunikasi terapeutik, mengidentifikasi gangguan mental, dan mengambil keputusan yang tepat pada berbagai kasus ibu nifas.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai melalui	Pada kesehatan mental ibu nifas, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
	performa nyata yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	teori, tetapi mampu menerapkan deteksi dini, komunikasi empatik, serta penatalaksanaan awal gangguan mental secara konsisten dalam praktik kebidanan.

Tabel 6.2
Case Report pada Kesehatan Mental Ibu Nifas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu nifas hari ke-10 yang mengalami kesedihan berkepanjangan, sulit tidur, merasa tidak mampu merawat bayi, serta menarik diri dari lingkungan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah psikologis yang dialami, faktor risiko, intervensi yang diberikan (dukungan emosional, edukasi), serta rencana kolaborasi atau rujukan bila diperlukan.
Isi laporan	Isi case report mencakup identitas pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan keluhan sedih terus-menerus, insomnia, kehilangan minat, merasa tidak mampu merawat bayi, hasil pemeriksaan normal, analisis depresi postpartum, intervensi berupa komunikasi terapeutik dan edukasi, serta rencana rujukan jika kondisi memburuk.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
	logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	gejala emosional, gangguan tidur, dan perasaan tidak berharga sebagai tanda depresi postpartum serta menentukan intervensi yang tepat.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kemampuan refleksi praktik klinik.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar pentingnya deteksi dini gangguan mental postpartum, komunikasi empatik, serta peran dukungan keluarga dalam pemulihan ibu.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep kesehatan mental ibu nifas, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara holistik (bio-psiko-sosial).

Tabel 6.3
Refleksi Patient Safety pada Kesehatan Mental Ibu Nifas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus depresi postpartum, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan deteksi dapat menyebabkan kondisi memburuk hingga risiko menyakiti diri atau bayi.
Tujuan	Refleksi bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa mengabaikan keluhan emosional ibu nifas dapat berdampak serius terhadap keselamatan ibu dan bayi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah depresi berat, gangguan bonding ibu-bayi, penurunan kualitas perawatan bayi, serta kemungkinan berkembang menjadi psikosis postpartum.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi meliputi keterlambatan diagnosis depresi postpartum, kurangnya dukungan keluarga, tidak dilakukannya skrining mental, serta tidak dikenalnya tanda psikosis seperti halusinasi atau waham.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya skrining rutin kesehatan mental, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, pemantauan kondisi ibu, serta rujukan tepat waktu pada kasus berat seperti psikosis postpartum.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan dampaknya pada praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa gangguan mental postpartum sama pentingnya dengan kondisi fisik, sehingga memerlukan kepekaan, empati, dan deteksi dini dalam praktik kebidanan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia mampu tidak hanya memberikan asuhan, tetapi juga mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kesehatan Mental Ibu Nifas
		kebidanan secara berkelanjutan, khususnya dalam kesehatan mental ibu nifas.

E. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 24 tahun, P1A0, melahirkan spontan empat hari yang lalu. Hasil anamnesis: ibu mengatakan sejak kemarin sering tiba-tiba menangis, mudah tersinggung, dan khawatir tidak mampu merawat bayinya. Tidurnya sering terbangun karena bayi menyusu. Hasil pemeriksaan: tanda vital normal, ibu sadar, orientasi baik, mampu menyusui dan mengganti popok bayi, serta tidak memiliki pikiran menyakiti diri sendiri atau bayinya.
   Apakah kondisi yang paling mungkin dialami ibu pada kasus tersebut?
   A. Postpartum depression
   B. Postpartum blues
   C. Postpartum psychosis
   D. Depresi berat dengan gejala psikotik
   E. Gangguan skizoafektif postpartum

2. Seorang perempuan berusia 29 tahun, P2A0, datang ke puskesmas enam minggu setelah melahirkan. Hasil anamnesis: selama tiga minggu terakhir ibu merasa sedih hampir sepanjang hari, kehilangan minat terhadap kegiatan yang sebelumnya disukai, sulit tidur meskipun bayi sedang tidur, nafsu makan menurun, serta merasa tidak berguna sebagai ibu. Ibu mulai menghindari bayinya dan tidak mampu menjalankan pekerjaan sehari-hari. Hasil pemeriksaan: ibu tampak murung, pembicaraan koheren, orientasi baik, serta tidak ditemukan halusinasi maupun waham.
   Apakah kondisi yang paling mungkin dialami ibu pada kasus tersebut?
   A. Postpartum blues
   B. Postpartum psychosis
   C. Gangguan emosional sementara akibat kelelahan
   D. Postpartum depression tanpa gambaran psikosis
   E. Postpartum depression dengan gambaran psikosis

3. Seorang perempuan berusia 32 tahun, P1A0, dibawa suaminya ke IGD pada hari ke-12 setelah melahirkan. Hasil anamnesis: ibu tidak tidur selama dua malam, berjalan mondar-mandir, dan suasana hatinya berubah cepat dari tertawa menjadi marah. Ibu mengatakan bayinya memiliki kekuatan khusus dan mengaku mendengar suara yang memerintahkannya membawa bayi ke sungai untuk "disucikan". Hasil pemeriksaan: ibu tampak sangat gelisah, pembicaraan tidak terarah, serta sulit membedakan kenyataan dan khayalan.
   Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Postpartum psychosis
   B. Postpartum blues
   C. Postpartum depression tanpa psikosis
   D. Gangguan emosional ringan masa nifas
   E. Kelelahan fisik akibat perawatan bayi

4. Seorang perempuan berusia 22 tahun, P1A0, dikunjungi bidan pada hari kelima setelah persalinan. Hasil anamnesis: ibu mengaku mudah menangis, cemas tidak mampu menyusui dengan baik, dan merasa seluruh perhatian keluarga hanya tertuju kepada bayinya. Keluhan muncul sejak dua hari terakhir. Hasil pemeriksaan: ibu sadar, kooperatif, masih mampu menyusui dan merawat bayi dengan pendampingan suami, serta menyangkal adanya pikiran menyakiti diri sendiri atau bayi.
   Apakah tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut?
   A. Memberikan obat antipsikotik tanpa konsultasi
   B. Memisahkan ibu dari bayinya selama satu bulan
   C. Memberikan komunikasi terapeutik, memfasilitasi istirahat, melibatkan keluarga, dan melakukan pemantauan
   D. Tidak melakukan intervensi karena keluhan pasti menghilang dengan sendirinya
   E. Langsung merujuk sebagai kegawatdaruratan psikiatri tanpa penilaian lebih lanjut

5. Seorang perempuan berusia 27 tahun, P2A0, datang dua bulan setelah melahirkan. Hasil anamnesis: ibu merasa sedih dan tidak berharga selama lima minggu, tidak tertarik merawat bayinya, serta mengatakan keluarganya akan lebih baik tanpa dirinya. Suami menemukan surat perpisahan dan ibu mengaku telah merencanakan meminum cairan pestisida yang disimpan di rumah. Hasil pemeriksaan: ibu tampak murung, menangis, pembicaraan koheren, dan tidak ditemukan halusinasi maupun waham.
   Apakah tindakan prioritas yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Menjadwalkan kunjungan ulang satu minggu kemudian
   B. Menganjurkan ibu tidur ketika bayi tidur dan melakukan olahraga ringan
   C. Meminta suami mengawasi ibu di rumah tanpa melakukan rujukan
   D. Memberikan edukasi perawatan bayi dan memulangkan ibu
   E. Menjamin keselamatan ibu, tidak meninggalkannya sendirian, mengamankan bayi dan benda berbahaya, serta segera melakukan rujukan

Kunci Jawaban

1. Postpartum blues
2. Postpartum depression tanpa gambaran psikosis
3. Postpartum psychosis
4. Memberikan komunikasi terapeutik, memfasilitasi istirahat, melibatkan keluarga, dan melakukan pemantauan
5. Menjamin keselamatan ibu, tidak meninggalkannya sendirian, mengamankan bayi dan benda berbahaya, serta segera melakukan rujukan

Pembahasan

1. Jawaban: **B**. Postpartum blues
   Kata kunci: hari keempat postpartum, mudah menangis, mudah tersinggung, cemas, masih mampu merawat bayi, tidak ada pikiran menyakiti diri atau bayi.
   Postpartum blues biasanya muncul pada hari kedua sampai hari kelima setelah persalinan dan umumnya terjadi dalam 14 hari pertama. Gejalanya dapat berupa mudah menangis, perubahan suasana hati, kecemasan, mudah tersinggung, gangguan tidur, dan perasaan tidak percaya diri dalam merawat bayi. Kondisi ini bersifat sementara dan intensitasnya relatif ringan.
   Pada kasus tersebut, ibu masih dapat menyusui serta mengganti popok bayi, memiliki orientasi yang baik, dan tidak menunjukkan gangguan fungsi berat. Tidak ditemukan pula halusinasi, waham, atau pikiran membahayakan diri sendiri maupun bayi. Data tersebut lebih sesuai dengan postpartum blues dibandingkan depresi atau psikosis postpartum.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. A: Postpartum depression biasanya berlangsung lebih lama, lebih berat, dan menyebabkan gangguan fungsi yang nyata.
b. C: Postpartum psychosis ditandai halusinasi, waham, kebingungan berat, atau perilaku tidak rasional.
c. D: Tidak terdapat gejala psikotik atau depresi berat.
d. E: Tidak ditemukan riwayat atau gejala gangguan skizoafektif.

2. Jawaban: **D**. Postpartum depression tanpa gambaran psikosis

   Kata kunci: gejala berlangsung tiga minggu, sedih hampir sepanjang hari, kehilangan minat, insomnia, merasa tidak berguna, gangguan merawat bayi, tidak ada halusinasi atau waham.

   Postpartum depression mempunyai gejala yang dapat menyerupai postpartum blues, tetapi berlangsung lebih lama, lebih sering, dan lebih berat. Gejalanya meliputi suasana hati terdepresi, berkurangnya minat atau kesenangan, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan, perasaan tidak berharga, rasa bersalah, kesulitan berkonsentrasi, serta gangguan dalam menjalankan fungsi sosial dan peran sebagai ibu.

   Dalam kasus tersebut, keluhan telah berlangsung selama tiga minggu dan menyebabkan ibu tidak mampu menjalankan pekerjaan sehari-hari serta mulai menghindari bayinya. Kondisi tersebut bukan lagi gangguan emosional ringan yang bersifat sementara. Karena pembicaraan ibu tetap koheren dan tidak terdapat halusinasi maupun waham, kondisi ini dikategorikan sebagai postpartum depression tanpa gambaran psikosis.

   Alasan opsi lain tidak tepat:

   a. A: Postpartum blues umumnya singkat dan ibu masih dapat menjalankan fungsi perawatan bayi.
   b. B: Psikosis postpartum harus disertai gangguan realitas, seperti halusinasi, waham, kebingungan, atau perilaku tidak rasional.
   c. C: Gangguan sementara akibat kelelahan tidak menjelaskan gejala menetap selama tiga minggu dan gangguan fungsi berat.
   d. E: Tidak ditemukan halusinasi, waham, atau gangguan proses pikir.

3. Jawaban: A. Postpartum psychosis

   Kata kunci: hari ke-12 postpartum, tidak tidur, agitasi, perubahan suasana hati ekstrem, waham, halusinasi perintah, pembicaraan tidak terarah.

   Postpartum psychosis merupakan gangguan kejiwaan berat setelah persalinan yang ditandai dengan ketidakmampuan membedakan kenyataan dan khayalan.

Gejalanya antara lain halusinasi, waham, kebingungan, agitasi, insomnia, perubahan suasana hati yang ekstrem, hiperaktivitas, pembicaraan tidak koheren, dan perilaku tidak rasional. Kondisi ini sering muncul pada minggu-minggu awal setelah melahirkan.

Ibu pada kasus tersebut mengalami waham bahwa bayinya memiliki kekuatan khusus dan halusinasi auditorik berupa suara yang memerintahkannya membawa bayi ke sungai. Halusinasi perintah tersebut menunjukkan risiko langsung terhadap keselamatan bayi. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan kegawatdaruratan psikiatri yang memerlukan perlindungan segera terhadap ibu dan bayi serta rujukan ke fasilitas yang mampu memberikan perawatan psikiatri.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. B: Postpartum blues tidak menyebabkan kehilangan kontak dengan realitas.
b. C: Depresi postpartum tanpa psikosis tidak disertai halusinasi dan waham.
c. D: Gangguan emosional ringan tidak menyebabkan pembicaraan tidak terarah dan perilaku berbahaya.
d. E: Kelelahan dapat menyebabkan emosi tidak stabil, tetapi tidak menjelaskan halusinasi dan waham.

4. Jawaban: **C**. Memberikan komunikasi terapeutik, memfasilitasi istirahat, melibatkan keluarga, dan melakukan pemantauan

Kata kunci: hari kelima postpartum, gejala ringan, masih mampu merawat bayi, tidak ada ide menyakiti diri atau bayi, keluarga tersedia.

Gambaran kasus mengarah pada postpartum blues. Penatalaksanaan awal postpartum blues berfokus pada dukungan psikologis dan praktis. Bidan perlu memberi kesempatan kepada ibu untuk mengungkapkan perasaan, mendengarkan secara empatik, mengurangi rasa bersalah, dan menjelaskan bahwa perubahan emosi ringan dapat terjadi pada awal masa nifas.

Bidan juga perlu melibatkan suami dan keluarga untuk membantu perawatan bayi dan pekerjaan rumah tangga sehingga ibu memperoleh waktu istirahat yang cukup. Ibu tetap diberi kesempatan merawat bayinya secara bertahap agar rasa percaya dirinya meningkat. Pemantauan diperlukan untuk menilai apakah gejala berkurang atau justru menetap, memburuk, mengganggu fungsi, atau disertai pikiran menyakiti diri sendiri maupun bayi.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. A: Obat antipsikotik bukan penatalaksanaan rutin postpartum blues dan tidak boleh diberikan tanpa indikasi serta kolaborasi.
b. B: Pemisahan ibu dan bayi secara tidak perlu dapat mengganggu proses bonding.

c. D: Meskipun dapat bersifat sementara, keluhan tetap memerlukan edukasi, dukungan, dan pemantauan.
d. E: Tidak ditemukan kondisi kegawatdaruratan yang mengharuskan rujukan psikiatri segera.

5. Jawaban: E. Menjamin keselamatan ibu, tidak meninggalkannya sendirian, mengamankan bayi dan benda berbahaya, serta segera melakukan rujukan
   Kata kunci: gejala lima minggu, merasa tidak berharga, surat perpisahan, rencana bunuh diri spesifik, tersedia pestisida.
   Ibu menunjukkan postpartum depression dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Risiko tersebut dibuktikan dengan adanya perasaan tidak berharga, pernyataan bahwa keluarga akan lebih baik tanpa dirinya, penulisan surat perpisahan, dan rencana spesifik untuk meminum pestisida. Walaupun tidak ditemukan halusinasi atau waham, keberadaan rencana bunuh diri menjadikan kondisi ini sebagai keadaan yang membutuhkan penanganan segera.
   Prioritas bidan adalah menjaga keselamatan ibu dan bayi. Ibu tidak boleh ditinggalkan sendirian, benda atau zat yang berpotensi digunakan untuk menyakiti diri harus diamankan, dan bayi perlu berada dalam pengawasan anggota keluarga yang aman. Setelah tindakan keselamatan awal dilakukan, ibu harus segera dirujuk atau dikolaborasikan dengan dokter, psikolog klinis, atau psikiater untuk memperoleh pemeriksaan dan penatalaksanaan lebih lanjut.
   Alasan opsi lain tidak tepat:
   a. A: Menunda penanganan selama satu minggu dapat meningkatkan risiko terjadinya percobaan bunuh diri.
   b. B: Istirahat dan olahraga ringan tidak memadai untuk kondisi dengan rencana bunuh diri.
   c. C: Pengawasan keluarga di rumah saja tidak cukup tanpa penilaian profesional dan rujukan segera.
   d. D: Edukasi rutin dan pemulangan ibu dapat membahayakan keselamatannya karena terdapat rencana bunuh diri yang spesifik.

F. Ringkasan Materi

Masa nifas merupakan periode adaptasi fisik dan psikologis yang kompleks bagi seorang ibu. Perubahan hormonal, kelelahan, serta tuntutan peran baru sebagai ibu dapat memicu berbagai gangguan emosional, mulai dari baby blues, depresi postpartum, hingga psikosis postpartum. Dalam praktik kebidanan, penilaian kesehatan mental ibu nifas tidak boleh hanya berdasarkan satu gejala, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi

emosional, pola tidur, kemampuan merawat bayi, dukungan sosial, serta adanya pikiran menyakiti diri atau bayi.

Baby blues merupakan kondisi ringan yang biasanya muncul pada hari ke-2 hingga ke-5 postpartum dan bersifat sementara, ditandai dengan mudah menangis, cemas, dan perubahan suasana hati, namun ibu masih mampu merawat bayi. Depresi postpartum merupakan kondisi yang lebih serius dengan gejala seperti kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat, gangguan tidur, kelelahan, perasaan tidak berharga, serta gangguan bonding dengan bayi. Sementara itu, psikosis postpartum merupakan kondisi kegawatdaruratan yang ditandai dengan halusinasi, waham, perilaku aneh, dan risiko tinggi membahayakan diri sendiri atau bayi.

Bidan memiliki peran penting dalam deteksi dini, penilaian, dan penatalaksanaan awal gangguan kesehatan mental ibu nifas. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat holistik, empatik, dan berpusat pada ibu (woman-centred care). Langkah utama meliputi anamnesis psikologis, penilaian status mental sederhana, identifikasi faktor risiko, serta skrining kondisi mental bila memungkinkan. Intervensi awal mencakup komunikasi terapeutik, pemberian dukungan emosional, edukasi kepada ibu dan keluarga, serta penguatan dukungan sosial.

Pada kasus ringan seperti baby blues, penatalaksanaan berfokus pada edukasi dan dukungan. Pada depresi postpartum, diperlukan pemantauan lebih lanjut dan kemungkinan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Sedangkan pada psikosis postpartum, tindakan harus segera berfokus pada keselamatan ibu dan bayi, termasuk tidak meninggalkan pasien sendiri dan segera melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih mampu. Prinsip utama dalam asuhan adalah keselamatan ibu dan bayi, deteksi dini, serta pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

G. Alur asuhan singkat

Ibu nifas dengan keluhan emosional → lakukan anamnesis psikologis dan penilaian status mental → identifikasi tingkat gangguan (baby blues / depresi / psikosis) → nilai risiko keselamatan ibu dan bayi → berikan komunikasi terapeutik dan dukungan emosional →tentukan intervensi (edukasi, pemantauan, atau rujukan) → libatkan keluarga →lakukan dokumentasi dan tindak lanjut yang jelas

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Kesehatan Mental Ibu Nifas (Baby Blues, Depresi Postpartum, dan Psikosis Postpartum)

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Ibu merasa sedih berkepanjangan (>2 minggu) dan kehilangan minat	Mengarah pada depresi postpartum	Lakukan pengkajian lebih dalam, lapor ke pembimbing, pertimbangkan kolaborasi dengan psikolog/tenaga kesehatan jiwa
Gangguan tidur berat (tidak bisa tidur meskipun bayi tidur)	Indikasi gangguan psikologis sedang–berat	Berikan dukungan, evaluasi kondisi mental, pertimbangkan rujukan
Ibu merasa tidak mampu merawat bayi atau merasa menjadi ibu yang buruk	Gangguan bonding ibu-bayi dan risiko depresi	Berikan komunikasi terapeutik, libatkan keluarga, pantau ketat
Menarik diri dari lingkungan sosial	Risiko depresi memburuk	Lakukan pendekatan empatik, dorong dukungan sosial, follow-up
Ibu menyatakan keinginan menyakiti diri sendiri	Kegawatdaruratan mental	Jangan tinggalkan ibu sendiri, lapor segera, rujuk emergensi
Ibu menunjukkan keinginan menyakiti bayi	Risiko tinggi keselamatan bayi	Amankan bayi, libatkan keluarga, rujuk segera
Halusinasi (mendengar suara/ melihat sesuatu yang tidak ada)	Tanda psikosis postpartum	Segera lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan jiwa
Waham (misalnya bayi bukan miliknya)	Psikosis postpartum	Jangan tunda, lakukan rujukan emergensi
Perilaku aneh, gelisah, atau tidak terkontrol	Gangguan mental berat	Pastikan keamanan, dampingi pasien, rujuk segera
Ibu tidak mau makan/minum atau merawat diri	Risiko penurunan kondisi fisik dan mental	Stabilkan kondisi, libatkan keluarga, pertimbangkan rujukan
Tidak ada dukungan keluarga	Faktor risiko perburukan kondisi	Edukasi keluarga, cari support system, follow-up intensif
Keputusan rujukan sudah jelas tetapi tertunda	Meningkatkan risiko ibu dan bayi	Segera lakukan rujukan, komunikasi efektif dengan keluarga dan fasilitas tujuan

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Bab: Kesehatan Mental Ibu Nifas (Baby Blues, Depresi Postpartum, Psikosis Postpartum)

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian baby blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa membedakan tingkat keparahan gangguan mental postpartum	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis psikologis secara terarah pada ibu nifas	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi perubahan emosi pada ibu nifas	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menilai pola tidur dan kelelahan ibu	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menilai kemampuan ibu dalam merawat bayi	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengenali tanda depresi postpartum	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengenali tanda psikosis postpartum	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi risiko menyakiti diri atau bayi	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik secara empatik	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa memberikan dukungan emosional kepada ibu nifas	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa melibatkan keluarga dalam perawatan ibu	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan perlu kolaborasi atau rujukan	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal pada kasus psikosis postpartum (keamanan ibu & bayi)	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi secara tepat dan sistematis	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjaga privasi, empati, dan profesionalisme dalam asuhan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

_____

_____

BAB 7

EDUKASI TANDA BAHAYA NIFAS, DOKUMENTASI, DAN TINDAK LANJUT: KUNJUNGAN NIFAS, KONSELING KB, DAN CONTINUITY OF CARE

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan (PPI/K3) dalam pelayanan/asuhan masa nifas.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-6
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-2, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Menggunakan clinical reasoning dan evidence-based practice dalam pengambilan keputusan asuhan pada komplikasi nifas.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Melakukan pengkajian terfokus–komprehensif masa nifas (anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital) untuk deteksi dini komplikasi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Melaksanakan tindakan awal, stabilisasi dasar, dan menentukan kebutuhan rujukan pada komplikasi nifas.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-6
CPL-6	Melaksanakan edukasi, konseling, dukungan laktasi dan kesehatan mental, dokumentasi, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.	CPMK-5, CPMK-7, CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etika–legal, keselamatan (PPI/K3), dokumentasi, dan penggunaan pedoman/evidence dalam asuhan komplikasi nifas.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus ibu nifas dan menafsirkan tanda vital untuk menetapkan prioritas masalah serta rencana asuhan awal.

CPMK-3	Melaksanakan penatalaksanaan awal perdarahan postpartum dengan pendekatan 4T, stabilisasi, monitoring, dan keputusan rujukan sesuai algoritme.
CPMK-4	Melaksanakan deteksi dini serta penatalaksanaan awal infeksi masa nifas dan sepsis, termasuk pencegahan penyebaran dan evaluasi respons.
CPMK-5	Melaksanakan pengkajian dan penatalaksanaan awal gangguan laktasi (bendungan ASI, puting lecet, mastitis) serta koreksi teknik menyusui dan dukungan keluarga.
CPMK-6	Melakukan triase, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan efektif untuk komplikasi nifas termasuk komplikasi sistemik.
CPMK-7	Merancang dan melaksanakan edukasi, skrining kesehatan mental, konseling KB, serta tindak lanjut continuity of care pada ibu nifas.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Komplikasi Masa Nifas: Fisiologi Nifas, Faktor Risiko, dan Keselamatan Ibu	1.1 Menguraikan parameter fisiologis nifas normal dan deviasi yang mengarah pada komplikasi.	1.2 Mengidentifikasi faktor risiko dan menerapkan prinsip keselamatan ibu pada pelayanan nifas.	CPMK-1	CPMK-2
Bab 2. Pengkajian Ibu Nifas dengan Keluhan: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Tanda Vital	2.1 Melakukan anamnesis terfokus berbasis keluhan dan red flags komplikasi nifas.	2.2 Melakukan pemeriksaan fisik dan interpretasi tanda vital untuk menentukan prioritas masalah.	CPMK-2	CPMK-1
Bab 3. Perdarahan Postpartum: Klasifikasi, Penyebab (4T), dan Tindakan Awal di Pelayanan Primer	3.1 Menentukan klasifikasi perdarahan postpartum dan menelusuri penyebab dengan pendekatan 4T.	3.2 Menyusun dan menerapkan langkah tindakan awal serta monitoring sesuai algoritme di pelayanan primer.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 4. Atonia Uteri dan Subinvolusi: Deteksi Dini, Stabilisasi, dan Indikasi Rujukan	4.1 Melakukan deteksi dini atonia uteri/subinvolusi melalui temuan klinis nifas.	4.2 Melaksanakan stabilisasi awal dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan tingkat kegawatan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6

Bab 5. Retensio Plasenta dan Sisa Plasenta: Tanda Klinis, Penanganan Awal, dan Rujukan	5.1 Mengidentifikasi tanda retensio/sisa plasenta serta risiko perdarahan dan infeksi.	5.2 Melaksanakan penanganan awal, persiapan, dan komunikasi rujukan sesuai kebutuhan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 6. Laserasi Jalan Lahir dan Hematoma: Identifikasi, Penatalaksanaan Awal, dan Rujukan	6.1 Mengidentifikasi laserasi jalan lahir/hematoma melalui inspeksi dan tanda klinis.	6.2 Menyusun tatalaksana awal, monitoring, dan keputusan rujukan berdasarkan kondisi klinis.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 7. Infeksi Masa Nifas: Endometritis, Infeksi Luka, dan Pencegahan Penyebaran	7.1 Membedakan endometritis dan infeksi luka berdasarkan gejala, faktor risiko, dan pemeriksaan.	7.2 Menerapkan tatalaksana awal serta pencegahan penyebaran (PPI) pada infeksi masa nifas.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-1
Bab 8. Sepsis Puerperalis: Tanda Bahaya, Stabilisasi Pra-Rujukan, dan Komunikasi Rujukan	8.1 Mengidentifikasi tanda bahaya sepsis puerperalis dan menilai derajat kegawatan.	8.2 Melaksanakan stabilisasi pra-rujukan dan komunikasi rujukan terstruktur kepada fasilitas rujukan.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-2
Bab 9. Gangguan Laktasi: Bendungan ASI, Puting Lecet, dan Teknik Koreksi Menyusui	9.1 Mengkaji masalah menyusui dan mengidentifikasi penyebab bendungan ASI/puting lecet.	9.2 Mendemonstrasikan koreksi teknik menyusui dan konseling perawatan payudara.	CPMK-5	CPMK-7; CPMK-2
Bab 10. Mastitis dan Abses Payudara: Tanda Klinis, Tatalaksana Awal, dan Kriteria Rujukan	10.1 Mengidentifikasi mastitis/abses payudara dan menilai tingkat keparahan serta komplikasi.	10.2 Menyusun tatalaksana awal, monitoring, dan kriteria rujukan/kolaborasi.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-6
Bab 11. Tromboemboli dan Komplikasi Sistemik Nifas: Deteksi Dini, Tanda Bahaya, dan Rujukan	11.1 Melakukan deteksi dini tromboemboli/komplikasi sistemik berdasarkan gejala, faktor risiko, dan tanda bahaya.	11.2 Melaksanakan triase, stabilisasi, dan rujukan segera disertai dokumentasi klinis.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-1

Bab 12. Gangguan Eliminasi dan Masalah Pascapersalinan Lain: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid	12.1 Mengkaji retensi urine, konstipasi, dan hemoroid serta faktor pencetus dan derajat keluhan.	12.2 Menyusun asuhan awal, edukasi self-care, dan kriteria rujukan bila terdapat tanda bahaya.	CPMK-2	CPMK-7; CPMK-1
Bab 13. Kesehatan Mental Ibu Nifas: Baby Blues, Depresi Postpartum, Risiko Bunuh Diri, dan Dukungan Keluarga	13.1 Melakukan skrining kesehatan mental nifas dan menilai risiko bunuh diri/krisis.	13.2 Menyusun dukungan awal, pelibatan keluarga, dan rujukan/kolaborasi sesuai tingkat risiko.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-1
Bab 14. Edukasi Tanda Bahaya Nifas, Dokumentasi, dan Tindak Lanjut: Kunjungan Nifas, Konseling KB, dan Continuity of Care	14.1 Melaksanakan edukasi tanda bahaya nifas, jadwal kunjungan, dan konseling KB berbasis kebutuhan.	14.2 Menyusun dokumentasi, rencana tindak lanjut, dan continuity of care termasuk rujukan balik bila diperlukan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6

Uraian Materi

A. Edukasi Tanda Bahaya Nifas

1. Pengertian

   Tanda bahaya nifas adalah kondisi abnormal yang menunjukkan adanya komplikasi pada ibu setelah persalinan dan membutuhkan penanganan segera (Triastin & Nabila, 2024)

2. Jenis Tanda Bahaya

   Beberapa tanda bahaya nifas meliputi:

   a. Perdarahan postpartum

      1) Pengertian

         Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah ≥500 ml setelah persalinan pervaginam atau ≥1000 ml setelah sectio caesarea yang terjadi dalam 24 jam pertama (primer) maupun setelah 24 jam hingga 6 minggu (sekunder). Kondisi ini merupakan penyebab utama kematian ibu di dunia karena dapat menyebabkan syok hipovolemik dalam waktu singkat apabila tidak ditangani segera (Ekowati & Herlina, 2023).

      2) Penyebab

         Penyebab utama perdarahan postpartum dikenal dengan konsep "4T" yaitu *tone* (atonia uteri), *tissue* (retensi plasenta), trauma (luka jalan lahir), dan thrombin (gangguan koagulasi). Atonia uteri merupakan penyebab paling sering, di mana uterus gagal berkontraksi setelah persalinan sehingga pembuluh darah terbuka dan menyebabkan perdarahan (WHO, 2022; Ekowati & Herlina, 2023).

      3) Tanda Gejala

         Tanda klinis yang muncul meliputi perdarahan pervaginam yang banyak dan terus-menerus, uterus lembek, pucat, takikardia, penurunan tekanan darah, serta tanda syok seperti gelisah dan penurunan kesadaran. Pada kondisi lanjut, pasien dapat mengalami syok hipovolemik yang mengancam jiwa (Say et al., 2014).

      4) Penatalaksanaan

         Penatalaksanaan dilakukan secara cepat dan terintegrasi, meliputi masase uterus untuk merangsang kontraksi, pemberian uterotonika seperti oksitosin, serta tindakan resusitasi cairan untuk menjaga stabilitas hemodinamik. Jika penyebabnya retensi plasenta atau trauma, maka dilakukan tindakan manual atau pembedahan sesuai indikasi (WHO, 2022).

b. Demam (>38°C)
   1) Pengertian
      Demam pada masa nifas adalah peningkatan suhu tubuh ≥38°C yang terjadi setelah 24 jam postpartum dan dapat menjadi indikator adanya infeksi puerperium. Kondisi ini harus segera diidentifikasi karena dapat berkembang menjadi sepsis apabila tidak ditangani (Acosta et al., 2014).
   2) Penyebab
      Demam nifas umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri pada uterus (endometritis), saluran kemih, luka episiotomi, atau mastitis. Faktor risiko meliputi persalinan lama, ketuban pecah dini, dan prosedur invasif selama persalinan (Acosta et al., 2014).
   3) Tanda Gejala
      Gejala yang menyertai meliputi menggigil, nyeri perut bawah, lochea berbau, nyeri saat berkemih, dan malaise. Pada kondisi berat dapat terjadi takikardia dan tanda infeksi sistemik (sepsis) (Bonet et al., 2017).
   4) Penatalaksanaan
      Penatalaksanaan dilakukan dengan pemberian antibiotik spektrum luas sesuai penyebab infeksi, hidrasi adekuat, serta pemantauan tanda vital. Jika terdapat sumber infeksi spesifik seperti abses, diperlukan tindakan drainase (WHO, 2015).
c. Lochea berbau busuk
   1) Pengertian
      Lochea berbau busuk adalah pengeluaran cairan dari vagina yang memiliki bau tidak normal pada masa nifas, yang mengindikasikan adanya infeksi pada uterus atau jalan lahir (endometritis) (Hussein et al., 2020).
   2) Penyebab
      Penyebab utama adalah infeksi bakteri akibat sisa plasenta, higiene yang buruk, atau prosedur persalinan yang tidak aseptik. Mikroorganisme seperti Streptococcus dan Escherichia coli sering terlibat dalam infeksi ini (Hussein et al., 2020).
   3) Tanda dan Gejala
      Selain bau tidak sedap, biasanya disertai perubahan warna lochea menjadi keruh atau kehijauan, demam, nyeri uterus, dan subinvolusi uterus. Kondisi ini dapat berkembang menjadi infeksi sistemik jika tidak ditangani (Bonet et al., 2017).

4) Penatalaksanaan

Penatalaksanaan meliputi pemberian antibiotik, edukasi kebersihan personal, serta evaluasi adanya sisa plasenta. Jika ditemukan retensi jaringan, dilakukan kuretase (WHO, 2015).

d. Nyeri abdomen hebat

1) Pengertian

Nyeri abdomen hebat pada masa nifas merupakan kondisi abnormal yang mengindikasikan adanya komplikasi seperti infeksi, perdarahan internal, atau subinvolusi uterus (Betrán et al., 2016).

2) Penyebab

Penyebab dapat berupa infeksi uterus, hematoma, ruptur uterus, atau retensi plasenta. Nyeri juga dapat berkaitan dengan gangguan gastrointestinal atau komplikasi pasca operasi (Betrán et al., 2016).

3) Tanda dan Gejala

Gejala meliputi nyeri intens pada perut bagian bawah, uterus nyeri tekan, demam, serta gangguan mobilitas. Pada kasus berat dapat disertai tanda syok atau distensi abdomen (Bonet et al., 2017).

4) Penatalaksanaan

Penatalaksanaan tergantung penyebab, meliputi pemberian analgesik, antibiotik, serta tindakan bedah jika terdapat komplikasi serius seperti hematoma atau ruptur (WHO, 2015).

e. Tromboflebitis

1) Pengertian

Tromboflebitis adalah peradangan pembuluh darah vena yang disertai pembentukan trombus, yang sering terjadi pada ekstremitas bawah pada masa nifas (Heit et al., 2016).

2) Penyebab

Kondisi ini disebabkan oleh trias Virchow yaitu stasis darah, kerusakan endotel, dan hiperkoagulabilitas yang meningkat selama kehamilan dan nifas (Heit et al., 2016).

3) Tanda dan Gejala

Gejala berupa nyeri pada tungkai, kemerahan, bengkak, serta rasa hangat pada area vena yang terkena. Pada kondisi berat dapat terjadi emboli paru yang mengancam jiwa (James, 2018).

4) Penatalaksanaan

Penatalaksanaan meliputi pemberian antikoagulan, mobilisasi dini, serta kompres hangat. Pencegahan sangat penting dengan mendorong ibu untuk bergerak aktif setelah persalinan (James, 2018).

f. Depresi postpartum

1) Pengertian

Depresi postpartum adalah gangguan mood yang terjadi setelah persalinan yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan gangguan fungsi sehari-hari (O'Hara & McCabe, 2013).

2) Penyebab

Penyebab melibatkan faktor hormonal, psikologis, dan sosial seperti kurangnya dukungan keluarga, stres, serta riwayat gangguan mental sebelumnya (O'Hara & McCabe, 2013).

3) Tanda dan Gejala

Gejala meliputi perasaan sedih, mudah menangis, kelelahan, gangguan tidur, serta perasaan tidak mampu merawat bayi. Pada kasus berat dapat muncul pikiran menyakiti diri sendiri atau bayi (Stewart & Vigod, 2016).

4) Penatalaksanaan

Penatalaksanaan mencakup terapi psikologis, dukungan sosial, serta terapi farmakologis jika diperlukan. Deteksi dini melalui skrining sangat penting untuk mencegah komplikasi (Stewart & Vigod, 2016).

g. Pusing dan lemah berlebihan

1) Pengertian

Pusing dan lemah berlebihan pada masa nifas merupakan kondisi yang dapat mengindikasikan anemia, kelelahan, atau komplikasi serius seperti perdarahan postpartum (Milman, 2011).

2) Penyebab

Penyebab utama adalah anemia akibat kehilangan darah saat persalinan, kekurangan zat besi, serta kurang istirahat. Faktor lain termasuk dehidrasi dan infeksi (Milman, 2011).

3) Tanda dan Gejala

Gejala meliputi pusing, lemah, pucat, sesak napas ringan, serta penurunan konsentrasi. Pada anemia berat dapat terjadi sinkop dan takikardia (Milman, 2011).

4) Penatalaksanaan

Penatalaksanaan meliputi pemberian suplemen zat besi, nutrisi adekuat, istirahat cukup, serta penanganan penyebab dasar seperti perdarahan atau infeksi (WHO, 2016).

3. Pentingnya Edukasi

Kurangnya pengetahuan ibu tentang tanda bahaya masa nifas merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan medis. Ketidaktahuan ini

sering menyebabkan ibu menganggap kondisi yang dialami sebagai hal yang normal, sehingga penanganan terhadap komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan psikologis menjadi terlambat. Keterlambatan ini termasuk dalam "three delays" (terlambat mengenali masalah, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan pelayanan), yang secara signifikan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan ibu nifas menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan komplikasi yang lebih serius (Argaheni & Zubaidah, 2021).

Edukasi kesehatan yang diberikan secara tepat dan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan pemahaman ibu mengenai tanda bahaya nifas serta mendorong perilaku pencarian pertolongan yang lebih cepat dan tepat. Penggunaan media edukasi seperti leaflet, video, maupun media audiovisual lainnya memberikan stimulus visual dan auditori yang dapat memperkuat daya ingat dan pemahaman ibu. Media tersebut juga memungkinkan penyampaian informasi yang lebih menarik, mudah dipahami, dan dapat diakses kembali oleh ibu di rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukasi menggunakan media ini secara signifikan meningkatkan tingkat pengetahuan ibu nifas dibandingkan metode konvensional, sehingga sangat direkomendasikan dalam praktik kebidanan untuk mendukung keselamatan ibu pada masa nifas (Masini et al., 2024).

B. Dokumentasi

1. Pengertian

   Dokumentasi dalam asuhan kebidanan merupakan proses pencatatan yang sistematis, lengkap, dan akurat terhadap seluruh tindakan yang diberikan kepada pasien, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses asuhan kebidanan yang mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan. Pencatatan yang baik harus dilakukan secara berkesinambungan, objektif, dan sesuai dengan standar praktik kebidanan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis serta menjamin keselamatan pasien (Fitriani et al., 2021; Kunang & Puspariny, 2020).

2. Tujuan

   a. Sebagai bukti hukum

      Dokumentasi berfungsi sebagai bukti hukum yang dapat melindungi tenaga kesehatan apabila terjadi tuntutan atau masalah etik dan legal, karena seluruh tindakan yang dilakukan telah tercatat secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Media komunikasi tenaga Kesehatan

   Dokumentasi menjadi media komunikasi antar tenaga kesehatan, sehingga memudahkan koordinasi dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan, terutama ketika pasien ditangani oleh lebih dari satu tenaga Kesehatan.

c. Evaluasi pelayanan

   Dokumentasi berperan sebagai alat evaluasi pelayanan, karena melalui catatan yang lengkap, tenaga kesehatan dapat menilai efektivitas tindakan yang telah dilakukan serta merencanakan tindak lanjut yang lebih tepat.

3. Metode Dokumentasi (SOAP)

a. S (Subjective): Keluhan ibu

   Pada bagian Subjective, tenaga kesehatan mencatat semua keluhan yang disampaikan oleh ibu, termasuk perasaan, pengalaman, dan riwayat yang relevan.

b. O (Objective): Pemeriksaan fisik

   Bagian Objective berisi hasil pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, serta temuan klinis yang diperoleh melalui observasi dan pemeriksaan penunjang

c. A (Assessment): Diagnosa

   Bagian Assessment, tenaga kesehatan merumuskan diagnosis atau masalah berdasarkan data subjektif dan objektif yang telah dikumpulkan

d. P (Planning): Rencana Tindakan

   Bagian Planning mencakup rencana tindakan yang akan dilakukan, termasuk intervensi, edukasi, serta tindak lanjut yang diperlukan.

Penggunaan metode SOAP terbukti membantu meningkatkan kejelasan dokumentasi, mempermudah komunikasi antar tenaga kesehatan, serta mendukung kesinambungan pelayanan sehingga asuhan yang diberikan menjadi lebih efektif dan terarah (Fitriani et al., 2021; Kunang & Puspariny, 2020).

C. Tindak Lanjut Kunjungan Nifas

1. Jadwal Kunjungan

   Kunjungan nifas minimal dilakukan:

a. 6–48 jam postpartum

   Kunjungan pertama dilakukan pada 6–48 jam postpartum, yang merupakan periode paling kritis karena risiko perdarahan postpartum dan komplikasi akut lainnya sangat tinggi. Pada fase ini, tenaga kesehatan berfokus pada pemantauan tanda vital, kontraksi uterus, serta kondisi umum ibu untuk memastikan tidak terjadi komplikasi yang mengancam jiwa (WHO, 2022; Kemenkes RI, 2020).

b. 3–7 hari

Kunjungan kedua dilakukan pada 3–7 hari postpartum, di mana ibu mulai memasuki fase adaptasi terhadap perubahan fisiologis dan psikologis. Pada periode ini, tenaga kesehatan melakukan evaluasi terhadap proses involusi uterus, kondisi luka perineum, serta tanda-tanda infeksi. Selain itu, fase ini juga penting untuk menilai keberhasilan pemberian ASI dan memberikan dukungan laktasi kepada ibu (Titaley et al., 2019).

c. 8–28 hari

Kunjungan ketiga dilakukan pada 8–28 hari postpartum, yang bertujuan untuk memantau proses pemulihan organ reproduksi serta memastikan tidak ada komplikasi lanjutan. Pada tahap ini, ibu juga mulai beradaptasi dengan peran barunya sehingga dukungan psikososial menjadi sangat penting. Tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa ibu tidak mengalami gangguan seperti depresi postpartum serta memberikan edukasi terkait perawatan bayi dan kesehatan diri (WHO, 2015).

d. 29–42 hari

Kunjungan terakhir dilakukan pada 29–42 hari postpartum, yang merupakan akhir dari masa nifas. Pada periode ini dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemulihan ibu, termasuk kembalinya fungsi organ reproduksi, status kesehatan umum, serta kesiapan ibu dalam menggunakan metode kontrasepsi. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan konseling keluarga berencana guna mencegah kehamilan yang terlalu dekat (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2015).

2. Tujuan

a. Deteksi dini komplikasi

Salah satu tujuan utama kunjungan nifas adalah melakukan deteksi dini terhadap komplikasi yang dapat terjadi setelah persalinan, seperti perdarahan, infeksi, dan gangguan tromboemboli. Deteksi dini memungkinkan tenaga kesehatan untuk segera memberikan intervensi yang tepat sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius. Tanpa pemantauan yang teratur, banyak komplikasi nifas tidak teridentifikasi hingga mencapai tahap yang membahayakan jiwa ibu (Say et al., 2014).

b. Evaluasi involusi uterus

Kunjungan nifas juga bertujuan untuk mengevaluasi proses involusi uterus, yaitu kembalinya ukuran dan kondisi uterus seperti sebelum hamil. Proses ini harus berlangsung secara normal dan bertahap, sehingga pemantauan tinggi fundus uteri, konsistensi uterus, serta pengeluaran lochea menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan involusi. Gangguan pada proses ini dapat

mengindikasikan adanya infeksi atau retensi plasenta yang memerlukan penanganan lebih lanjut (WHO, 2015).

c. Pemantauan laktasi

Pemantauan laktasi menjadi aspek penting dalam kunjungan nifas karena keberhasilan pemberian ASI sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa ibu mampu menyusui dengan teknik yang benar, produksi ASI mencukupi, serta tidak terdapat masalah seperti mastitis atau puting lecet. Dukungan yang diberikan selama kunjungan nifas terbukti meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Victora et al., 2016).

d. Edukasi Kesehatan

Kunjungan nifas juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan bagi ibu dan keluarga, meliputi perawatan diri, perawatan bayi, tanda bahaya nifas, serta pentingnya penggunaan kontrasepsi. Edukasi yang diberikan secara berulang pada setiap kunjungan akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatannya. Hal ini berkontribusi dalam menurunkan angka komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi (Masini et al., 2024).

Secara keseluruhan, kunjungan nifas memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka komplikasi dan kematian ibu, mengingat periode postpartum merupakan fase dengan risiko tinggi yang membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan dan komprehensif (Masini et al., 2024).

D. Konseling KB

1. Pengertian

Konseling keluarga berencana (KB) merupakan suatu proses komunikasi interpersonal yang dilakukan antara tenaga kesehatan dan klien, baik individu maupun pasangan, dengan tujuan membantu klien memahami berbagai pilihan metode kontrasepsi serta menentukan metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, dan preferensinya. Konseling tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga melibatkan proses edukasi, klarifikasi nilai, serta pengambilan keputusan secara sadar dan sukarela (informed choice). Dalam konteks pelayanan kebidanan, konseling KB postpartum menjadi sangat penting karena dilakukan pada masa transisi setelah persalinan, di mana ibu berada pada kondisi yang lebih terbuka untuk menerima informasi terkait perencanaan kehamilan berikutnya (WHO, 2018; Ekowati & Herlina, 2023).

2. Tujuan
    a. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan

       Salah satu tujuan utama konseling KB adalah mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, maupun sosial ibu. Kehamilan yang tidak direncanakan seringkali terjadi karena kurangnya pengetahuan atau akses terhadap metode kontrasepsi yang tepat. Melalui konseling yang efektif, tenaga kesehatan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai berbagai metode KB sehingga klien dapat memilih metode yang sesuai dan menggunakannya secara konsisten. Hal ini berkontribusi dalam menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga (Cleland et al., 2012).
    b. Menjaga kesehatan ibu

       Konseling KB juga bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dengan cara menghindari kehamilan yang terlalu sering atau pada kondisi kesehatan yang belum optimal. Masa nifas merupakan periode pemulihan tubuh setelah persalinan, sehingga kehamilan yang terjadi terlalu cepat dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti anemia, perdarahan, dan gangguan nutrisi. Dengan penggunaan kontrasepsi yang tepat, ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi fisiknya sebelum merencanakan kehamilan berikutnya (WHO, 2018).
    c. Mengatur jarak kehamilan

       Pengaturan jarak kehamilan merupakan aspek penting dalam kesehatan reproduksi. Jarak kehamilan yang ideal, yaitu minimal 24 bulan setelah persalinan, terbukti dapat menurunkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi, seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian neonatal. Konseling KB memberikan pemahaman kepada ibu mengenai pentingnya perencanaan kehamilan serta membantu memilih metode kontrasepsi yang efektif untuk mencapai jarak kehamilan yang aman (Conde-Agudelo et al., 2012).
3. Metode KB Postpartum
    a. Amenore laktasi (MAL)

       Metode amenore laktasi (MAL) merupakan metode kontrasepsi alami yang mengandalkan pemberian ASI eksklusif sebagai penekan ovulasi. Metode ini efektif digunakan selama enam bulan pertama postpartum dengan syarat ibu belum mengalami menstruasi dan memberikan ASI secara eksklusif. MAL menjadi pilihan yang aman karena tidak menggunakan hormon tambahan,

namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan ibu dalam menyusui secara teratur (WHO, 2015).

b. Pil KB

Pil KB merupakan metode kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen dan progesteron atau hanya progesteron. Pada ibu menyusui, pil yang direkomendasikan adalah pil progestin (mini pill) karena tidak memengaruhi produksi ASI. Pil KB bekerja dengan cara menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks sehingga mencegah sperma bertemu dengan ovum. Penggunaan pil memerlukan kepatuhan tinggi karena harus dikonsumsi secara rutin setiap hari untuk menjaga efektivitasnya (CDC, 2016).

c. Suntik

Kontrasepsi suntik merupakan metode hormonal yang diberikan secara intramuskular dalam interval tertentu, biasanya setiap 1 atau 3 bulan. Metode ini bekerja dengan menghambat ovulasi dan memberikan perlindungan jangka menengah terhadap kehamilan. Suntik KB menjadi pilihan populer karena praktis dan tidak memerlukan konsumsi harian, namun dapat memiliki efek samping seperti perubahan pola menstruasi (WHO, 2015).

d. IUD

IUD adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang dipasang di dalam rahim dan dapat bertahan hingga 5–10 tahun tergantung jenisnya. IUD bekerja dengan mencegah fertilisasi melalui perubahan lingkungan uterus yang tidak mendukung kehidupan sperma dan ovum. Metode ini sangat efektif, reversibel, dan aman digunakan pada ibu postpartum, bahkan dapat dipasang segera setelah persalinan apabila tidak terdapat kontraindikasi (WHO, 2015).

e. Implan

Implan merupakan metode kontrasepsi jangka panjang berbentuk batang kecil yang ditanam di bawah kulit lengan atas dan mengandung hormon progestin. Implan bekerja dengan menghambat ovulasi serta mengentalkan lendir serviks. Metode ini memiliki efektivitas tinggi hingga 3–5 tahun dan cocok bagi ibu yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang tanpa perlu pemeliharaan rutin (CDC, 2016).

Edukasi mengenai KB setelah masa nifas sangat penting untuk mencegah kehamilan yang terlalu dekat, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi baik bagi ibu maupun bayi. Dengan konseling yang tepat dan komprehensif, ibu dapat memahami pilihan kontrasepsi yang tersedia serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya, sehingga mendukung terciptanya kesehatan reproduksi yang optimal (Ekowati & Herlina, 2023).

E. Continuity of Care

1. Pengertian

   Continuity of care merupakan suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkesinambungan dan terintegrasi kepada perempuan mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan keluarga berencana. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang berkelanjutan antara tenaga kesehatan dan klien, sehingga setiap tahap pelayanan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu rangkaian asuhan yang komprehensif. Dengan *continuity of care*, tenaga kesehatan dapat memahami riwayat kesehatan ibu secara menyeluruh, termasuk faktor risiko yang mungkin memengaruhi kondisi selama kehamilan hingga masa nifas, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat dan individual (WHO, 2016; Listiyorini & Budiasri, 2022).

   Pendekatan ini juga berorientasi pada *patient-centered care*, di mana kebutuhan, preferensi, dan kondisi ibu menjadi dasar dalam pemberian pelayanan. Dengan adanya kesinambungan asuhan, ibu akan merasa lebih nyaman dan percaya terhadap tenaga kesehatan karena adanya hubungan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting dalam pelayanan kebidanan karena kondisi ibu dapat berubah secara dinamis sepanjang siklus reproduksi (Sandall et al., 2016).

2. Manfaat

   a. Meningkatkan kualitas pelayanan

      Continuity of care berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan karena memungkinkan tenaga kesehatan memberikan asuhan yang lebih komprehensif, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Informasi mengenai kondisi ibu terdokumentasi dengan baik dari satu tahap ke tahap berikutnya, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan atau kehilangan informasi penting. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung penerapan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) karena keputusan klinis didasarkan pada riwayat dan kondisi aktual pasien secara menyeluruh (Sandall et al., 2016).

   b. Menurunkan risiko komplikasi

      Pelayanan yang berkesinambungan memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan yang mungkin timbul selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Dengan pemantauan yang terus-menerus, tenaga kesehatan dapat segera mengidentifikasi tanda bahaya dan memberikan intervensi yang tepat sebelum kondisi berkembang menjadi komplikasi serius. Hal ini terbukti dapat menurunkan angka morbiditas dan

mortalitas ibu serta bayi, karena penanganan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran (WHO, 2016).

c. Meningkatkan kepuasan pasien

Continuity of care juga memberikan dampak positif terhadap kepuasan pasien, karena ibu merasa mendapatkan perhatian yang lebih personal dan berkelanjutan. Hubungan yang terjalin antara ibu dan tenaga kesehatan menciptakan rasa percaya, kenyamanan, serta meningkatkan keterbukaan ibu dalam menyampaikan keluhan atau masalah yang dihadapi. Kepuasan ini tidak hanya berdampak pada pengalaman pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan ibu terhadap anjuran kesehatan, termasuk kunjungan ulang, penggunaan kontrasepsi, dan perawatan bayi (Listiyorini & Budiasri, 2022).

Pendekatan *continuity of care* memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan ibu secara menyeluruh dan berkelanjutan, karena setiap tahap pelayanan saling terhubung dan terpantau secara sistematis. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan serta menurunkan angka komplikasi pada ibu dan bayi (Listiyorini & Budiasri, 2022).

3. Prinsip Continuity of Care

Pelaksanaan *continuity of care* dalam pelayanan kebidanan didasarkan pada beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas asuhan. Prinsip pertama adalah asuhan berkesinambungan (*continuity*), yaitu pelayanan yang diberikan secara terus-menerus tanpa terputus sejak masa kehamilan hingga masa nifas dan keluarga berencana. Prinsip ini memastikan bahwa setiap perubahan kondisi ibu dapat terpantau dengan baik. Prinsip kedua adalah komprehensif, di mana pelayanan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sehingga kebutuhan ibu terpenuhi secara menyeluruh. Prinsip ketiga adalah terintegrasi, yaitu adanya koordinasi antar tenaga kesehatan maupun antar fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin kesinambungan informasi dan tindakan. Selain itu, terdapat prinsip berpusat pada klien (woman-centered care), yang menempatkan ibu sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya (WHO, 2016; Renfrew et al., 2014).

Prinsip lainnya adalah *evidence-based practice*, yaitu setiap tindakan yang dilakukan didasarkan pada bukti ilmiah terkini sehingga dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas pelayanan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, continuity of care tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik kebidanan untuk meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi (Renfrew et al., 2014).

4. Komponen *Continuity of Care* dalam Kebidanan

   Continuity of care dalam kebidanan terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah asuhan antenatal (kehamilan), yang meliputi pemeriksaan rutin, deteksi faktor risiko, serta edukasi kesehatan selama kehamilan. Pada tahap ini, tenaga kesehatan mulai membangun hubungan terapeutik dengan ibu serta mengidentifikasi kebutuhan individu yang akan menjadi dasar asuhan selanjutnya.

   Komponen kedua adalah asuhan intranatal (persalinan), yaitu pendampingan selama proses persalinan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Dalam *continuity of care*, tenaga kesehatan yang sama atau tim yang terkoordinasi akan memberikan pelayanan sehingga riwayat kehamilan ibu dapat dipahami secara utuh dan keputusan klinis dapat diambil secara cepat dan tepat.

   Komponen ketiga adalah asuhan postnatal (nifas), yang berfokus pada pemulihan kondisi ibu, pemantauan bayi baru lahir, serta deteksi dini komplikasi. Pada tahap ini juga dilakukan edukasi mengenai perawatan bayi, pemberian ASI, serta tanda bahaya nifas.

   Komponen terakhir adalah pelayanan keluarga berencana (KB), yang bertujuan membantu ibu merencanakan kehamilan berikutnya secara aman dan sehat. Keempat komponen ini membentuk suatu siklus pelayanan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan, sehingga memberikan manfaat optimal bagi kesehatan ibu dan bayi (WHO, 2016; Kerber et al., 2007).

5. Peran Tenaga Kesehatan dalam *Continuity of Care*

   Tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran sentral dalam pelaksanaan *continuity of care*. Bidan bertindak sebagai pemberi asuhan utama yang tidak hanya memberikan pelayanan klinis, tetapi juga edukasi, dukungan emosional, serta advokasi bagi ibu dan keluarganya. Dalam praktiknya, bidan harus mampu melakukan komunikasi efektif, membangun hubungan saling percaya, serta memahami kebutuhan unik setiap ibu.

   Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan lain apabila ditemukan komplikasi yang memerlukan rujukan. Sistem rujukan yang efektif merupakan bagian penting dari *continuity of care* untuk memastikan bahwa ibu mendapatkan penanganan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dengan demikian, peran tenaga kesehatan tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan langsung, tetapi juga mencakup pengelolaan sistem pelayanan secara menyeluruh (Sandall et al., 2016).

6. Implementasi *Continuity of Care* dalam Praktik Kebidanan

   Implementasi *continuity of care* dalam praktik kebidanan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, salah satunya adalah model *midwife-led continuity*

care, di mana seorang bidan atau tim kecil bidan memberikan pelayanan secara berkelanjutan kepada ibu sejak kehamilan hingga postpartum. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan intervensi medis yang tidak perlu.

Selain itu, penggunaan rekam medis terintegrasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung continuity of care, karena memungkinkan informasi pasien dapat diakses secara lengkap oleh tenaga kesehatan yang terlibat. Edukasi yang konsisten pada setiap kunjungan juga menjadi bagian dari implementasi, sehingga ibu mendapatkan informasi yang berulang dan berkesinambungan.

Di sisi lain, keterlibatan keluarga juga menjadi faktor pendukung keberhasilan continuity of care, karena keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan serta memberikan dukungan selama proses kehamilan hingga nifas. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, *continuity of care* dapat diterapkan secara optimal dalam pelayanan kebidanan (WHO, 2016; Sandall et al., 2016).

7. Tantangan dalam Penerapan Continuity of Care

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan *continuity of care* masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan, terutama di daerah dengan akses pelayanan yang terbatas. Selain itu, sistem pelayanan kesehatan yang belum terintegrasi secara optimal dapat menyebabkan terputusnya alur informasi antar fasilitas kesehatan.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah rendahnya kesadaran ibu untuk melakukan kunjungan secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi, penguatan sistem rujukan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah untuk memastikan *continuity of care* dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Kerber et al., 2007).

Secara keseluruhan, *continuity of care* merupakan pendekatan yang sangat penting dalam pelayanan kebidanan karena mampu mengintegrasikan seluruh tahapan asuhan dalam satu sistem yang berkesinambungan. Dengan penerapan yang optimal, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi.

F. Aktivitas 1: Knows How (Mini-Case Tertulis / Diskusi Kelompok)

1. Seorang ibu, usia 28 tahun, P2A0, hari ke-5 postpartum datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 2 hari terakhir, lochea berbau tidak sedap, serta merasa lemah. Ibu mengatakan belum pernah mendapatkan edukasi tentang tanda bahaya nifas. Bayi disusui, tetapi ibu mengeluhkan ASI sedikit. Riwayat persalinan normal di bidan praktik mandiri.

Tugas Mahasiswa (Diskusi Kelompok)

Mahasiswa diminta mendiskusikan kasus dan menjawab pertanyaan berikut:

1. Identifikasi masalah utama pada kasus di atas
   Jelaskan kondisi ibu berdasarkan tanda dan gejala yang muncul.
2. Analisis tanda bahaya nifas yang dialami ibu
   Kaitkan dengan kemungkinan diagnosis.
3. Rencana edukasi yang harus diberikan kepada ibu
   Jelaskan poin-poin edukasi yang relevan.
4. Rencana tindak lanjut kunjungan nifas
   Tentukan tindakan monitoring dan evaluasi yang diperlukan.
5. Rencana konseling KB postpartum
   Metode apa yang sesuai untuk ibu? Jelaskan alasan pemilihan.
6. Penerapan continuity of care pada kasus ini
   Jelaskan bagaimana kesinambungan pelayanan dapat dilakukan.
7. Buat contoh dokumentasi SOAP berdasarkan kasus

Output yang Diharapkan

1. Laporan diskusi kelompok
2. Presentasi hasil analisis kasus
3. Dokumentasi SOAP tertulis

Penilaian (OBE)

1. Ketepatan analisis masalah
2. Kesesuaian rencana asuhan
3. Kemampuan berpikir kritis
4. Kerjasama tim

G. Aktivitas 2: Shows How (Simulasi / Skill Lab)

Judul: Simulasi Asuhan Nifas Komprehensif

Tujuan: Mahasiswa mampu mempraktikkan secara langsung (Edukasi tanda bahaya nifas, dokumentasi SOAP, pemeriksaan nifas, konseling KB, penerapan *continuity of care*)

Skenario Simulasi

Mahasiswa berperan sebagai bidan yang melakukan kunjungan nifas hari ke-7 pada seorang ibu postpartum. Pasien simulasi mengeluhkan:

1. Nyeri perut ringan
2. ASI belum lancar
3. Belum mengetahui tanda bahaya nifas
4. Belum memilih KB

Langkah Kegiatan

1. Pengkajian
   a. Anamnesis (keluhan, riwayat persalinan)
   b. Pemeriksaan umum dan tanda vital
   c. Pemeriksaan uterus dan lochea
2. Identifikasi Masalah
   Tentukan kondisi normal/abnormal
3. Edukasi
   a. Tanda bahaya nifas
   b. Perawatan diri dan bayi
   c. Laktasi
4. Konseling KB
   a. Jelaskan pilihan metode
   b. Bantu pasien memilih (informed choice)
5. Dokumentasi
   Catat hasil asuhan dalam format SOAP
6. Penutup
   a. Rencana kunjungan ulang
   b. Evaluasi pemahaman pasien

Alat dan Media

1. Phantom / manekin
2. Leaflet edukasi nifas
3. Format SOAP
4. Alat pemeriksaan (tensimeter, termometer)

Penilaian (Checklist OSCE)

Mahasiswa dinilai berdasarkan:

1. Keterampilan komunikasi
2. Ketepatan pemeriksaan
3. Kemampuan edukasi
4. Ketepatan konseling KB
5. Kelengkapan dokumentasi
6. Penerapan continuity of care

Kriteria Kelulusan

1. ≥ 75% checklist terpenuhi → Kompeten
2. < 75% → Perlu latihan ulang

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	**No. Stasiun**	Stasiun 1
2	**Judul**	Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Konseling KB
3	**Kasus**	Seorang ibu usia 27 tahun, P1A0, hari ke-7 postpartum datang untuk kunjungan nifas. Ibu mengeluh ASI belum lancar dan merasa lelah. Ibu belum mengetahui tanda bahaya nifas dan belum memilih metode KB.
4	**Tujuan**	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan asuhan nifas meliputi pengkajian, edukasi tanda bahaya, konseling KB, serta dokumentasi SOAP
5	**Kompetensi**	1. Melakukan pengkajian nifas 2. Memberikan edukasi tanda bahaya nifas 3. Melakukan konseling KB postpartum 4. Melakukan dokumentasi SOAP 5. Menerapkan continuity of care
6	**Soal: Skenario dan tugas peserta ujian**	**SKENARIO KLINIK** Anda adalah seorang bidan yang melakukan kunjungan nifas hari ke-7 di puskesmas. Pasien mengeluhkan ASI kurang lancar dan belum mengetahui tanda bahaya nifas. Anda diminta memberikan asuhan yang sesuai. **TUGAS** 1. Lakukan pengkajian singkat pada pasien 2. Identifikasi masalah yang dialami pasien 3. Berikan edukasi tanda bahaya nifas 4. Lakukan konseling KB postpartum 5. Jelaskan rencana tindak lanjut kunjungan nifas 6. Sampaikan dokumentasi SOAP secara lisan
7	**Instruksi penguji**	**INSTRUKSI UMUM** 1. Amati keterampilan peserta tanpa intervensi

		2. Gunakan checklist penilaian yang tersedia **INSTRUKSI KHUSUS** 1. Nilai kemampuan komunikasi terapeutik peserta 2. Nilai ketepatan edukasi tanda bahaya nifas 3. Nilai ketepatan pemilihan metode KB 4. Nilai sistematika dokumentasi SOAP **INSTRUKSI TAMBAHAN** 1. Berikan pertanyaan klarifikasi bila diperlukan sesuai skenario
8	**Kebutuhan dan instruksi PS (Pasien Simulasi)**	**Instruksi PS:** 1. Berperan sebagai ibu nifas hari ke-7 2. Mengeluh ASI sedikit dan merasa Lelah 3. Tidak mengetahui tanda bahaya nifas 4. Menanyakan metode KB yang aman saat menyusui
9	**Dialog PS**	**Peserta:** "Apa keluhan ibu saat ini?" **PS:** "ASI saya masih sedikit dan saya sering merasa lemas." **Peserta:** "Apakah ibu tahu tanda bahaya setelah melahirkan?" **PS:** "Belum tahu, Bu." **Catatan:** PS menjawab sesuai instruksi, tidak menambahkan informasi jika tidak ditanya
10	**Kebutuhan manikin**	-
11	**Kebutuhan laboran**	**Peran laboran:** 1. Menyiapkan alat dan ruangan 2. Mengatur waktu stasiun (±10–15 menit)
12	**Kebutuhan alat**	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Tensimeter — 1 3. Termometer — 1 4. Stetoskop — 1 5. Leaflet edukasi nifas — 1 6. Format SOAP — 1
13	**Penulis**	.....
14	**Referensi**	1. Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Nifas*. Jakarta: Kemenkes RI. 2. World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. Geneva: WHO.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase: Asuhan Kebidanan Masa Nifas Komprehensif

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Keluhan utama ibu nifas		
2. Riwayat persalinan (jenis persalinan, komplikasi)		
3. Riwayat masa nifas saat ini (perdarahan, lochea, nyeri, demam)		
4. Riwayat menyusui/laktasi (ASI lancar/tidak)		
5. Riwayat eliminasi (BAK/BAB)		
6. Riwayat istirahat dan aktivitas		
7. Riwayat kesehatan (penyakit, alergi, obat)		
8. Pengetahuan ibu tentang tanda bahaya nifas dan KB		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta melakukan semua 8 langkah dengan benar
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 langkah dengan benar
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 langkah dengan benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis dan Asuhan

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Persiapan		
a. Menyapa dan memperkenalkan diri		
b. Menjelaskan tujuan tindakan		
c. Informed consent		
d. Menjaga privasi		
e. Hand hygiene		
f. Menyiapkan alat		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum		
b. Mengukur tanda vital		
c. Menilai involusi uterus		
d. Menilai lochea		
e. Menilai tanda bahaya nifas		
f. Menilai laktasi		
g. Mengidentifikasi masalah		
h. Menentukan diagnosis/assessment		
i. Menentukan rencana tindak lanjut kunjungan		
j. Menentukan kebutuhan rujukan bila ada		
k. Melakukan edukasi kesehatan		
l. Melakukan konseling KB postpartum		
m. Mengaitkan dengan continuity of care		
3. Dokumentasi		

a. Menuliskan S (Subjective)		
b. Menuliskan O (Objective)		
c. Menuliskan A (Assessment)		
d. Menuliskan P (Planning)		
4. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil kepada pasien		
b. Menyampaikan rencana tindak lanjut		
c. Menutup dengan baik		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika melakukan 18–23 langkah dengan tepat dan sistematis
- 2= Jika melakukan 12–17 langkah dengan cukup tepat
- 1= Jika melakukan 1–11 langkah atau banyak kesalahan
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 3. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) & Konseling

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi ibu dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tanda bahaya nifas		
4. Memberikan edukasi perawatan nifas dan laktasi		
5. Memberikan konseling KB (pilihan, manfaat, efek samping)		
6. Membantu pengambilan keputusan (informed choice)		
7. Memberi kesempatan bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika melakukan semua 7 langkah dengan benar
- 2= Jika melakukan 5–6 langkah
- 1= Jika melakukan 1–4 langkah
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Sistematis dan terstruktur		
2. Menjaga privasi dan kenyamanan pasien		
3. Empati dan komunikasi terapeutik		
4. Percaya diri		
5. Suara jelas dan informatif		
6. Menghargai pasien dan keluarga		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika melakukan semua 6 langkah dengan benar
- 2= Jika melakukan 4–5 langkah
- 1= Jika melakukan 1–3 langkah

- 0= Tidak melakukan

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = (K1 + K2 + K3 + K4) / 4

GLOBAL PERFORMANCE

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Perhitungan Nilai Akhir

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{12} \times 100 =$$

(Kota), ...

Penguji: .....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Kebidanan Masa Nifas Komprehensif (Edukasi Tanda Bahaya, Dokumentasi, Kunjungan Nifas, Konseling KB, dan Continuity of Care)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Metode penilaian	Penilaian dilakukan melalui observasi langsung oleh pembimbing terhadap keterampilan klinis mahasiswa saat memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas di setting nyata atau simulasi.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan kunjungan nifas hari ke-7 di ruang praktik/skill lab.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif meliputi pengkajian, edukasi, tindakan, dokumentasi, konseling KB, dan penerapan continuity of care.	Mahasiswa mampu memberikan asuhan yang tepat pada ibu nifas serta melakukan edukasi dan tindak lanjut yang sesuai.
Kasus klinik	Kasus yang digunakan berupa kondisi ibu nifas dengan atau tanpa komplikasi ringan yang membutuhkan edukasi dan pemantauan lanjutan.	Ibu usia 26 tahun, hari ke-7 postpartum, mengeluh ASI belum lancar, belum mengetahui tanda bahaya nifas, dan belum memilih metode KB.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama interaksi dengan pasien dari awal hingga akhir pelayanan.	Mahasiswa melakukan anamnesis, pemeriksaan, edukasi tanda bahaya nifas, konseling KB, dan dokumentasi SOAP.
Aspek yang dinilai	1. Pengumpulan data subjektif dan objektif 2. Keterampilan pemeriksaan nifas 3. Kemampuan identifikasi masalah dan diagnosis 4. Edukasi tanda bahaya nifas 5. Konseling KB postpartum 6. Dokumentasi SOAP 7. Penerapan continuity of care 8. Komunikasi dan profesionalisme	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kondisi normal/abnormal, memberikan edukasi yang tepat, serta menyusun rencana tindak lanjut kunjungan nifas.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai ketepatan langkah klinis, sistematika tindakan, komunikasi terapeutik, serta kemampuan pengambilan keputusan klinis mahasiswa.	Pembimbing fokus pada cara mahasiswa menjelaskan tanda bahaya nifas, memilih metode KB yang sesuai, dan melakukan dokumentasi yang benar.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai, mencakup kelebihan, kekurangan, dan saran perbaikan.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, namun perlu

		meningkatkan ketepatan dalam dokumentasi SOAP.
Keputusan penilaian	Hasil penilaian dikategorikan menjadi kompeten, borderline, atau belum kompeten berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan ≥75% prosedur dengan benar dan sistematis.
Makna dalam OBE	DOPS mendukung pencapaian *Outcome-Based Education* dengan menilai kemampuan nyata mahasiswa dalam praktik klinis secara langsung dan terukur.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menunjukkan keterampilan klinis dalam asuhan nifas secara komprehensif.

PORTOFOLIO PEMBELAJARAN

Topik: Edukasi Tanda Bahaya Nifas, Dokumentasi, Tindak Lanjut Kunjungan Nifas, Konseling KB, dan Continuity of Care

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Nifas Komprehensif
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti autentik yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan melalui berbagai aktivitas pembelajaran klinik. Portofolio tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar mahasiswa.	Mahasiswa mengumpulkan bukti praktik asuhan nifas mulai dari pengkajian, edukasi, hingga konseling KB pada beberapa pasien selama praktik klinik.
Tujuan portofolio	Untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif, meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif, serta memastikan mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan secara nyata dan berkesinambungan.	Mahasiswa dinilai tidak hanya memahami teori nifas, tetapi juga mampu memberikan edukasi tanda bahaya, melakukan dokumentasi SOAP, dan konseling KB secara tepat.
OSCE dan DOPS	OSCE digunakan untuk menilai keterampilan dalam setting simulasi, sedangkan DOPS menilai keterampilan dalam praktik langsung. Keduanya menjadi bukti utama keterampilan klinis mahasiswa.	Hasil OSCE menunjukkan mahasiswa mampu melakukan edukasi nifas dan konseling KB, sedangkan DOPS menunjukkan kemampuan tersebut diterapkan pada pasien nyata.
Catatan kasus singkat	Catatan ringkas mengenai kasus pasien yang ditangani mahasiswa, mencakup identitas singkat, masalah utama, tindakan yang dilakukan, dan hasil.	Kasus ibu nifas hari ke-7 dengan keluhan ASI kurang lancar. Mahasiswa melakukan edukasi laktasi, tanda bahaya nifas, serta merencanakan kunjungan ulang.
Refleksi patient safety	Refleksi mahasiswa mengenai aspek keselamatan pasien, termasuk identifikasi risiko, tindakan	Mahasiswa menyadari pentingnya edukasi tanda bahaya nifas untuk mencegah

	pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh.	keterlambatan penanganan komplikasi seperti infeksi atau perdarahan.
Feedback CI/dosen	Masukan dari Clinical Instructor (CI) atau dosen pembimbing mengenai performa mahasiswa selama praktik. Feedback bersifat konstruktif untuk meningkatkan kompetensi.	CI memberikan saran agar mahasiswa lebih sistematis dalam dokumentasi SOAP dan lebih percaya diri saat konseling KB.
Karakteristik penilaian	Penilaian bersifat berkelanjutan, autentik, dan berbasis kinerja nyata mahasiswa dalam praktik klinik, bukan hanya ujian satu kali.	Penilaian dilakukan dari beberapa kasus dan aktivitas, bukan hanya dari satu hasil OSCE.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mempertahankan kompetensinya secara konsisten dalam berbagai situasi klinik yang berbeda.	Mahasiswa mampu secara konsisten memberikan edukasi nifas, melakukan dokumentasi, dan konseling KB pada beberapa pasien dengan hasil yang baik.
Makna dalam OBE	Portofolio mendukung Outcome-Based Education dengan memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak hanya diukur dari pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan nyata dan berulang dalam praktik.	Mahasiswa menunjukkan pencapaian kompetensi secara utuh: memahami, melakukan, dan merefleksikan asuhan kebidanan masa nifas secara berkesinambungan.

Tabel 7.1
Case Report pada Asuhan Kebidanan Masa Nifas Komprehensif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Nifas (Edukasi, Dokumentasi, KB, dan Continuity of Care)
Hakikat case report	Case report merupakan laporan tertulis mengenai satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa secara sistematis dan terstruktur, mencerminkan proses asuhan kebidanan dari pengkajian hingga evaluasi.	Mahasiswa membuat laporan kasus ibu nifas hari ke-7 yang mengalami masalah laktasi dan kurang pengetahuan tentang tanda bahaya nifas.
Tujuan	Untuk melatih kemampuan analisis klinis, pengambilan keputusan, serta dokumentasi asuhan kebidanan berbasis kasus nyata.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan asuhan, dan mengevaluasi hasil tindakan pada ibu nifas.
Isi laporan	Meliputi identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis/assessment, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi (SOAP).	Laporan mencakup keluhan ASI kurang lancar, hasil pemeriksaan uterus dan lochea, edukasi tanda bahaya nifas, konseling KB, serta rencana kunjungan ulang.

Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis masalah, perencanaan asuhan, implementasi tindakan, serta kualitas dokumentasi.	Mahasiswa dinilai dari kemampuan menyusun SOAP yang lengkap dan logis serta kesesuaian tindakan dengan kondisi pasien.
Nilai edukatif	Memberikan pengalaman belajar kontekstual yang mengintegrasikan teori dengan praktik klinik.	Mahasiswa memahami pentingnya edukasi nifas dan konseling KB dalam mencegah komplikasi postpartum.
Makna dalam OBE	Case report menjadi bukti pencapaian kompetensi mahasiswa secara nyata dan terukur sesuai capaian pembelajaran.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan "knows how" dan "shows how" dalam asuhan nifas komprehensif.

Tabel 7.2
Refleksi Patient Safety pada Asuhan Kebidanan Masa Nifas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Nifas Komprehensif
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety adalah proses berpikir kritis mahasiswa terhadap praktik yang dilakukan, khususnya terkait keselamatan pasien, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.	Mahasiswa merefleksikan pengalaman memberikan asuhan pada ibu nifas yang belum memahami tanda bahaya.
Tujuan	Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko keselamatan pasien serta kemampuan mencegah kesalahan dalam pelayanan.	Mahasiswa memahami pentingnya edukasi dini untuk mencegah keterlambatan penanganan komplikasi nifas.
Fokus refleksi	Identifikasi kejadian berisiko, respons yang dilakukan, serta evaluasi tindakan yang telah diberikan.	Mahasiswa menilai apakah edukasi yang diberikan sudah cukup jelas dan dipahami pasien.
Risiko yang diidentifikasi	Risiko klinis yang dapat membahayakan pasien jika tidak ditangani dengan baik.	Risiko keterlambatan penanganan infeksi nifas karena ibu tidak mengetahui tanda bahaya seperti demam dan lochea berbau.
Tindakan pencegahan	Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keselamatan pasien.	Memberikan edukasi tanda bahaya nifas secara jelas, menggunakan media edukasi, dan menyarankan kunjungan ulang.
Pembelajaran mahasiswa	Hal-hal yang dipelajari mahasiswa dari pengalaman klinik tersebut.	Mahasiswa belajar bahwa komunikasi efektif dan edukasi sangat penting dalam mencegah komplikasi nifas.

Makna dalam OBE	Refleksi patient safety mendukung pembelajaran berbasis outcome dengan menekankan kemampuan berpikir kritis dan perbaikan berkelanjutan.	Mahasiswa tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas asuhan yang diberikan.

H. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 31 tahun, P3A0, melahirkan pervaginam dua jam yang lalu di puskesmas. Hasil anamnesis: ibu mengeluh pusing, sangat lemah, dan darah terus mengalir dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan: ibu tampak pucat dan gelisah, tekanan darah 85/55 mmHg, nadi 118 kali/menit, uterus teraba lembek, dan plasenta lahir lengkap.
   Apakah tindakan awal yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Memberikan tablet zat besi dan melakukan observasi
   B. Melakukan masase uterus, memberikan uterotonika, dan resusitasi cairan
   C. Memberikan kompres hangat pada abdomen dan menganjurkan mobilisasi
   D. Memberikan antibiotik spektrum luas dan melakukan perawatan perineum
   E. Memberikan konseling keluarga berencana dan menjadwalkan kunjungan ulang

2. Seorang perempuan berusia 28 tahun, P2A0, datang ke puskesmas pada hari kelima setelah persalinan. Hasil anamnesis: ibu mengalami demam, menggigil, nyeri perut bawah, dan pengeluaran dari vagina berbau tidak sedap. Hasil pemeriksaan: suhu 39°C, nadi 110 kali/menit, uterus nyeri tekan, involusi uterus lebih lambat, dan lochea tampak keruh kehijauan.
   Apakah rumusan yang paling tepat untuk bagian Assessment pada dokumentasi SOAP kasus tersebut?
   A. Involusi uterus fisiologis hari kelima postpartum
   B. Anemia postpartum tanpa komplikasi
   C. Infeksi puerperium dengan kemungkinan endometritis
   D. Tromboflebitis pada ekstremitas bawah
   E. Depresi postpartum dengan gangguan fungsi sehari-hari

3. Seorang perempuan berusia 34 tahun, P2A0, dirawat pada hari kedelapan setelah persalinan melalui sectio caesarea. Hasil anamnesis: ibu mengeluh nyeri pada tungkai kiri sejak satu hari terakhir dan lebih banyak berbaring setelah persalinan. Hasil pemeriksaan: tungkai kiri tampak bengkak dan kemerahan, teraba lebih hangat dibandingkan tungkai kanan, serta nyeri saat digerakkan.

Apakah tanda bahaya nifas yang paling mungkin dialami ibu pada kasus tersebut?

A. Subinvolusi uterus
B. Endometritis postpartum
C. Anemia postpartum
D. Tromboflebitis
E. Depresi postpartum

4. Seorang perempuan berusia 25 tahun, P1A0, datang pada hari ke-18 postpartum bersama suaminya. Hasil anamnesis: ibu terus-menerus merasa sedih, kehilangan minat merawat bayi, sulit tidur meskipun bayi sedang tidur, dan merasa dirinya tidak berguna. Ibu mengaku beberapa kali terpikir untuk menyakiti dirinya sendiri dan bayinya. Hasil pemeriksaan: tanda vital dalam batas normal.
   Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Menilai keselamatan ibu dan bayi, melibatkan keluarga, serta merujuk segera ke layanan kesehatan jiwa
   B. Menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan perubahan normal setelah persalinan
   C. Menganjurkan ibu beristirahat tanpa melakukan skrining lebih lanjut
   D. Memberikan konseling KB dan meminta ibu kembali pada hari ke-42
   E. Menunda penanganan sampai keluhan berlangsung lebih dari enam minggu

5. Seorang perempuan berusia 30 tahun, P1A0, melakukan kunjungan nifas pada hari ke-35 postpartum. Hasil anamnesis: ibu memberikan ASI eksklusif, belum menstruasi, ingin menunda kehamilan sekurang-kurangnya tiga tahun, tidak menginginkan metode hormonal, dan tidak ingin menggunakan kontrasepsi yang harus diingat setiap hari. Hasil pemeriksaan: kondisi umum baik, tidak terdapat demam, lochea berbau, maupun tanda infeksi.
   Apakah rencana pelayanan yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Menganjurkan MAL saja sampai menstruasi kembali tanpa evaluasi lanjutan
   B. Memberikan pil kombinasi karena mudah dihentikan sewaktu-waktu
   C. Memberikan kontrasepsi suntik satu bulanan tanpa membahas metode lainnya
   D. Menunda penggunaan kontrasepsi sampai ibu selesai menyusui
   E. Memberikan konseling IUD, memastikan *informed choice*, mendokumentasikan keputusan, dan merencanakan tindak lanjut

Kunci Jawaban

1. B
2. C
3. D
4. A
5. E

Pembahasan

1. Jawaban: **B**. Melakukan masase uterus, memberikan uterotonika, dan resusitasi cairan

   Kata kunci: dua jam postpartum, perdarahan banyak, uterus lembek, hipotensi, takikardia, pucat, gelisah.

   Ibu mengalami perdarahan postpartum primer dengan tanda gangguan hemodinamik. Uterus yang teraba lembek setelah persalinan menunjukkan bahwa penyebab yang paling mungkin adalah atonia uteri atau faktor tone dalam konsep "4T". Kegagalan uterus berkontraksi menyebabkan pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta tetap terbuka sehingga perdarahan terus berlangsung.

   Penatalaksanaan harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Masase uterus dilakukan untuk merangsang kontraksi, uterotonika seperti oksitosin diberikan untuk mempertahankan kontraksi uterus, sedangkan resusitasi cairan dibutuhkan karena ibu telah menunjukkan hipotensi, takikardia, pucat, dan gelisah sebagai tanda awal syok hipovolemik.

   Alasan opsi lain:

   a. A salah: tablet zat besi tidak dapat mengatasi perdarahan akut dan syok.
   b. C salah: kompres hangat dan mobilisasi merupakan bagian penatalaksanaan tromboflebitis, bukan perdarahan postpartum.
   c. D salah: antibiotik bukan tindakan utama pada perdarahan akibat atonia uteri.
   d. E salah: konseling KB dapat dilakukan setelah kondisi ibu stabil, bukan saat terjadi kegawatdaruratan.

2. Jawaban: **C**. Infeksi puerperium dengan kemungkinan endometritis

   Kata kunci: hari kelima postpartum, suhu 39°C, menggigil, lochea berbau busuk, nyeri uterus, subinvolusi.

   Bagian Assessment pada dokumentasi SOAP berisi diagnosis atau masalah yang dirumuskan berdasarkan data subjektif dan objektif. Data subjektif dalam kasus ini berupa demam, menggigil, nyeri perut bawah, dan lochea berbau. Data objektif berupa suhu 39°C, takikardia, uterus nyeri tekan, subinvolusi, serta lochea keruh kehijauan.

Kombinasi demam lebih dari 38°C setelah 24 jam postpartum, lochea berbau tidak sedap, nyeri uterus, dan subinvolusi mengarah pada infeksi puerperium, terutama endometritis. Kondisi tersebut memerlukan penanganan dengan antibiotik spektrum luas, hidrasi, pemantauan tanda vital, serta evaluasi kemungkinan sisa jaringan plasenta.

Alasan opsi lain:

a. A salah: involusi fisiologis tidak disertai demam tinggi, lochea berbau busuk, dan nyeri tekan uterus.
b. B salah: anemia dapat menyebabkan pucat dan lemah, tetapi tidak menyebabkan demam dan lochea berbau.
c. D salah: tromboflebitis ditandai nyeri, bengkak, kemerahan, dan rasa hangat pada tungkai.
d. E salah: depresi postpartum ditandai gangguan mood dan fungsi, bukan demam serta perubahan lochea.

3. Jawaban: D. Tromboflebitis

   Kata kunci: postpartum pasca-sectio caesarea, imobilisasi, nyeri tungkai unilateral, bengkak, merah, dan hangat.

   Tromboflebitis merupakan peradangan pembuluh vena yang disertai pembentukan trombus. Masa kehamilan dan nifas meningkatkan risiko trombosis karena adanya hiperkoagulabilitas. Risiko semakin meningkat pada ibu pascaoperasi yang lebih banyak berbaring karena terjadi stasis aliran darah.

   Nyeri, pembengkakan, kemerahan, dan peningkatan suhu lokal pada satu tungkai merupakan gambaran khas tromboflebitis. Kondisi ini harus segera dikenali karena trombus dapat terlepas dan menyebabkan emboli paru yang mengancam jiwa. Penatalaksanaan dapat mencakup antikoagulan, kompres hangat, dan mobilisasi sesuai kondisi serta instruksi tenaga medis.

   Alasan opsi lain:

   a. A salah: subinvolusi ditandai ukuran uterus lebih besar dari yang seharusnya dan dapat disertai lochea abnormal.
   b. B salah: endometritis lebih dominan menimbulkan demam, nyeri uterus, dan lochea berbau.
   c. C salah: anemia menyebabkan pucat, lemah, pusing, dan takikardia, bukan pembengkakan tungkai unilateral.
   d. E salah: depresi postpartum menimbulkan gangguan mood dan fungsi psikososial.

4. Jawaban: A. Menilai keselamatan ibu dan bayi, melibatkan keluarga, serta merujuk segera ke layanan kesehatan jiwa

Kata kunci: sedih berkepanjangan, kehilangan minat, gangguan tidur, merasa tidak berguna, pikiran menyakiti diri dan bayi.

Keluhan ibu mengarah pada depresi postpartum karena terdapat kesedihan berkepanjangan, hilangnya minat, gangguan tidur, perasaan tidak mampu merawat bayi, serta gangguan fungsi sehari-hari. Adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan bayi menunjukkan kondisi berat yang memerlukan tindakan segera.

Prioritas bidan adalah memastikan keselamatan ibu dan bayi, melakukan penilaian risiko, tidak membiarkan ibu sendirian, melibatkan suami atau keluarga sebagai sistem pendukung, serta mengoordinasikan rujukan ke layanan kesehatan jiwa. Penanganan selanjutnya dapat mencakup terapi psikologis, dukungan sosial, dan terapi farmakologis sesuai hasil pemeriksaan tenaga yang berwenang.

Alasan opsi lain:

a. B salah: keluhan tersebut bukan perubahan normal karena telah mengganggu fungsi dan disertai pikiran membahayakan.
b. C salah: istirahat saja tidak cukup dan dapat menunda penanganan kondisi berisiko tinggi.
c. D salah: konseling KB bukan prioritas utama ketika terdapat ancaman keselamatan ibu dan bayi.
d. E salah: penanganan tidak boleh ditunda karena terdapat pikiran menyakiti diri dan bayi.

5. Jawaban: **E**. Memberikan konseling IUD, memastikan informed choice, mendokumentasikan keputusan, dan merencanakan tindak lanjut

   Kata kunci: hari ke-35 postpartum, ingin menunda kehamilan minimal tiga tahun, tidak menginginkan hormon, tidak ingin metode harian.

   Hari ke-35 postpartum termasuk jadwal kunjungan nifas keempat, yaitu pada rentang 29–42 hari. Pada kunjungan ini bidan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemulihan ibu, status kesehatan umum, kondisi psikologis, laktasi, serta kesiapan menggunakan kontrasepsi.

   IUD sesuai dengan kebutuhan ibu karena merupakan metode kontrasepsi jangka panjang, sangat efektif, reversibel, tidak memerlukan kepatuhan harian, dan tersedia dalam jenis nonhormonal. Sebelum pemasangan, bidan tetap harus menjelaskan manfaat, cara kerja, kemungkinan efek samping, alternatif metode, dan memastikan tidak ada kontraindikasi. Keputusan harus dibuat secara sadar dan sukarela melalui prinsip *informed choice*, kemudian dicatat dalam dokumentasi SOAP dan dilanjutkan dengan pemantauan sebagai bagian dari *continuity of care*.

Alasan opsi lain:

a. A salah: MAL hanya efektif selama enam bulan pertama apabila ibu belum menstruasi dan memberikan ASI eksklusif. Metode ini tidak memenuhi kebutuhan kontrasepsi jangka panjang ibu.
b. B salah: pil kombinasi mengandung estrogen dan tidak sesuai dengan preferensi ibu yang menolak hormon; materi juga lebih merekomendasikan pil progestin bagi ibu menyusui.
c. C salah: kontrasepsi suntik merupakan metode hormonal dan bertentangan dengan preferensi ibu.
d. D salah: ibu menyusui tidak harus menunggu sampai berhenti menyusui untuk menggunakan kontrasepsi.

I. Ringkasan Materi

Masa nifas merupakan periode kritis setelah persalinan yang berlangsung hingga 42 hari, di mana ibu mengalami perubahan fisiologis dan psikologis serta berisiko tinggi mengalami komplikasi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan asuhan komprehensif yang mencakup edukasi tanda bahaya, dokumentasi yang baik, tindak lanjut kunjungan nifas, konseling keluarga berencana, serta penerapan *continuity of care* secara berkesinambungan (WHO, 2015; Ekowati & Herlina, 2023).

Edukasi tanda bahaya nifas menjadi komponen penting dalam mencegah keterlambatan penanganan komplikasi, karena pengetahuan ibu yang baik akan mendorong perilaku pencarian pertolongan secara cepat dan tepat. Dokumentasi asuhan kebidanan melalui metode SOAP mendukung kesinambungan pelayanan serta mempermudah komunikasi antar tenaga kesehatan. Sementara itu, kunjungan nifas yang dilakukan secara terjadwal memungkinkan deteksi dini komplikasi, pemantauan involusi uterus, keberhasilan laktasi, serta pemberian edukasi kesehatan secara berkelanjutan (Kunang & Puspariny, 2020; Masini et al., 2024).

Konseling keluarga berencana postpartum bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, menjaga kesehatan ibu, serta mengatur jarak kehamilan agar optimal. Seluruh rangkaian pelayanan ini terintegrasi dalam pendekatan *continuity of care*, yang menekankan pelayanan berkesinambungan dari kehamilan hingga keluarga berencana, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan risiko komplikasi, serta meningkatkan kepuasan pasien (Listiyorini & Budiasri, 2022)..

J. Alur Asuhan Ringkas

Alur asuhan kebidanan pada masa nifas dimulai sejak ibu memasuki periode postpartum, di mana tenaga kesehatan melakukan pengkajian awal yang meliputi kondisi umum ibu, riwayat persalinan, tanda vital, serta pemeriksaan fisik. Hasil pengkajian ini kemudian didokumentasikan secara sistematis menggunakan metode SOAP sebagai dasar dalam menentukan diagnosis dan rencana asuhan.

Selanjutnya, tenaga kesehatan memberikan edukasi tanda bahaya nifas kepada ibu dan keluarga, seperti perdarahan, demam, lochea berbau, nyeri hebat, serta gangguan psikologis. Edukasi ini bertujuan agar ibu mampu mengenali kondisi abnormal secara mandiri dan segera mencari pertolongan apabila diperlukan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kunjungan nifas secara terjadwal, yaitu pada 6–48 jam, 3–7 hari, 8–28 hari, dan 29–42 hari postpartum. Pada setiap kunjungan dilakukan pemantauan kondisi ibu, evaluasi involusi uterus, pemantauan laktasi, serta deteksi dini komplikasi. Selain itu, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi berkelanjutan terkait perawatan diri dan bayi.

Selama masa nifas, ibu juga diberikan konseling keluarga berencana untuk membantu memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Konseling dilakukan secara komunikatif dan berbasis informed choice agar ibu dapat mengambil keputusan yang tepat.

Seluruh proses asuhan ini dilaksanakan dalam kerangka *continuity of care*, yaitu pelayanan yang berkesinambungan dari kehamilan hingga nifas dan keluarga berencana. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahap pelayanan saling terhubung, sehingga memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Tabel Red Flags dan Eskalasi Pada Masa Nifas

No	Kondisi (Red Flags)	Tanda & Gejala Kunci	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Awal (Bidan)	Eskalasi/Rujukan
1	Perdarahan Postpartum	Perdarahan banyak, uterus lembek, pucat, takikardia	Atonia uteri, retensi plasenta, trauma	Masase uterus, oksitosin, observasi ketat	Rujuk segera jika perdarahan tidak terkontrol / tanda syok

2	Demam (>38°C)	Demam, menggigil, nyeri perut, malaise	Infeksi (endometritis, UTI, mastitis)	Monitor suhu, edukasi, mulai antibiotik sesuai kewenangan	Rujuk jika demam persisten atau tanda sepsis
3	Lochea berbau busuk	Cairan berbau, warna abnormal, nyeri uterus	Infeksi uterus, sisa plasenta	Edukasi kebersihan, observasi, antibiotik	Rujuk jika disertai demam tinggi atau perdarahan
4	Nyeri abdomen hebat	Nyeri tajam, uterus nyeri tekan, distensi	Infeksi, hematoma, ruptur	Observasi, analgesik, pemeriksaan lanjut	Rujuk segera jika nyeri berat atau tanda syok
5	Tromboflebitis	Kaki bengkak, merah, nyeri, hangat	Trombus vena	Anjurkan mobilisasi ringan, observasi	Rujuk untuk terapi antikoagulan
6	Depresi postpartum	Sedih, menangis, tidak minat, gangguan tidur	Perubahan hormon, faktor psikososial	Dukungan emosional, konseling awal	Rujuk ke psikolog/psikiater jika berat
7	Pusing & lemah berlebihan	Pusing, pucat, lemah, sesak ringan	Anemia, perdarahan	Istirahat, nutrisi, Fe	Rujuk jika anemia berat / Hb sangat rendah

FORM CHECKLIST "SAYA SUDAH BISA..."

BAB: Edukasi Tanda Bahaya Nifas, Dokumentasi, Tindak Lanjut Kunjungan Nifas, Konseling KB, dan Continuity of Care

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / *Skill Lab* *:* _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Edukasi Tanda Bahaya Nifas				
No	**Pernyataan**	**Sudah**	**Belum**	**Catatan**
1	Saya mampu menjelaskan pengertian masa nifas kepada ibu			
2	Saya mampu menyebutkan tanda bahaya nifas secara lengkap			
3	Saya mampu menjelaskan tanda perdarahan postpartum kepada ibu			
4	Saya mampu menjelaskan tanda infeksi (demam, lochea bau)			
5	Saya mampu memberikan edukasi kapan harus segera ke fasilitas kesehatan			
6	Saya mampu menggunakan media edukasi (leaflet/video)			
Dokumentasi Asuhan Kebidanan				
7	Saya mampu menjelaskan pentingnya dokumentasi kebidanan			
8	Saya mampu melakukan pencatatan data subjektif (S)			
9	Saya mampu melakukan pencatatan data objektif (O)			
10	Saya mampu merumuskan assessment/diagnosa (A)			
11	Saya mampu menyusun planning/tindakan (P)			
12	Saya mampu mendokumentasikan asuhan secara lengkap dan sistematis			
Tindak Lanjut Kunjungan Nifas				
13	Saya mampu menyebutkan jadwal kunjungan nifas			
14	Saya mampu melakukan pengkajian pada kunjungan nifas			
15	Saya mampu mendeteksi dini tanda komplikasi			
16	Saya mampu mengevaluasi involusi uterus			
17	Saya mampu melakukan pemantauan laktasi			
18	Saya mampu memberikan edukasi lanjutan kepada ibu			
Konseling Keluarga Berencana (KB)				
19	Saya mampu menjelaskan tujuan KB postpartum			
20	Saya mampu menjelaskan metode KB (MAL, pil, suntik, IUD, implan)			
21	Saya mampu melakukan komunikasi efektif saat konseling			

22	Saya mampu membantu ibu memilih metode KB (informed choice)			
23	Saya mampu menjelaskan efek samping KB			
24	Saya mampu mendokumentasikan hasil konseling KB			
Continuity of Care				
25	Saya mampu menjelaskan konsep continuity of care			
26	Saya mampu mengidentifikasi kebutuhan ibu secara berkelanjutan			
27	Saya mampu menghubungkan asuhan kehamilan–persalinan–nifas–KB			
28	Saya mampu melakukan koordinasi/rujukan bila diperlukan			
29	Saya mampu memberikan asuhan berpusat pada pasien			
30	Saya mampu menerapkan continuity of care dalam kasus sederhana			

Refleksi singkat mahasiswa:

K. Referensi

Acosta, C. D., et al. (2014). Maternal sepsis in the UK. BMJ Open.

Argaheni, N. B., & Zubaidah, L. (2021). Pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya masa nifas. OVUM Journal. https://doi.org/10.47701/ovum.v1i2.1602

Betrán, A. P., et al. (2016). The increasing trend in caesarean section rates. PLOS ONE.

Bonet, M., et al. (2017). Towards a consensus definition of maternal sepsis. Reproductive Health.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2016). *U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use*.

Cleland, J., et al. (2012). Contraception and health. *The Lancet*.

Conde-Agudelo, A., et al. (2012). Birth spacing and maternal outcomes. *JAMA*.

Deasy. (2024). Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya masa nifas. JKKSE. https://doi.org/10.12538/jkkse-akbidsteli.v3i01.51

Ekowati, E., & Herlina, N. (2023). Postpartum obstetric danger signs. *Indonesian Midwifery Journal*.

Ekowati, E., & Herlina, N. (2023). Risk factors associated with postpartum obstetric danger signs. Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal. https://doi.org/10.20473/imhsj.v7i3.2023.216-225

Fitriani, Y., Sari, M., & Handayani, L. (2021). Penerapan dokumentasi asuhan kebidanan berbasis SOAP dalam meningkatkan kualitas pelayanan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*.

Heit, J. A., et al. (2016). Risk factors for venous thromboembolism. Blood Journal.

Hidayat, A. A., & Uliyah, M. (2019). *Pengantar dokumentasi keperawatan dan kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.

Hussein, J., et al. (2020). Postpartum infections. BMC Pregnancy and Childbirth.

James, A. H. (2018). Thrombosis in pregnancy. Hematology.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan ibu nifas*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kerber, K. J., et al. (2007). Continuum of care for maternal, newborn, and child health. *The Lancet*.

Kunang, A., & Puspariny, C. (2020). Efektivitas penggunaan buku KIA terhadap peningkatan kualitas pelayanan nifas. *Jurnal Kesehatan Bina Generasi*.

Listiyorini, D., & Budiasri, A. (2022). Program penyuluhan tanda bahaya masa nifas. JPPMA. https://doi.org/10.70371/jppma.v2i1.164

Lubis, U. L., et al. (2021). Gambaran pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya. Jurnal Alaqoh. https://doi.org/10.70371/jala.v10i1.123

Masini, M., et al. (2024). Efektivitas media leaflet dan video pada tanda bahaya nifas. Midwifery Care Journal. https://doi.org/10.31983/micajo.v5i4.11274

Milman, N. (2011). Postpartum anemia. Annals of Hematology.

O'Hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum depression. Annual Review of Clinical Psychology.

Rejeki, I. S., & Fajri, F. (2023). Edukasi tanda bahaya dan komplikasi masa nifas. Jurnal Pengabdian Masyarakat. https://doi.org/10.58294/jpmgs.v2i1.150

Renfrew, M. J., et al. (2014). Midwifery and quality care. *The Lancet*.

Sandall, J., et al. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.

Say, L., et al. (2014). Global causes of maternal death. *The Lancet*.

Stewart, D. E., & Vigod, S. (2016). Postpartum depression. NEJM.

Titaley, C. R., et al. (2019). Determinants of postnatal care utilization in Indonesia. *BMC Pregnancy and Childbirth*.

Triastin, S. A., & Nabila, F. (2024). Upaya peningkatan pengetahuan ibu nifas terhadap tanda bahaya masa nifas. Jurnal ADM. https://doi.org/10.61930/jurnaladm.v2i2.729

Victora, C. G., et al. (2016). Breastfeeding in the 21st century. *The Lancet*.

WHO. (2015). WHO recommendations for prevention and treatment of maternal infections.

WHO. (2016). Guideline on iron supplementation.

WHO. (2022). Recommendations on postpartum hemorrhage.

World Health Organization (WHO). (2015). *Medical eligibility criteria for contraceptive use*.

World Health Organization (WHO). (2015). *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn*.

World Health Organization (WHO). (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.

World Health Organization (WHO). (2018). *Family planning: A global handbook for providers*.

World Health Organization (WHO). (2022). *Recommendations on maternal and newborn care*.

PROFIL PENULIS



Nurbaety, S.SiT., M.K.M. Nurbaety, S.SiT., M.K.M. lahir di Bima, 2 September 1986. Ia menyelesaikan pendidikan Diploma IV Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2009. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Prof. Dr. Hamka dan lulus pada tahun 2020. Karier akademiknya dimulai pada tahun 2010 di Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan pada periode 2017–2024. Saat ini, ia dipercaya sebagai Direktur Politeknik Muhammad Dahlan. Dalam jabatan tersebut, ia berperan melanjutkan transformasi kelembagaan dari Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima menjadi politeknik multi-program studi.

Dalam bidang akademik, Nurbaety aktif mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Dokumentasi dalam Praktik Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, serta Kewirausahaan dalam Kebidanan.

Sebagai pendidik dan akademisi, ia aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan. Ia juga menjadi narasumber, mengikuti seminar, pelatihan, dan pertemuan ilmiah tingkat nasional. Pada tahun 2020, ia mendapat kepercayaan sebagai Pengawas Pusat Ujian Kompetensi Bidan.

Nurbaety merupakan penulis produktif yang telah menulis dan menerbitkan sejumlah buku serta artikel ilmiah di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat. Atas kontribusinya dalam pendidikan, pengembangan institusi, dan kegiatan akademik, ia juga telah menerima berbagai penghargaan. Melalui Politeknik Muhammad Dahlan, ia terus mendorong inovasi pendidikan, peningkatan mutu, serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan daerah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bettygindi@gmail.com

Motto: “Living your life well”

PROFIL PENULIS



Gita Kostania, S.ST., M.Kes. lahir di Cilacap pada tanggal 16 Desember 1986. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Diploma 3 Kebidanan, Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Malang. Pendidikan tinggi penulis diawali dengan menyelesaikan program Diploma-III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada program Diploma-IV Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan Magister pada Program Studi Magister Kedokteran dengan peminatan Pendidikan Profesi Kesehatan di universitas yang sama. Sebagai bidan pendidik, penulis secara konsisten menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, penulis aktif mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran kebidanan. Dalam bidang penelitian, penulis telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Beberapa karya ilmiah penulis, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat diakses melalui profil SINTA pada laman: https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5982765.

Melalui kegiatan akademik dan profesional yang dijalani, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan maternal. Untuk keperluan korespondensi, penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: gita_kostania@poltekkes-malang.ac.id. Motto: "Mendidik dengan hati, mengabdi melalui ilmu, dan berkarya demi kebermanfaatan."

PROFIL PENULIS



Pipit Indra lestari, S.ST.,M.Kes.,CHE. Lahir di Tegal, 16 April 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan Politeknik Harapan Bersama Tegal tahun 2011, pada jenjang D4 pendidik Universitas Nasional Jakarta tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Universitas Insan Mahardika Cirebon sebagai Dosen Tetap Prodi DIII Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, aktif kegiatan Pengabdian Masyarakat, dan memberikan pelayanan dalam therapy komplementer kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pipitindralestari16@gmail.com

Motto: Hidup Bermanfaat, Bersyukur, Bahagia Dunia & Akhirat Aamin



Bdn. Sri Hennyati Amiruddin, S.ST., M.Kes., M.Tr.Keb., Menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan di AKBID Yayasan Mona Banda Aceh. Menyelesaikan pendidikan D4 di Universitas Sumatera Utara. Penulis melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di STIKes Dharma Husada Bandung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Profesi Kebidanan di STIKes Dharma Husada Bandung. Sejak tahun 2009 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan dan saat ini penulis aktif mengajar di STIKes Dharma Husada. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya.

Penulis dapat dihubungi melalui email srihennyati@gmail.com

Pesan untuk para pembaca: "Pendidikan bukan sekadar proses memperoleh pengetahuan, tetapi proses membentuk karakter, memperluas cara berpikir, dan mempersiapkan seseorang untuk memberi manfaat bagi kehidupan."

PROFIL PENULIS



Eva Fauziah, S.ST., M.Kes., lahir di Majalengka pada 31 Oktober 1988. Menyelesaikan pendidikan Diploma III dan Diploma IV Kebidanan serta Program Magister Kesehatan Masyarakat. Saat ini berkarier sebagai Dosen Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Bhakti Husada Indonesia. Penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penulisan buku ajar dan publikasi ilmiah. Bidang kepakaran dan minat penelitian penulis meliputi kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, kebidanan komunitas, promosi kesehatan, kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupan, serta pendidikan kebidanan. Berbagai hasil penelitian penulis telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dengan fokus pada kesehatan maternal dan neonatal, antara lain mengenai hipertensi pada kehamilan trimester III, keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), bayi berat lahir rendah (BBLR), serta kesehatan perempuan pada masa menopause. Penelitian tersebut menjadi bagian dari kontribusi penulis dalam pengembangan praktik kebidanan berbasis bukti (evidence-based midwifery). Selain aktif sebagai peneliti dan penulis, penulis juga membimbing tugas akhir mahasiswa, menyusun bahan ajar, serta berpartisipasi dalam berbagai seminar, pelatihan, dan kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi profesional.
Email: evafauziah.office@gmail.com
Motto: "Melahirkan kehidupan, mendidik generasi, dengan hati, ilmu, ketulusan, dan ketangguhan."

PROFIL PENULIS



Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes., Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Prodi DIV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (MIKM) Minat Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, lulus tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Profesi Kebidanan di Univeritas Muhammadiyah Gombong. Saat ini (tahun 2023), penulis melanjutkan pendidikan Doktoral S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gajah Mada (UGM). Sejak tahun 2008 sampai sekarang, penulis aktif mengajar sebagai dosen kebidanan pada Prodi Kebidanan Program Diploma, Sarjana dan Profesi di Univeritas Muhammadiyah Gombong. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis pernah mendapatkan Beasiswa Retooling Kompetensi Dosen Vokasi pada Tahun 2019 dari Kemenristekdikti. Penulis juga mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia (BPI) untuk Studi S3 dari Kendikbud tabun 2022. Penulis juga telah mengikuti pelatihan *T*raining of trainer *(TOT) P*renatal dan Post Natal Gentle Yoga *serta Yoga Kids*. Penulis dapat dihubungi melalui email ncuz.kusuma26@gmail.com. Pesan untuk para pembaca: Hidup adalah tentang belajar maka bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat dan jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.



Nurul Hidayah, M.Tr.Keb., Lahir di Majalengka, 11 Agustus 1995. Menempuh pendidikan D-III dan D-IV Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kemudian melanjutkan pendidikan Kebidanan Program Magister Terapan di Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus pada tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhakti Husada Indonesia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: n.hidayahhhhhhh@gmail.com Motto: "Believe in yourself and all that you are"

Sinopsis

Masa nifas bukan sekadar periode pemulihan setelah persalinan, melainkan fase penting yang menuntut pemantauan menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial ibu. Berbagai komplikasi dapat muncul secara tiba-tiba, berkembang dengan cepat, serta mengancam keselamatan ibu apabila tanda awalnya tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Karena itu, bidan dan tenaga kesehatan perlu memiliki kemampuan pengkajian, penalaran klinis, tindakan awal, komunikasi, serta pengambilan keputusan rujukan yang cepat dan terstruktur.

Buku ajar "Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu" menyajikan pembahasan komprehensif mengenai berbagai masalah yang dapat terjadi selama masa nifas. Materi mencakup perdarahan postpartum berdasarkan pendekatan penyebab 4T, atonia uteri, subinvolusi, retensio dan sisa plasenta, laserasi jalan lahir, serta hematoma. Aspek infeksi dibahas melalui endometritis, infeksi luka, sepsis puerperalis, pengenalan tanda bahaya, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan yang efektif.

Permasalahan menyusui mendapat perhatian khusus melalui pembahasan bendungan ASI, puting lecet, koreksi posisi dan perlekatan menyusui, mastitis, serta abses payudara. Buku ini juga menguraikan komplikasi sistemik yang memerlukan kewaspadaan tinggi, seperti trombosis vena dalam, emboli paru, dan kondisi kegawatdaruratan lain pada masa nifas. Gangguan eliminasi, termasuk retensi urine, konstipasi, dan hemoroid, disajikan bersama prinsip pengkajian, perawatan awal, edukasi perawatan mandiri, serta kriteria kolaborasi dan rujukan.

Tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, buku ini menempatkan kesehatan mental ibu sebagai bagian penting dalam asuhan nifas. Pembaca diajak memahami perbedaan antara *baby blues*, depresi postpartum, dan psikosis postpartum, sekaligus mempelajari skrining psikologis, penilaian risiko bunuh diri atau tindakan yang membahayakan bayi, dukungan awal, pelibatan keluarga, penyusunan rencana keselamatan, serta rujukan sesuai tingkat kegawatan.

Setiap pembahasan diarahkan pada penerapan asuhan yang aman, empatik, berbasis bukti, dan sesuai kewenangan bidan. Penekanan diberikan pada identifikasi *red flags*, penilaian sistematis menggunakan pendekatan ABCDE, stabilisasi awal, komunikasi rujukan dengan metode SBAR, dokumentasi SOAP, edukasi tanda bahaya, kunjungan nifas, konseling keluarga berencana, dan *continuity of care*. Materi dilengkapi dengan kasus klinis, latihan soal, simulasi, OSCE, DOPS, rubrik penilaian, portofolio, refleksi keselamatan pasien, serta daftar periksa keterampilan untuk menghubungkan pemahaman teoretis dengan praktik klinik.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa Diploma III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan, Sarjana Kebidanan, mahasiswa Profesi Bidan, dosen, pembimbing klinik, bidan praktisi, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan maternal. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memberikan asuhan masa nifas secara lebih tanggap, profesional, manusiawi, dan berkesinambungan sehingga komplikasi dapat dikenali lebih dini, ditangani secara tepat, dan keselamatan ibu tetap menjadi prioritas utama.

Masa nifas bukan sekadar periode pemulihan setelah persalinan, melainkan fase penting yang menuntut pemantauan menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial ibu. Berbagai komplikasi dapat muncul secara tiba-tiba, berkembang dengan cepat, serta mengancam keselamatan ibu apabila tanda awalnya tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Karena itu, bidan dan tenaga kesehatan perlu memiliki kemampuan pengkajian, penalaran klinis, tindakan awal, komunikasi, serta pengambilan keputusan rujukan yang cepat dan terstruktur.

Buku ajar "Komplikasi Nifas: Perdarahan, Infeksi, Gangguan Laktasi, dan Kesehatan Mental Ibu" menyajikan pembahasan komprehensif mengenai berbagai masalah yang dapat terjadi selama masa nifas. Materi mencakup perdarahan postpartum berdasarkan pendekatan penyebab 4T, atonia uteri, subinvolusi, retensio dan sisa plasenta, laserasi jalan lahir, serta hematoma. Aspek infeksi dibahas melalui endometritis, infeksi luka, sepsis puerperalis, pengenalan tanda bahaya, stabilisasi pra-rujukan, dan komunikasi rujukan yang efektif.

Permasalahan menyusui mendapat perhatian khusus melalui pembahasan bendungan ASI, puting lecet, koreksi posisi dan perlekatan menyusui, mastitis, serta abses payudara. Buku ini juga menguraikan komplikasi sistemik yang memerlukan kewaspadaan tinggi, seperti trombosis vena dalam, emboli paru, dan kondisi kegawatdaruratan lain pada masa nifas. Gangguan eliminasi, termasuk retensi urine, konstipasi, dan hemoroid, disajikan bersama prinsip pengkajian, perawatan awal, edukasi perawatan mandiri, serta kriteria kolaborasi dan rujukan.

Tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, buku ini menempatkan kesehatan mental ibu sebagai bagian penting dalam asuhan nifas. Pembaca diajak memahami perbedaan antara baby blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum, sekaligus mempelajari skrining psikologis, penilaian risiko bunuh diri atau tindakan yang membahayakan bayi, dukungan awal, pelibatan keluarga, penyusunan rencana keselamatan, serta rujukan sesuai tingkat kegawatan.

Setiap pembahasan diarahkan pada penerapan asuhan yang aman, empatik, berbasis bukti, dan sesuai kewenangan bidan. Penekanan diberikan pada identifikasi red flags, penilaian sistematis menggunakan pendekatan ABCDE, stabilisasi awal, komunikasi rujukan dengan metode SBAR, dokumentasi SOAP, edukasi tanda bahaya, kunjungan nifas, konseling keluarga berencana, dan continuity of care. Materi dilengkapi dengan kasus klinis, latihan soal, simulasi, OSCE, DOPS, rubrik penilaian, portofolio, refleksi keselamatan pasien, serta daftar periksa keterampilan untuk menghubungkan pemahaman teoretis dengan praktik klinik.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa Diploma III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan, Sarjana Kebidanan, mahasiswa Profesi Bidan, dosen, pembimbing klinik, bidan praktisi, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan maternal. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memberikan asuhan masa nifas secara lebih tanggap, profesional, manusiawi, dan berkesinambungan sehingga komplikasi dapat dikenali lebih dini, ditangani secara tepat, dan keselamatan ibu tetap menjadi prioritas utama.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-22-4 (PDF)
9 786347 927224